



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN BULAN JULI
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Bab I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Tujuan 1

Bab II Gambaran Umum Rumah Sakit Prima Husada Malang 2

2.1 Visi 2

2.2 Misi..... 2

2.3 Motto 2

2.4 7 Nilai Budi Utama 2

2.5 Struktur Organisasi 3

Bab III Laporan Kinerja Pelayanan..... 4

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI) 4

3.1.1 Tabel Capaian BOR,LOS,TOI,BTO 4

3.1.2 Grafik Capaian BOR,LOS,TOI,BTO 4

3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut 4

3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan 6

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada 7

3.3 Kinerja Bidang Pelayanan 25

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik 25

3.3.2 Rawat Inap 27

3.3.3 Intensive Care Unit (ICU) 33

3.3.4 High Care Unit (HCU) 34

3.3.5 Instalasi Gawat Darurat (IGD) 35

3.3.6 Instalasi Kamar Operasi (IKO) 36

3.4 Kinerja Bidang Penunjang 38

3.4.1 Instalasi Farmasi 38

3.4.2 Laboratorium 56

3.4.3 Rekam Medis - Pendaftaran..... 59

3.4.4 Radiologi 66

3.4.5 Gizi 72

3.4.6 CSSD - Laundry 87

3.5 Kinerja Bidang Umum dan Keuangan 95

3.5.1 SDM 95

3.5.2 IPSRS 103

3.5.3 Security 109

3.5.4 Parkir..... 112

3.5.5 Humas Marketing 113

3.5.6 Penjaminan 119

3.5.7 PIPP – MOD - MPP..... 120

3.5.8 *Cleaning Service* 128

3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum..... 129

3.6 Komite dan Tim 132

3.6.1 Komite Mutu 132

3.6.2 Komite PPI 186

3.6.3 Tim PKRS..... 199

3.6.4 Tim Prognas..... 201

3.6.5 Tim PPRA..... 242

3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT 247

3.7 Permasalahan Rumah Sakit 249

3.8 Profil SDM 264

Bab IV Kesimpulan dan Saran..... 267

Bab V Penutup..... 268

Lampiran 269

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Rumah Sakit Prima Husada Malang untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi Rumah Sakit Prima Husada Malang dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan dan sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan berkelanjutan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, penunjang dan tindakan medik.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Bulan Juli Tahun 2025 adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan antar unit untuk meningkatkan kinerja rumah sakit

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

2.1 VISI

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilhan seluruh lapisan masyarakat

2.2 MISI

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

2.3 MOTTO

Sahabat Menuju Sehat

2.4 7 NILAI BUDI UTAMA

1. Jujur Dipercaya
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan struktur Organisasi Rumah Sakit Prima Husada Malang sebagai berikut :



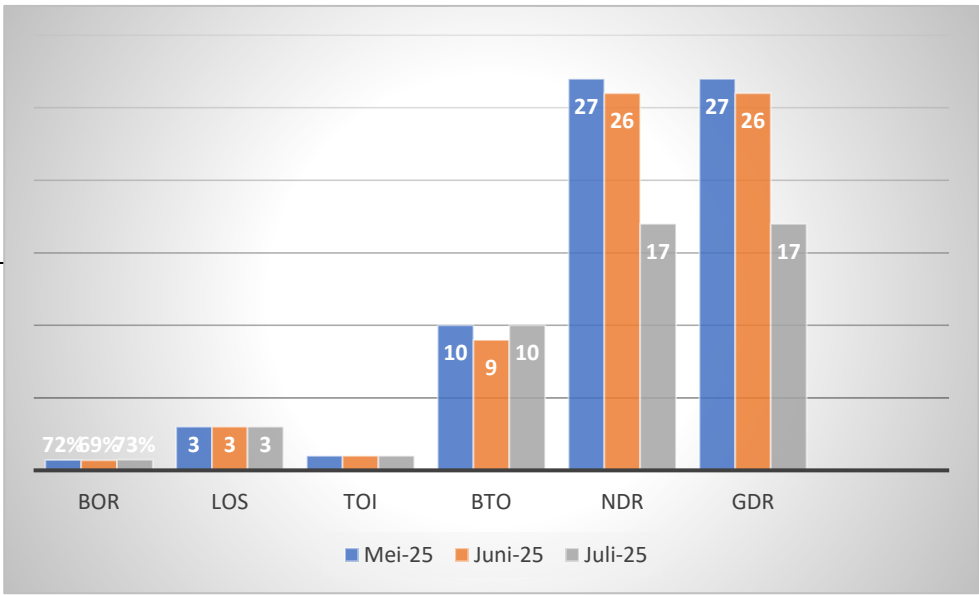
BAB III
LAPORAN KINERJA PELAYANAN

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI)

3.1.1 Tabel Capaian BOR, LOS, TOI, BTO

INDIKATOR	MEI	JUNI	JULI	CATATAN
BOR	72%	69%	73%	Mengalami kenaikan di bulan Juli
LOS	3 hari	3 hari	3 hari	Penurunan LOS, dibawah standar SE PT DPM
TOI	1 hari	1 hari	1 hari	Stabil, efisien
BTO	10 kali	9 kali	10 kali	Konsisten tinggi, diluar standar ideal

3.1.2 Grafik Capaian BOR, LOS, TOI, BTO



3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut

INDIKATOR	NILAI JULI 2025	STANDAR IDEAL	EVALUASI SINGKAT
BOR	72%	60%-85%	Masih dalam standar, batas rendah
LOS	3 hari	BPJS : 3 hari UMUM : 6-12 hari	Dibawah standar BPJS, perlu dicermati
TOI	1 hari	1-3 hari	Sesuai standar, efisien
BTO	10 kali	4-5 kali	Konsisten tinggi, perlu evaluasi

Masalah :

- BOR (Bed Occupancy Rate)**
 - Mendekati zona efisien tetapi masih di bawah standar efisiensi internasional ($\geq 75\%$), khususnya pada Juni yang turun ke 69 %.
 - Dapat menunjukkan fluktuasi musiman, perubahan kapasitas, atau bottleneck alur masuk (eksekutif, BPJS, program khusus, dsb.).
- LOS (Length of Stay)**

Sangat pendek (3 hari), hampir setengah dari standar (6–9 hari), dengan beberapa potensi risiko:

 - Kemungkinan besar banyak kasus low-complexity / fast-track atau "mini-stay".
 - Risiko kasus readmission tinggi jika discharge dilakukan terlalu cepat.
 - Case mix index mungkin rendah, layanan belum optimal bidang rawat inap.

3. **TOI (Turn Over Interval)**

1 hari (tepat batas efisiensi), tapi:

- a) Tingkat desinfeksi, administrasi, perawatan gizi/keperawatan harus disiplin agar tidak tergesa-gesa.
- b) Tidak ada buffer kalau ada keterlambatan triase IGD/ruang/transport pasien atau gangguan logistik.

4. **BTO (Bed Turn Over)**

Sangat tinggi (sekitar 10x/bulan), artinya volume turnover sangat besar:

- a) Bisa menimbulkan burnout tim cleaning, housekeeping, frontliner.
- b) Boleh jadi menunjukkan just-in-time turnover, tapi bisa mengurangi kualitas jika tidak seimbang dengan standar sterilitas dan manajemen alur.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Tingkatkan Volume & Turnover Pasien

- a) Target BTO: naikan ke minimal 30 kali/tahun, optimal 40–50 kali/tahun.
- b) Pendekatan: tingkatkan layanan rawat inap jangka pendek (bedah minor, observasi), buka unit baru yang cepat turnover.

2. Evaluasi Kualitas LOS

- a) Lakukan audit Clinical Pathway untuk memastikan LOS singkat tidak menimbulkan efek readmisi atau kompromi mutu.
- b) Monitor rata-rata LOS per diagnosis alternatif untuk memastikan sesuai praktik terbaik.

3. Optimasi Proses Internal

- a) TOI saat ini optimal, tetap jaga proses pembersihan dan kesiapan TT agar tidak mengganggu turnover.
- b) Perlu diagram alir proses (flowchart) pelunasan pasien, pembersihan, dan penyiapan tempat tidur.

4. Promosi & Koordinasi Layanan

- a) Tingkatkan kolaborasi antar poliklinik rawat jalan dan unit rawat inap untuk mengaktifkan rujukan pasien rawat inap.
- b) Edukasi masyarakat mengenai manfaat rawat inap untuk kondisi yang cocok, serta promosi layanan tertentu.

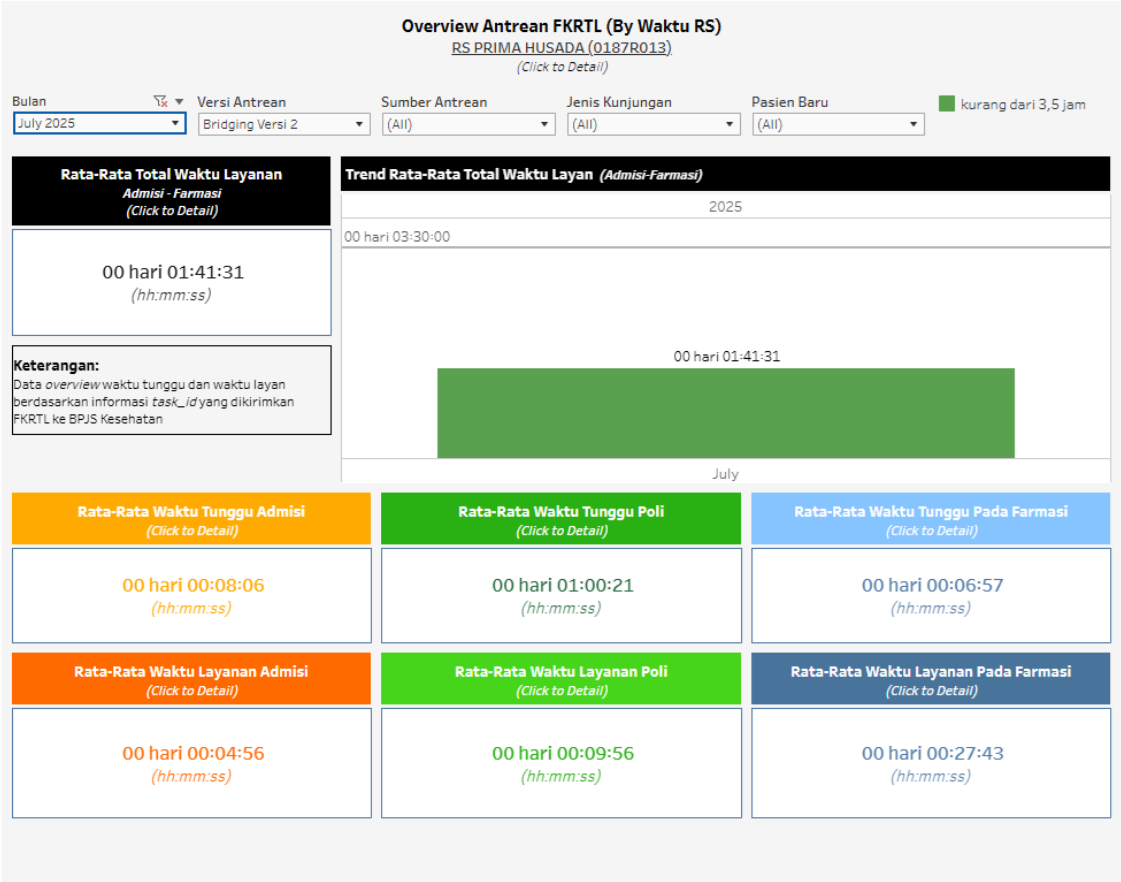
5. Visualisasi & Monitoring Berkala

- a) Buat Grafik Barber-Johnson untuk memantau BOR, LOS, TOI, BTO secara bersamaan dalam satu visual.
- b) Laporan bulanan/triwulan agar indikator mudah dipantau dan dianalisis trend-nya.

6. Evaluasi Kapasitas TT

Jika BTO rendah karena jumlah TT terlalu banyak terhadap volume kasus, pertimbangkan penyesuaian kapasitas: konsolidasi unit/penutupan sementara blok TT yang underutilized.

3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan



NO	KETERANGAN		BULAN (2025)						
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Total Waktu Layanan	Rata-Rata Tahun 2024 2:12:37	02:07:27	01:59:21	02:09:52	02:18:27	02:08:00	01:43:32	01:43:31
2	Waktu Tunggu Admisi	0:11:52	00:07:37	00:04:57	00:06:52	00:05:18	00:05:52	00:07:06	00:08:06
3	Waktu Layanan Admisi	0:07:49	00:05:49	00:04:58	00:05:36	00:07:16	00:08:24	00:07:39	00:04:56
4	Waktu Tunggu Poli	1:03:51	01:06:01	01:05:56	01:02:05	01:08:06	01:00:46	00:56:02	01:00:21
5	Waktu Layanan Poli	0:14:56	00:09:41	00:10:08	00:10:47	00:09:38	00:10:39	00:09:45	00:09:56
6	Waktu Tunggu Farmasi	0:14:47	00:11:17	00:09:31	00:12:56	00:13:02	00:10:22	00:08:01	00:06:57
7	Waktu Layanan Farmasi	0:54:42	00:44:57	00:38:06	00:48:35	00:51:36	00:50:31	00:32:51	00:27:43

Analisis :
Pada bulan ini terjadi perbaikan di keseluruhan waktu layanan. Terutama Waktu Tunggu Farmasi dan Waktu Layanan Farmasi membaik.

Plan	Menyampaikan hasil evaluasi ke programmer PT Disa Prima Medika
Do	Koordinasi dengan unit terkait dan factor yang mempengaruhi.hasil dari identifikasi programmer
Study	Data rekap bulan sebelumnya yang menjadi acuan dalam perbandingan perbaikan.
Action	1. Menghubungi programmer 2. Monitoring evaluasi 3. Lakukan Tindak lanjut sesuai hasil Monev

NO	Jenis	Target	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Sumber antrian melalui mobile JKN	30%	46,43%	47.64%	49.61%	50.19%	48.42%	48.20%	Belum ada feedback
2	Capaian pemanfaatan antrian (onsite dan online Mobile JKN)	>90%	95.11%	94.28%	92.04%	94.61%	94.20%	94.36%	Belum ada feedback

Analisis :
Pemanfaatan antrian online sudah mencapai target yang disyaratkan (>30%) dan (>90%)

Plan	Mempertahankan hasil > 30% dan meningkatkan untuk kinerja di bulan selanjutnya
Do	Sosialisasi ke unit terkait
Study	Data bulan-bulan sebelumnya sebagai acuan dari data yang sudah diperbaiki
Action	1. Memanfaatkan aplikasi https://dataviz.bpjs-kesehatan.go.id/ untuk monitoring 2. Monitoring evaluasi <i>feedback</i> 3. Supervisi kabid

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada

3.2.1 Bidang Pelayanan Dan Keperawatan

NO	UNIT	PENGEMBANGAN PELAYANAN	PROGRESS PENGEMBANGAN	KENDALA
BIDANG PELAYANAN DAN KEPERAWATAN				
1	IRNA	Coaching terkait flebitis	Supervisi berjalan koordinasi dengan PPI	Supervisi harus dipertahankan agar unit disiplin dalam pelaporan dan penecegahan kasus flebitis

2	Komite keperawatan	Restrukturisasi komite keperawatan	Struktur komkep yang baru sudah terbentuk	Program terkait kredensial perawat PK3 dengan melibatkan pemateri DPJP sudah di list berdasarkan asuhan keperawatan PK3. Dan akan ada master of master masing-masing askep, misalnya pernafasan, balance cairan& elektrolit dll.
3	IRJA	Poli Eksekutif promo paket MCU	Ada 2 promo paket MCU IPD dr Aji, SpPD dan dr Zora, SpPD	Pasien saraf sakura IPD ada 2, anak 7, obgyn 9. Jumlah tersebut turun dari bulan kemarin. Target bulan Agustus aka nada promo kemerdekaan untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien obgyn. Dengan promo USG Sakura Rp. 200.000
		ERM Loadingan	Pasien loadingan sudah mulai menggunakan ERM pada minggu terakhir bulan Juli	Untuk SPRI dari poli masih ditemukan GCS yang belum terisi, koordinasi dengan programmer agar dapat dimunculkan di fitur cetak
4	IGD	Fitur Copy WA	Fitur Copy WA memudahkan dokter IGD untuk konsul ke DPJP tanpa harus mengetik ulang	Dengan mengakses dan menekan tombol fitur di pengkajian medis IGD, maka teks dapat langsung di copy dan dikonsulkan ke dpjp via WA

		Kendali mutu dan biaya tiap diagnosis koordinasi dokter igd dan dokter casemix	Kendali mutu dan biaya tiap diagnosis diawali dengan diagnosis Anemia. Mulai dari pengenalan bagan sampai pembacaan retikulosit darah dan resources diagnose tersebut jika ada diagnose sekunder yang lain	Dokter IGD lebih paham bahwa resources anemia, tidak hanya hematemesis melena dengan plafon sedikit dan potensi minus. Sehingga banyak variasi diagnose yang mungkin bisa muncul dan dijadikan diagnose bandingnya
		Perakitan form loadingan anestesi regional dan general tidak boleh dirakit menjadi satu	Perakitan DRM sudah berjalan , koordinasi dengan kains RM.	Masih ditemukan adanya perakitan dobel di unit IGD, karena termasuk rakitan lama. Segera di TL
		Pelayanan IGD cepat, tanggap, dan respect. Skill dokter meningkat	Dokter IGD dapat melakukan Tindakan secara mandiri, terutama untuk Tindakan kegawatan di IGD	Dokter IGD sudah melakukan Tindakan ekstraksi kuku, pasang dan lepas kateter, intubasi secara mandiri
		Pelayanan IGD cepat, tanggap, dan respect. Skill dokter meningkat	Dokter IGD dapat melakukan Tindakan secara mandiri, terutama untuk Tindakan kegawatan di IGD	Dokter IGD sudah melakukan Tindakan ekstraksi kuku, pasang dan lepas kateter, intubasi secara mandiri
5	NICU	ERM bayi hanya bisa pada pengkajian awal medis anak	ERM pasien bayi dari ibu post partum (rawat gabung), masih menggunakan DRM manual	Progress ERM untuk bayi segera di TL

3.2.2 Bidang Penunjang

NO	UNIT	PENGEMBANGAN PELAYANAN	PROGRESS PENGEMBANGAN	KENDALA
INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT				
1.	Depo Farmasi	1. KPO Elektronik (E-KPO)	a. Penulisan KPO (Kartu Pengambilan Obat) menulis manual sehingga memperlama waktu tunggu obat rawat jalan. b. Pengajuan form penambahan fitur E-KPO ke programmer yaitu data obat di print	Dalam antrian progamer

			dengan printer thermal kemudian di tempel ke KPO pasien. c. DPJP bisa mengakses e-KPO di SIMRS. d. Jumlah KPO tertinggal : 126. e. Belum tersedia printer thermal untuk cetak e-KPO.	
		2. Perbaikan sistem ROP Depo Farmasi dan Gudang Farmasi	a. Melakukan evaluasi dan perbaikan rumus serta sistem permintaan barang dari depo ke Gudang Farmasi melalui rumus ROP. b. Melakukan evaluasi dan perbaikan rumus serta sistem permintaan pembelian Gudang Farmasi melalui rumus ROP. c. Fitur sisa stok depo pada sistem ROP sudah tersedia.	Monitoring dan evaluasi rumus ROP yang sudah ada
		3. Renovasi ruang Pencampuran Obat (LAF) sesuai standart	a. Renovasi Pencampuran Obat (LAF) sesuai standart selesai tanggal 20/03/2025, ruangan steril dilapisi vinyl dan monitoring tekanan ruangan dengan magnehelic dan dicatat pada spreadsheet. b. Form pengajuan penambahan 1 unit Laminar Air Flow (LAF) untuk dispensing sediaan steril dan 1 unit pass-box air lock untuk tempat masuk dan keluarnya alat kesehatan dan bahan obat sebelum dan sesudah dilakukan pencampuran. <i>Pass box</i> ini terletak di antara ruang persiapan dan ruang steril. Form sudah masuk ke Pengadaan PT. Disa Prima Medika.	Follow up form pengajuan LAF dan pass-box air lock
		4. Perluasan ruang Depo Farmasi sesuai standart	a. Pengajuan perluasan ruangan di depo farmasi untuk penggantian lemari pendingin yaitu penyimpanan obat ke lemari pendingin yang lebih besar dan vaksin	Koordinasi dengan kepala bidang terkait rencana lokasi penyimpanan showcase 2 pintu (785 liter) dan <i>vaccine refrigerator</i> .

			di letakkan dalam <i>vaccine refrigerator</i> disertai Log tag. b. Perluasan ruang buffer stok 6 Maret 2025, sudah tersedia cctv dan smart door lock.	
		5. Website PRIMANTARA	a. Presentasi MOCKUP oleh Programmer PT sudah dilakukan pada tanggal 23/09/2024. b. Presentasi MOCKUP oleh Vendor pada tanggal 20/12/2024, notulen sudah masuk ke PT, menunggu ACC Pendaftaran pasien PRIMANTARA ke farmasi masih menggunakan kertas manual. c. Belum ada fitur jasa pengiriman obat (Primantara) ke rumah pasien di SIMRS dan diperlukan penanda di resep bahwa obat dikirim serta diperlukan marking agar terdapat penanda bahwa obat telah disiapkan.	Permintaan dihold menunggu kenaikan pasien PRIMANTARA. Monitoring dan Evaluasi
		6. Jasa pengantaran obat	a. Pendataan pasien masih menggunakan google spreadsheet dan kitir manual, belum ada fitur yang bridging dengan SIMRS sebagai penanda resep bahwa obat dikirim serta diperlukan marking agar terdapat penanda bahwa obat sudah siap. b. Promo Lifetime diskon 50% untuk pengguna baru berjalan mulai Bulan Desember 2024. c. Subsidi promo untuk obat tertinggal menggunakan pengantaran gratis. d. Perubahan alur pembayaran PRIMANTARA di kasir sudah dilakukan pada tanggal 08/01/2025.	Pendataan secara manual, belum bridging dengan SIMRS. Sementara menggunakan spreadsheet dan perubahan alur pembayaran di Kasir.
		7. Rencana pemisahan penyiapan obat kronis dan non kronis	a. Sudah dilakukan pemisahan penyiapan obat kronis dan non kronis namun masih terkendala tenaga TTK	Pengajuan fitur ke progamer.

		kurang (jika ada staf yang sakit). b. Meminimalisir waktu tunggu pasien non kronis dengan obat yang tidak banyak. c. Masih ada komplain pasien terkait waktu tunggu. d. Belum ada fitur pemisahan resep masuk kronis dan non kronis.	
	8. Pengambilan obat dengan TTD elektronik	a. TTD elektronik pengambilan obat rawat jalan sudah berjalan dan memudahkan untuk mengecek retriaksi kelengkapan obat kronis, namun terkendala pada jaringan yang lemah. b. TTD elektronik pengambilan obat IGD rawat jalan dan pasien rawat inap pulang masih belum bisa dan tahap koordinasi dengan progamer.	Dalam antrian progamer. Monitoring dan evaluasi sistem elektronik.
	9. Pelayanan retriaksi obat kronis: penambahan fitur Centang "Perlu Hasil Penunjang Lab dan Hasil Pemeriksaan Lab dimunculkan saat DPJP input e-resep; Hasil Pemeriksaan Lab di Fitur Penjualan Farmasi	Pengajuan form penambahan fitur agar DPJP input resep dan penjaminan pelayanan obat bagi peserta JKN sesuai dengan ketentuan retriaksi dan/atau peresepan maksimal obat, memudahkan Farmasi mengecek kesesuaian hasil penunjang dan obat yang diresepkan sesuai retriaksi obat kronis.	Pengajuan fitur ke progamer.
	10. Penambahan fitur laporan berkas obat kronis, laporan resep iter, dan laporan reep PRB di SIMRS	Pengajuan form penambahan fitur laporan di SIMRS yaitu : a. Format laporan berkas obat kronis, berisi : nomor, tanggal registrasi, no. registrasi, no. rm, nama pasien, unit asal, nama dokter, no. sep, nama obat, hasil pemeriksaan penunjang. Tujuan untuk memudahkan farmasi melihat kelengkapan berkas klaim obat kronis yaitu Resep, SEP, Hasil	Pengajuan fitur ke progamer.

			Pemeriksaan Penunjang b. Format laporan resep iter, berisi : nomor, tanggal kunjungan, nama pasien, no. rm, no. kartu, no. SEP, unit asal, nama dokter, jumlah iter, nama obat, aturan pakai, jumlah obat, tanggal kunjungan berikutnya, status iter (terlayani/ belum). Tujuan untuk memudahkan farmasi, verifikator, DPJP untuk melihat laporan resep iter dan target iter. c. Format laporan resep PRB, berisi : nomor, nama dokter, tanggal kunjungan, nama pasien, no. rm, no. kartu, no. SEP, alamat, no. telp, diagnosa PRB, asal FKTP perujuk, asal SRB (FKTL/RS), nama obat, aturan pakai, jumlah obat. Tujuan untuk memudahkan farmasi, verifikator, DPJP untuk melihat laporan resep PRB dan target PRB.	
		11. Penambahan fitur warning di SIMRS DPJP "Pasien tidak ambil obat"	Pengajuan form penambahan fitur warning di SIMRS DPJP "Pasien tidak ambil obat" untuk mengurangi retur obat tertinggal.	Pengajuan fitur ke progamer.
2.	Gudang Farmasi	1. Pengembangan fitur scan barcode gudang farmasi dan depo farmasi untuk pemasukan dan pengeluaran stok.	a. Proposal scan barcode sudah diajukan ke PT pada tanggal 01/10/2024. b. Sudah dilakukan presentasi pada tanggal 04/10/2024. c. Pendataan master barcode sudah diserahkan ke Programmer PT. Tindak lanjut untuk barang yang tidak memiliki barcode yaitu dibuatkan barcode internal oleh progamer. d. Alat scanner barcode, barcode printer, thermal paper sudah tersedia pada tanggal 16/11/2024.	Rencana trial menunggu Programmer PT

			e. Software aplikasi barcode dalam tahap dikerjakan oleh progamer.	
		2. Perluasan Gudang Farmasi	a. Perluasan Gudang Farmasi di Lantai 2, karena pallet buffer sudah tidak cukup. b. Pengajuan katrol untuk penurunan buffer dari lantai 2.	Sudah berjalan. Follow up pengadaan katrol.
3.	Floorstok IKO	Perbaiki sistem penyimpanan floorstok IKO	Progres perbaikan Floorstok IKO tahun 2023 : a. Tanggal 03 Januari 2023 dilakukan rapat koordinasi floorstok IKO dengan perawat IKO dan progamer terkait sistem floorstok IKO yaitu : - Tidak adanya petugas farmasi khusus IKO sehingga monitoring stok di IKO tidak berjalan → Pengajuan petugas farmasi di IKO. - Perubahan alur dari depo iko ke floorstok IKO. - Karu IKO menentukan obat dan BMHP yang dimasukkan dalam list floorstok. - Perbaikan alur floorstok iko ke depo farmasi. - List barang yang masuk dalam kategori floorstok dan jumlahnya. - List barang yang masuk dalam kategori BMHP. - Penggunaan BMHP yang diambil dari Gudang Farmasi apakah perlu di inputkan tindakan dan ditagihkan ke pasien → Konsul dengan keuangan PT terkait tagihan BMHP yang digunakan IKO. - Koordinasi dengan karu IKO	Monitoring dan Evaluasi.

			penentuan barang sharing dose. - Konsul dengan keuangan PT terkait tagihan pasien untuk penggunaan obat maupun alkes sharing. - Konsul dengan programmer terkait alur penginputan sharing dose. b. Tanggal 17 Maret 2023 dilakukan sosialisasi alur floorstok IKO oleh progamer yaitu : - Alur input obat dan bmhp oleh perawat IKO di SIMRS → perawat menulis resep manual – barang disiapkan, kemudian input resep setelah operasi sesuai yang terpakai. - Alur permintaan floorstok iko ke depo farmasi oleh perawat IKO di SIMRS. - Alur release stok oleh depo farmasi di SIMRS. - Alur minta barang BMHP IKO ke gudang farmasi oleh perawat di SIMRS. c. SPO alur Pelayanan Sediaan Farmasi Sistem Floorstock Di Instalasi Kamar Operasi terbit tanggal 24 Maret 2023. d. Tanggal 03 April 2023 dilakukan rapat evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO dan programmer terkait sistem floorstok IKO yaitu : - Petugas IKO ditemukan salah memilih unit tujuan saat input permintaan sehingga dapat menyebabkan selisih stok → Petugas IKO	
--	--	--	---	--

			diharap lebih teliti dalam melakukan inputan permintaan (memperhatikan tujuan permintaan BMHP ke Gudang dan permintaan barang floorstok ke depo farmasi). - Melakukan double check oleh petugas farmasi, apabila IKO salah input permintaan maka konfirmasi ke petugas IKO untuk revisi inputan sesuai tujuan permintaan - Pembuatan SPO alur floorstok iko. - Jumlah stok di sistem Floorstok IKO bisa sampai minus → Pengajuan ke programmer untuk stok sistem di lock hanya sampai angka 0 (tidak sampai minus). - Penetapan alur bmhp IKO bahwa list bmhp yang sudah disetor ke keuangan PT dimasukkan dalam paket tindakan operasi sehingga tidak perawat tidak input ke pasien. e. Tanggal 08 Mei 2023 dilakukan rapat evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO dan programmer terkait sistem floorstok IKO yaitu : - Terdapat stok yang tidak sesuai antara kartu stok, jumlah fisik, dan jumlah sistem. Stok sistem belum di lock. Dengan adanya penyesuaian item dan jumlah floorstok di IKO sehingga terdapat stok yang kelebihan dan atau kurang → Melakukan stok	
--	--	--	---	--

			opname floorstok IKO. Mengajukan pemutihan stok IKO untuk penyesuaian dengan kesepakatan jumlah floorstok terbaru. Kelebihan dan atau kekurangan stok dibuatkan berita acara untuk penyesuaian stok. Progres perbaikan Floorstok IKO tahun 2024 : a. Fitur Floorstok unit IKO sudah tersedia dan sudah dijalankan. b. Fitur minta barang floor stock sudah tersedia dan sudah dijalankan. c. Sistem stok IKO sudah dikunci. d. Ada petugas farmasi di IKO untuk monitoring stok. e. Tanggal 15 Juli 2024 dilakukan rapat evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO, Kabid Penunjang, Kabid Keperawatan yaitu : - Ditemukan input permintaan FS menggunakan tipe trans "farmasi" bukan fitur "floor stok unit" sehingga terjadi kelebihan barang yang tidak sesuai jumlah FS, dikarenakan barang yang dikirimkan ada yang kurang dari yang dimintakan. Hal ini terjadi dikarenakan selisih stok di IKO di sistem stoknya tidak ada namun fisiknya ada sehingga staf farmasi yang diiko tidak mencatat di barang menipis sehingga tidak disiapkan permintaan FS ketika malam hari	
--	--	--	--	--

			karena secara fisik stoknya masih ada → Menyamakan persepsi antara permintaan FS dengan permintaan hutang input ke pasien. Jika staf farmasi melakukan random stok dan ditemukan selisih stok lebih disistem maka akan konfirmasi ke perawat untuk diinputkan ke pasien. Jika terdapat selisih stok fisik lebih dan stok simrs 0 maka farmasi mengecek stok yang ada didepo farmasi dan simrs depo farmasi. Jika stok simrs berlebih maka release stok ke iko. - Ditemukan perbedaan barang di resep manual dan inputan simrs, farmasi menuliskan apa yang ada diinputan resep, perawat iko mengambil barang namun tidak ada di tulisan resep manual hari itu → Farmasi melakukan double cek resep manual dan inputan simrs jika ada yang belum diinputkan maka akan di stabilo di resep manual dan resep diserahkan ke perawat untuk diinputkan kembali. Resep akan dibedakan, untuk resep yang belum selesai diinput akan ada didekat komputer iko. Untuk resep yang sudah diinput akan ditaruh dikeranjang di lemari obat. f. Tanggal 15 Juli 2024 dilakukan rapat	
--	--	--	---	--

			evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO, Kabid Penunjang, Kabid Keperawatan yaitu : - Konsinyasi implant IKO belum di lock → dilakukan stok opname. Data diberikan ke progamer agar dilakukan penyesuaian stok. Programmer langsung merubah dan sistem di lock. - Perubahan alur penyiapan obat dan bmhp operasi → perawat input resep sesuai advice DPJP – farmasi menyiapkan – jika ada barang yang tidak terpakai maka di retur penjualan. g. Revisi SPO : - SPO Pelayanan Kefarmasian Di Instalasi Kamar Operasi terbit tanggal 12 November 2024. - SPO Permintaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Instalasi Kamar Operasi Kepada Instalasi Farmasi. h. Tersedia alur penggunaan sediaan sharing dose. Contoh : Isonest. i. Menggunakan tabel penggunaan obat sharing dose. j. Ada petugas farmasi di IKO	
Instalasi Rekam Medis				
1.	Rekam Medis	1. Mengaplikasikan E-RM (IRJA dan IRNA).	a. Sudah terealisasi E-RM Rawat Jalan IGD dan IRJA. Rehab sudah berjalan mulai tanggal 01-05-2024. IRNA dalam proses tahap akhir, target pada Bulan Juni 2025. b. Melakukan pendataan fitur yang dibutuhkan pada SIMRS, lalu	Kurang sinkron antara fitur perawat dan rekam medis, seperti : TTD tidak terisi, belum muncul pengkajian fisioterapis di fitur rekam medis. Permasalahan E-RM dan layanan Poli yang belum masuk E-RM sudah disampaikan kepada Programmer PT sekaligus flow chart.

			diserahkan kepada Programmer PT.	
		2. Penggunaan ERM Rawat Inap	a. Kolaborasi dengan Programmer PT. b. Melakukan trial pada awal Bulan Mei 2025.	Follow up. Monitoring dan Evaluasi.
		3. Kirim ke Satu Sehat untuk Pasien Rawat Jalan (Baik ERM ataupun Non ERM)	Pengiriman data ke satu sehat (untuk data kunjungan dan diagnosis) dilakukan setiap hari. Temuan dan TL : a. ERM yang belum lengkap dan valid. TL : Koordinasi dengan Tim Pendaftaran terkait identitas pasien yang tidak lengkap. b. Bayi baru lahir yang belum mempunyai NIK. TL : Kie ke keluarga pasien agar segera pengurusan KK. c. Pasien yang tidak membawa identitas dengan lengkap. TL : KIE ke keluarga pasien untuk mengirimkan identitas melalui chat WA.	Monitoring dan Evaluasi.
		4. Dokumentasi DRM lama.	a. Melakukan scanning form kedalam SIMRS. b. Tarikan data bisa diambil pada rekap kunjungan di SIMRS. c. Menunggu programmer membuat fitur scanning.	Koordinasi dengan Programmer. Pengajuan ke PT.
		5. Retensi DRM	a. Data DRM yang akan diretensi menunggu Programmer PT sebelum dilakukan pemilahan dan pemusnahan DRM. b. Pemusnahan terakhir dilakukan pada Tahun 2018.	Follow up Programmer PT.
		6. Rekap Data Laporan Dinkes	a. Data yang dibutuhkan tidak semua bisa ditarik oleh system. b. Pengajuan fitur ke Programmer PT. c. RM membuat Google Spreadsheet untuk diisi oleh unit-unit terkait setiap harinya.	Dalam Proses.

			d. Tujuannya untuk memudahkan Karu RM dalam pelaporan RL ke Dinkes tepat waktu.	
2.	Pendaftaran	1. Anjungan Pasien Mandiri.	a. Melakukan studi banding atau mencari informasi terkait penggunaan APM di RS lain. b. Membuat flowchart dan diajukan ke Programmer PT.	Dalam proses dan diajukan ke Program Kerja Tahun 2025.
		2. Penetapan petugas jaga.	Melakukan penetapan PJ disetiap divisi, Pendaftaran Central, CSO dan Pendaftaran IGD dengan personil tetap, dengan tujuan supaya petugas menguasai permasalahan dan fokus pelayanan, memudahkan telusur dan perbaikan jika ada komplain dan masalah.	PJ Pendaftaran Central : Tyas PJ Pendaftaran IGD : Riri Pendaftaran CSO : Shinta Bella
		3. Pendaftaran pasien	a. Reservasi pasien umum dan asuransi melalui web, disertai pembayaran melalui VA. b. Kolaborasi dengan IT dan SIMRS.	Proses mengerjakan TOR
Instalasi Radiologi				
1.	Radiologi	1. Menambahkan fitur hasil radiologi di SIMRS supaya hasil JPEG dapat diakses.	Sudah dirapatkan dengan Programmer untuk dibuatkan fitur tersendiri.	Dalam antrian programmer.
		2. Menambah jam pelayanan supaya pelayanan maksimal.	Melakukan close recruitmen untuk mengisi jam kosong pada siang hari.	Surat pemberitahuan kebutuhan Sp.Rad sudah diterima oleh Ketua Kolegium.
		3. Respon Time Radiologi	Kolaborasi dengan perawat untuk melakukan pencatatan di Google Spreadsheet secara real time.	Mulai dijalankan awal Tahun 2024.
Instalasi Laboratorium				
1.	Laboratorium	1. Pengadaan LIS.	a. Hardware sudah terpasang di Laboratorium. b. Software proses dikerjakan oleh Programmer dan Vendor.	Dalam antrian programmer.
		2. Stok Opname BDRS	BDRS berjalan mulai 29 November 2024.	SO akan dilakukan Pada hari Sabtu, 22 Maret 2025.
		3. Penambahan fitur	a. Penambahan fitur upload hasil laboratorium rujukan dari luar RS. b. Penambahan fitur centang otomatis hasil pemeriksaan yang	Dalam antrian Programmer PT.

			abnormal, batas atas dan batas bawah sudah dicatat dan diajukan ke Programmer PT.	
Instalasi Gizi dan Dapur				
1.	Gizi	1. Pengaktifan Poli Gizi di Rawat Jalan/MCU Gizi.	a. Kolaborasi dengan Humas&Marketing. b. Kolaborasi dengan pelayanan antar obat (PRIMANTARA), free MCU Gizi.	Monitoring dan evaluasi setiap bulan.
		2. Prima Healthy Meal.	Sudah pengajuan TOR ke PT.	Menunggu ACC.
		3. Daftar Menu Makanan Penunggu VIP.	Book Menu sudah proses dikerjakan oleh PKRS.	Dalam proses.
		4. Registrasi alat makan	a. Kolaborasi dengan penyaji untuk melakukan pencatatan keluar masuknya sendok di Google Spreadsheet. b. Perbaikan alur saat mengambil peralatan makan di ruangan, jika ditemukan sendok hilang maka dicatat di Google Spreadsheet dan dioperkan ke perawat ruangan untuk ditagihkan ke saat pasien KRS. c. Dilakukan stok opname setiap bulan untuk menghitung peralatan makan. d. Membuat SPO Pengecekan Fasilitas RS Sebelum Pasien KRS.	Registrasi alat makan sudah berjalan sejak Bulan Januari 2024 Proses dibuatkan SPO kehilangan alat makan, penggantian biaya dilakukan di Kasir, jika tidak tertagihkan maka tanggungjawab unit bersama.
		5. Pemesanan diet melalui SIMRS	a. Memastikan proses pemesanan diet lebih efisien dan mengurangi kesalahan pemesanan diet dari DPJP ke perawat, perawat ke ahli gizi. b. Ahli gizi mengkonfirmasi diet di SIM-RS jika ada penambahan diet/ganti diet saat selesai visitasi di ruangan. c. Proses cetak label langsung efisien tanpa harus mengetik ulang dan tidak menulis manual di label. d. Koordinasi dengan bagian SIM-RS supaya segera di realisasikan ke unit.	Monitoring dan evaluasi.
		6. QC sesuai sistem HACCP	a. Pelatihan HACCP dilakukan oleh seluruh Ahli Gizi.	Menunggu jadwal pelatihan.

			b. Memastikan proses quality control makanan sesuai standar. c. Memastikan 7 prinsip HACCP. d. Koordinasi dengan SDM jika ada informasi terkait pelatihan tersebut.	
2.	Dapur	1. Perbaikan menu makanan dan plating.	a. Sudah dilakukan supervisi oleh Direktur Utama PT DPM pada hari Senin, 18 November 2024. b. Kebijakan penggunaan alat makan dan SPO plating sudah dibuatkan sebagai pedoman penyaji dalam melakukan pekerjaan.	Monitoring dan Evaluasi. Revisi tampilan sedang diproses oleh PKRS (Eriko).
		2. Menu makanan buka puasa senin-kamis.	Program PT berjalan mulai tanggal 09 Desember 2024. Yang sudah disiapkan : a. Daftar siklus menu makanan. b. SPO pemesanan makanan buka puasa (+). c. Link google form untuk pemesanan (+). d. Kebijakan pemesanan makanan hari H maksimal pukul 06.00 WIB.	Monitoring dan Evaluasi.
3.	Pantry	Food Waste	Perbaikan pencatatan sisa makanan berdasarkan menu makanan untuk mengetahui makanan yang kurang diminati.	Monitoring dan Evaluasi
Instalasi CSSD dan Laundry				
1.	CSSD	1. Mengajukan mesin sterilikator (steam plasma).	Belum terealisasi.	Monitoring dan evaluasi permintaan sterilisasi alat semi critical sesuai kebutuhan sterilisasi instrument bedah syaraf.
		2. Perbaikan serah terima menggunakan digital form.	Sudah berjalan di Bulan Juli 2024.	a. Kolom tidak terisi lengkap. b. Monitoring Evaluasi oleh Karu dan Kabid.
		3. Perbaikan jam kerja	Pelayanan mulai pukul 06.30-21.00 WIB, jika ada alat yang akan disetor diatas jam pelayanan maka dilakukan pre-cleaning di unit masing-masing.	Berjalan per Bulan Desember 2024. Monitoring Evaluasi oleh Karu dan Kabid.
2.	Laundry	1. Mengajukan mesin cuci industry dengan kapasitas 30kg.	Belum terealisasi.	Monitoring dan evaluasi penggunaan mesin cuci industry utama.
		2. Membuat digital form untuk	a. Rencana permintaan sehari 2 kali oleh unit sesuai dengan	Berjawal awal Tahun 2025.

		permintaan linen.	kebutuhan.	
			b. Belum terealisasi.	
		3. Pengadaan Bedcover untuk pasien VIP dan LINEN IKO.	Rencana diajukan ulang dengan melampirkan keluhan pasien VIP, kerusakan linen IKO.	Linen IKO dan VIP sudah diproses. Selimut VIP sudah diajukan.
		4. Perbaikan jam kerja	Pelayanan ada 3 shift, shift malam dimulai pukul 22.00-04.00 WIB tanpa jam istirahat, dan memenuhi stok di unit.	Berjalan per Bulan Desember 2024.
Lain-lain				
1.	Lain-lain	1. Rapat Bulanan masing-masing Unit dengan Kabid.	Dilakukan per Bulan November 2024. Supervisi pemahaman pelaksana tentang pedoman pelayanan, pengorganisasian, dan pelayanan sesuai dengan akreditasi. Pelaksanaan : c. Tanya Jawab d. Role Play	1. RM dan Pendaftaran Hari : Senin, 14-07-2025. Waktu : 13.00 WIB sd selesai. Tempat : Hall Sakura Lt 5 (Yang berhalangan hadir menggunakan Zoom). 2. Farmasi Hari : Selasa, 15-07-2025. Waktu : 13.00 WIB sd selesai Tempat : Hall Sakura Lt 5 (Yang berhalangan hadir menggunakan Zoom) 3. Gizi Hari : Rabu, 16-07-2025 Waktu : 11.00 WIB sd selesai Tempat : Lokasi Dinas (Yang berhalangan hadir menggunakan Zoom) 4. Laboratorium Hari : Kamis, 17-07-2025 Waktu : 14.00 WIB sd selesai Tempat : Lokasi Dinas (Yang berhalangan hadir menggunakan Zoom) 5. Radiologi Hari : Jum'at, 18-07-2025

				Waktu : 14.00 WIB sd selesai Tempat : Lokasi Dinas (Yang berhalangan hadir menggunakan Zoom) 6. CSSD dan Laundry Hari : Sabtu, 19- 06-2025 Waktu : 13.00 WIB sd selesai Tempat : Laundry (Yang berhalangan hadir menggunakan Zoom) 7. Rapat All Karu Penunjang Hari : Sabtu, 26- 07-2025 Waktu : 13.00 WIB sd selesai Tempat : Ruang Direktur RS
--	--	--	--	--

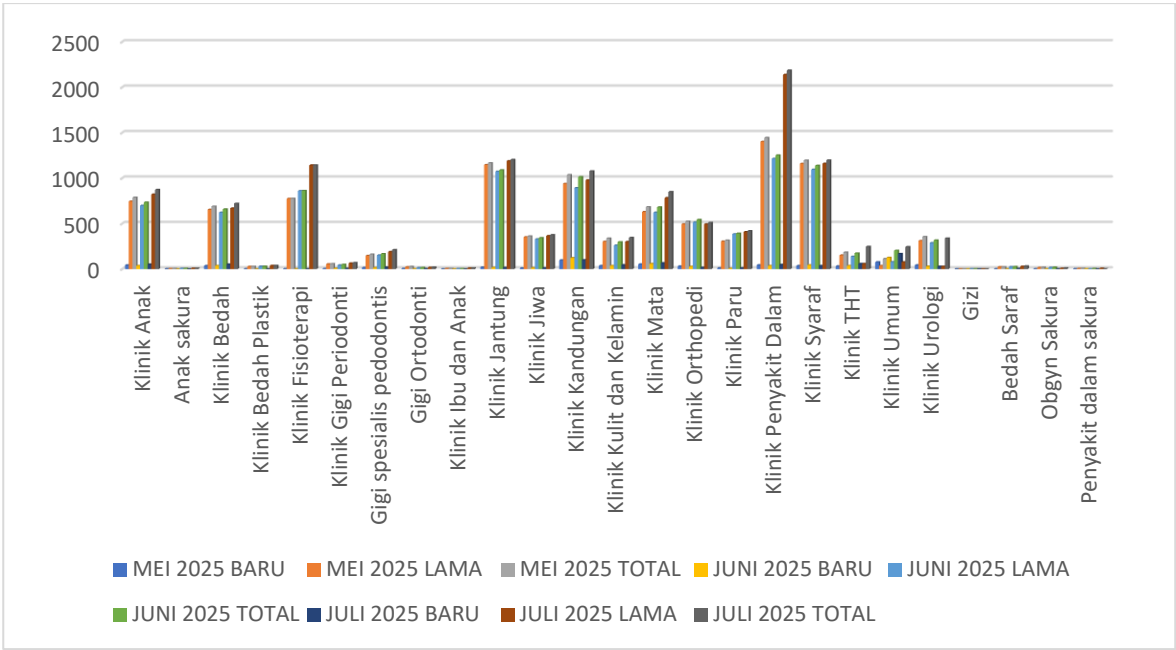
3.3 Kinerja Bidang Pelayanan

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik

3.3.1.1 Kunjungan Pasien Lama dan Baru

NO	NAMA UNIT	MEI 2025			JUNI 2025			JULI 2025		
		BARU	LAMA	TOTAL	BARU	LAMA	TOTAL	BARU	LAMA	TOTAL
1	Klinik Anak	42	745	787	36	697	733	51	821	872
2	Anak sakura	1	3	4	0	6	6	0	7	7
3	Klinik Bedah	35	654	689	36	622	658	52	668	720
4	Klinik Bedah Plastik	1	26	27	0	29	29	0	37	37
5	Klinik Fisioterapi	1	774	775	1	860	861	1	1142	1143
6	Klinik Gigi Periodonti	3	54	57	7	42	49	6	63	69
7	Gigi spesialis pedodontis	15	146	161	14	152	166	20	190	210
8	Gigi Ortodonti	4	22	26	2	13	15	3	16	19
9	Klinik Ibu dan Anak	0	4	4	0	3	3	0	9	9
10	Klinik Jantung	19	1147	1166	16	1073	1089	14	1189	1.203
11	Klinik Jiwa	9	352	361	13	329	342	10	365	375
12	Klinik Kandungan	97	939	1036	122	892	1014	99	978	1.077
13	Klinik Kulit dan Kelamin	35	302	337	36	260	296	45	300	345
14	Klinik Mata	53	629	682	58	622	680	66	783	849
15	Klinik Orthopedi	30	494	524	27	515	542	16	494	510
16	Klinik Paru	10	304	314	6	385	391	10	408	418
17	Klinik Penyakit Dalam	43	1402	1445	36	1215	1251	47	2139	2186
18	Klinik Syaraf	35	1160	1195	44	1095	1139	36	1161	1197
19	Klinik THT	32	151	183	36	137	173	58	58	246
20	Klinik Umum	76	36	112	125	78	203	167	77	244

21	Klinik Urologi	43	311	354	29	287	316	28	28	337
22	Gizi	0	0	0	0	1	1	0	0	0
23	Bedah Saraf	1	22	23	1	24	25	4	28	32
24	Obgyn Sakura	2	15	17	2	16	18	2	7	9
25	Penyakit dalam sakura	1	4	5	2	2	4	0	7	2
Total		847	10237	11084	935	9961	10896	1051	12017	13068



Analisis :

1. Kunjungan pasien rawat jalan Juni ke Juli 2025 mengalami kenaikan secara keseluruhan sebesar 20%
2. Kunjungan tertinggi : Poli Penyakit Dalam dengan kunjungan 2186
3. Kenaikan tertinggi : Poli Penyakit Dalam dengan persentase 75%
4. Penurunan tertinggi : Poli Obgyn Sakura dengan persentase 50%

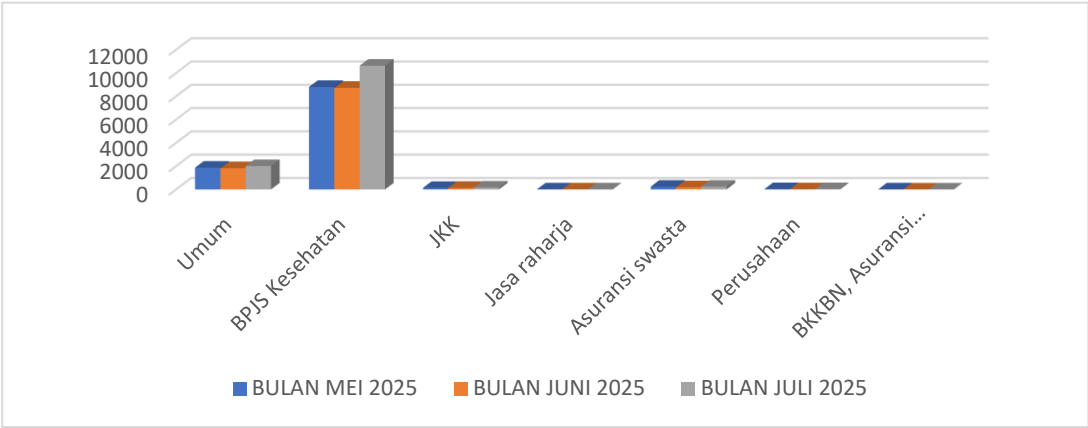
Rencana Tindak Lanjut :

1. Koordinasi dengan pendaftaran penjangkaran pasien umum dan asuransi untuk memperkenalkan pelayanan poli Sakura
2. Menginformasikan kepada seluruh unit rawat inap wajib edukasi saat krs untuk pasien umum,asuransi tentang pelayanan poli Sakura
3. Memisahkan pasien BPJS dengan pasien non BPJS. Pasien Non BPJS di daftarkan di poli Sakura.
4. Koordinasi dengan Humas dan Marketing untuk penjangkaran asuransi dan perusahaan.
5. Sosialisasi pada faskes dengan pelayanan baru yang ada di rumah sakit prima husada
6. Koordinasi dengan humas marketing untuk rutin menampilkan promo di media sosial
7. Koordinasi dengan pendaftaran untuk sellau menanyakan pasien yang mendaftar apakah memiliki asuransi komersil.

1.3.1.2 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran

NO	STATUS PEMBAYARAN	BULAN MEI 2025	%	BULAN JUNI 2025	%	BULAN JULI 2025	%
1	Umum	1872	16,89%	1825	16,75%	2010	15,38%
2	BPJS Kesehatan	8804	79,43%	8728	80,10%	10625	81,30%
3	JKK	134	1,21%	136	1,25%	165	1,26%
4	Jasa raharja	7	0,06%	7	0,06%	3	0,02%
5	Asuransi swasta	237	2,14%	188	1,73%	237	1,81%
6	Perusahaan	28	0,25%	12	0,11%	28	0,22%
7	BKKBN, Asuransi Pemerintah	2	0,02%	0	0	0	0
	Total	11084	100%	10896	100%	13068	100%

1.3.1.2.1 Grafik Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran



- Analisis :**
- 1. Kunjungan dengan cara bayar umum mengalami kenaikan 9.20%
 - 2. Kunjungan dengan cara bayar BPJS mengalami kenaikan 17.85%
 - 3. Kunjungan dengan cara bayar BPJS KETENAGAKERJAAN mengalami kenaikan 17.58%

Rencana Tindak Lanjut :
Untuk meningkatkan kunjungan pasien rawat jalan adalah dengan meningkatkan pelayanan terbaik serta berkoordinasi dengan marketing untuk melakukan kunjungan dan menawarkan beberapa pelayanan baru seperti poli sakura yang bisa bekerjasama dengan berbagai asuransi, poli bedah saraf dan poli gigi anak. bekerjasama dengan humas marketing terutama MCU haji dan vaksin internasional (meningitis, polio dan influenza)

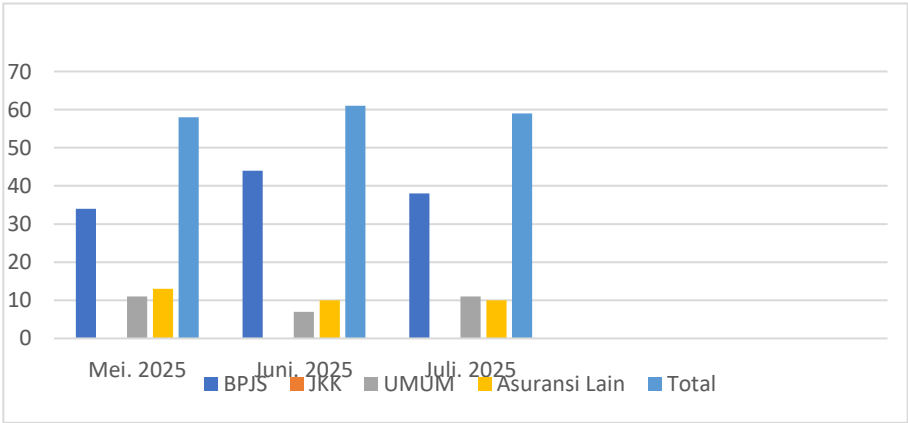
3.3.2 Rawat Inap

3.3.2.1 Kunjungan Rawat Inap 2C

3.1.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April - Juni 2025)

NO	HAL	MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	34	44	38	↓13,63%
2	JKK	0	0	0	100%
3	Umum	11	7	11	↑ 57,14%
4	Asuransi Lain	13	10	10	100%
Total Pasien		73	58	61	59

3.1.1.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Bayar (Mei - Juli 2025)



1.3.2.1.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

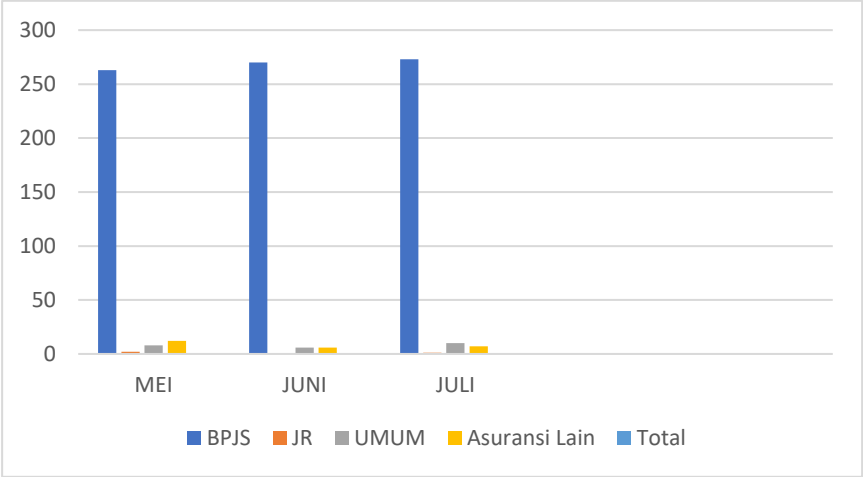
NO.	BULAN	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Juli 2025	38	11	0	10	59
	Analisa	Pasien BPJS bulan Juni mengalami penurunan lagi dibandingkan bulan mei	Pasien umum mengalami kenaikan di bulan JULI	Pasien JKK tidak ada	Untuk pasien asuransi bulan juli stabil sama dengan bulan juni	Total bulan April mengalami penurunan daripada bulan Juni
	RTL	Meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran, memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti baju pasien khusus VIP/VVIP dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap				

3.1.1.1 Kunjungan Rawat Inap 3C Anak

3.1.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Bayar (Mei – Juli 2025)

NO	HAL	MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	263	270	273	↑1%
2	JR	2	0	1	↑100%
3	Umum	8	6	10	↑40%
4	Asuransi Lain	1	6	7	↑14%
Total Pasien			274	282	291

3.1.1.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei - Juli 2025)



3.3.2.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

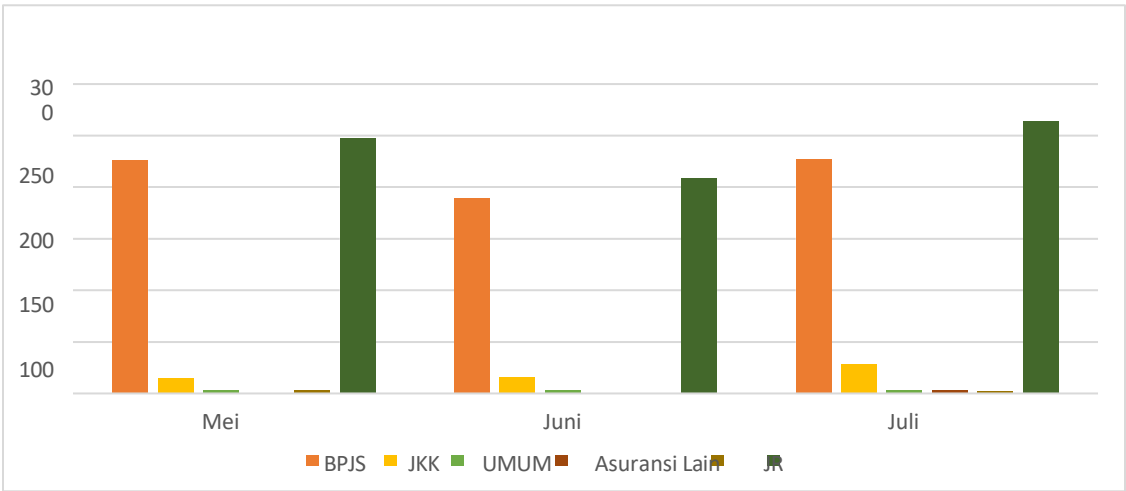
NO.	BULAN JULI 2025	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JR	ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS ada kenaikan selama 3 bulan terakhir pada bulan Juli 2025 mengalami Peningkatan 1% dikarenakan liburan pasca sekolah menyebabkan banyak anak2 tumbang dan mengalami demam	Pasien Umum mengalami peningkatan di bulan juli sebanyak 40% Dikarenakan pasien sudah memiliki BPJS semua	Pasien JR dari 3 bulan terakhir mengalami kenaikan di bulan Juli sebanyak 100% Dikarenaka KLL kebanyakan tunggal dan jatuh sendiri	Pasien Asuransi mengalami kenaikan 14% di bulan Juli Karena rata-rata Sebagian pasien BPJS sudah memiliki asuransi	Peningkatan jumlah pasien selama 3 bulan terakhir banyak terjadi di bulan juli peningkatan di setiap bulannya yaitu 291
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Mempromosikan RS prima Husada Melalui media Sosial				

3.1.1.2 Kunjungan Rawat Inap 2,3,4 A

3.1.1.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei - Juli 2025)

NO	HAL	MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	226	190	227	↑ 19,47 %
2	JKK	15	16	29	↑ 81,25 %
3	Umum	3	3	3	↑ 100 %
4	Asuransi Lain	1	0	3	↑ 100 %
5	JR	3	0	2	↑100 %
Total Pasien		248	209	264	↑ 26,31 %

3.1.1.2.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei – Juli 2025)



3.1.1.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

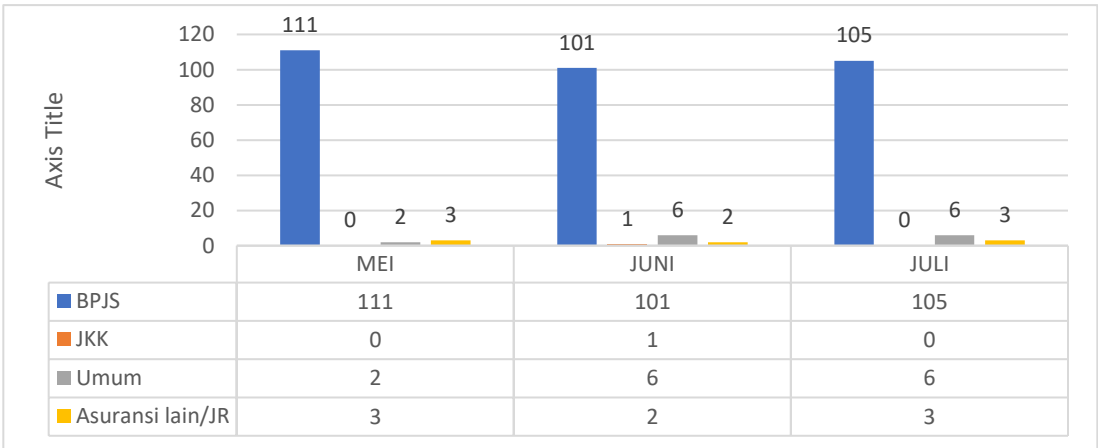
NO.	BULAN JULI	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian Juli 2025	Pasien BPJS mengalami peningkatan pada bulan Juli 2025 yaitu sebanyak 227 pasien	Pasien Umum sama di bulan Juli 2025 yaitu sebanyak 3 pasien	Pasien JKK mengalami peningkatan pada bulan Juli 2025 yaitu sebanyak 29 pasien	Pasien JR mengalami peningkatan pada bulan Juli 2025 yaitu sebanyak 2 pasien dan Pasien Asuransi mengalami peningkatan pada bulan Juli	Peningkatan jumlah pasien terjadi di bulan Juli 2025 dengan jumlah pasien
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif				

3.1.1.3 Kunjungan Rawat Inap 5C

3.1.1.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei - Juli 2025)

NO	HAL	MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	111	101	105	↑3,80%
2	JKK	0	1	0	↓100%
3	Umum	2	6	6	0%
4	Asuransi Lain	3	2	3	↑33%
Total Pasien		116	110	114	↑3,50%

3.1.1.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei - Juli 2025)



3.1.1.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN JULI	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANS I	
1	Analisis capaian Juli 2025	Total Pasien BPJS mengalami kenaikan	Total Pasien Umum sama dengan jumlah	Pasien JKK tidak mengalami penurunan	Pasien Asuransi / JR mengalami peningkatan	Pada bulan Juli untuk total kunjungan pasien

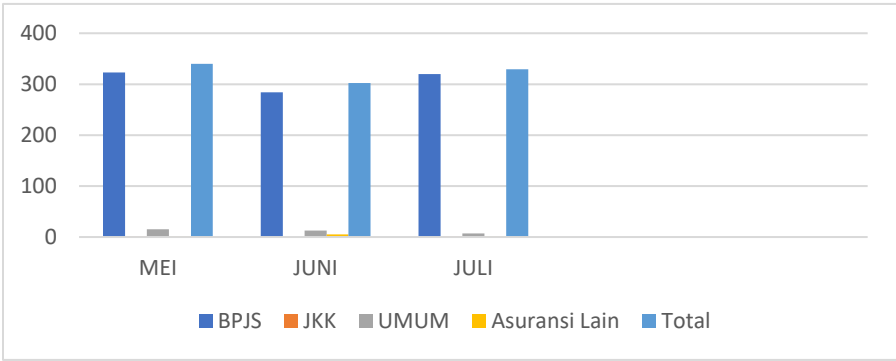
		sebanyak ↑3,80% dari bulan sebelumnya	kunjungan bulan sebelumnya	maupun peningkatan ↓100% dari bulan sebelumnya.	sebanyak ↑33% dari bulan sebelumnya	mengalami Peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar ↑3,50%
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya				

3.1.1.4 Kunjungan Rawat Inap 6, 7, 8 A

3.1.1.4.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei - Juli 2025)

NO	PENJAMIN	MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	323	284	320	↑11,25%
2	JKK	1	0	1	↓100%
3	Umum	15	13	7	↓46%
4	Asuransi Lain	1	5	1	↑28,7%
Total Pasien		340	302	329	↑8,2%

3.1.1.4.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei - Juli 2025)



3.1.1.4.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

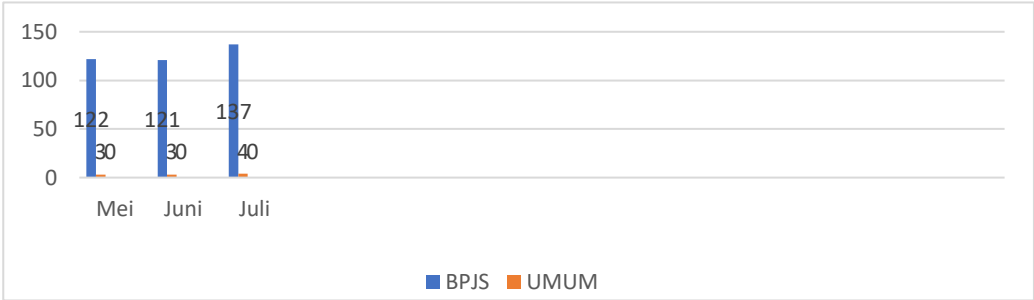
NO.	BULAN JUNI	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis pencapaian jumlah pasien 3 bulan terakhir	Pasien BPJS mengalami terjadi penurunan pada bulan Juni 2025 yaitu sebanyak 284 pasien	Pasien Umum mengalami penurnan pada bulan Juli 2025 yaitu sebanyak 7 pasien	Terdapat 1 pasien JKK pada bulan Juli 2025	Jumlah pasien Asuransi / JR mengalami peningkatan pada bulan Juni 2025	Penurunan jumlah pasien selama 3 bulan terakhir banyak pada bulan Juni dengan jumlah pasien sebanyak 302 pasien.
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Meningkatkan MOU dengan perusahaan				

3.1.1.5 Kunjungan Rawat Inap Maternitas

3.1.1.5.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei – Juli 2025)

NO	HAL	MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	122	121	137	↑11,67%
2	Umum	2	3	4	↑25%
3	Asuransi	0	0	0	0%
Total Pasien		124	124	143	↑13,28%

3.1.1.5.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei - Juli 2025)



3.1.1.1.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

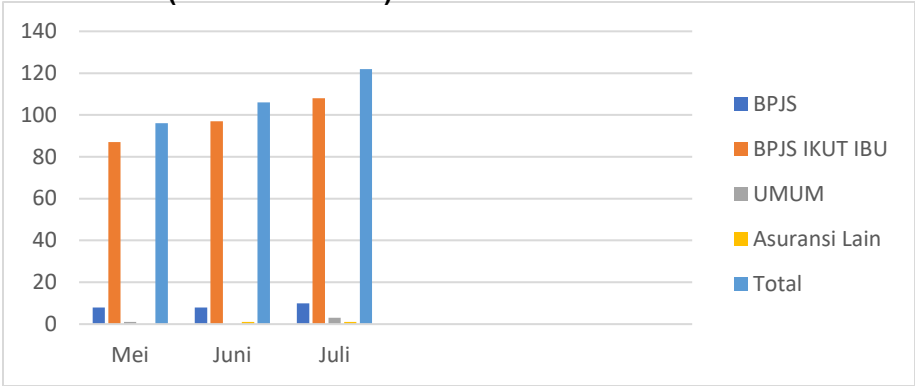
NO	BULAN JUNI	RAWAT INAP			KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian Bulan Mei - Juli	Pasien BPJS pada bulan Juni mengalami kenaikan 11,67%	Pasien umum pada bulan Juni mengalami kenaikan 25 %	Tidak ada pasien asuransi di bulan Juli	Kunjungan naik dengan bulan sebelumnya. Tetap melakukan Upaya peningkatan dan evaluasi program telusur sederhana
2	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan	Meningkatkan pelayanan serta koordinasi dengan tim IGD	

3.1.1.2 Kunjungan Rawat Inap Neonatologi

3.3.2.7.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei - Juli 2025)

NO	HAL	TARGET/BULAN	MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	7	8	8	10	↑1,64%
2	Umum	2	1	0	3	↑2,46%
3	Asuransi Lain	1	0	1	1	↑5,7%
4	BPJS IKUT IBU	100	87	97	108	↑90.2%
Total Pasien		110	96	106	122	↑15,09%

1.3.2.7.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei - Juli 2025)



3.3.2.7.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

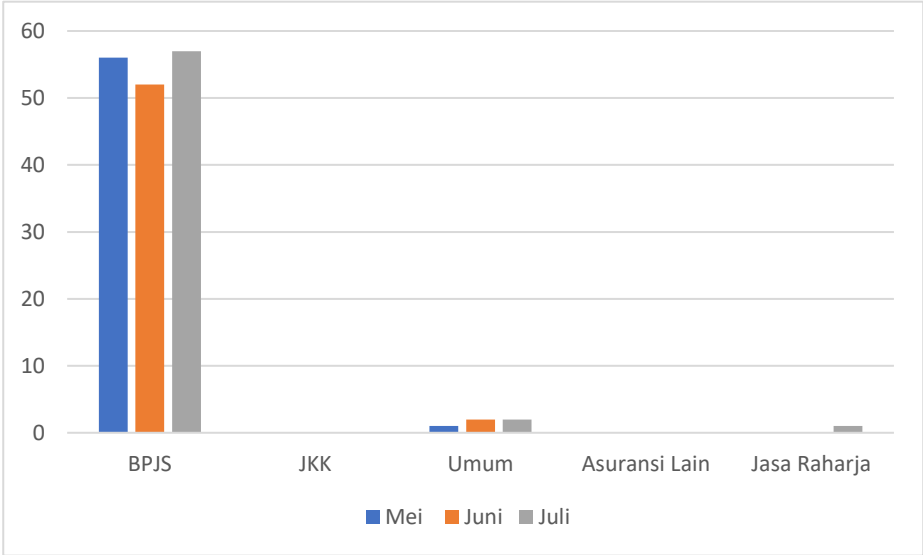
NO.	BULAN	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	ASURANSI	BPJS IKUT IBU	TOTAL PASIEN
1	Juli 2025	10	3	1	108	122
	Analisa	Untuk pasien BPJS mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 1,64%	Untuk pasien Umum mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 2,46%	ada 1 pasien asuransi	Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami kenaikan 90,2%	
	RTL	Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Bekerjasama dengan IGD untuk promosi kesehatan	Meningkatkan pelayanan khususnya pada pasien bayi baru lahir, Koordinasi dengan tim Maternitas dan poli untuk promosi Kesehatan ibu dan bayi melalui senam hamil.	

3.1.2 Intensive Care Unit (ICU)

3.1.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei - Juli 2025)

NO	PENJAMIN	MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	56	52	57	↑9,61%
2	JKK	0	0	0	tetap
3	Umum	1	2	2	tetap
4	Asuransi Lain	0	0	0	tetap
5	JR	0	0	1	↑100%
Total Pasien		57	54	60	↑11,11%

3.1.1.1 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei - Juli 2025)



3.1.1.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

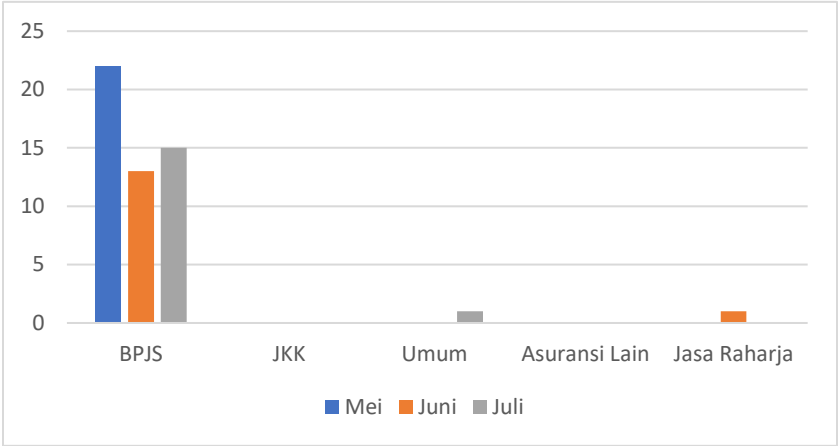
NO.	BULAN JUNI	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan juni 2025 mengalami penurunan 7,80% dibandingkan bulan sebelumnya	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan bulan juni mengalami peningkatan 100% 2025 di bandingkan bulan dengan bulan sebelumnya	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir tidak ada pasien 0	Pasien JR/ Asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan Juli 2025 tidak ada kunjungan sama dengan bulan sebelumnya	Kunjungan pasien rawat inap ICU RS Prima Husada mengalami kenaikan sebesar 11,11% dibandingkan dari bulan sebelumnya karena pasien yang perawatan di ruang ICU adalah sebagian pasien jantung
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama ICU 3. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 4. Menerima pasien dari IGD dengan cepat 5. Meningkatkan kualitas SDM yang ada di ICU				

3.1.2 High Care Unit (HCU)

3.1.2.2 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei - Juli 2025)

NO	HAL	MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	22	13	15	↑13,3%
2	JKK	0	0	0	Tetap
3	Umum	0	0	1	↑100%
4	Asuransi Lain	0	0	0	Tetap
5	JR	0	1	0	↓100%
Total Pasien		22	14	16	↑12,5%

3.1.1.1 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei - Juli 2025)



3.1.2.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

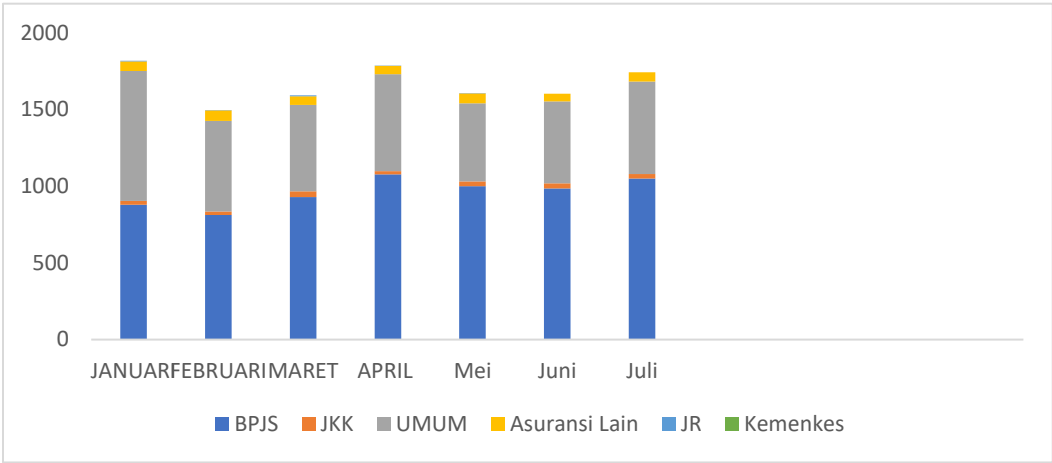
NO.	BULAN JUNI	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil, untuk bulan juli 2025 mengalami kenaikan di bandingkan bulan lalu	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan juli 2025 sama seperti bulan sebelumnya	Tidak ada pasien JKK selama 3 bulan	Pasien JR/ Asuransi bulan Juli 2025 tidak ada pasien	Kunjungan pasien rawat inap HCU RS Prima Husada mengalami peningkatan sebesar 12,5% dari bulan sebelumnya
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama HICU 3. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 4. Menerima pasien dari IGD dengan cepat				

3.1.3 Instalasi Gawat Darurat (IGD)

3.1.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei - Juli 2025)

NO	HAL	MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	1.000	987	1050	↑6 %
2	JKK	509	533	603	↑ 11,6 %
3	Umum	32	33	30	↓ 30 %
4	Asuransi Lain	64	50	61	↑ 18,03%
5	JR	2	0	0	0%
Total Pasien			1.607	1.625	1.744

3.1.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei - Juli 2025)



3.1.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

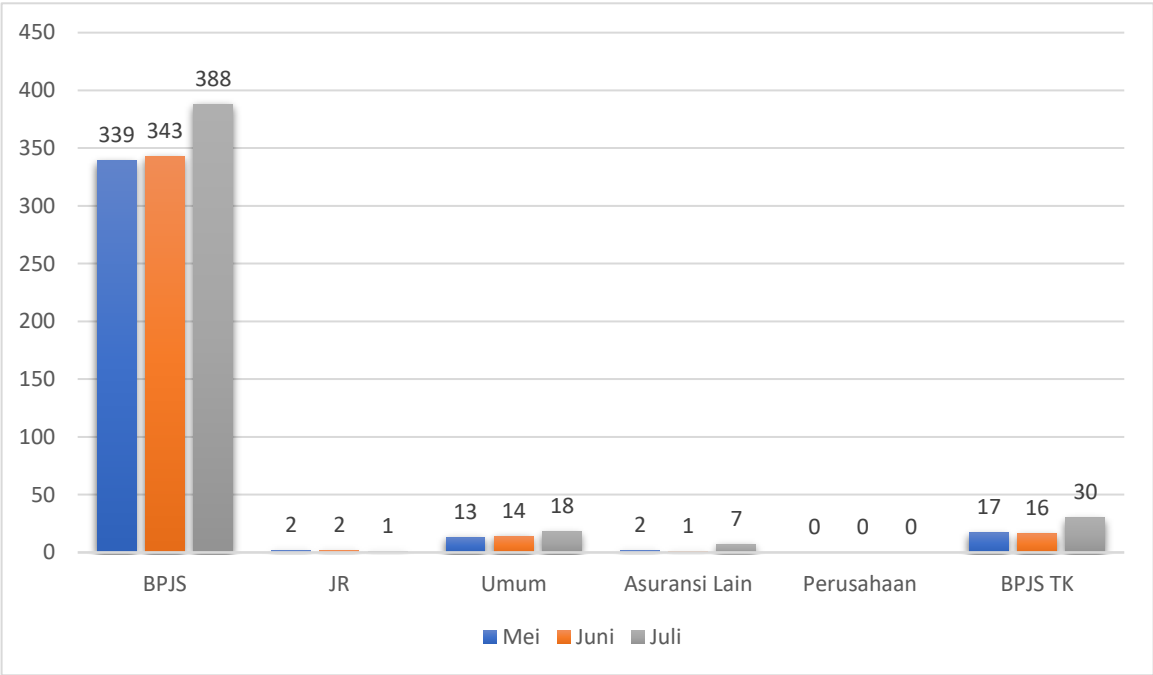
NO.	BULAN JULI 2025	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis	Kunjungan pasien BPJS dari bulan Juni ke Juli mengalami peningkatan ↑ 6 %	Kunjungan pasien UMUM dari bulan Juni ke Juli mengalami peningkatan ↑ 11,6 %	Kunjungan pasien dengan jaminan JKK bulan Juni ke Juli mengalami penurunan ↓ 30 %	Kunjungan pasien dengan jaminan Asuransi lain dari bulan Juni ke Juli mengalami peningkatan ↑ 18,03%	Kunjungan pasien dengan jaminan JR dari bulan Juni ke Juli mengalami penurunan 0 %
2	RTL	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan pasien BPJS IGD bekerjasama dengan marketing untuk menambah kerja sama dengan beberapa faskes I area kabupaten Malang	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan jaminan UMUM dengan memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan maksimal	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan jaminan JKK dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan beberapa Perusahaan Kabupaten Malang	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan Asuransi swasta IGD bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan asuransi	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan JR IGD bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan asuransi

3.1.4 Instalasi Kamar Operasi (IKO)

3.1.4.1 Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (Mei - Juli 2025)

NO	HAL	MEI 2025				JUNI 2025				JULI 2025			
		k	s	b	kh	k	s	b	kh	k	s	b	kh
1	BPJS	46	1	257	35	52	4	265	22	51	6	297	34
2	JR	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	1	0
3	Umum	2	0	8	3	2	0	11	1	2	0	14	2
4	Asuransi Lain	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	2	4
5	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BPJS TK	0	0	0	17	0	0	1	15	0	0	4	26
	Total Pasien	373				376				444			

3.1.4.2 Grafik Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin
(Mei - Juli 2025)



3.1.4.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN JULI	IKO					KESIMPULAN
		BPJS	BPJS TK	UMUM	PERUSAHAAN	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir pasien operasi yang menggunakan BPJS meningkat dari bulan sebelumnya	Pasien BPJS TK dalam 3 bulan operasi belum stabil untuk bpjs TK meningkat untuk bulan juli di bandingkan bulan sebelumnya	Pasien Umum operasi dalam 3 bulan mengalami peningkatan	Pasien perusahaan dalam 3 bulan terakhir stagnan tidak ada operasi selama 3 bulan terakhir	Pasien Asuransi / JR dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk juni 2025 mengalami peningkatan di bandingkan bulan sebeleumnya	Total pasien untuk bulan juli 2025 meningkat ↑ 18.08% di bandingkan bulan sebelumnya
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya dan mengurangi pasien IDO sehingga pasien puas dengan pelayanan operasi di prima husada 2. Berkoordinasi dengan bagian marketing untuk ekspos ruangan IKO yang sudah di ganti vinyl 3. Mengikuti pelatihan yang terbaru sehingga menunjang pelayanan yang terbaik di IKO 4. Berkoordinasi dengan humas marketing,terutama kunjungan ke perusahaan-perusahaan dan psc untuk mengirim ke prima husada malang 5. mengirimkan pelatihan asisten bedah saraf 6. Memberikan edukasi yang bagus untuk pasien pasien operasi					

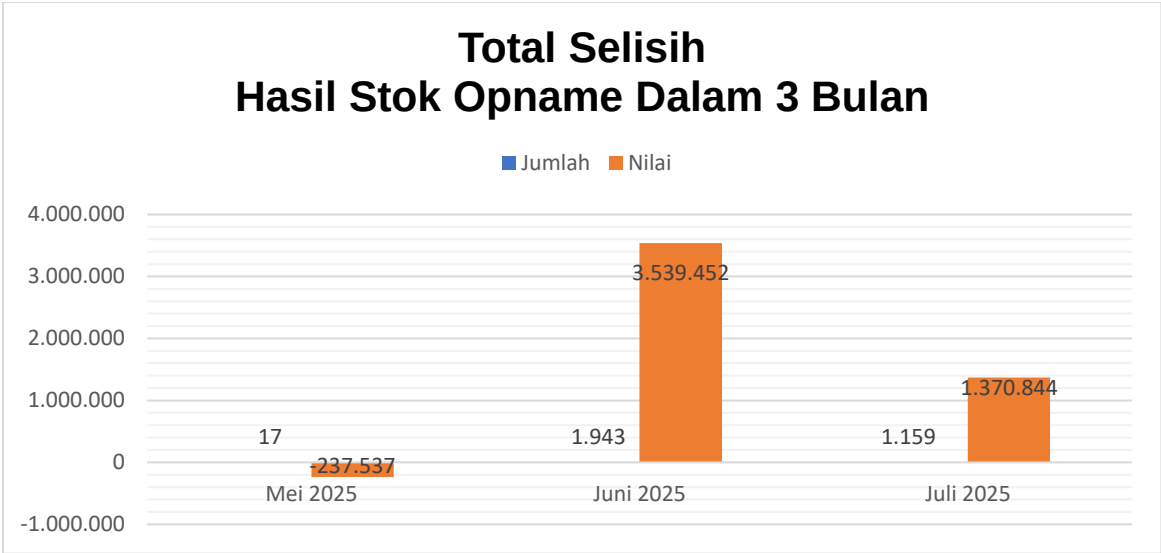
3.2 Kinerja Bidang Penunjang

3.2.1 Instalasi Farmasi

3.2.1.1 Tabel Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Mei - Juli 2025

UNIT	STOK	MEI 2025		JUNI 2025		JULI 2025	
		JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI
GUDANG	Fisik	925.158	1.698.286.012	1.026.778	1.713.691.456	781.394	1.348.925.757
	Sistem	925.120	1.697.960.945	1.026.751	1.713.581.456	781.394	1.348.925.757
	Selisih	38	+325.067	26	0	0	0
DEPO FARMASI	Fisik	242.327	721.442.047	296.141	744.906.778	185.996	594.215.843
	Sistem	242.338	721.932.977	294.212	739.557.458	184.837	592.844.999
	Selisih	11	-490.932	1.917	+3.539.452	1.159	1.370.844
IKO	Fisik	2.301	91.020.298	2.504	95.918.212	2.270	86.545.010
	Sistem	2.311	91.091.969	2.496	95.775.965	2.270	86.545.010
	Selisih	10	-71.672	0	0	0	0
Total Selisih		-237.537	-237.537	1.943	+3.539.452	1.159	+1.370.844

3.2.1.2 Grafik Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Mei - Juli 2025



3.2.1.3 Analisis dan Tindak Lanjut

NO	ANALISIS	RENCANA TINDAK LANJUT
Gudang Farmasi : Dari tabel 3.1 tampak bahwa hasil stok opname mencapai target (0). Analisa :		
1	Penandaan nama pada rak sudah tertata dan kartu stok sudah berjalan	Supervisi secara berkala
Depo Farmasi : Dari tabel 3.1 tampak bahwa hasil stok opname masih sangat jauh dari target (0) yaitu sebesar +Rp 5.349.316 , hal ini disebabkan karena :		
1	F00911 BD Micro Fine Pen Needle 32G x 4MM selisih lebih 56 karena ditemukan di laci meja KIE sehingga tidak terhitung saat stok opname juni 2025.	1. Menegur petugas dan dilakukan pemahaman kembali terkait penyimpanan yang tidak sesuai untuk menghindari stok tidak terhitung. 2. Supervisi oleh kains farmasi terkait penyimpanan yang tidak sesuai.
2	Terdapat selisih minus dikarenakan petugas tidak menambahkan di lembar kerja saat menyiapkan permintaan IGD menggunakan resep manual, kemudian resep disimpan pukul 22.08 setelah SO, seperti : F01972 Spalk 70 X 10 X 8 cm (Te-70) = -4	Meningkatkan ketelitian petugas saat perhitungan SO dan validasi ulang oleh pj input setelah verifikasi SO.
3	Kesalahan dalam perhitungan buffer stok tidak terhitung saat stok opname bulan Juni 2025 : F00628 Prednison Tab 5 mg – Triman = +226 F04501 Santagesik Inj 500 mg/2ml – Sanbe = +81	1. Perbaikan penataan ulang buffer stok sesuai rak di ruang buffer stok (sesuai alfabetis dan penggolongan obat). 2. Penambahan lemari buffer stok di ruang buffer agar buffer tidak di tumpuk di dalam kardus

4	Ketidaksesuaian dalam proses INPUT (tidak menulis perubahan jumlah di resep) dan SIAP menyebabkan kesalahan dalam jumlah obat yang disiapkan, yang seharusnya dapat dihindari dengan melakukan double check dengan penerima obat.	- Double check wajib di lakukan dengan alur kerja ISEP obat yang sudah di tentukan - Supervisi oleh kains farmasi terkait penyiapan obat hingga alur penyerahan secara berkala - Monitoring dan evaluasi oleh kaid Jangmed terkait dengan proses Input hingga penyerahan obat. ☐ jika ada kesalahan dalam proses langsung di tegur dan langsung diperbaiki
5	Ketidaksesuaian antara barang yang diambil perawat IGD menggunakan resep manual dengan inputan resep di SIMRS, seperti : F00413 Ketorolac Inj 30 mg 1 ml - Hexpharm Jaya = -12 F00567 Omeprazole Inj 40 Mg - Ogb Dexta = -2 F04639 Ondansetron Inj 4 mg/2 ml - Hexpharm Jaya = +2 F00996 Blood Transfusi Set – Otsuka = -2 F04514 Cairan Inf NS 0.9% 500 ml – Satoria = +5 F00222 Combivent 25 ml Udv – Boehringer = +3 F00659 Ranitidine Inj 50mg/2ml - Hexpharm Jaya = -1	- Penegasan kembali kepada perawat IGD terkait kewajiban penulisan resep yang sesuai ☐ kolaborasi dengan Karu IGD. - Petugas farmasi wajib double crosscheck sebelum obat atau BMHP di serahkan ☐ supervisi oleh kains farmasi. - Perbaikan alur resep akan diarsipkan oleh Petugas Farmasi dan dilakukan double crosscheck, jika ada yang belum terinput maka akan dishare di Grup dan meminta bukti inputan.
6	Ketidaksesuaian antara inputan resep dan barang yang diberikan disebabkan perbedaan nama barang sama namun beda pabrik atau beda ukuran yang digunakan, seperti: F00425 Lafalos Cr 20 G – Sanbe = -11 F00426 Lafalos Cr Plus 20 G – Sanbe = +10 F00481 Methylprednisolone Inj 125 Mg/2 ml – Mahakam = -14 F00480 Methylprednisolone Inj 125 Mg/2 ml – Phapros = +14	- Memperbaiki sistem pengeluaran barang dari gudang ketika ada nama barang sama namun beda pabrik dengan memastikan stok depo dihabiskan terlebih dahulu sebelum dinonaktifkan. - Sosialisasi kepada perawat perbaikan fitur pencarian dalam SIMRS untuk meningkatkan akurasi pemilihan barang. - Memperbaiki sistem penyiapan barang bertanggungjawab atas input penjualan.
7	Selisih lebih terjadi karena proses retur ODD harian yang tidak optimal dari rawat inap (Resep ODD harian tidak diinput retur di SIMRS oleh perawat IRNA sementara pasien sudah KRS).	- Dilakukan pemahaman kembali proses return sesuai alur dan dilakukan supervisi berkala oleh Karu IRNA dan PJ Shift ruangan untuk mengontrol terkait proses return ke farmasi sesuai dengan alur yang sudah di sepakati - Melakukan double crosscheck oleh petugas farmasi saat akan melakukan return di supervisi setiap hari oleh kains farmasi - Melakukan audit dan evaluasi berkala oleh Kaid keperawatan dan Kaid penunjang terkait obat-obatan yang belum terreturn sesuai dengan alur
IKO : Dari tabel 3.1 tampak bahwa hasil stok opname mencapai target (0). Analisa :		
1	Perawat patuh melakukan input resep; retur penjualan barang yang tidak terpakai sudah rutin dilakukan; tidak ada anomali data di SIMRS	Supervisi secara berkala

3.2.1.4 Tabel Daftar Obat-obat Near ED <6 bulan (Juli 2025 – Januari 2026)

No.	Kode	Nama Barang	Satuan	Harga Beli	Tgl. Expired	No. Batch	Jumlah Fisik Baik			Total Harga	Laporan Penjualan Mar 24 - Juli 25
							Mei	Juni	Juli		
1	F00030	Aminophylline inj 24 mg/ml - phapros	Amp	4.000	30/08/2025	66307030-1	11	7	7	28.000	256
2	F00726	Susuk kb II (levonorgestrel 75 mg)	Pcs	-	31/08/2025	0100017	15	15	15	0	0
3	F00228	Cotrimoxazole syr 240 mg/5 ml - mersi	Btl	2.773	30/09/2025	A21797	53	43	25	69.325	286
4	F01337	Dj stent 6 fr close end - medika	Pcs	280.000	30/09/2025	76122032	13	10	10	2.800.000	21
5	F01680	Nelaton cath no 12 - rusch	Pcs	16.500	30/09/2025	KMA2030441	1	1	1	16.500	1

6	F04623	Tobramycin eye drop 5 ml - ferron	Btl	15.856	30/09/2025	463091 0	20	43	18	285.408	92
7	F01400	Foley cath silicon no 8 - rusch	Pcs	222.00 0	30/10/2025	KMF20I 2362	4	5	5	1.110.0 00	5
8	F00586	Oxoferin sol 30 ml - pharos	Btl	80.500	30/10/2025	B3K953 C	7	7	6	483.000	11
9	F01390	Foley cath no 20 - rusch	Pcs	20.570	30/11/2025	P20L04	24	24	22	452.540	18
10	F00313	Flamar ed 5 ml - sanbe	Flash	40.550	30/12/2025	DM352 1	75	61	24	973.200	99
11	F01398	Foley cath silicon no 18 - rusch	Pcs	88.250	31/12/2025	KME21 A0960	1	1	1	88.250	0
12	F00606	Phenobarbital inj 50 mg/ml - phapros	Amp	1.532	31/12/2025	468030 02-2	8	8	5	7.660	41
13	F04476	Susu dancow full cream 780 g (hibah) - nestle	Box	0	01/01/2026	125780 64	74	74	57	0	63
TOTAL										6.313.8 83	

3.2.1.5 Analisis Obat Near ED < 6 bulan (Bulan Juli 2025 – Januari 2026)

No	Analisis	Tindak Lanjut
1	Rekap Near ED < 6 bulan (Bulan Juli 2025 – Januari 2026 karena obat dan alkes slow moving: 1. Aminophylline inj 24 mg/ml – phapros, untuk mengatasi serangan asma bronkial. Pembelian terakhir tanggal 27/11/2024 dari RS Prima Husada Sukorejo sejumlah 30 ampul. Penggunaan obat slow moving tapi termasuk obat emergency. 2. Susuk kb II (levonorgestrel 75 mg) diberikan untuk kontrasepsi. Penggunaan KB slow moving. Penerimaan hibah dari BKKBN dengan ed < 1 tahun pada tanggal 31/07/2024 sejumlah 16 pcs. 3. Cotrimoxazole syr 240 mg/5 ml – mersi untuk infeksi saluran nafas, kulit, saluran kemih dan kelain, gastrointestinal, infeksi THT. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 04/12/2024 dari distributor sejumlah 30 botol. 4. Dj stent 6 fr close end – medika dimasukkan ke dalam ureter untuk mencegah atau menangani penyumbatan aliran urine dari ginjal. Faktur pembelian terakhir tanggal 26/11/2024 dari distributor sejumlah 5 pcs. 5. Nelaton cath no 12 – rusch, digunakan untuk kateterisasi kandung kemih jangka pendek. 6. Tobramycin eye drop 5 ml – ferron, digunakan untuk mengatasi iritasi mata akibat infeksi bakteri. Faktur pembelian terakhir tanggal 18/02/2025 dari distributor sejumlah 40 botol, penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor. 7. Foley cath silicon no 8 – rusch dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urine. Penggunaan alkes slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 26/03/2024 dari distributor sejumlah 10 pcs. 8. Oxoferin sol 30 ml – pharos digunakan untuk luka terinfeksi, penyembuhan luka yang lambat sesudah traumatik atau sesudah operasi, ulkus decubitus, ulkus kaki kronis pada insufisiensi vena, ulkus dan luka akibat aliran darah arteri, ulkus diabetik, ganggren, luka bakar. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 27/02/2024 dari distributor sejumlah 3 botol. 9. Foley cath no 20 – rusch dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urine. Faktur pembelian terakhir tanggal 24/09/2024 dari distributor sejumlah 10 pcs. Penerimaan alkes dengan ed < 1 tahun dari distributor. 10. Flamar ed 5 ml – sanbe Mengatasi nyeri, bengkak, kemerahan, dan silau yang timbul setelah operasi mata, seperti operasi katarak atau lasik. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 20/02/2024 dari distributor sejumlah 72 flash. 11. Foley cath silicon no 18 – rusch dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urine. Penggunaan alkes slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 10/01/2025 dari distributor sejumlah 1 pc.	1. Sediaan farmasi near ED akan dilakukan koordinasi dengan PHS jika barang lebih berjalan di PHS akan diberikan ke PHS untuk lainnya akan dilakukan koordinasi dengan DPJP untuk peresepan. 2. Membuat surat edaran ke DPJP untuk meresepkan obat/ alkes yang near ed. 3. Koordinasi dengan karu untuk menggunakan alkes yang near ed. 4. Koordinasi dengan PT. DPM untuk melakukan retur ke distributor. 5. Koordinasi dengan DPJP obat yang <i>death moving</i> di <i>stop order</i> dan dikeluarkan dari Formularium RS.

	12. Phenobarbital inj 50 mg/ml – phapros untuk mengontrol dan meredakan kejang, serta sebagai obat penenang sebelum tindakan operasi dan untuk mengatasi insomnia. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 15/11/2023 dari distributor sejumlah 30 ampul. 13. Susu dancow full cream 780 g (hibah) – nestle, Penggunaan susu slow moving diberikan untuk pasien anak yang mengkonsumsi obat TB. Penerimaan hibah dari Dinkes Kabupaten Malang dengan ed < 1 tahun pada tanggal 16/10/2024 sejumlah 120 box.	
--	---	--

3.2.1.6 Managemen Resiko dan Aksi Mitigasi

No Risk	Divisi	Spesialis terkait	Pemilik Risk	Tipe Risk	Deskripsi Risk	Pengendalian yang sudah ada	Skor Risk Sebelumnya	Dampak	Kemungkinan	Status Perubahan Rating Risiko	Mitigasi yang sedang dijalankan	Target Penyelesaian	Target Skor Risk	Indikator Kunci Mitigasi	Rencana Review
1	Komite medik	Dokter/ Dokter spesialis	Pasien	Klinis	Kesalahan input e-resep	Kontrol dan supervisi	9	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	SPO penulisan dan input resep serta supervisi	Meninjau ulang setiap tahun terkait kompetensi dokter
2	IFRS	Apoteker/ TTK	Pasien	Klinis	Kesalahan penyiapan obat	Kontrol dan supervisi	14	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi serta pelatihan berkelanjutan	3 bulan - 6 bulan	6	SPO alur pelayanan resep rawat jalan dan resep pulang pasien rawat inap. Jumlah TTK/ apoteker terpenuhi sesuai dengan kebutuhan tenaga. Terdapat diklat dan motivasi kerja	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
3	IFRS	Apoteker/ TTK	Pasien	Klinis	Kesalahan penulisan pada etiket obat	Kontrol dan supervisi	7	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	Motivasi dan kinerja petugas meningkat. SPO penulisan etiket	Meninjau ulang kemampuan dan

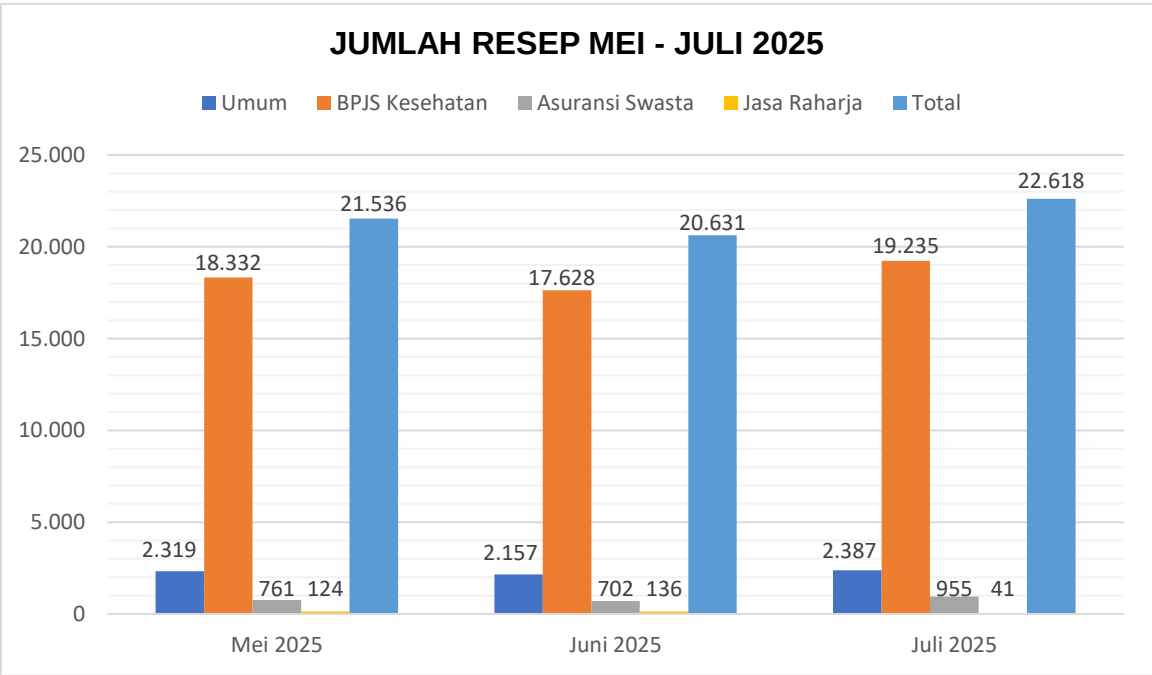
														di Instalasi Farmasi	kompetensi petugas
4	IFRS	Apoteker/ TTK	Pasien	Klinis	Obat tidak dilengkapi <i>expired date/ beyond use date</i>	Kontrol dan supervisi	7	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	Motivasi dan kinerja petugas meningkat. SPO penulisan etiket di Instalasi Farmasi	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
5	IFRS	Apoteker/ TTK	Pasien	Klinis	Kesalahan identifikasi pasien	Kontrol dan supervisi	5	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	2	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
6	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Kesalahan pemberian obat pada pasien	Kontrol dan supervisi	14	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	SPO telaah obat, SPO verifikasi pemberian obat rawat inap. Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
7	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Insiden kelebihan/ kekurangan penyerahan obat pada pasien rawat jalan	Kontrol dan supervisi	5	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	3	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
8	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Insiden kelebihan/ kekurangan penyerahan obat pada pasien rawat inap	Kontrol dan supervisi	3	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	2	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas

9	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Insiden reaksi alergi obat	Kontrol dan supervisi	11	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
10	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Insiden kesalahan dosis obat	Kontrol dan supervisi	8	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas

3.2.1.7 Tabel Jumlah Pelayanan Resep pada Bulan Juli 2025

No	Instalasi	Umum	BPJS Kesehatan	BPJS Ketenagakerjaan	Asurans i Swasta	Jasa Raharja	Total
1	Instalasi Rawat Inap						
	Jumlah Resep Obat Racikan	11	249	0	0	0	260
	Jumlah Resep Obat Jadi	441	7.970	7	424	22	8864
	Jumlah Resep Obat	452	8.219	7	424	22	9.124
2	IGD						
	Jumlah Resep Obat Racikan	46	32	0	0	0	78
	Jumlah Resep Obat Jadi	647	1680	3	136	11	2.477
	Jumlah Resep Obat	693	1.712	3	136	11	2.555
3	Instalasi Rawat Jalan						
	Jumlah Resep Obat Racikan	272	1.531	0	0	0	1.803
	Jumlah Resep Obat Jadi	926	6.781	0	285	2	7.994
	Jumlah Resep Obat	1.198	8.312	0	285	2	9.797
4	IKO						
	Jumlah Resep Obat Racikan	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Resep Obat Jadi	44	992	3	97	6	1.142
	Jumlah Resep Obat	44	992	3	97	6	1.142
TOTAL		2.387	19.235	13	942	41	22.618

3.2.1.8 Grafik Jumlah Pelayanan Resep pada Bulan Mei - Juli 2025



Analisis :

1. Kunjungan pasien Umum pada bulan Juli 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan Juni 2025, dengan total resep yaitu : bulan Juni 2025 sebanyak 2.157 resep umum dan bulan Juli 2025 sebanyak 2.387 resep umum.
2. Kunjungan pasien BPJS Kesehatan pada bulan Juli 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan Juni 2025, dengan total resep yaitu : bulan Juni 2025 sebanyak 17.628 resep BPJS Kesehatan dan bulan Juli 2025 sebanyak 19.235 resep BPJS Kesehatan.
3. Kunjungan pasien Asuransi Swasta dan Jasa Raharja pada bulan Juli 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan Juni 2025, dengan total resep yaitu : bulan Juni 2025 sebanyak 838 resep Asuransi Swasta dan Jasa Raharja, sedangkan bulan Juli 2025 sebanyak 1.036 resep Asuransi Swasta dan Jasa Raharja.
4. Secara keseluruhan total resep pada bulan Juli 2025 mengalami peningkatan tapi tidak signifikan, hal ini disebabkan untuk pasien rawat jalan adanya target PRB dimana pasien rujuk balik ke FKTP jika pasien sudah stabil, retur obat tertinggal rawat jalan yang tidak diambil pasien, kurangnya promo tarif vaksin di poli, kurangnya promo tarif poli sakura untuk poli lain, dan ada DPJP tidak praktek karena cuti; untuk pasien IGD ada batasan diagnosa yang tidak bisa di layani di FKRTL; untuk pasien rawat inap adanya batasan plafon BPJS Kesehatan sehingga tidak semua obat dapat di cover sesuai kebutuhan pasien dengan pertimbangan biaya obat.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Meningkatkan promosi tarif dan tindakan RS di sosial media RS agar kunjungan pasien meningkat.
2. Meningkatkan pelayanan resep yang tepat, cepat, dan akurat sehingga meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan di Farmasi. Evaluasi pelayanan ODD.
3. Mengajukan fitur cek hasil laboratorium dalam batas waktu 6 bulan dari IRNA dan IRJA untuk memudahkan pemberian obat sesuai dengan retriaksi yang ditentukan.
4. Menciptakan inovasi pengembangan pelayanan pengantaran obat dengan penambahan jumlah driver.
5. Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan. Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru dan obat tertinggal.
6. Perubahan alur distribusi obat, petugas melebur menjadi satu. Penambahan petugas shift malam supaya tidak terjadi lembur menyelesaikan obat rawat jalan.
7. Penambahan admin IKO untuk focus pada mutase barang di Floorstok IKO.

3.2.1.9 Tabel Hasil Kinerja Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Bulan Mei – Juli 2025

No	Kegiatan	Standard	Pencapaian			Keterangan
			Mei 25	Juni 25	Juli 25	
1	Pengkajian resep	100%	98.86%	98.61%	99.14%	Jumlah pengkajian resep yaitu Mei 2025 = 21.536 Juni 2025 = 20.631 Juli 2025 = 22.618 Jumlah ketidaklengkapan penulisan resep yaitu Mei 2025 = 246 Juni 2025 = 287 Juli 2025 = 195
2	Dispensing Sediaan Steril	100%	100%	100%	100%	Dispensing sediaan steril dilakukan oleh apoteker di ruang pencampuran obat steril.
3	Pemantauan Terapi Obat (PTO)	100%	100%	100%	100%	Form PTO sudah terlaksana dimana apoteker melakukan seleksi pasien berdasarkan kriteria PTO. Form PTO diletakkan dalam RM.
4	Kejadian Efek Samping Obat	0	0	0	0	Tidak ada kejadian pelaporan efek samping obat
5	Edukasi Obat pada pasien dan keluarga	100%	100%	100%	100%	Data berdasarkan rekam medis dan resep yang di ttd penerima obat
6	Konseling	100%	100%	100%	100%	Konseling sudah dilakukan apoteker dibuktikan dengan bukti edukasi di form edukasi (pasien rawat inap) dan ttd penerima obat di resep (pasien rawat jalan)
7	Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah	TDD	TDD	TDD	TDD	Tidak punya alat untuk pemantauan kadar obat dalam darah. TTD RS tipe C tidak wajib.
8	Visite Ronde Besar	100%	0%	0%	0%	Koordinasi dengan PPA (Professional Pemberi Asuhan) agar dilakukan visite ronde besar.
9	Visite Pasien/ Farmasi Klinik	100%	100%	100%	100%	Seluruh pasien rawat inap dilakukan visite mandiri dibuktikan dengan pengisian CPPT oleh apoteker di RM.
10	Pelayanan Informasi Obat (PIO)	100%	100%	100%	100%	Data berdasarkan map informasi obat, MIMS, aplikasi medscape
11	Obat tertinggal yang tidak diambil pasien	0	42	59	56	Obat tertinggal yang tidak diambil pasien dilakukan Penerimaan Hibah Lainnya ke gudang retur

3.2.1.10 Tabel Analisa dan Tindaklanjuti Hasil Kinerja Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada pada Bulan Juni 2025

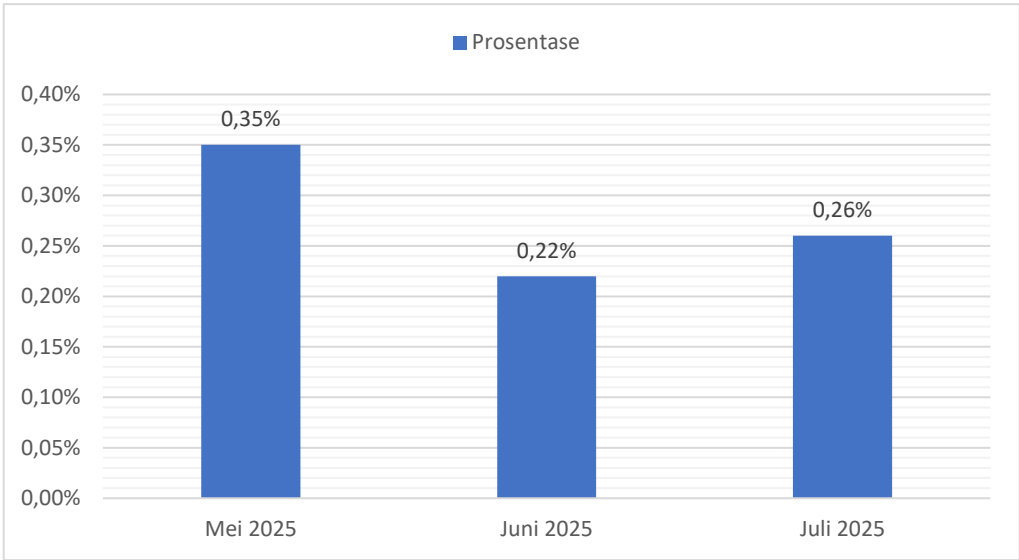
KINERJA	ANALISA	TINDAKLANJUT
Pengkajian Resep	Penulisan resep yang lengkap bulan Juli 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Juni 2025, dengan prosentase resep yang tidak lengkap yaitu : bulan Juni 2025 sebanyak 98.61% dan bulan Juli 2025 sebanyak 99.14%. Dari data di atas ditemukan pengkajian resep : 1. Dari segi telaah adminitrasi : sudah lengkap karena menggunakan e-resep melalui SIMRS. 2. Dari segi telaah farmasetik : masih ditemukan dokter salah input dosis dan jumlah obat, aturan dan cara penggunaan serta rute pemberian tidak lengkap terisi. 3. Dari segi telaah klinis : sudah terlaksana oleh Apoteker karena jika ada interaksi obat langsung diberi jeda pemberian obat oleh Apoteker.	1. Koordinasi dengan tim SIMRS untuk membuat sistem jika resep tidak terinput dengan lengkap maka resep tidak dapat masuk ke IFRS. 2. Inputan resep harus dilakukan oleh dokter/ dokter spesialis yang kompeten dan berwenang mulai dari identitas pasien, nama obat, dosis, rute pemberian, waktu pemberian, nama dan tandatangan dokter (untuk resep manual). 3. Pelatihan penulisan resep untuk semua dokter dan dokter spesialis.
Kejadian Efek Samping Obat	1. Hasil monitoring pelaporan MESO bulan Juli 2025 tidak ditemukan terjadinya efek samping obat. 2. Kurangnya pelaporan kejadian efek samping obat oleh tenaga kesehatan.	1. Kolaborasi dengan komite medik, kepala bidang keperawatan, kepala bidang pelayanan medis untuk sosialisasi pentingnya pelaporan kejadian efek samping obat, alergi obat, interaksi obat, dan ROTD oleh tenaga kesehatan. 2. Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dan Pemantauan Reaksi Obat Tidak Dikehendaki (ROTD) dilaksanakan secara kolaboratif antara dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, ditulis di dalam dokumen rekam medik pasien dan dilaporkan selambat - lambatnya 1 x 24 jam dalam bentuk laporan MESO dan dicatat dalam status pasien. 3. Mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki (ESO). 4. Mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami ESO. 5. Menganalisa laporan ESO. 6. Mengisi formulir ESO (lihat di lembar pelaporan ESO). 7. Melaporkan ke Tim MESO dan ROTD.
Edukasi Obat Pada Pasien dan Keluarga	1. Hasil supervisi dari rekam medis di rawat inap pada form edukasi bahwa apoteker sudah melakukan edukasi dibuktikan dengan ttd pasien/ keluarga di form edukasi. 2. Hasil supervisi dirawat jalan petugas farmasi sudah melakukan edukasi ke pasien dibuktikan dengan ttd penerima obat beserta KIE.	Supervisi berjenjang terkait pelaksanaan edukasi obat di rawat inap dan rawat jalan.
Pelayanan Informasi Obat (PIO)	PPA dapat mengakses Map informasi obat berisi : daftar dosis maksimal prorenata (jika perlu), daftar obat automatic stop order, daftar obat high alert update, daftar obat resiko jatuh, informasi cara pengenceran obat, informasi pembatasan resep, tabel rekonstitusi untuk pemberian intravena; MIMS; aplikasi Medscape di Nurse Station atau di Poli.	Map informasi obat, MIMS, aplikasi Medscape sudah tersedia di unit pelayanan

Obat Tertinggal Yang Tidak Diambil Pasien	Data obat tertinggal yang tidak diambil pasien bulan Juni 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan Mei 2025, dengan total resep yang di retur yaitu bulan Mei 2025 sebanyak 42 dan bulan Juni 2025 sebanyak 59. Hal ini disebabkan beberapa pasien tidak mengetahui mendapatkan resep sehingga obat ditinggal dalam waktu 3x24 jam dan keterlambatan penyiapan obat sehingga waktu tunggu obat lama.	- Admin primantara tiap hari menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal untuk mengurangi penumpukan obat tertinggal. - Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan. - Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru.
--	---	---

3.2.1.11 Tabel Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Mei - Juli 2025

No	Tanggal	Nama Obat	Golongan Obat	Distributor	Tindak Lanjut
1	1/5/2025-31/5/2025	Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg	Diuretik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
2	1/5/2025-31/5/2025	Methylegometrin tab 0,125 mg	Oksitosik	PT. Kimia Farma	Substitusi dengan Bledstop tab 0,125 mg
3	1/5/2025-31/5/2025	Itraconazole caps 100 mg	Anti fungi	PT. Tri Sapta Jaya	Tanpa saran substitusi
4	1/5/2025-15/5/2025	Ketoprofen tab 100 mg	Analgesik	PT. Antar Mitra Sembada	Tanpa saran substitusi
Total prosentase Mei 2025 = 0.35%					
1	1/6/2025-31/6/2025	Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg	Diuretik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
2	1/6/2025-31/6/2025	Methylegometrin tab 0,125 mg	Oksitosik	PT. Kimia Farma	Substitusi dengan Bledstop tab 0,125 mg
3	1/6/2025-31/6/2025	Itraconazole caps 100 mg	Anti fungi	PT. Tri Sapta Jaya	Tanpa saran substitusi
4	1/6/2025-15/6/2025	Santagesik inj 1 gr	Analgesik	PT. Bina San Prima	Tanpa saran substitusi
Total prosentase Juni 2025 = 0.22%					
1	1/7/2025-31/7/2025	Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg	Diuretik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
2	1/7/2025-31/7/2025	Methylegometrin tab 0,125 mg	Oksitosik	PT. Kimia Farma	Substitusi dengan Bledstop tab 0,125 mg
3	1/7/2025-30/7/2025	Itraconazole caps 100 mg	Anti fungi	PT. Tri Sapta Jaya	Tanpa saran substitusi
4	1/7/2025-4/7/2025	Divalproex sodium tab 500 mg	Anti konvulsan	PT. Parit Padang Global	Tanpa saran substitusi
Total prosentase Juli 2025 = 0.26%					

3.2.1.12 Grafik Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada April - Juni 2025



Analisis :

- 1. Hasil monitoring ketersediaan obat selama 3 bulan ditemukan masih sering terjadi kekosongan di distributor karena kekurangan bahan baku, delisting produk (pabrik tidak produksi), stok di distributor habis, kekosongan produk originator seperti Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg dan Itraconazole caps 100 mg sehingga tidak tersedia di pabrik lain dengan kandungan yang sama.
- 2. RS belum bisa melakukan pembelian lewat e-purchasing sehingga belum bisa order obat fast moving khusus obat kronis.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Evaluasi mutu perjanjian kerjasama dengan distributor untuk memberikan konfirmasi apabila stok barang tidak tersedia di distributor setelah menerima pesanan dari RS.
- 2. Mencari substitusi obat lain yang isi/ kandungannya sama.
- 3. Evaluasi stok minimal depo farmasi dan Gudang farmasi serta alur pengadaan.
- 4. RS sudah mempunyai akun e-purchasing dan koordinasi dengan pengadaan terkait e-purchasing.
- 5. Memberitahukan info kekosongan obat di distributor ke DPJP melalui surat edaran beserta saran substitusi.

3.2.1.13 Tabel Pemusnahan Obat, BMHP/ Alat Kesehatan Rusak (Substandar), dan Recall Bulan Juli 2025

No	Kegiatan	Nama Obat/ BMHP/ Alat Kesehatan	Jumlah	Alasan	Keterangan
1	Pemusnahan Obat	-	-	-	Tidak ada pemusnahan
2	BMHP/ Alat Kesehatan Rusak (Substandar)	Three way stopcock - Onemed	3 pcs	Three way patah setelah di buka dari bungkusnya. No. Batch : 01102488	Form keluhan alat kesehatan substandard dari ruang ICU dilaporkan tanggal 20/07/2025 sudah diajukan ke Pengadaan PT.
3	Recall	-	-	-	Tidak ada recall

3.2.1.14 Tabel Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Farmasi Pada Bulan Juli 2025

No	Monitoring dan Evaluasi	Hasil	Tindak Lanjut												
1	Perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP	Perencanaan dilakukan dengan metode konsumsi dan rumus VEN-ABC. Evaluasi terhadap perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP digudang farmasi menggunakan sistem ROP dan Non ROP farmasi di SIMRS, dikarenakan sistem ROP belum mendeteksi penjualan obat slow moving namun tetap harus disediakan jadi petugas mendata obat menipis secara manual kemudian diinput Non ROP farmasi	Monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP menggunakan sistem ROP di gudang farmasi.												
2	Pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP ke distributor	Pengadaan sediaan farmasi dan BMHP dengan pembelian langsung, repacking dan donasi/ hibah. Tersedia PKS dengan distributor; Semua pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, termasuk obat vaksin harus menjamin garansi keaslian yakni : a. Sediaan farmasi - No.Ijin Edar dari BPOM b. Alkes - No.Ijin Edar dari Dirjen Binfar dan CoA c. BMHP - No ijin edar dari Binfar d. B3 - MSDS; Kunjungan ke distributor; Surat Pesanan obat, alkes, dan BMHP di tandatangan oleh APJ	Monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP												
3	Pemantauan suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin	Form monitoring suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin sudah tersedia namun petugas masih tidak rutin mengisi.	Monitoring dan evaluasi pengisian monitoring suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin di depo dan gudang farmasi oleh apoteker setiap hari												
4	Supervisi box emergency, trolley emergency, kit emergency, box HPP dan Eklamsi	Pengecekan obat dan alat kesehatan yang mendekati ED (<i>expired date</i>) 6 bulan segera diganti dilakukan tiap 3 bulan sekali. Bedah box triwulan 3 pada Bulan April Tahun 2025 sudah dilakukan. Berikut temuan obat yang mendekati ED 6 bulan dan diganti dengan ED jauh yaitu : <table><tr><th>No</th><th>Temuan obat near ED < 6 bulan</th><th>Pergantian obat near ED</th></tr><tr><td>1</td><td>Box emergency poli lantai 1: Clopidogrel Tab (5 tab) 1/26</td><td>Clopidogrel Tab (5 tab) 1/27</td></tr><tr><td>2</td><td>Box emergency poli treadmill: Amiodaron inj 8/26, Dobutamine inj 1/26, Atropin sulfat inj 11/26, Valisanbe inj 2/26, Clopidogrel tab 1/26, IV canul no. 20 1/26, Sput 1 cc 1/26</td><td>Amiodaron inj 1/27, Dobutamine inj 2/27, Atropin sulfat inj 9/27, Valisanbe inj 1/27, Clopidogrel tab 4/27, IV canul no. 20 4/29, Sput 1 cc 5/29</td></tr><tr><td>3</td><td>Box emergency poli lantai 2: Clopidogrel (5 tab)</td><td>Clopidogrel (5 tab)</td></tr></table>	No	Temuan obat near ED < 6 bulan	Pergantian obat near ED	1	Box emergency poli lantai 1: Clopidogrel Tab (5 tab) 1/26	Clopidogrel Tab (5 tab) 1/27	2	Box emergency poli treadmill: Amiodaron inj 8/26, Dobutamine inj 1/26, Atropin sulfat inj 11/26, Valisanbe inj 2/26, Clopidogrel tab 1/26, IV canul no. 20 1/26, Sput 1 cc 1/26	Amiodaron inj 1/27, Dobutamine inj 2/27, Atropin sulfat inj 9/27, Valisanbe inj 1/27, Clopidogrel tab 4/27, IV canul no. 20 4/29, Sput 1 cc 5/29	3	Box emergency poli lantai 2: Clopidogrel (5 tab)	Clopidogrel (5 tab)	Dilakukan supervisi oleh apoteker terhadap penyimpanan obat <i>emergency</i> dan segera diganti apabila dipakai, kedaluwarsa, atau rusak. Pelaksanaan supervisi dilakukan sebagai berikut : a. Pengecekan segel, pengecekan kedaluwarsa di list daftar obat dan pengecekan suhu penyimpanan dilakukan setiap hari. b. Pengecekan jumlah dan dipakai dilakukan saat segel terbuka. c. Pengecekan obat yang mendekati ED (<i>expired date</i>) 6 bulan segera diganti dilakukan tiap 3 bulan sekali untuk mencegah
No	Temuan obat near ED < 6 bulan	Pergantian obat near ED													
1	Box emergency poli lantai 1: Clopidogrel Tab (5 tab) 1/26	Clopidogrel Tab (5 tab) 1/27													
2	Box emergency poli treadmill: Amiodaron inj 8/26, Dobutamine inj 1/26, Atropin sulfat inj 11/26, Valisanbe inj 2/26, Clopidogrel tab 1/26, IV canul no. 20 1/26, Sput 1 cc 1/26	Amiodaron inj 1/27, Dobutamine inj 2/27, Atropin sulfat inj 9/27, Valisanbe inj 1/27, Clopidogrel tab 4/27, IV canul no. 20 4/29, Sput 1 cc 5/29													
3	Box emergency poli lantai 2: Clopidogrel (5 tab)	Clopidogrel (5 tab)													

			1/26 Mannitol (1 flash) 1/26	3/27 Mannitol (1 flash) 1/27	kedaluwarsa saat dibutuhkan.
		4	Box emergency poli vaksin: Mannitol (1 flash) 1/26 Phenytoin inj (1 amp) 1/26 Diphenhydramine Inj (1 amp) 1/26 Furosemid (2 amp) 2/26	Mannitol (1 flash) 1/27 Phenytoin inj (1 amp) 1/28 Diphenhydramine Inj (1 amp) 1/27 Furosemid (2 amp) 12/26	
		5	Trolley emergency IGD: Amiodaron Inj (4 amp) 11/25	Amiodaron Inj (4 amp) 1/27	
		6	Box emergency infant Ponak IGD: Terfusion Terumo (1 pcs) 2/26 Dopamin Inj (1 amp) 2/26	Terfusion Terumo (1 pcs) 12/26 Dopamin Inj (1 amp) 12/26	
		7	Box HPP – Eklamsi IGD: MgSO4 20% (1 flash) 11/25 Misoprostol tab (1 tab) 1/26	MgSO4 20% (1 flash) 9/26 Misoprostol tab (1 tab) 12/26	
		8	Kit emergency IGD 1: Tidak ada obat near ED	-	
		9	Kit emergency IGD 2: Tidak ada obat near ED	-	
		10	Box emergency ambulance: Tidak ada obat near ED	-	
		11	Trolley emergency IKO: Tidak ada obat near ED	-	
		12	Box emergency infant IKO: Suction cath no. 8 12/25 Suction cath no.6 01/26	Suction cath no. 8 03/27 Suction cath no.6 12/27	
		13	Box HPP-Eklamsi IKO: Tidak ada obat near ED	-	
		14	Box emergency 2C: Amiodaron 06/26 Aspilet 06/26 Clopidogrel tab 06/26 Dexamethasone 06/26 Furosemide 05/26	Amiodaron 01/27 Nospirinal tab 04/27 Clopidogrel tab 01/27 Dexamethasone 03/27 Furosemide 12/26	

		15	Box emergency ICU: Dexamethason 06/26 Inzana 03/26 Furosemide 05/26	Dexamethason 03/27 Inzana 04/27 Furosemide 12/26	
		16	Box emergency ICU ventilator: Dexamethason 06/26 ISDN 05/26 Norepinephrin 04/26 Manitol 04/26	Dexamethason 03/27 Inzana 12/26 Norepinephrin 07/26 Manitol 01/27	
		17	Box emergency HCU: Amiodaron 06/26 Inzana tab 06/26 Clopidogrel tab 05/26 Dexamethason 05/26 Manitol 03/26 Infusion set dewasa 07/26	Amiodaron 01/27 Nospirinal tab 04/27 Clopidogrel tab 01/27 Dexamethason 03/27 Manitol 01/27 Infusion set dewasa 01/30	
		18	Box emergency 3C anak: Tidak ada obat near ED	-	
		19	Box emergency PICU Ventilator: Tidak ada obat near ED	-	
		20	Box emergency PICU: Tidak ada obat near ED	-	
		21	Box emergency 2A: Inzana 06/26 Amiodarone 06/26 Dexamethasone 04/26 Natrium phenytoin 02/26 Manitol 03/26	Inzana 04/27 Amiodarone 01/27 Dexamethasone 03/27 Natrium phenytoin 09/27 Manitol 01/27	
		22	Box emergency 3A: Tidak ada obat near ED	-	
		23	Box emergency 4A: Dexamethasone 04/26 Nospirinal tab 07/26 Phenytoin 03/26 Valisanbe 03/26 IV cannul no. 20 02/26 Manitol 03/26	Dexamethasone 03/27 Nospirinal tab 04/27 Phenytoin 09/27 Valisanbe 01/27 IV cannul no. 20 09/29 Manitol 01/27	
		24	Box emergency infant Maternitas: D10% 04/26 Sput 10cc Terumo 02/26 Dobutamin 01/26	D10% 11/26 Sput 10cc Terumo 01/30 Dobutamin 02/27	
		25	Trolley emergency Maternitas: Amiodaron 06/26	Amiodaron 01/27	

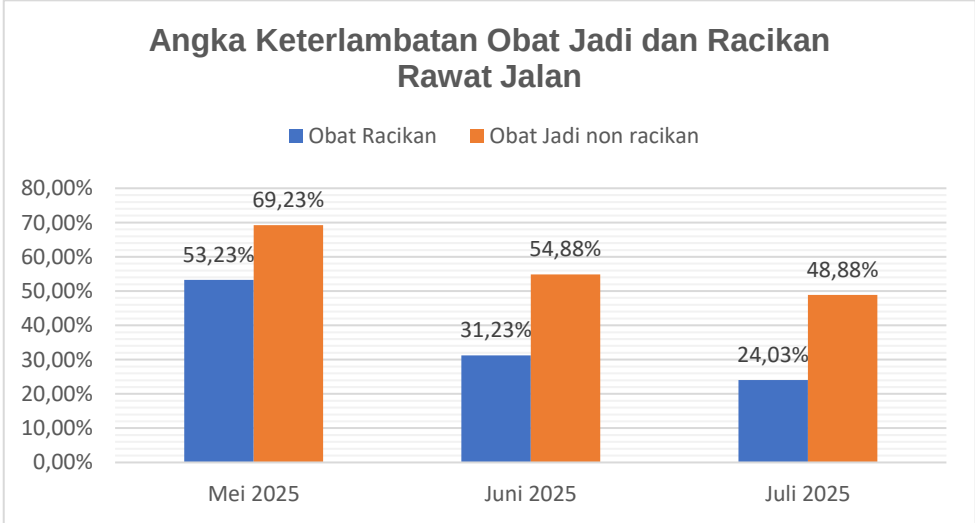
			Nospirinal 06/26 Valisanbe 03/26 Furosemide 04/26 Clopidogrel tab 04/26	Nospirinal 04/27 Valisanbe 01/27 Furosemide 12/26 Clopidogrel tab 01/27	
		26	Box emergency infant Perinatologi: D10% 07/26 Dobutamin 12/26 Dopamin 09/26 Infus Gelafusal 02/26 ETT uncuff no.2 02/26	D10% 11/26 Dobutamin 02/27 Dopamin 12/26 Infus Gelafusal 01/27 ETT uncuff no.2 08/29	
		27	Box emergency 5C: Amiodaron 06/26 Clopidogrel tab 10/26 Nospirinal 11/26 Furosemide 11/26 Dopamin 09/26	Amiodaron 01/27 Clopidogrel tab 11/27 Nospirinal 04/27 Furosemide 12/26 Dopamin 12/26	
		28	Box emergency 6A: Atropine 02/26 Dobutamin 12/26 Inzana tab 04/26 Furosemide 04/26 Natrium Phenytoin 06/26 Clopidogrel tab 06/26 Manitol 04/26	Atropine 09/27 Dobutamin 02/27 Nospirinal tab 04/27 Furosemide 12/26 Natrium Phenytoin 01/28 Clopidogrel tab 01/27 Manitol 01/27	
		29	Box emergency 7A: Amiodaron 02/26 Dopamin 04/26 Inzana tab 04/26 Furosemide 04/26 Gelafusal 02/26 Manitol 04/26	Amiodaron 01/27 Dopamin 12/26 Nospirinal tab 04/27 Furosemide 12/26 Gelofusan 01/27 Manitol 01/27	
		30	Box emergency 8A: Hi-Oxy dewasa 01/26	Hi-Oxy dewasa 04/29	
		31	Box emergency Radiologi: Tidak ada obat near ED	-	
		Penambahan obat dan alat kesehatan pada masing-masing box emergency ruangan 2A, 3A, 4A, 2C, 3C, 5C, ICU, dan HCU yaitu : - Cairan Dextrose D40% 1 fl, - Mayo kuning 1 pc, - Mayo hijau 1 pc, - Norephinephrine inj 1 amp, - Perfursor white 1 pc, - Sduit 20 cc 1pc, - Sduit 50 cc LP 1 pc, - Three way stopcock 1 pc.			- Supervisi secara berkala penyimpanan dan pemakaian obat dan alat kesehatan di box emergency.
5	Kartu stok obat	Kepatuhan penulisan kartu stok 70% di depo farmasi, petugas masih merapel pengeluaran kartu stok dan belum menulis sisa stok. Kepatuhan penulisan kartu stok 100% di gudang farmasi.			- Supervisi petugas farmasi dalam melakukan pelayanan (barang masuk dan keluar) dengan tetap menuliskan pada kartu stok

			- Petugas lebih teliti ketika menghitung pemasukan atau pengeluaran.
6	Penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3)	Penyimpanan bahan berbahaya dan beracun di ruangan terpisah dan didalam lemari B3 tersedia APAR dan diberi label B3 sesuai sifat dan risiko bahan.	Monitoring dan evaluasi terhadap penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3)
7	Penyimpanan produk steril di unit	Ditemukan perawat menyimpan sisa infus NS 0.9% dan sisanya digunakan kembali besok hari (lebih dari 1x24 jam) sehingga melewati batas BUD.	Supervisi secara berkala dan edukasi ke perawat BUD produk steril tidak boleh lebih dari 3 jam
8	Pelaksanaan double check untuk pemberian obat high alert	• Rawat inap : Double check obat dan bmhp resep ODD (One Daily Dose) dilakukan oleh farmasi sebelum distribusi ke ruangan rawat inap. Pelaksanaan double check obat high alert secara independen menggunakan resep dan daftar pemberian obat (DPO) antara farmasi dan perawat/ bidan. Perawat/ bidan penerima obat melakukan double check secara independen dengan PJ Shift/ kepala ruang menggunakan daftar pemberian obat (DPO) sebelum obat diserahkan/ disuntikkan ke pasien secara UDD (Unit Dose Dispensing). • Rawat Jalan : Pelaksanaan double check obat high alert secara independen menggunakan resep antara petugas verifikasi dan petugas penyerah sebelum obat diserahkan ke pasien.	Supervisi secara berkala terkait pelaksanaan double check obat high alert di rawat inap dan rawat jalan

3.2.1.15 Tabel Angka Keterlambatan Obat Jadi dan Racikan Bulan Mei – Juli 2025

INDIKATOR	BULAN		
	MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025
Penyiapan Obat Jadi Rawat Jalan > 30 menit	69.23%	54.88%	48.88%
Penyiapan Obat Racikan > 60 menit	53.23%	31.23%	24.03%

3.2.1.16 Grafik Angka Keterlambatan Obat Jadi dan Racikan Bulan Mei – Juli 2025



Analisis :

- 1. Waktu tunggu obat rawat jalan pada Bulan Juli Tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Juni 2025. Namun prosentasi tersebut masih jauh dari target (0%). Hal ini disebabkan :
 - DPJP tidak praktek karena cuti sehingga menyebabkan penumpukan kunjungan pasien pada saat hari berikutnya ketika DPJP praktek,
 - Kunjungan pasien yang tidak dibatasi sehingga terjadi penumpukan resep di jam-jam tertentu,
 - Penurunan angka keterlambatan obat di rawat jalan karena komposisi farmasi sudah lengkap (cuti melahirkan sudah masuk bekerja) dengan 5 apoteker rawat jalan, 25 TTK, dan 2 Non TTK.

Rencana Tindak Lanjut:

- 1. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi dalam klik obat selesai maupun ambil obat, sehingga petugas farmasi diharapkan *real time* dalam pelaksanaannya.
- 2. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terkait alur pemberian obat kepada pasien, bahwa harus dihindari terjadi penumpukan obat yang telah siap diberikan.
- 3. Terdapat program pengantaran obat melalui Primantara sehingga mengurangi antrian pasien menunggu obat.
- 4. Petugas input dibagi menjadi resep kronis dan resep non kronis oleh TTK, resep iter dan PRB oleh apoteker.

1.2.1 Laboratorium

1.2.1.11 Tabel Jumlah Pemeriksaan Laboratorium

	JULI PERIODE 1 2025	JULI PERIODE 2 2025	(PERSENTASE TERHADAP PERIODE SEBELUMNYA)
HEMATOLOGI	842	905	>6,9 %
FAAL HEMOSTASIS	422	409	< 3,0 %
HEMATOLOGI LAIN	0	0	0 %
URINALISIS	129	127	< 1,5 %
ANALISA FEACES	3	11	➤ 72,7 %
FUNGSI HATI	179	194	➤ 7,7 %
LEMAK DARAH	339	458	➤ 25,9 %
GINJAL HIPERTENSI	620	768	➤ 19 %
GULA DARAH	945	1017	➤ 7,01 %
JANTUNG	294	283	< 3,7 %
ELEKTROLIT DAN BGA	114	121	➤ 6,1 %
IMUNO SEROLOGI	227	242	➤ 6,1 %
REMATIK	2	1	< 50 %
ENDOKRINOLO GI	41	52	➤ 21,1 %
REPRODUKSI	10	16	➤ 37,5 %
MIKROBIOLOGI	17	26	➤ 34,6 %
Jumlah	4.184	4.630	> 9,6%

Analisis :

Jumlah Pemeriksaan Pada Periode pertama bulan Juli 2025 didapatkan jumlah total pemeriksaan 4.184 pemeriksaan, pada periode Kedua bulan Juli didapat jumlah total pemeriksaan 4.630, pada periode kedua mengalami kenaikan 9,6% di bandingkan dengan periode Pertama bulan Juli.

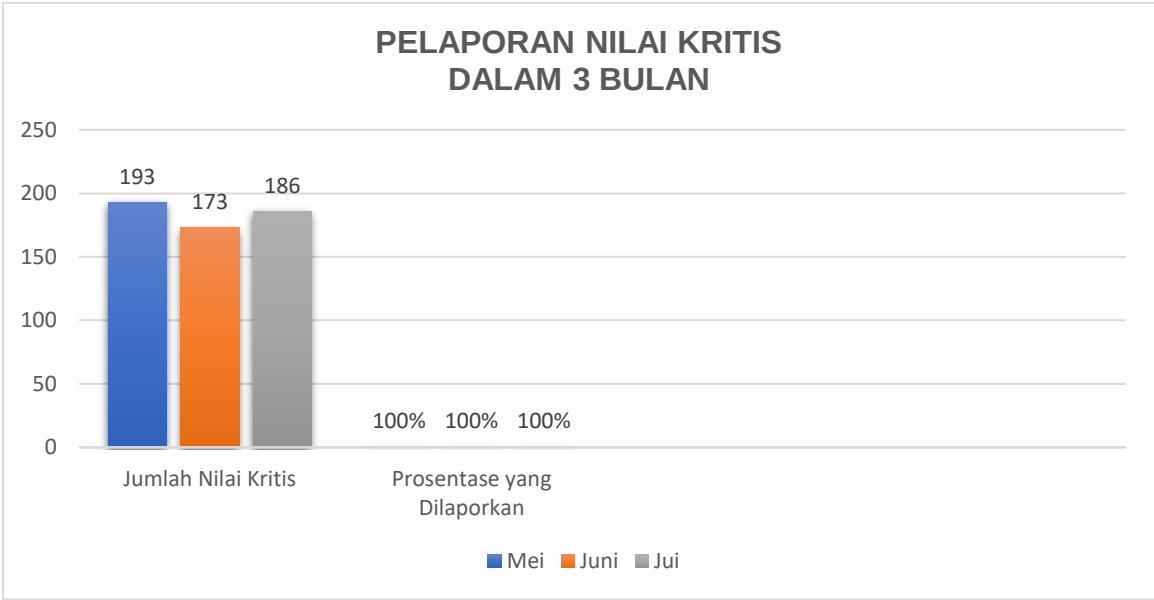
Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Proses pengembangan pelayanan dengan menggunakan LIS.
- 2. Perbaikan serah terima hasil laboratorium menggunakan system digital.
- 3. Melakukan pencatatan keluar masuk stok reagen pada kartu stok dan dilakukan SO.
- 4. Follow up pengadaan reagen yang lama kosong.
- 5. Mengajukan pengadaan Laboratorium PA di RS Prima Husada Malang.
- 6. Membuat kesepakatan batas akhir bacaan hasil PA dan follow up secara berkala kepada Dokter Penanggungjawab Patologi Anatomi.
- 7. Mengajukan review tarif pemeriksaan laboratorium kepada Kepala Keuangan PT.

1.2.1.12 Pelaporan Nilai Kritis Mei - Juli 2025

NO	BULAN	JUMLAH NILAI KRITIS	PROSENTASE YANG DILAPORKAN	PROSENTASE YANG TIDAK DILAPORKAN
1.	April 2025	206	100%	0%
2.	Mei 2025	193	100%	0%
3.	Juni 2025	173	100%	0%
4.	Juli 2025	186	100%	0%

1.2.1.13 Grafik Pelaporan Nilai Kritis Mei – Juli 2025



Analisis :

- 1. Pelaporan nilai kritis pada Bulan Juli 2025 sudah mencapai 100%.
- 2. Petugas sudah disiplin dalam melakukan dokumentasi pelaporan nilai kritis.
- 3. Tidak ada complain yang masuk karena keterlambatan pelaporan nilai kritis ke unit.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Supervisi berkala dilakukan oleh Karu dan Kabid Penunjang Medis
- 2. Kolaborasi dengan Kabid Keperawatan dan Kabid Pelayanan Medis terkait pelaporan complain DPJP terhadap keterlambatan pelaporan nilai kritis.
- 3. Kolaborasi dengan SDM terkait kedisiplinan petugas dalam melakukan pekerjaan.
- 4. Pertahankan kinerja yang sudah baik.

4.1.1.5 Tabel Pelaporan Kerusakan Sampel pada Bulan April - Juni 2025

NO	NAMA PASIEN	NO RM	TANGGAL PENGAMBILAN SAMPEL	UNIT ASAL	SAMPEL YANG DITERIMA
Bulan April 2025					
1.	Abd Rohman	229923	18/04/2025	ICU	Sampel Vena BGA
2.	Aqilla Putri	160607	19/04/2025	IRNA 3C	Sampel Clotting
3.	Rochmad	102166	29/04/2025	IRNA 5C	Sampel Clotting
Bulan Mei 2025					
1.	Andara	224145	01/05/2025	IGD	Sampel Clotting
Bulan Juni 2025					
Tidak ditemukan sampel rusak					
Bulan Juli 2025					
1.	Kuseran	183848	16/07/2025	IGD	DL clotting
2.	Juri	069001	21/07/2025	IGD	DL clotting

Analisis :

Ditemukan 2 sampel rusak ketika diterima oleh petugas laboratorium pada Bulan Juli 2025.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Monitoring dan Evaluasi.
2. Memberikan pemahaman bahwa pengambilan sampel sesuai dengan batas garis indicator.
3. Kolaborasi dengan Kabid Keperawatan terkait training prosedur pengambilan darah, penyimpanan dan pengiriman sampel.
4. Supervisi ED reagen.

4.1.1.6 Tabel Pelayanan BDRS Bulan April - Juni 2025

Bulan	Permintaan Labu Darah				Total	Return Labu Darah				Total
	A	B	O	AB		A	B	O	AB	
April 2025	13	10	25	20	68	2	7	5	4	18
Mei 2025	20	27	42	9	98	4	-	-	-	4
Juni 2025	15	29	27	8	79	2	1	-	-	3
Juli 2025	18	14	29	6	67	1	4	-	3	8

4.1.1.7 Tabel Hasil Incompatible pada Crossmatch pada Bulan Maret - Mei 2025

NO	NAMA PASIEN	JUMLAH PASIEN DAN PERMINTAAN LABU DARAH INCOMPATIBLE				TOTAL PERMINTAAN LABU DARAH
		A	AB	O	B	
Bulan April 2025						
Tidak ada						
Bulan Mei 2025						
Tidak ada						
Bulan Juni 2025						
1.	Siti Rahajuningsih				√	2 Labu
Bulan Juli 2025						
Tidak ada						

Analisis :

Pada periode pertama bulan Juli 2025 tidak ditemukan pasien Incompatible

Rencana Tindak Lanjut :

Pertahankan Tetap telili dan berhati hati dalam melakukan crossmatch

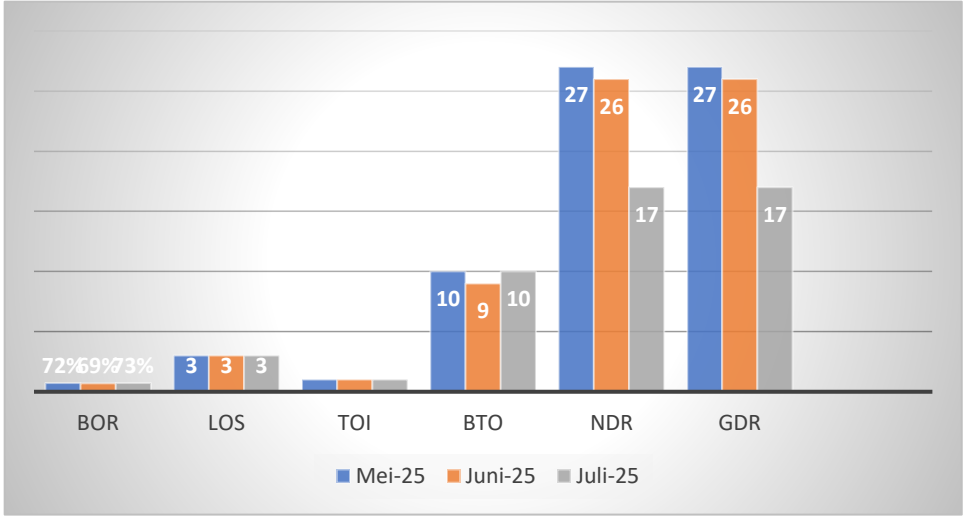
1.2.3 Rekam Medis – Pendaftaran

3.1.1.1 Tabel Kinerja Unit Rawat Inap Bulan Mei - Juli 2025

INDIKATOR	RUMUS	DATA	STANDAR DEPKES	BULAN	UNIT												TOTAL
					2C	3A	3C	4Ab	5C	6A	7A	8A	MTS	NICU	HCU	ICU	
BOR (Bed Occupancy Rate) “Prosesntase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu”	$(\sum HP / (\sum TT \times \text{jumlah hari dalam satu periode})) \times 100$	Jumlah hari perawatan, jumlah TT, jumlah hari dalam satu periode	60-80 %	Mei 25	65	89	68	80	56	74	76	72	61	25	26	22	72
				Juni 25	63	75	73	71	57	64	77	70	60	50	25	33	69
				Juli 25	83	111	71	79	58	66	77	69	66	39	24	28	73
ALOS (Average Length of Stay) “Rata-rata lama rawat seorang pasien”	$LD / \sum px \text{ keluar } (H+M)$	Jumlah lama dirawat, jumlah pasien keluar	6-9 hari	Mei 25	4	3	3	3	3	4	4	1	3	4	2	2	3
				Juni 25	4	3	3	3	3	4	3	2	3	2	2	2	3
				Juli 25	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	2	2	3
TOI (Turn Over Interval) “Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati”	$((\sum TT \times \sum \text{hari}) - HP) / \sum \text{pasien keluar } (H+M)$	Jumlah tempat tidur, hari perawatan, pasien keluar	1-3 hari	Mei 25	1	0	1	1	2	1	1	1	1	14	2	4	1
				Juni 25	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	3	4	1
				Juli 25	1	0	1	1	2	1	1	1	1	7	3	3	1
BTO (Bed Turn Over) “Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode”	$\sum Px \text{ keluar } (H+M) / \sum TT$	Jumlah pasien, Jumlah TT	4-5 kali (dalam hitungan bulan)	Mei 25	7	9	10	11	8	10	9	9	10	2	11	6	10
				Juni 25	8	9	10	11	7	8	10	8	9	5	9	6	9
				Juli 25	7	10	10	11	8	9	9	10	11	3	8	7	10

NDR (Net Death Rate) “Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit”	$(\sum Px \text{ Mati } >48\text{jm}) / \sum Px \text{ keluar (H+M)} \times 1000\text{‰}$	Jumlah pasien meninggal >48jm, jumlah pasien keluar	<25 ‰	Mei 25	0	13	0	0	9	34	36	55	0	200	143	255	27
				Juni 25	0	0	0	8	9	20	9	32	0	0	59	404	26
GDR (Gross Death Rate) “Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit”	$(\sum Px \text{ mati} / \sum Px \text{ keluar (H+M)}) \times 1000\text{‰}$	Jumlah pasien keluar mati, jumlah pasien keluar	<45‰	Juli 25	35	12	0	0	0	27	9	43	0	0	0	167	17
				Mei 25	0	13	0	0	9	34	36	55	0	200	143	255	27
				Juni 25	0	0	0	8	9	20	9	32	0	0	59	404	26

3.1.1.2 Grafik Kinerja Unit Rawat Inap Bulan Mei - Juli 2025 2025



Analisis :

Indikator	Nilai Juli 2025	Standar Ideal	Evaluasi Singkat
BOR	73%	60%-85%	Masih dalam standar, batas rendah
LOS	3 hari	BPJS : 3 hari UMUM : 6-12 hari	Dibawah standar BPJS, perlu dicermati
TOI	1 hari	1-3 hari	Sesuai standar, efisien
BTO	10 kali	4-5 kali	Konsisten tinggi, perlu evaluasi

Update Tren Tahun 2025

Indikator	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Catatan
BOR	81%	75%	72%	68%	69%	73%	Penurunan signifikan sejak Bulan April
LOS	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	Penurunan LOS, dibawah standar SE PT DPM
TOI	2 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	Stabil, efisien
BTO	9 kali	10 kali	10 kali	9 kali	9 kali	10 kali	Konsisten tinggi, diluar standar ideal

Masalah :

1. BOR (Bed Occupancy Rate)

a) Mendekati zona efisien tetapi masih di bawah standar efisiensi internasional ($\geq 75\%$), khususnya pada Juni yang turun ke 69 %.

b) Dapat menunjukkan fluktuasi musiman, perubahan kapasitas, atau bottleneck alur masuk (eksekutif, BPJS, program khusus, dsb.).
2. LOS (Length of Stay)

Sangat pendek (3 hari), hampir setengah dari standar (6–9 hari), dengan beberapa potensi risiko:

a) Kemungkinan besar banyak kasus low-complexity / fast-track atau "mini-stay".

b) Risiko kasus readmission tinggi jika discharge dilakukan terlalu cepat.

c) Case mix index mungkin rendah, layanan belum optimal bidang rawat inap.
3. TOI (Turn Over Interval)

1 hari (tepat batas efisiensi), tapi:

a) Tingkat desinfeksi, administrasi, perawatan gizi/keperawatan harus disiplin agar tidak tergesa-gesa.

b) Tidak ada buffer kalau ada keterlambatan triase IGD/ruang/transport pasien atau gangguan logistik.
4. BTO (Bed Turn Over)

Sangat tinggi (sekitar 10x/bulan), artinya volume turnover sangat besar:

- a) Bisa menimbulkan burnout tim cleaning, housekeeping, frontliner.
- b) Boleh jadi menunjukkan just-in-time turnover, tapi bisa mengurangi kualitas jika tidak seimbang dengan standar sterilitas dan manajemen alur.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Tingkatkan Volume & Turnover Pasien
 - a) Target BTO: naikkan ke minimal 30 kali/tahun, optimal 40–50 kali/tahun.
 - b) Pendekatan: tingkatkan layanan rawat inap jangka pendek (bedah minor, observasi), buka unit baru yang cepat turnover.
2. Evaluasi Kualitas LOS
 - a) Lakukan audit Clinical Pathway untuk memastikan LOS singkat tidak menimbulkan efek readmisi atau kompromi mutu.
 - b) Monitor rata-rata LOS per diagnosis alternatif untuk memastikan sesuai praktik terbaik.
3. Optimasi Proses Internal
 - a) TOI saat ini optimal, tetap jaga proses pembersihan dan kesiapan TT agar tidak mengganggu turnover.
 - b) Perlu diagram alir proses (flowchart) pelunasan pasien, pembersihan, dan penyiapan tempat tidur.
4. Promosi & Koordinasi Layanan
 - a) Tingkatkan kolaborasi antar poliklinik rawat jalan dan unit rawat inap untuk mengaktifkan rujukan pasien rawat inap.
 - b) Edukasi masyarakat mengenai manfaat rawat inap untuk kondisi yang cocok, serta promosi layanan tertentu.
5. Visualisasi & Monitoring Berkala
 - a) Buat Grafik Barber-Johnson untuk memantau BOR, LOS, TOI, BTO secara bersamaan dalam satu visual.
 - b) Laporan bulanan/triwulan agar indikator mudah dipantau dan dianalisis trend-nya.
6. Evaluasi Kapasitas TT

Jika BTO rendah karena jumlah TT terlalu banyak terhadap volume kasus, pertimbangkan penyesuaian kapasitas: konsolidasi unit/penutupan sementara blok TT yang underutilized.

3.1.1.3 Tabel Diagnosa Terbanyak Rawat Jalan Bulan Juli 2025

NO	KODE	DIAGNOSA	TOTAL
1.	E11.9	DM Tanpa komplikasi / Without complications	459
2.	I11.9	HHD / Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure	394
3.	E11.4	With neurological complications	338
4.	I25.9	Chronic ischemic heart disease, unspecified	333
5.	I51.9	Decomp Cordis / Heart disease, unspecified	304
6.	I63.9	CVA Infark / Cerebral infarction, unspecified	273
7.	J44.9	COPD / Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified	228
8.	K04.1	Necrosis of pulp	206
9.	R50.9	Febris / Fever, unspecified (Observasi Febris)	180
10.	A01.0	Typhoid Fever (TF)	175

3.1.1.4 Tabel Diagnosa Rawat Inap Bulan Juli 2025

NO	KODE	DIAGNOSA	TOTAL
1.	A01.0	Typhoid Fever	264
2.	I63.9	Cerebro Vaskuler Accident	47
	A90	Dengue Fever	27
3.	E11.9	Diabetes Mellitus Type 2	26
4.	E14.9	Diabetes Mellitus Hyperglikemia	17

5.	I21.4	Non-ST Elevation Myocardial Infarction	17
6.	J18.9	Pneumonia	17
7.	N20.0	Unstable Angina Pectoris	15
8.	K40.9	Hernia Inguinalis	14
9.	M72.6	Necrotizing Fascitis	14
10.	A01.0	Typhoid Fever	264

Analisis :

- 1. Diagnosa terbanyak di Rawat Jalan adalah DM Tanpa komplikasi / Without complications sebesar 459 kasus, sedangkan diagnose terbanyak di Rawat Inap adalah Typhoid Fever sebesar 264 kasus.
- 2. Tarikan data diagnose rawat inap diambil dari hasil analisa pada resume medis saat pasien pulang, yaitu pada diagnose utama yang ditulis oleh DPJP. Sedangkan tarikan data diagnose rawat jalan diambil dari SIMRS.

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan analisa pada resume medis saat pasien pulang berdasarkan diagnose sekunder.

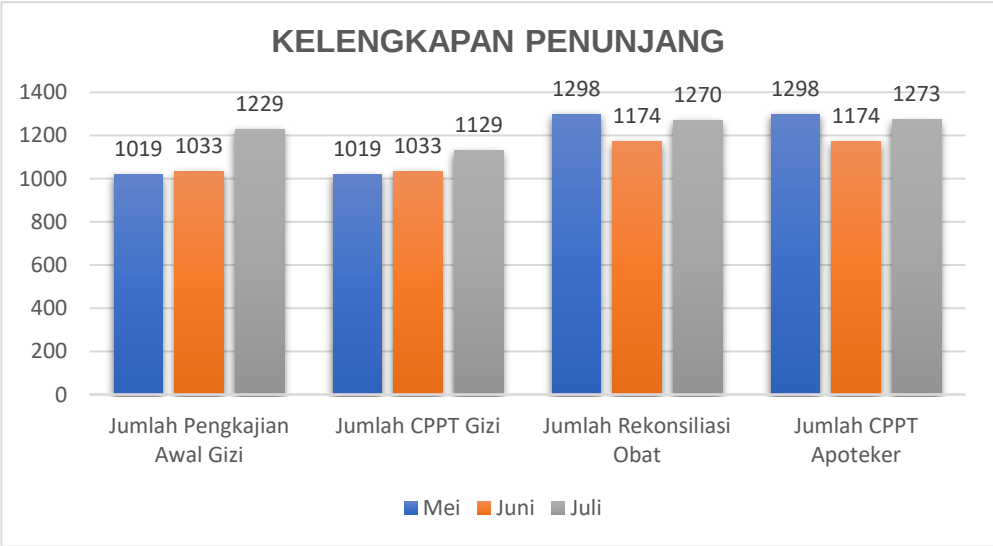
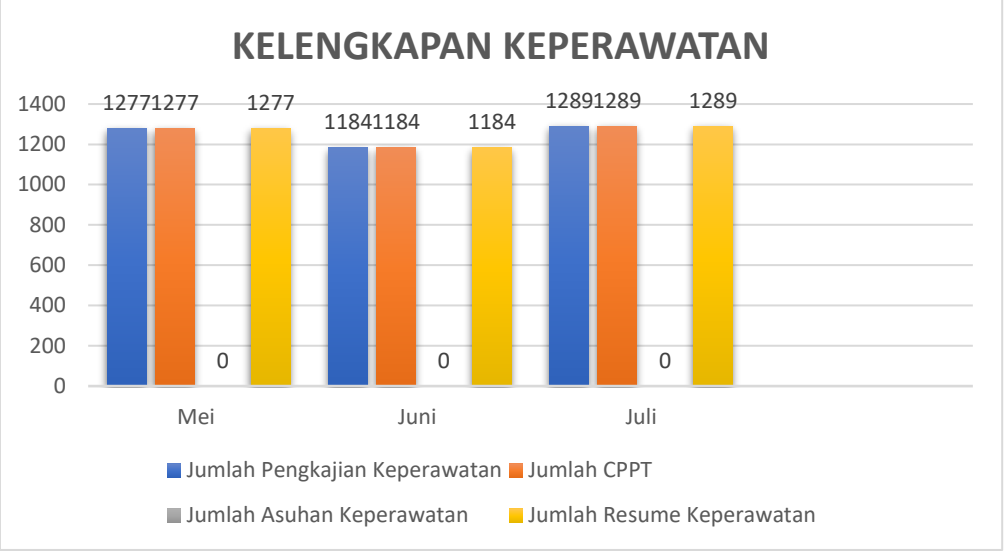
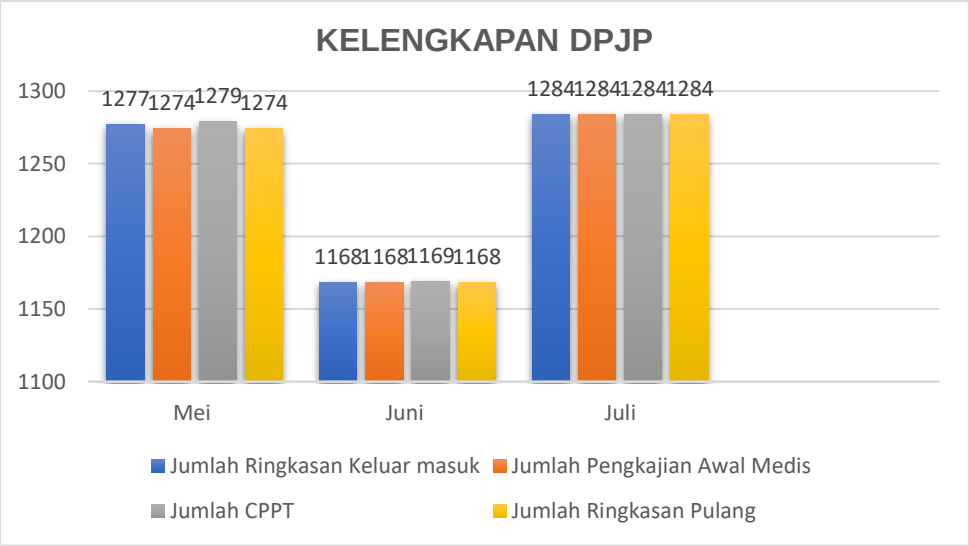
3.1.1.5 Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Juli 2025

KELENGKAPAN																
DPJP																
BULAN	Ringkasan Keluar Masuk				Pengkajian Awal Medis				CPPT				Ringkasan Pulang			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	1055	98.1	20	1.9	1019	94.8	56	5.2	1026	95.4	49	4.6	1061	98.7	14	1.3
Maret	1201	99.17	10	0.83	1128	93.15	83	6.85	1196	98.76	15	1.24	1187	98.02	24	1.98
April	1204	99	12	1	1148	94	69	6	1200	99	16	1	1185	97	31	3
Mei	1265	98	12	2	1175	92	99	8	1229	94	50	6	1246	97	28	3
Juni	1164	99.87	4	0.13	1127	96.87	41	3.13	1150	98.31	19	1.69	1162	99.72	6	0.28
Juli	1281	99,89	3	0,10	1281	99,89	3	0,11	1281	99,89	3	0,11	1281	99,89	3	0,11

KELENGKAPAN																
PERAWAT																
BULAN	Pengkajian Keperawatan				CPPT				Asuhan Keperawatan				Resume Keperawatan			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	1070	99.5	5	1048	1048	1048	1048	1.8	1056	98.2	1	0.1	1074	99.9	1	0.1
Maret	1200	98.68	16	1.32	1189	97.78	27	2.22	1214	99.84	2	0.16	1193	98.11	23	1.89
April	1240	99	10	1	1233	99	17	1	1242	99	8	1	1229	98	21	2
Mei	1270	99	7	1	1240	98	37	2	-	-	-	-	1267	99	10	1
Juni	1184	100	0	0	1177	99.49	7	0.51	-	-	-	-	1182	99.80	2	0.20
Juli	1289	100	0	0	1289	100	0	0	-	-	-	-	1289	100	0	0

KELENGKAPAN																
BULAN	AHLI GIZI								APOTEKER							
	Pengkajian Awal Gizi				CPPT				Rekonsialisasi Obat				CPPT			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	944	92	82	8	944	92	82	8	1010	98	16	2	912	89	114	11
Maret	1049	97.6	26	2.4	1074	99.9	1	0.1	1066	99.2	9	0.8	1067	99.3	8	0.7
April	1249	99.9	1	0.1	1250	100	0	0	1247	99.8	3	0.2	1250	100	0	0
Mei	753	72	266	25	1019	100	0	0	1298	100	0	0	1298	100	0	0
Juni	661	66	372	34	1032	99.91	1	0.09	1173	99.95	1	0.05	1172	98.8	2	1.2
Juli	666	58	563	48	1124	99,65	5	0,35	1269	96,67	1	3,33	1272	96,67	1	3,33

3.1.1.6 3.1.1.6 Grafik Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Bulan Juli 2025



Analisis :

- 1. Ketidaklengkapan DRM Ahli Gizi mengalami peningkatan pada dokumen pengkajian awal medis gizi sebanyak 563 dokumen tidak lengkap.
- 2. Pengkajian keperawatan 100% lengkap pada Bulan Juli 2025.
- 3. Masih ditemukan ketidaklengkapan pengkajian awal medis oleh DPJP pada Bulan Julski 2025.

Rencana Tindak Lanjut :

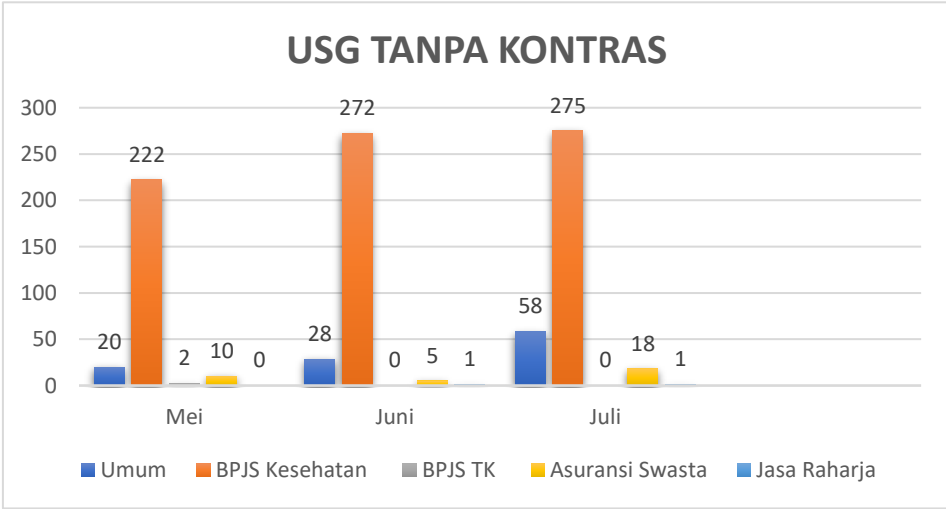
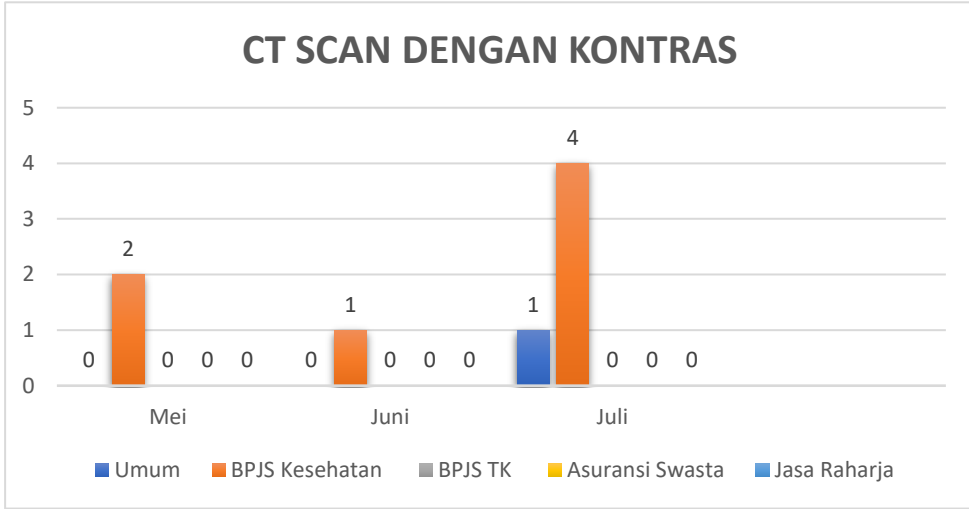
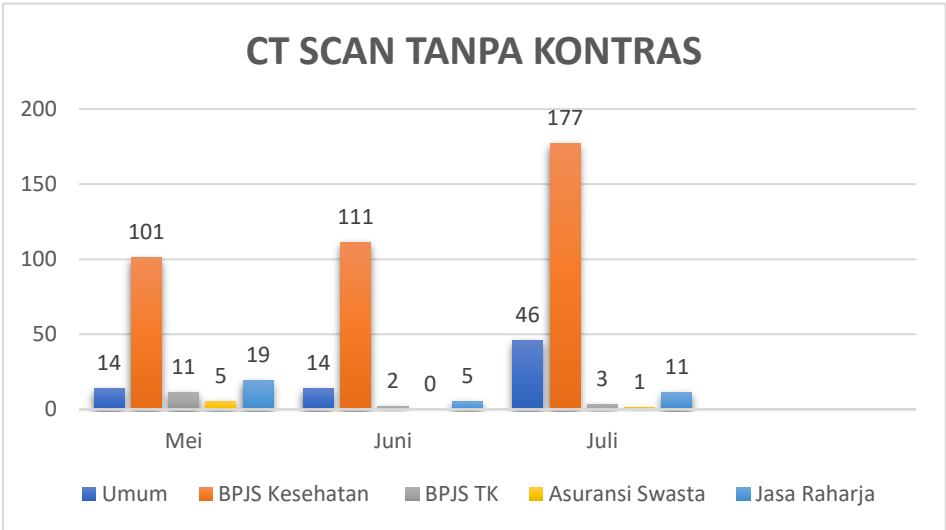
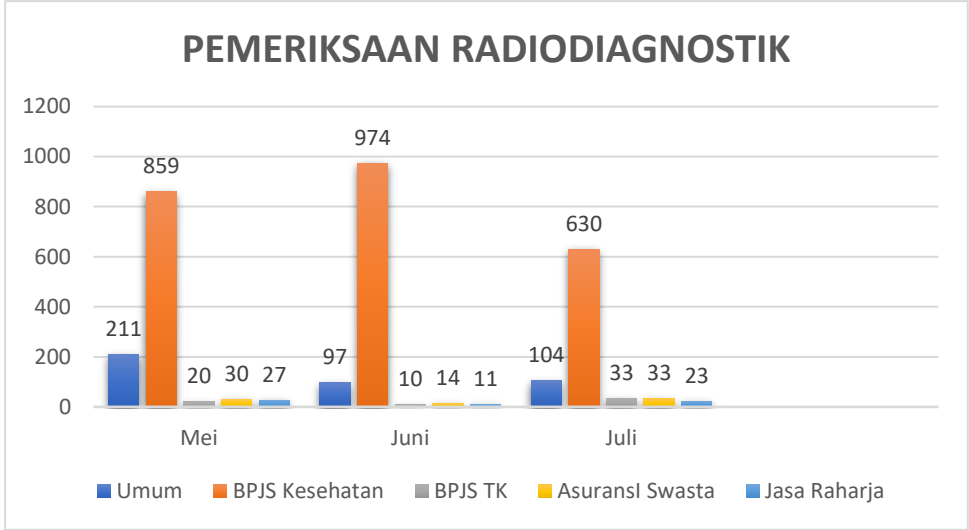
- 1. Menginformasikan kepada KARU hasil audit ketidaklengkapan DRM untuk melengkapi kekurangannya.
- 2. Melakukan supervise secara berkala.
- 3. Trial ERM Rawat Inap, diperlukan warning jika form belum terisi lengkap sehingga tidak bisa melanjutkan ke menu berikutnya.
- 4. Sosialisasi saat Rapat Unit, cara pengisian DRM.
- 5. Membuat rapot ketidaklengkapan .
- 6. Kolaborasi dengan Kabid Pelayanan dan Kabid Keperawatan.

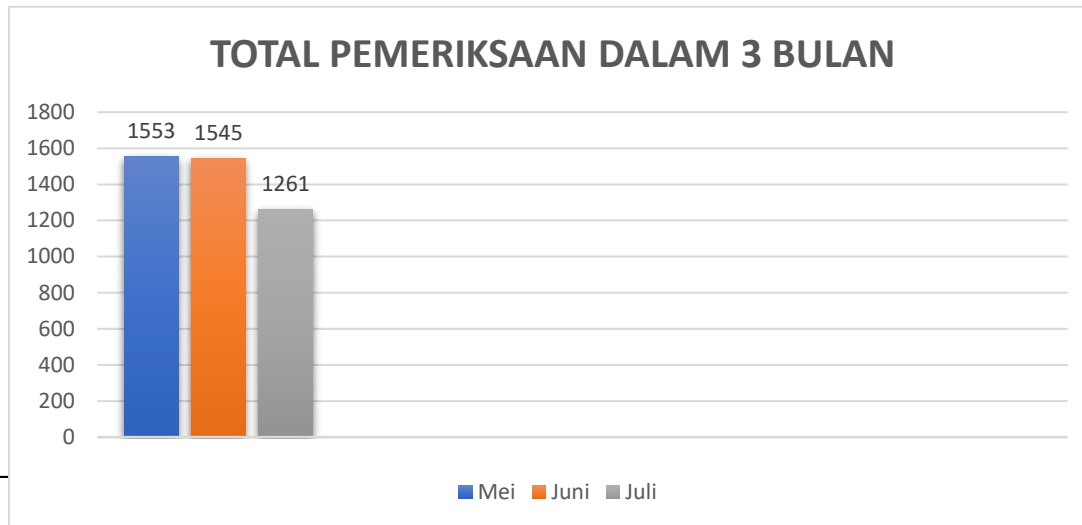
6.2.4 Radiologi

6.2.4.1 Tabel Jumlah Pemeriksaan Radiologi Mei - Juli 2025

NO	JENIS PEMERIKSAAN	PENJAMIN	BULAN		
			MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025
1.	RADIOLOGI	UMUM	211	97	104
		BPJS KESEHATAN	859	974	630
		BPJS TK	20	10	36
		ASURANSI SWASTA	30	14	33
		JASARAHARJA	27	11	23
	TOTAL		1147	1106	826
2.	CT SCAN TANPA KONTRAS	UMUM	14	14	46
		BPJS KESEHATAN	101	111	177
		BPJS TK	11	2	3
		ASURANSI SWASTA	5	0	1
		JASARAHARJA	19	5	11
	TOTAL		150	132	78
3.	CT SCAN DENGAN KONTRAS	UMUM	0	0	1
		BPJS KESEHATAN	2	1	4
		BPJS TK	0	0	0
		ASURANSI SWASTA	0	0	0
		JASARAHARJA	0	0	0
	TOTAL		2	1	5
4.	USG TANPA KONTRAS	UMUM	20	28	58
		BPJS KESEHATAN	222	272	275
		BPJS TK	2	0	0
		ASURANSI SWASTA	10	5	18
		JASARAHARJA	0	1	1
	TOTAL		254	306	352
TOTAL KESELURUHAN			1553	1545	1261

6.2.4.2 Grafik Jumlah Pemeriksaan Radiologi Mei - Juli 2025





Analisis :

1. Pelayanan pemeriksaan selama Bulan Juli 2025 meliputi Radiodiagnostik, USG dan CT Scan, terbagi menjadi pasien UMUM, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi Swasta dan Jasaraharja.

Pada Bulan Juli 2025 pemeriksaan terbanyak, yaitu :

- a. Radiodiagnostik : 826
 - b. USG Tanpa Kontras : 352
 - c. CT Scan Tanpa Kontras : 78
2. Jumlah total pemeriksaan selama Bulan Juli 2025 adalah sebanyak 1261 pemeriksaan.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Koordinasi dengan Humas & Marketing untuk meningkatkan kunjungan di Radiologi dengan cara :
 - a. Melakukan kerja sama dengan RS yang belum memiliki CT Scan untuk meningkatkan pendapatan.
 - b. Mengajukan MCU kepada perusahaan-perusahaan besar di Kab/Kota Malang.
2. Kolaborasi dengan Humas & Marketing untuk mengawal Polisi LAKA supaya tetap melakukan rujukan LAKA LANTAS ke RS Prima Husada Malang.
3. Mendokumentasikan respon time pelayanan Radiologi menggunakan Google Spreadsheet, sambil menunggu waktu selesai hasil dimunculkan di Hasil Bacaan oleh Programmer PT.

6.2.4.3 Tabel Laporan Ulang Hasil Bulan Mei - Juli 2025

NO	NAMA DOKTER	NAMA PASIEN	BACAAN AWAL	BACAAN ULANG	TOTAL
Bulan Maret 2025					
1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	By Ny Zaimatus (227984)	Normal	Pneumonia	2
2.		Kasti (073280)	Normal	Infark Akut	
3.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	Agus Wahyu (114824)	Spondylosis	Compresi Fractura	1
Bulan April 2025					
1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	Ny Sri Asnanik (224631)	CVA Infark	CVA Infark	2
2.		Dian Nihayatul (212732)	Normal	Normal	
3.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	0	0	0	0
Bulan Mei 2025					
1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	Sumroti (231733)	Cardiomegali	Cardiomegaly dan Pneumonia	2
2.		Roeskandar	Lung Tumor	Lung Tumor dan Pneumonia	
1.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	Rizka Anada	Normal	Fracture Scapulla	1
Bulan Juni 2025					
1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	0	0	0	0
2.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	Kiki Nur Ika Sari (232011)	Normal	Tetap Normal	1
Bulan Juli 2025					
1	dr. AgungSp.Rad (K)	- Eko sutaji (189842) - Sabar (195701)	-Normal -Normal	- Pulmonary hipertension - Pneumonia	2
2	dr. Rumbiyo Yudho Sp.rad	0	0	0	0

Analisis :

Pada Bulan Juli Tahun 2025 terdapat pembacaan ulang pemeriksaan ke radiologi. Hal ini disebabkan karena klinis tidak ditulis secara lengkap pada surat permintaan radiologi.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Kolaborasi dengan MOD dan Kabid Pelayanan jika ada complain DPJP untuk melaporkan ke Radiologi dan Kabid Penunjang Medis.
2. Kolaborasi dengan Kabid Pelayanan dan Kabid Keperawatan untuk melengkapi pemeriksaan klinis pada surat pengantar supaya dapat menunjang hasil pemeriksaan.

6.2.4.4 Tabel Rata-Rata Respon Time Pembacaan Pemeriksaan Radiologi

NO	PEMERIKSAAN	RATA-RATA WAKTU (menit)			
		dr Agung, Sp.Rad (K)		dr Yudho, Sp.Rad	
		SELESAI PERIKSA	SELESAI PEMBACAAN	SELESAI PERIKSA	SELESAI PEMBACAAN
1.	Ro Thorax PA/AP	3	25-180	3	10-1440
2.	Ro Vertebrae	-	-	4	10-1440
3.	Ro Abdomen	-	-	10	10-1440
4.	Ro Extremitas	-	-	2	10-1440
5.	Ro Skull	-	-	2	10-1440
6.	USG Abdomen	8	5	15	10
7.	CT Scan Non Kontras	5	30-24	-	-
8.	CT Scan Dengan Kontras	15	25-24	-	-
9.	Radiologi CITO	10	04-25	10	10

Analisa :

1. Rata-rata pemeriksaan radiologi adalah 3 menit dengan rata-rata hasil pembacaan radiologi 25 menit untuk dr Agung, Sp.Rad (K), hal ini disebabkan karena hasil rontgen dapat dikonsultasikan via pesan whatsapp. (Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam).
2. Rata-rata pembacaan radiologi oleh dr Yudho, Sp.Rad adalah 1440menit/24 jam, tidak sesuai dengan target standar RS. Hal ini disebabkan karena adanya pembagian jobdesk konsulan, dr Yudho, Sp.Rad tidak berkenan dikonsuli via pesan whatsapp dan dibacakan saat praktik keesokan harinya.
3. Pembacaan elektif dilakukan oleh dr Yudho, Sp.Rad saat praktik. (Semua foto Vertebrae, Ekstremitas, Abdomen, dan Skull).
4. Terdapat pembacaan CITO selama bulan Juli 2025 dan hasil *ekspertise* sesuai target yakni kurang dari 30 menit
5. Semua pemeriksaan CT Scan dibacakan oleh dr Agung, Sp.Rad (K).
6. Terdapat kekosongan jam pelayanan radiologi pada siang hari.
7. Pembacaan hasil pemeriksaan radiologi oleh dr Agung, Sp.Rad, diatas target standar RS yakni 420-1440 menit dikarenakan hasil jadi diatas pukul 00.00 WIB dan DPJP meminta dibacakan oleh dr Agung, Sp.Rad.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Menemui kedua DPJP Radiologi untuk menambah jam praktik.
2. Memberikan surat pemberitahuan kepada Kepala Kolegium Radiografer bahwa RS membutuhkan tambahan DS Radiologi untuk mengisi jadwal praktik siang hari, sudah diterima oleh dr Agung, Sp.Rad.
3. Melakukan supervise pencatatan respon time pada Google Spreadsheet.
4. Membuat perjanjian dengan Kains Radiologi (dr Agung, Sp.Rad (K)) selama belum terpenuhi dokter untuk merespon konsulan secara cepat.

6.2.4.5 Tabel Angka Komplain DPJP Terhadap Keterlambatan Hasil Pembacaan Radiologi pada April – Juni 2025

NO	NAMA PASIEN	NAMA DPJP	PEMERIKSAAN	WAKTU	
				SELESAI PERIKSA	SELESAI HASIL
1.	-	-	-	-	-

Analisis :

Pada Bulan Juni tidak ada komplain DPJP dan Dokter Umum karena keterlambatan hasil pembacaan radiologi.

Hal ini disebabkan, selain waktu tunggu cito tidak melebihi standar, bisa disebabkan ketidakpahaman petugas pelayanan dalam melaporkan complain sehingga tidak terdokumentasikan dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut :

Kolaborasi dengan MOD dan Kabid Pelayanan jika ada complain DPJP untuk melaporkan ke Radiologi dan Kabid Penunjang Medis.

6.2.4.6 Tabel PMI dan PME di Radiologi

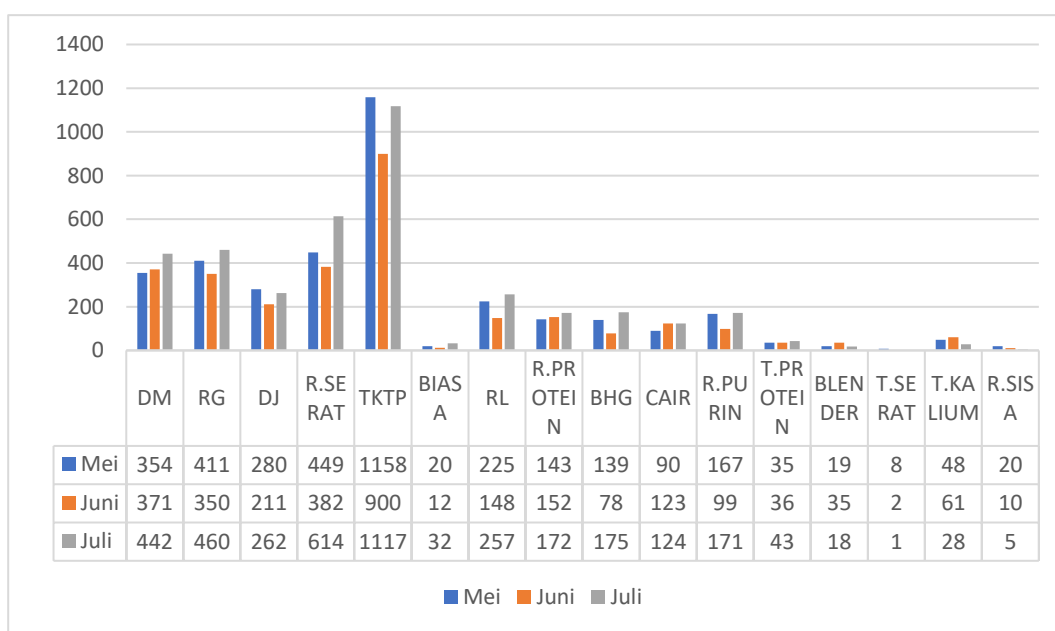
No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Sasaran Kegiatan
Pemantapan Mutu Internal (PMI)			
1.	Mencatat waktu tunggu pelayanan foto	Mencatat waktu mulai pengerjaan hingga hasil diserahkan.	1. Respons time pelayanan radiologi terukur dan sesuai standar. 2. Pengendalian kegagalan foto dan meminimalkan pengulangan. 3. Mengendalikan penggunaan BMHP radiologi.
2.	Mencatat jumlah Reject Film	Mencatat kegagalan foto (review pembacaan dan review hasil radiograf)	
3.	Memonitor pemakaian BMHP	Memonitor penyimpanan, pemeliharaan dan pemakaian bmhp.	
Pemantapan Mutu Eksternal (PME)			
1.	Melakukan uji paparan radiasi	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	1. Peralatan radiologi dalam kondisi siap pakai. 2. Standarisasi pelayanan radiologi rujukan.
2.	Melakukan uji akurasi tegangan	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	
3.	Pengukuran TLD Badge	Kegiatan pengukuran dilakukan setiap 3 bulan sekali ke BPFK (Balai Pengaman Fasilitas .Kesehatan)	
4.	Kalibrasi alat radiologi	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali.	
5.	Uji kesesuaian	Pengujian kondisi alat dilakukan setiap 4 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	
6.	Sertifikat kalibrasi	Memastikan sertifikat kalibrasi rs rujukan masih berlaku	

2.4.5 Gizi

2.4.5.1 Tabel Pemesanan Diit Mei - Juli 2025

NO	NAMA DIIT	BULAN			PROSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA (%)
		APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025	
1.	Diabetes Melitus	354	371	442	19
2.	Rendah Garam	411	350	460	31
3.	Jantung	280	211	262	24
4.	Rendah serat	449	382	614	60
5.	TKTP	1158	900	1117	24
6.	Makanan biasa	20	13	32	146
7.	Makanan Lunak	0	0	5	0
8.	Rendah Lemak	225	148	257	73
9.	Rendah Protein	143	152	172	13
10.	Bubur Halus	139	78	175	124
11.	Cair	90	123	124	81
12.	Rendah Purin	167	99	171	72
13.	Tinggi Protein	35	36	43	19,4
14.	Blender	19	35	18	-48
15.	Tinggi serat	8	2	1	-50
16.	Tinggi Kalium	48	61	28	-54
17.	Rendah Kalium	20	10	20	100
18.	Rendah Sisa	4	10	5	-50
TOTAL		3652	2981	3946	32

2.4.5.2 Grafik Jumlah Pesanan Diit Mei - Juli 2025



Analisis :

1. Jumlah pemberian diit pasien rawat inap pada Bulan Juli mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya.
2. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pemesanan diit terbanyak selama Bulan Juli 2025 adalah TKTP sebanyak 1117, berbanding lurus dengan diagnose terbanyak di rawat inap yaitu Thypoid Fever dengan kebutuhan diit TKTP.
3. Dari hasil survey kepuasan pasien terhadap menu makanan tidak ditemukan penurunan kepuasan terhadap variasi makanan.

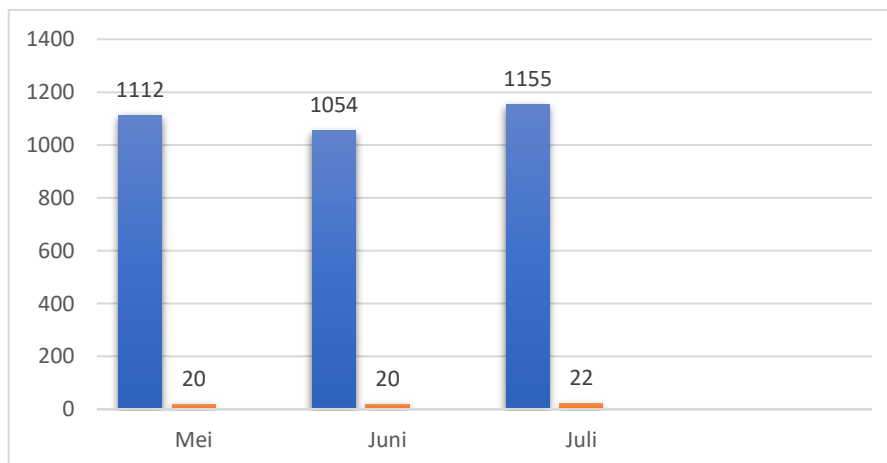
Rencana Tindak Lanjut :

1. Koordinasi dengan humas dan marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat inap. Evaluasi kembali terkait kepuasan pasien terhadap variasi menu makanan.
2. Mengajukan pelayanan catering makanan untuk pemulihan pasien saat pulang rawat inap.
3. Kolaborasi dengan layanan primantara (pengantaran obat) untuk MCU Gizi gratis sebagai reward.
4. Melakukan perbaikan menu makanan dan plating sesuai dengan kelas pasien.
5. Kolaborasi dengan PKRS untuk membuat leaflet menu makanan dan diupload di Sosial Media.
6. Perbaikan pencatatan food waste dipisahkan setiap menu makanan untuk mengetahui menu makanan mana yang tidak diminati.

2.4.5.3 Tabel Jumlah Konsultasi Gizi April - Juni 2025

NO	INDIKASI	JUMLAH PASIEN		
		MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025
1.	Konsultasi Rawat Inap	1122	1054	1155
2.	Konsultasi Rawat Jalan	20	20	22

2.4.5.4 Jumlah Konsultasi Gizi pada Bulan Juni Tahun 2025



Analisis :

1. Jumlah konsultasi gizi rawat inap pada Bulan Juli 2025 meningkat
2. Jumlah konsultasi gizi rawat jalan pada Bulan Juli 2025 kondisi stabil.
3. Tidak semua DPJP memberikan rujukan ke Poli Gizi, rujukan diterima dari Poli Jantung dan Poli IPD saja ketika pasien bertanya terkait pantangan makan saat control ke Poli Spesialis.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Merancang pengembangan pelayanan MCU Konsultasi Gizi dengan perusahaan.
2. Koordinasi dengan Humas Marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan.
3. Koordinasi dengan Kabid Pelayanan agar DPJP merujuk pasien ke Poli Giz

2.4.5.5 Tabel Rekap Data Komplain Pasien Terhadap Gizi Bulan Juni 2025

NO	JENIS KOMPLAIN	NAMA PASIEN	ANALISIS	RENCANA TINDAK LANJUT	TOTAL
Bulan Februari 2025					
1.	Makanan yang disajikan dan penjelasan mengenai menu makanan.	An Yuan (B3C-4 IRNA 3C Anak) Isi Komplain : Menu yang didapat tidak bervariasi dibandingkan dengan terakhir kali pasien rawat inap (siklus menu berulang)	1. Siklus menu yang berlaku di RS Prima Husada Malang adalah siklus menu 10 hari+1 hari 2. Pasien MRS pada hari dimana siklus menu yang sama dengan hari MRS sebelumnya.	Melakukan analisis asupan makan pasien selama rawat inap untuk melihat daya terima pasien tersebut terhadap menu yang disajikan	1
Bulan Maret 2025					
Tidak ada komplain					
Bulan April 2025					
Tidak ada komplain					
Bulan Mei 2025					
1.	Keluhan pasien dan OB yang belum mendapatkan makanan	An Abimanyu Putra Herlambang (C3C-8, IRNA 3C Anak) Isi Komplain : Ayah pasien menyampaikan bahwa jika pasien belum selesai makan maka jangan mengambil	1. Jam pengambilan makan adalah 1 jam setelah pembagian makan. 2. Pasien mengalami penurunan nafsu makan sehingga	1. Koordinasi dengan tim penyaji untuk memberikan edukasi terkait jam pengambilan alat makan yaitu 1 jam setelah	1

		makanan pasien terlebih dahulu.	mengonsumsi makanan dalam waktu lebih lama.	pembagian makan. 2. Koordinasi dengan CS pantry untuk cara edukasi yang benar sebelum mengambil alat makan pasien.	
Bulan Juni 2025					
1.	Makanan yang disajikan dan penjelasan mengenai menu makanan.	Ny Nadiah Firliani Komplain melalui google review "makanannya kurang enak"	a. Pasien sakit mengalami penurunan nafsu makan dan penurunan citarasa b. Antara satu petugas pengolahan dan pengolahan lain memiliki selera rasa yang berbeda sehingga ketika memberi rasa pada makanan disesuaikan dengan selera petugas masing-masing	Koordinasi dengan seluruh petugas pengolahan dalam pembuatan standar resep masakan agar masakan yang dihasilkan sama antara satu petugas dengan petugas lain	1
Bulan Juli 2025					
1	Keluhan adanya benda asing dalam makanan pasien	- Ani Puji Lestari (C3a-6) komplain ada benang wol saat makan siang menu mie bihun, benang dikunyah saat makan oleh pasien. Pasien tidak langsung lapor, tapi	- Ahli gizi kurang teliti dalam melakukan QC makanan pasien - Petugas pengolahan tidak teliti dalam mengolah bihun. Tidak menggunting	- Koordinasi dengan seluruh petugas pengolahan, pemorsia, dan ahli gizi dalam menjaga kebersihan makanan dari benda asing	2

		mengisi kuesioner saat KRS. - Hana Rizki Anjani (3c anak) komplain sebaiknya pasien sering diberi menu sayur dan buah.	benang bahun dengan teliti sehingga ada benang yang tertinggal - Pasien anak dengan diagnosa TF diberikan advice DPJP diet rendah serat (tidak boleh mengkonsumsi sayur dan buah). Ahli gizi sudah menjelaskan diet kepada keluarga pasien. Keluarga pasien yang dijelaskan tidak mengoperkan kepada anggota keluarga yang lain. Ahli gizi tidak konfirmasi terkait informasi yang diberikan.	- Sosialisasi kepada seluruh ahli gizi jika setelah memberikan penjelasan melakukan konfirmasi terkait informasi yang diberikan.	
--	--	--	---	--	--

2.4.5.6 Tabel Rekap Food Waste (Sisa Makanan) bulan Mei - Juli 2025

NO	MENU	RINCIAN MENU	TOTAL SISA MAKANAN (KG)			KETERANGAN
			MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025	
1.	Karbohidrat	Nasi	174,7	120,7	134,5	75% dari sisa makanan berasal dari karbohidrat.
		Nasi Tim	245,1	178	204,5	
		Total	467,1	298,7	339	
2.	Snack	Roti Kukus	0	0	0,3	Snack yang memiliki sisa paling banyak adalah
		Setup Pisang	0,8	0,7	0,8	
		Kacang Hijau	0,7	0,7	0,4	
		Kue Hongkong	0	0	0,2	

	Terang Bulan		0	0	1,4	bubur sagu dan terang bulan.
	Bubur Sagu		1,1	1,2	1,9	
	Kue Lumpur		0	0,5	0,8	
	Puding		0	0	0,5	
	Donat		0	0	0,8	
	Tahu Fantasi		0,4	0	1,0	
	Sagu Mutiara		0	0	0,7	
	Total		1,1	3	8,8	
1.	Menu 1					Menu 4 adalah menu paling tidak diminati, sisa makanan sebanyak 12,3 Kg
	Bulan		Mei 2025	Juni 2025	Juli 2025	
	Pagi	Semur (Tahu, Buncis, Bakso)	2,6	2,5	3,4	
		Rolade Ayam	2,2			
	Tambahan VIP	Tempe Goreng	0,2			
	Siang	Sup Kemangi (Jagung, Wortel, Oyong, Kemangi)	2,1	1,3	4,1	
		Ayam Kecap	2,1			
		Tahu Bumbu Tomat	0,8			
	Tambahan VIP	Telur Ceplok	0,2			
	Sore	Rawon (Daging Slice, Manisah Dadu, Cambah Pendek)	0,8	1,5	4,4	
		Tempe Goreng	0,5			
	Tambahan VIP	Perkedel	0			
	Total		11,5	5,3	11,9	
2.	Menu 2					
	Bulan		Mei 2025	Juni 2025	Juli 2025	
	Pagi	Sup (Manisah, Ayam Dadu, Wortel, Bihun)	5,4	2,5	3,5	
		Tahu Rempah (Remet)	3,1			
		Abon	0,8			
	Tambahan VIP	Telur Rebus	0,2			
	Siang	Sayur Bening (Bayam, Jagung, Wortel, Manisah)	3,9	2	3	
		Ayam Wijen	4			

		Bakwan Jagung	2,2		
	Tambahan VIP	Telur Gulung	0,2		
	Sore	Koloke (Ayam Goreng Fillet, Timun, Wortel)	5,4	2,7	3,2
		Tempe Goreng	2,5		
	Tambahan VIP	Bakso Goreng Mekar	0,2		
	Total		27,8	7,2	9,7
3.	Menu 3				
	Bulan		Mei 2025	Juni 2025	Juli 2025
	Pagi	Sup (wortel, Sawi Putih, Ayam Dadu)	3,7	2,3	3,3
		Tahu Krispy	2		
		Abon	0,3		
	Tambahan VIP	Telur Ceplok	0,3	4,1	3,8
	Siang	Sayur Asem (Wortel, Kacang Panjang, Manisah)	1,9		
		Rolade Ayam	2,1		
		Tahu Goreng	0,9		
	Tambahan VIP	Tempe Bacem	0,3		
	Sore	Oseng (Jamur Kuping, Wortel, Bakso, Kacang Polong)	2,1	4,5	4,4
		Ayam Bombay	2,8		
		Tempe Orek	1,5		
	Tambahan VIP	Telur Dadar	0,6		
	Total		18,5	10,9	11,5
4.	Menu 4				
	Bulan		Mei 2025	Juni 2025	Juli 2025
	Pagi	Sayur Bobor (Selada Air, Manisah, Kemangi)	3,5	3,2	3,6
		Tahu Nugget	1,8		
		Abon	0,2		
	Tambahan VIP	Oseng Bakso	0,5		

		Mekar			
	Siang	Sup (Oyong, Wortel, Jagung)	3,1	5,3	4,1
		Ayam Kecap	2,4		
		Jamur Krispy	1,3		
	Tambahan VIP	Tahu Bacem	0,3		
	Sore	Soto Ayam (Soun, Kubis, Seledri, Ayam Suwir)	3,3	5,6	4,6
		Telur Rebus	2,3		
		Tempe Goreng	2,3		
	Tambahan VIP	Keripik Kentang	0,5		
	Total		18,9	14,1	12,3
5.	Menu 5				
	Bulan		Mei 2025	Juni 2025	Juli 2025
	Pagi	Sup (Bunga Kol, Sawi Daging, Bakso, Wortel)	3,4	2	3,4
		Opor Tahu	2,2		
		Oper Telur	1		
	Tambahan VIP	Tempe Goreng	0,5		
	Siang	Sayur Bening (Bayam, Jagung, Manisah)	3,4	4,1	3,4
		Ayam Bombay	4,5		
		Bakwan Jagung	2,7		
	Tambahan VIP	Tahu Krispy	0,1		
	Sore	Sup Merah (Bakso, Ayam Dadu, Polong, Wortel)	1	3,9	2,7
		Tempe Goreng	0,7		
		Telur Dadar	0,2		
	Total		19,7	10	9,5
6.	Menu 6				
	Bulan		Mei 2025	Juni 2025	Juli 2025
	Pagi	Semur (Tahu, Buncis, Bakso)	2,2	2,8	3,1
		Orak Arik (Wortel, Kubis, Daun Bawang, Telur)	2,1		

		Tempe Goreng	1,9		
	Tambahan VIP	Ayam Goreng	0,8		
	Siang	Sup Kemangi (Jagung, Wortel, Oyong, Kemangi)	3,1	2,1	1,6
		Ayam Laos	4,5		
		Tahu Bumbu Tomat	1,6		
	Tambahan VIP	Telur Ceplok	0,6		
	Sore	Rawon (Daging Slice, Manisah Dadu, Cambah Pendek)	2	4,2	2,4
		Tahu Krispy	1,5		
	Tambahan VIP	Perkedel	0,7		
	Total		21	9,1	7,1
7.	Menu 7				
	Bulan		Mei 2025	Juni 2025	Juli 2025
	Pagi	Cah Sawi (Sawi Putih, Wortel Serut, Ayam Dadu)	2,8	3,3	2,9
		Telur Ceplok Bumbu Kuning	5,7		
		Abon	0,3		
	Tambahan VIP	Tempe Bacem	0,5		
	Siang	Sup (Wortel Dadu, Jamur Es, Polong, Bakso)	1,8	2,4	3,8
		Ayam Ungkep	1,8		
		Perkedel	1,1		
	Tambahan VIP	Jamur Krispy	0		
	Sore	Koloke (Ayam Goreng Fillet, Timun, Wortel)	1,8	3,4	5,5
		Tempe Goreng	1		
	Tambahan VIP	Telur Dadar	0,2		
	Total		17	9,1	12,2
8.	Menu 8				
	Bulan		Mei 2025	Juni 2025	Juli 2025
	Pagi	Sayur Bobor	2,2	2,2	3,7

		(Manisah, Sawi Hijau)			
		Tahu Nugget	2,3		
		Abon	0,6		
	Tambahan VIP	Ayam Fillet Tepung	0,5		
	Siang	Sayur Asem (Wortel, Jagung, Manisah)	1,6	2	3,7
		Ayam Bakar	2		
		Tahu Goreng	1		
	Tambahan VIP	Nugget Ayam	0		
	Sore	Semur (Ayam Fillet, Soun, Daun Bawang, Tomat)	1,5	2	3,8
		Botok Tahu	2,1		
		Abon	0,2		
	Tambahan VIP	Tempe Goreng	0		
	Total		14	6,2	11,2
9.	Menu 9				
Bulan		Mei 2025	Juni 2025	Juli 2025	
Pagi	Tumis (Bakso, Wortel, Buncis)	2,2	6,2	3,6	
	Tahu Rempah	1,2			
	Abon	0,1			
Tambahan VIP	Telur Dadar	0,7			
Siang	Sup (Bihun, Wortel, Pokcoy)	2,7	4,5	3,2	
	Ayam Kemangi	2,4			
	Tahu Krispi	1,5			
Tambahan VIP	Bakso Goreng Mekar	0,4			
Sore	Soto Ayam (Soun, Kubis, Seledri, Ayam Suwir)	2,3	4,8	3,4	
	Telur Rebus	1,6			
	Tempe Goreng	1,1			
Tambahan VIP	Keripik Kentang	0,1			
Total		24	15,5	10,2	
10.	Menu 10				
Bulan		Mei 2025	Juni 2025	Juli 2025	

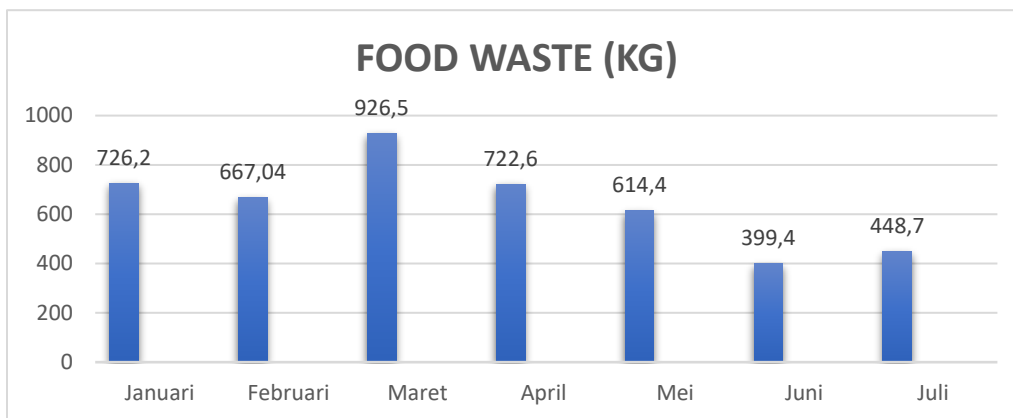
	Pagi	Sup (Wortel, Bakso, Sawi Putih)	1,8	2	3			
		Telur Ceplok	1,6					
		Abon	0,7					
	Tambahan VIP	Tempe Bacem	0,3					
	Siang	Sayur Bening (Bayam, Wortel, Jagung, Manisah)	3,1	3,1	2,8			
		Ayam Wijen	4,2					
		Tahu Goreng	1,4					
	Tambahan VIP	Telur Orak Arik	0					
	Sore	Capjay (Wortel, Kembang Kol, Sawi, Bakso, Ayam Dadu)	2	5,1	3,9			
		Tempe Goreng	1					
Tambahan VIP	Oseng Bakso Mekar	0,3						
Total			16,4	10,2	9,7			
11	Menu 11							
	Bulan		Mei 2025	Juni 2025	Juli 2025			
	Pagi	Sapo Tahu (Tahu, wortel,kembang kol, bakso)	1	-	1,8			
			Tempe Goreng	0,8			-	
			Abon	0,3			-	
		Tambahan VIP	Telur rebus	0,2			-	
	Siang	Sayur asem (Wortel, kacang panjang, manisah)	1,7	-	0,7			
			Ayam bakar	0,8			-	
			Bakwan jagung	0,9			-	
		Tmbahan VIP	Tahu Goreng	0,3			-	
	Sore	Semur (Ayam fillet, soun, daun bawang,tomat)	0,8	-	1,9		-	
			Tahu Rempah	0,5				-
			Abon	0				-
		Tambahan VIP	Jamur krispy	0,2				-

	Total	7,5	-	4,4	
	Total Sisa Menu tanpa KH	196,3	97,9	109,7	
	Total Keseluruhan dengan KH	663,4	396,6	448,7	

1.4.5.7 Tabel Rekap Food Waste Tahun 2025

No	Bulan	Total Sisa Makanan (kg)	Rata-Rata/Hari
1.	Januari 2025	726.2	23,42
2.	Februari 2025	667.04	23,82
3.	Maret 2025	926.5	29,88
4.	April 2025	722.6	24,08
5.	Mei 2025	614,4	19,81
6.	Juni 2025	399,4	13,3
7.	Juli 2025	448,7	14

1.4.5.8 Grafik Food Waste pada Bulan Juni Tahun 2025



Analisis :

1. Terdapat perubahan perhitungan sisa makanan pada Bulan Maret 2025, dimana perhitungan dipisahkan per menu dengan tujuan mengetahui menu makanan yang kurang diminati.
2. Dari data diatas, dapat diketahui bahwa ada kenaikan sisa makanan pada Bulan Juli 2025, yaitu sebanyak 448.7 kg, setelah dilakukan tindaklanjut mengurangi porsi nasi pada setiap penyajian dan memperbaiki dalam segi rasa dan penampilan.
3. Masih ditemukan sisa makanan selain karbohidrat, hal ini dipengaruhi beberapa faktor, antara lain :
 - a. Ada batasan diit yang dapat mempengaruhi rasa dan tampilan sehingga kurang menggugah selera.
 - b. Tidak ada pantangan dari keluarga pasien, sehingga konsumsi makanan dari luar / dibawa dari rumah, komunikasi/edukasi Ahli Gizi kurang diperhatikan.
 - c. Suasana lingkungan perawatan dan kondisi fisik pasien.

2.4.5.8 Lampiran Rekap Dara Kehilangan Alat Makan

NO	TANGGAL	NAMA PASIEN	RUANGAN	NAMA ALAT	BUKTI KUITANSI	DOKUMENTASI	KETERANGAN
Januari 2025							
1.	19/01/2025	Suratman	D7A-9	Sendok			Kasir salah nama
2.	21/01/2025	Anissa Octaviafitri Widodo	B5C-2	Sendok			Pasien sudah KRS
3.	26/01/2025	Aqilla Rassi Susanto	B2	Mangkuk Kecil			Sudah kembali
4.	31/01/2025	Ilma Ayuningsi	T4C-3	Gelas			Sudah pembayaran
Februari 2025							
1.	01/02/2025	Abid Fadhul Abyan	B3C-4	Sendok			Sendok hilang pasien sudah pulang
2.	01/02/2025	Cholifah	B5C-4	Sendok			Sendok hilang pasien sudah pulang
3.	04/02/2025	Widya Dwi Anandita	D6A-11	Sendok			Sendok hilang pasien sudah pulang
4.	05/02/2025	Arzanka Daneswara Ghazali	A1	Sendok Makan			Sendok terbawa pulang
5.	05/02/2025	Arzanka Daneswara Ghazali	A1	Sendok Snack			Sendok terbawa pulang
6.	06/02/2025	Chabibatul Aziizah	B3C-1	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
7.	06/02/2025	Mimi Eka	D4C-7	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
8.	19/02/2025	Ni'matul Udhma Himza	D3B-3	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
Maret 2025							
1.	11/03/2025	Muhammad Syifa	V3 (VIP)				Sendok hilang pasien sudah pulang
2.	24/03/2025	Pranata Dimas Ariansyah	C3C-10				Sendok hilang pasien sudah pulang
3.	25/03/2025	Mistianingsih	C3A-4				Sendok hilang

							pasien sudah pulang
April 2025							
1.	17/04/2025	Achmad Yogie Septiansyah	B2-5C	Gelas			Sudah pembayaran
Mei 2025							
1.	05/05/2025	Kasiati	D8A-12	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
2.	12/05/2025	Adhibah Mahirah Azizah	C3C-3	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
3.	28/05/2025	Ika Rodyana	D6A-8	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
Juni 2025							
-							
Juli 2025							
1	04/07/2025	Ahmad Subandi	D7A-1	Sendok Makan			Sendok Hilang Px Pulang
2	06/07/2025	Lili Anita	B3C-6	Gelas			Memecahkan Gelas
3	11/07/2025	Eka Maulidia Sari	V3 (VVIP)	Sendok Snack			Sendok Snack Hilang Px Sudah Pulang
4	11/07/2025	Arnemelia Ayunda Lestari	A2 (VIP)	Sendok Snack			Sendok Snack Hilang Px Sudah Pulang
5	11/07/2025	Arnemelia Ayunda Lestari	A2 (VIP)	Garpu			Garpu Hilang Px Sudah Pulang
6	11/07/2025	Sophia Alya Khairani	B3C-4	Sendok Makan			Sendok Makan Hilang Px Sudah Pulang
7	20/07/2025	Arya Raka Pratama	C3C-7	Sendok Makan			Sendok Makan Hilang Px Sudah Pulang

Analisis :

1. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 7 kehilangan alat makan pada Bulan Juli 2025.
2. Ada perubahan alur dan dilakukan supervisi oleh Koordinator CS.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Mencantumkan tata tertib menjaga fasilitas pada GC, sehingga petugas admisi dapat mengedukasi saat melakukan pendaftaran, jika pasien menghilangkan atau merusak fasilitas maka wajib mengganti. Sementara menggunakan catatan tertulis selama GC yang lama belum habis.
2. Melakukan supervisi “SPO Pengecekan Fasilitas RS Sebelum Pasien KRS”, sebagai panduan petugas dalam pelayanan dimana terdapat kolaborasi antara Instalasi Gizi, Perawat Ruangan, CS Pantry dan Ruangan, dan Kasir.

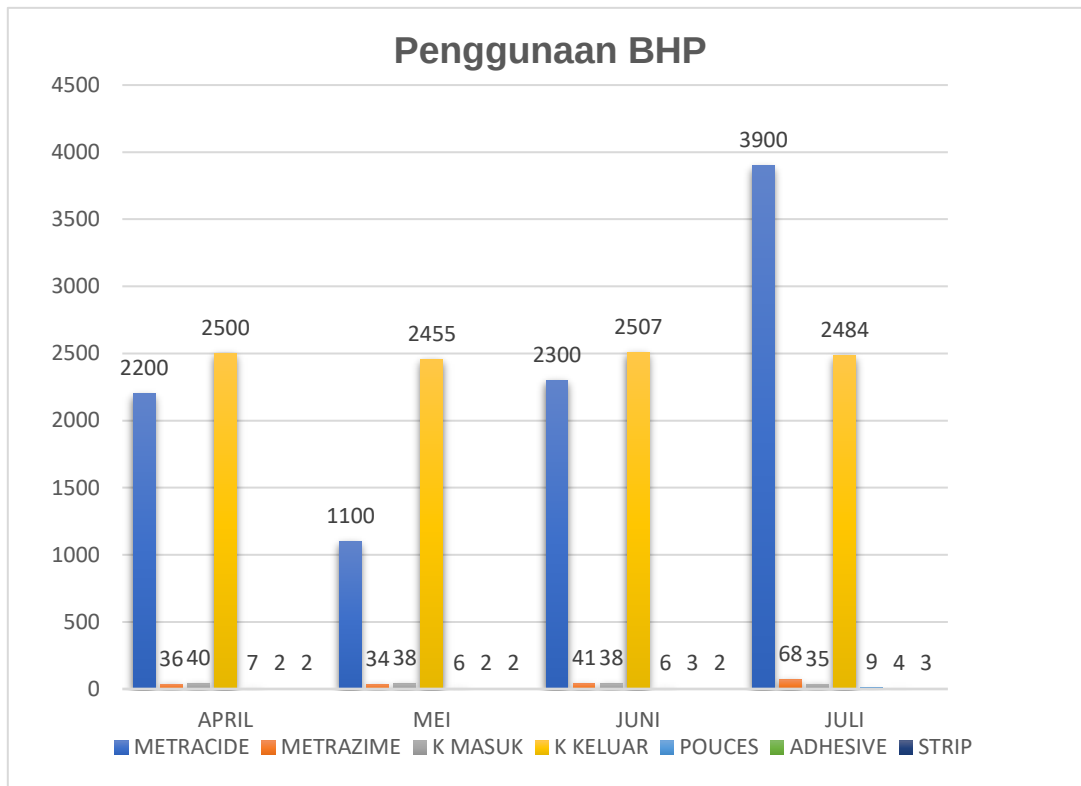
4.4.7 CSSD – Laundry

4.4.7.1 CSSD

4.4.7.2 Tabel Jumlah Pengeluaran Bahan Habis Pakai dan Alat yang Disetor ke CSSD Juli 2025

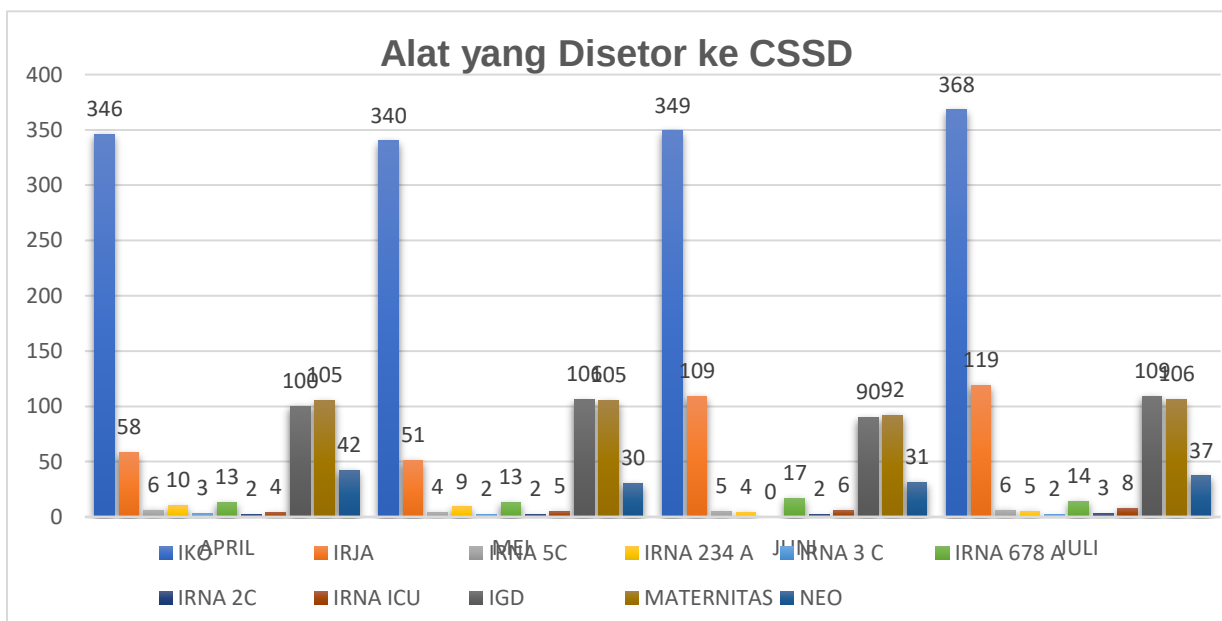
NO	HAL	BULAN TAHUN 2025		
		MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025
BHP				
1.	Chemical Alcacide (ml)	1100	2300	2900
2.	Chemical Alkazyme (pcs)	34	41	43
3.	Kassa Masuk (roll)	38	38	35
4.	Kassa Keluar (pouches)	2455	2500	2484
5.	BHP Pouces (roll)	6	6	6
6.	Indikator Adhesive (roll)	2	3	3
7.	Indikator Strip Steam (roll)	2	2	2
Alat Yang Disetor				
8.	IKO	340	349	368
9.	IRJA	51	109	119
10.	IRNA 5C	4	5	6
11.	IRNA 2A, 3A dan 4A	9	4	5
12.	IRNA 3C ANAK	2	0	2
13.	IRNA 6A, 7A dan 8A	13	17	14
14.	IRNA 2C VIP	2	2	3
15.	IRNA ICU	5	6	8
16.	IGD	106	90	109
17.	MATERNITAS	105	92	106
18.	NEONATOLOGI	30	31	37
Jumlah		667	705	777

4.4.7.3 Grafik Jumlah Alat Yang Disetor ke CSSD Bulan Juli 2025



Analisis :

1. Pada bulan Juli bhp yang mengalami peningkatan yaitu : metrazime , metracide, pouches, indicator strip, adhesive (permintaan dari gudang untuk RSDH)
2. Untuk kasa keluar steril dan kasa masuk roll mengalami penurunan



Analisis :

1. Pada bulan Juli jumlah alat yang disetor di CSSD yang mengalami peningkatan yaitu: IKO, IRJA, 3 C, 5 C, 2 C, IGD, NEO, MATERNITAS dan ICU
2. Sementara Pada bulan Juli alat yang disetor di CSSD yang mengalami penurunan yaitu lantai 6 7 8 A

Rencana Tindak Lanjut :

1. Memperbaiki pencatatan keluar masuk alat bersih dan kotor per bulan dengan kesepakatan alat yang dihitung.
2. Pendistribusian kasa steril dalam bentuk pouches terpusat di Gudang Farmasi, dengan jadwal permintaan BMHP seminggu 2x.
3. Monitoring dan Evaluasi pencatatan digital.
4. Melakukan orientasi petugas baru di CSSD.

4.4.7.4 Tabel Penggunaan Reuse Pada Bulan Juni Tahun 2025

Nama Alat	Reuse ke1
Junctionrees	-
Breathing circuit	-

Analisis :

Tidak ada permintaan alat reuse pada Bulan Juli 2025.

4.4.7.4 Tabel Hasil Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit CSSD

UNIT	BULAN				TOTAL
	APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025	
	Kejadian Instrument Kurang				
IKO	1	4	1	2	8
IGD	0	0	0	0	0
IRNA	0	0	0	0	0
IRJA	0	1	0	0	1
	Kejadian Instrumen Hilang				
IKO	0	0	0	0	0
IGD	2	0	0	0	2
IRNA	0	0	0	0	0
IRJA	0	0	1	0	1

Analisis :

1. Ditemukan kejadian instrument kurang di IKO, sebanyak 2 kali. Hal ini ditemukan ketika perawat setor alat kotor dan langsung dicek oleh petugas CSSD, setelah ditelusur ditemukan di unit.
2. Tidak ditemukan instrument hilang pada bulan Juli 2025

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan pencatatan saat ada penemuan.
2. Melaporkan temuan kepada Kabid Keperawatan untuk dilakukan pendisiplinan petugas.
3. Melakukan penggantian alat hilang oleh unit yang bersangkutan.

4.4.7.5 Tabel Rekap Data Permintaan Instrumen Cito 2025

UNIT	JUMLAH PERMINTAAN CITO			KETERANGAN
	APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025	
IKO	0	0	0	
IGD	0	0	0	
IRNA	0	0	0	
IRJA	0	0	0	

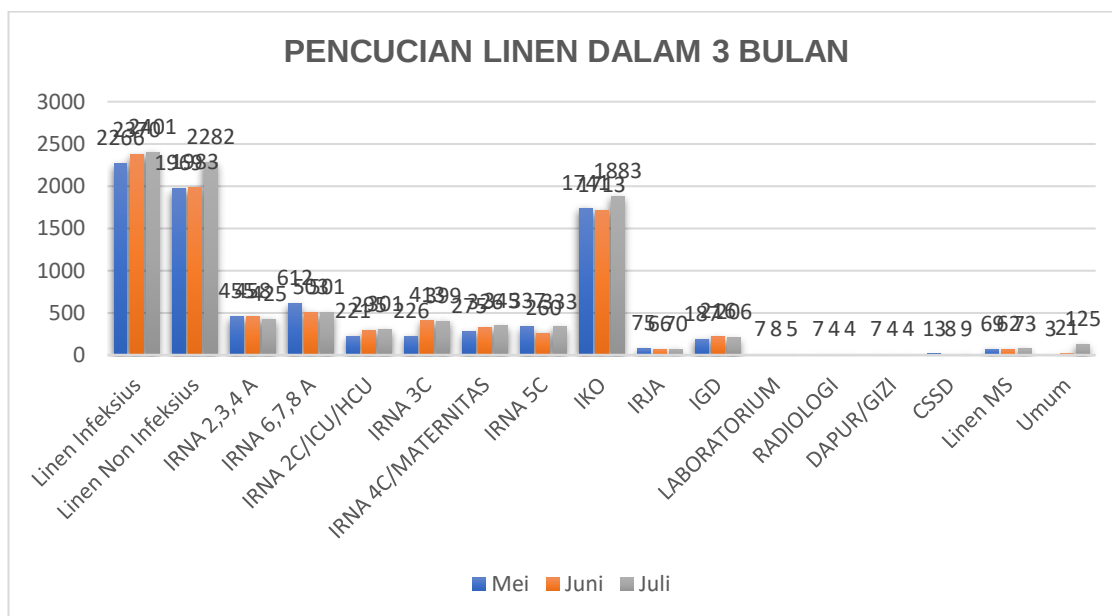
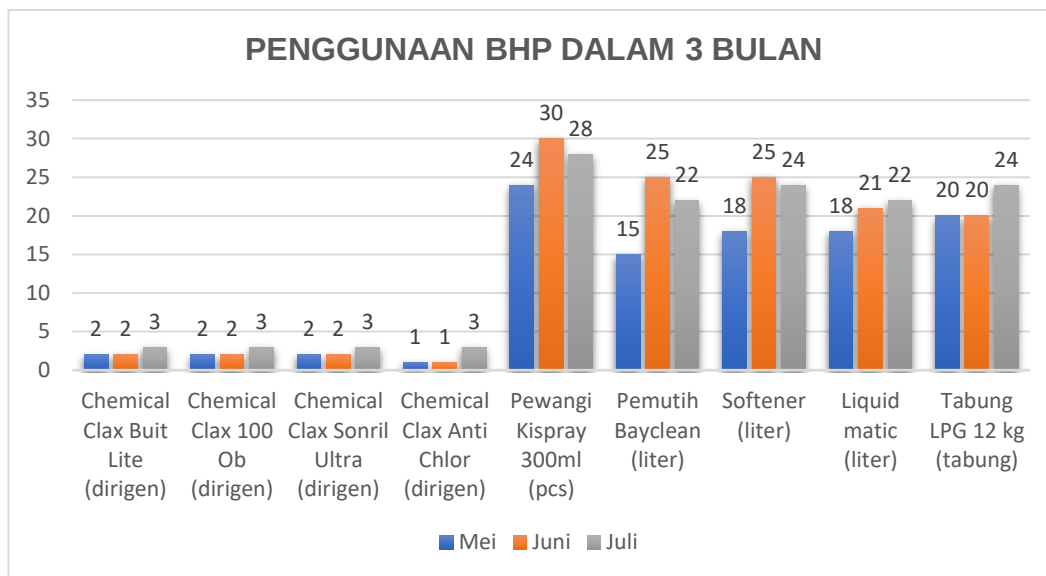
Analisis :

Tidak ada permintaan instrument cito selama 3 bulan terakhir, hal ini dipengaruhi ketertiban petugas dalam menyetorkan instrument kotor sehingga unit saat meminta alat selalu tersedia.

Rencana Tindak Lanjut : -**1.4.7.2 Laundry****1.4.7.2.1 Tabel Jumlah Pencucian Linen di Laundry pada Bulan Juni Tahun 2025**

NO	HAL	BULAN		
		MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025
1.	Chemical Clax Built Lite (dirigen)	2	2	3
2.	Chemical Clax 100 Ob (dirigen)	2	2	3
3.	Chemical Clax Sonril Ultra (dirigen)	2	2	3
4.	Chemical Clax Anti Chlor (dirigen)	1	1	3
5.	Pewangi Kispray 300ml (pcs)	24	30	28
6.	Pemutih Bayclean (liter)	15	25	22
7.	Softener (liter)	18	25	24
8.	Liquid matic (liter)	18	21	22
9.	Tabung LPG 12 kg (tabung)	20	20	24
TOTAL		102	128	132
LINEN (kg)				
1.	Linen Infeksius	2266	2370	2401
2.	Linen Non Infeksius	1969	1983	2282
3.	IRNA 2,3,4 A	455	458	425
4.	IRNA 6,7,8 A	612	503	501
5.	IRNA 2C/ICU/HCU	221	295	301
6.	IRNA 3C	226	413	399
7.	IRNA 4C/MATERNITAS	275	326	345
8.	IRNA 5C	337	260	333
9.	IKO	1741	1713	1883
10.	IRJA	75	66	70
11.	IGD	187	216	206
12.	LABORATORIUM	7	8	5
13.	RADIOLOGI	7	4	4
14.	DAPUR/GIZI	7	4	4
15.	CSSD	13	8	9
16.	Linen MS	69	62	73
17.	Umum	3	21	125
Total		4235	4353	9366

1.4.7.2.2 Grafik Jumlah Pencucian Linen di Laundry Pada Bulan Mei – Juli 2025



Analisis :

1. Data diatas adalah jumlah pencucian linen pada Bulan Juni 2025 sebanyak 9366kg, mengalami peningkatan 2x lipat dari bulan sebelumnya.
2. Jumlah linen infeksius sebesar 2401 kg, sebagian besar berasal dari IGD dan Maternitas. Linen infeksius berasal dari unit yang paling banyak tindakan.
3. Penggunaan BHP meningkat, sebanding dengan jumlah pencucian linen.
4. Terdapat peningkatan juga dikarenakan ada pencucian korden unit.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan breakdown pencatatan linen infeksius/non infeksius per unit.
2. Dilakukan perubahan alur permintaan linen bersih menggunakan digital form per unit, dilakukan pendistribusian sehari 2 kali untuk memenuhi kebutuhan unit sesuai dengan permintaan, yang dilaksanakan mulai awal Tahun 2025.
3. Rencana akan dilakukan pencatatan keluar masuknya linen menggunakan google spreadsheet per hari nya.
4. Rencana akan dilakukan stok opname setiap bulan.
5. Pemampatan jadwal dinas malam untuk memaksimalkan pekerjaan.
6. Perubahan alur pengambilan linen yang perlu disterilisasi, dilakukan oleh petugas CSSD karena petugas laundry yang kurang.

4.4.7.2.3 Tabel Inventarisasi Linen Laundry Pada Bulan Juli 2025

NO	NAMA / JENIS LINEN	MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025
1.	Sprei	205	160	142
2.	Sarung bantal	311	276	265
3.	Selimut	195	178	170
4.	Baju tim IKO	113	110	110
5.	Baju ganti pasien	40	37	36
6.	Skort	150	148	145
7.	Perlak	31	22	19
8.	Baju ganti laundry	15	14	14
9.	Duk lubang besar	21	20	20
10.	Duk pembungkus	56	56	54
11.	Duk kecil 1 meter	50	50	45
12.	Duk ortho	15	15	14
13.	Duk lubang kecil	17	17	17
14.	Duk kaki	11	11	11
15.	Meja mayo	20	20	20
16.	Skort IKO	61	61	61
17.	Waslap	64	59	55
18.	Handuk CSSD	10	10	10
19.	Bantal	131	129	126
20.	Baju Pasien	34	30	28

1.4.7.2.3 Tabel Rekap Kerusakan Linen dan Pemusnahan Pada Bulan Juli 2025

NO	NAMA / JENIS LINEN	MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025
1.	Sprei	15	45	18
2.	Sarung bantal	14	35	11
3.	Selimut	6	17	8
4.	Duk Pembungkus	3	0	2

5.	Duk Lubang Kecil	0	0	5
6.	Celana Tim IKO	1	3	0
7.	Baju Tim IKO	1	3	0
8.	Baju Pasien	1	7	1
9.	Skort	1	2	3
10.	Perlak	0	9	3
11.	Baju Ganti Laundry	0	1	0
12.	Duk Kecil	5	0	5
13.	Waslap	0	5	4
14.	Handuk CSSD	0	0	0
15.	Bantal	9	2	3
16.	Kerudung	0	0	0
17.	Kantung L	4	0	0
18.	Meja Mayo	0	0	0
Pemusnahan (+)		Tanggal 27/01/2025	Dijadwalkan 6 bulan sekali	Dijadwalkan 6 bulan sekali

Analisis :

1. Petugas melakukan sortir setiap hari, linen tidak layak dijadikan satu dan diajukan untuk dilakukan pemusnahan, BA sudah dikirim ke PT sebagai lampiran untuk penambahan linen pengganti.
2. Linen spre, selimut dan sarban yang rusak disebabkan karena sudah tipis dan bernoda yang sulit dikembalikan seperti semula.
3. Duk pembungkus dan duk kecil juga sudah tipis, sementara untuk baju tim yang rusak karena bolong dan tidak bisa dilakukan permak lagi.
4. Kantung linen juga banyak yang rusak karena jahitannya robek.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Follow up Pengadaan PT
2. Jadwal pemusnahan linen selanjutnya pada Bulan Juli 2025

1.4.7.2.4 Tabel Pelaporan Limbah atau Benda Asing Tercampur Linen Pada Bulan Juni Tahun 2025

NO	NAMA BENDA	JUMLAH		
		MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025
1.	Masker IKO	3	2	1
2.	Tissue	5	2	4
3.	Jarum	0	1	0
4.	Bumbu Dapur	0	0	0
5.	Uang	0	0	0
6.	Alat Tulis	1	0	0
7.	Benda lainnya	1 (selang oksigen)	1 (selang oksigen)	1 (selang oksigen)

Analisis :

1. Masih ditemukan benda asing tercampur dengan linen, karena pemilahan seharusnya dilakukan di Unit sebelum linen dimasukkan kedalam tong linen kotor.
2. Ketidakdisiplinan paling banyak dari Unit IKO.
3. Hal ini dapat menyebabkan kontaminasi terhadap linen lainnya dan dapat menyebabkan kerusakan pada mesin.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan sosialisasi kepada unit.
2. Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kemudian dilaporkan kepada Kabid Keperawatan dan SDM terkait hasil evaluasi.

4.4.7.5 Tabel Permintaan Linen Cito/Tidak Sesuai Jadwal Pada Bulan Juni 2025

UNIT	Tanggal	Jenis Linan	Jumlah	Alasan
-	-	-	-	-

Analisis :

Tidak ada permintaan linen cito dari unit, hal ini dikarenakan laundry memiliki jadwal permintaan linen sehari 2 kali, dan laundry standby 24 jam.

Rencana Tindak Lanjut :

4.5 Kinerja Bidang Umum dan Keuangan

4.5.7 SDM

3.5.7.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	1	0	0
2	Kabid Pelayanan Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
3	Kabid Penunjang Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	1	1	0	1	0
5	Kabid Umum & Keuangan	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Satuan Pengawas Internal	SMK	1	1	1	0	0
7	Dokter IGD	Dokter Umum	8	8	0	8	0
8	Dokter Casemix	Dokter Umum	2	2	0	2	0
9	Farmasi	Profesi Apoteker	43	13	6	7	0
		S1 Farmasi		3	2	1	0
		D3 Analis Farmasi dan Makanan		1	1	0	0
		D3 Farmasi		11	2	7	0
		SMK		4	3	1	0
		SMA		1	1	0	0
10	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	10	1	1	0	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		8	7	1	0
		SMK		0	0	0	0
		SMA		1	1	0	0
11	CSSD	D3 Keperawatan	5	3	2	1	0
		SMA		1	1	1	0
		SMK		1	0	1	0
12	Fisioterapi	S1 Fisioterapi	5	1	0	1	0
		D3 Fisioterapi		3	2	1	0
		D3 Terapi Wicara		1	0	1	0
13	Gizi	S1 Ilmu Gizi	17	2	2	0	0
		D4 Gizi dan Dietetika		2	2	0	0
		D3 Ahli Gizi		2	2	0	0
		SMK		7	0	7	0
		SMA		1	0	1	0
		SMP		3	2	1	0
14	Humas & Marketng	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	2	1	0	1	0
		S1 Teknik Informatika		1	0	1	0
15	ICU dan HCU	Profesi Ners	12	6	6	0	0
		D3 Keperawatan		6	5	1	0
16	IGD	Profesi Ners	23	10	7	3	1
		D3 Keperawatan		8	6	2	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
17	IKO	Profesi Ners	12	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
18	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
19	IPSRS	S1 Tenik Elektro	6	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0

		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0
		SMK		3	3	0	0
20	IRJA	Profesi Ners	27	8	7	1	1
		D3 Keperawatan		14	13	1	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
21	IRNA 2C	Profesi Ners	8	6	5	1	0
		D3 Keperawatan		2	2	0	0
22	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	18	5	4	1	0
		D3 Keperawatan		13	7	6	0
23	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	14	6	4	0	0
		D3 Keperawatan		7	7	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
24	IRNA 5C	Profesi Ners	8	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		5	4	1	0
25	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	22	10	4	6	3
		D3 Keperawatan		12	8	2	0
26	Maternitas	Profesi Kebidanan	11	1	0	1	0
		D4 Kebidanan		2	1	1	0
		D3 Kebidanan		8	8	0	0
27	Neonatologi	Profesi Ners	7	2	2	0	0
		D3 Keperawatan		5	4	0	1
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
28	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	10	2	2	0	0
		S1 Akuntansi		2	0	2	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
29	Laboratorium	D4 Analis Kesehatan	9	2	1	1	0
		D3 Analis Kesehatan		7	6	1	0
30	Laundry	SMK	4	1	0	1	0
		SMA		2	0	2	0
		SMP		1	0	1	0
31	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	9	9	9	0	0
32	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	16	1	4	0	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D4 Destinasi Wisata		2	0	1	0
		D3 Asuransi Kesehatan		2	0	2	1
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		5	3	2	1
		D1 Administrasi Perkantoran		1	1	0	0
		SMK		0	1	0	0
		SMA		2	2	0	0
33	PIPP & MPP	Profesi Ners	5	2	1	0	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1	1	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
34	PMKP	Profesi Ners	1	1	1	0	0
35	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	7	7	5	2	0

36	SDM	S1 Psikologi	2	1	0	1	0
		S1 Ilmu Sosial		1	1	0	0
37	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	1	0	0
38	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	3	0	0
39	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
40	Cleaning Service	SMK	39	11	2	6	1
		SMA		23	19	4	0
		SMP		5	5	0	0
41	Security	SMK	12	5	2	3	0
		SMA		7	6	1	0
42	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	5	1	1	0	0
		SMA		3	2	1	0
		SMP		1	1	0	0
43	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
44	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	5	4	1	4	0
45	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
46	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
47	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
48	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
49	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
50	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
51	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
52	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
53	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
54	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
55	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
56	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
59	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
60	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
61	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
62	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
65	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
Total			443	431	269	156	9

Keterangan :
Pada bulan Juli 2025 terdapat 6 staf resign

3.5.1.1 Update STR / SIP

NO	NAMA	PROFESI	TANGGAL KEJADIAN	KETERANGAN
1	Nabila Rizki Amalia, S.Tr .Kes	Fisioterapi	04 Juli 2025	SIP baru
2	dr. Kezia Berlian Rukmana	Dokter Umum	Juli 2025	Proses penerbitan SIP baru
3	dr. Andira Aulia Rahma	Dokter Umum	Juli 2025	Pencabutan SIP (resign)
4	dr. Sheila Dyah Prasetyo	Dokter Umum	Juli 2025	Pencabutan SIP (resign)
5	Apt. Ica Anindya Pangestika, S.Farm	Apoteker	Juli 2025	Pencabutan SIP (resign)
6	Rizky Dinda Maulidya, S.Tr.Keb	Bidan	Juli 2025	Proses pencabutan SIP (mutasi)
7	Fakhruru Rifqi Aliyanto, S.Kep., Ns	Perawat	Juli 2025	Proses pencabutan SIP (resign)
8	Octa Fitri Muazizah, S.Tr.Kep	Perawat	Juli 2025	Proses pencabutan SIP (resign)
9	Prima Dio Prasajo, A.Md.Kep	Perawat	Juli 2025	Proses pencabutan SIP (mutasi)
10	dr. Ageng Sunjoyo, Sp.An-TI	Dokter Spesialis Anestesi	Juli 2025	Proses pencabutan sip (resign)
11	Rina Tri Wahyuni, A.Md.RMIK	Rekam Medis	Juli 2025	Proses pencabutan SIP (resign)
12	Gusti Naila Rahmawati Gufron, A.Md.AK	Analisis Lab	Juli 2025	Proses pencabutan SIP (mutasi)
13	Aulia Rahmatul Amani, A.Md.Kep	Perawat	Juli 2025	Proses pencabutan SIP (mutasi)

Keterangan :
Pada bulan Juli terdapat 1 penerbitan SIP baru, 1 proses penerbitan SIP, 3 pencabutan sip staf resign, 4 proses pencabutan sip karena resign, dan 4 proses pencabutan sip karena mutasi

3.5.1.2 Rekrutmen

NO	PROFESI	JUMLAH YANG DIBUTUHKAN	TERPENUHI	KEKURANGAN	PENYEBAB	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Terapi Okupasi	1	0	1	Sulit mencari kandidat terapis okupasi	Menghubungi sosial media komunitas terapis okupasi, menghubungi kampus dengan jurusan terapis okupasi
2	Dokter Spesialis Bedah Mulut	1	0	1	Sulit mencari kandidat Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	Menghubungi kampus dengan jurusan tersebut
3	Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	1	0	1	Sulit mencari Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	Menghubungi kampus dengan jurusan tersebut
4	Dokter Spesialis Radiologi	1	0	1	Belum mendapatkan kandidat	Dibutuhkan yang Perempuan
5	Fisioterapis	5	4	1	Belum mendapatkan kandidat yang cocok	Sedang proses pemenuhan
6	Perawat Gigi	2	1	1	Sudah ACC dari PT DPM	Open recruitment setelah hari raya
7	Terapis Wicara	2	1	1	On proses pengajuan ke PT DPM	On proses pengajuan ke PT DPM

3.5.1.3 Orientasi Staf Baru

3.5.1.3.1 Orientasi Staf

NO	TANGGAL	JENIS ORIENTASI	NAMA STAF	PENDIDIKAN	PROFESI	SPMJ (TANGGAL MASUK)	KETERANGAN

Keterangan :
Pada bulan Juli 2025 tidak terdapat staf orientasi

3.5.1.4 Diklat

NO	JUDUL DIKLAT	JENIS DIKLAT	JUMLAH PESERTA		TANGGAL PELAKSANAAN	SERTIFIKAT	
			HADIR	TIDAK HADIR		ADA	TIDAK
1	Diklat Sosialisasi Pengolahan Limbah B3	Internal	297	24	07 Juli 2025	V	
2	Diklat Hak Pasien & Keluarga	Internal	311	39	16-17 Juli 2025	V	

3.5.1.5 Evaluasi Kinerja Staf

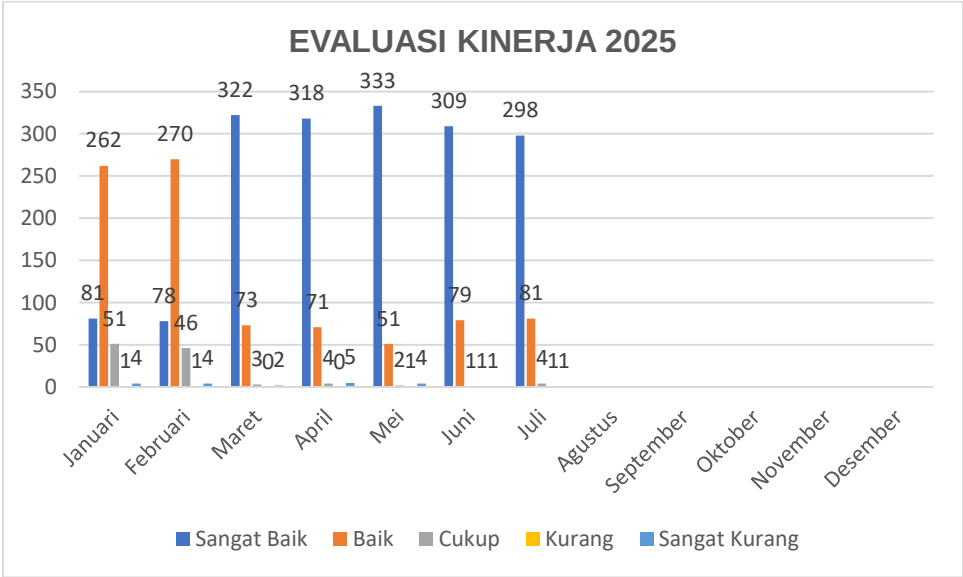
NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
1	Direktur	Umum	1	0	0	1	0	0	Unit Direktur secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
2	Kabid Pelayanan Medis	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Kabid Pelayanan Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
3	Kabid Penunjang Medis	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit KABid Penunjang Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
4	Kabid Keperawatan	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Kabid Keperawatan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
5	Kabid Umum & Keuangan	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Kabid Umum & Keuangan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
6	Satuan Pengawas Internal	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Satuan Pengawas Internal secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
7	Farmasi	Umum	40	2	22	18	2	0	Unit Farmasi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
8	Asuransi Center	Umum	10	0	10	0	0	0	Unit Asuransi Center secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
9	CSSD	Umum	5	0	5	0	0	0	Unit CSSD secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
10	Fisioterapi	Umum	5	0	3	2	0	0	Unit Fisioterapi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
11	Gizi	Umum	17	0	15	2	0	0	Unit Gizi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
12	Humas & Marketing & PKRS	Umum	2	0	2	0	0	0	Unit Humas Markrting & PKRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
13	ICU dan HCU	Umum	12	0	10	2	0	0	Unit ICU & HCU secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
14	IGD	Umum	25	0	21	4	0	0	Unit IGD secara keseluruhan mendapatcatatan baik dalam penilaian kinerja umum.
15	IKO	Umum	12	0	11	1	0	0	Unit IKO secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
16	IPCN	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit IPCNsecara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
17	IPSRs	Umum	6	0	5	1	0	0	Unit IPSRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
18	IRJA	Umum	27	0	23	4	0	0	Unit IRJA secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
18	IRNA 2C	Umum	8	0	7	1	0	0	Unit IRNA 2C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
19	IRNA 2A, 3A, & 4A	Umum	18	0	15	3	0	0	Unit IRNA 234A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
20	IRNA 3C Anak	Umum	15	0	13	2	0	0	Unit IRNA 3C Anak secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
21	IRNA 5C	Umum	9	0	7	2	0	0	Unit IRNA 5C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
22	IRNA 6A, 7A, & 8A	Umum	24	0	21	3	0	0	Unit IRNA 6A, 7A & 8A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
23	Maternitas	Umum	12	0	9	3	0	0	Unit Maternitas secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
24	Neonatologi	Umum	9	0	8	1	0	0	Unit Neonatologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
25	Keuangan & Akuntansi	Umum	10	0	6	4	0	0	Unit Keuangan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
26	Laboratorium	Umum	10	0	9	1	0	0	Unit Laboratorium secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
27	Laundry	Umum	5	0	5	0	0	0	Unit Laundry secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
28	Rekam Medis	Umum	9	0	9	0	0	0	Unit Rekam Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
29	Pendaftaran	Umum	18	0	16	2	0	0	Unit Pendaftaran secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
30	PIPP & MPP	Umum	5	0	4	1	0	0	Unit PIPP secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum. Terdapat 1 staf dengan evaluasi kinerja sangat kurang dikarenakan cuti melahirkan.
31	PMKP	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Mutu & PMKP secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
32	Radiologi	Umum	7	0	7	0	0	0	Unit radiologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
33	SDM	Umum	2	0	2	0	0	0	Unit SDM secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
34	Sekretaris	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Sekretaris secara

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
									keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
35	SIMRS & IT	Umum	3	0	2	1	0	0	Unit IT SIMRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
36	Umum & Rumah Tangga	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit IRJA secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
37	Cleaning Service	Umum	45	1	32	12	1		Unit Cleaning Service secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
38	Security	Umum	12	0	12	0	0	0	Unit Security secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
39	Driver	Umum	5	0	4	1	0	0	Unit Driver secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
40	Gudang Umum	Umum	1	1	0	0	1	0	Unit Gudang Umum secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.

Analisis :
Hampir seluruh unit di RS Prima Husada Malang berada pada kategori Sangat Baik pada penilaian umum periode Juli 2025.

3.7.1 Grafik Evaluasi Kinerja Karyawan



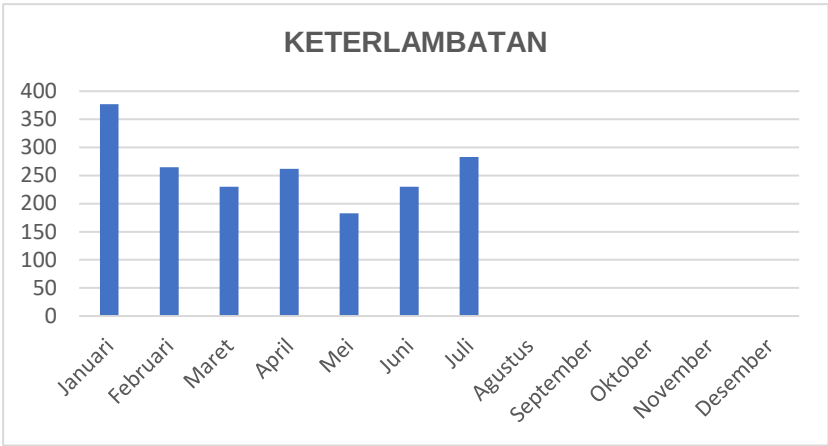
Kategori	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Sangat Baik	81	78	322	318	333	309	298					
Baik	262	270	73	71	51	79	81					
Cukup	51	46	3	4	2	1	4					
Kurang	1	1	0	0	1	1	1					
Sangat Kurang	4	4	2	5	4	1	1					
TOTAL	399	399	400	398	391	391	385					

Analisa :
Secara umum terdapat peningkatan kinerja dari staf dilihat dari jumlah kategori cukup yang naik menjadi kategori diatasnya.

Rencana Tindakanlanjut :

- 1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
- 2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
- 3. Mempertahankan kinerja staf terkait kedisiplinan.

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
KETERLAMBATAN	377	265	230	262	183	230	283					



Analisa :

Secara umum terdapat kenaikann keterlambatan karyawan.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
- 2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
- 3. Mempertahankan kinerja staf terkait kedisiplinan.

3.5.1.6 Konseling

3.5.1.6.1 Tabel Capaian Konseling Perbulan Tahun 2025

NO	UNIT	JUMLAH KONSELING GRUP	JUMLAH KONSELING INDIVIDU					
			KONTRAK N-ED	TERKAIT TATA TERTIB	TERKAIT KETIDAKPATUHAN MUTU	TERKAIT KETIDAKPATUHAN PPI	TERKAIT MANRISK	KARIR
1	Manajerial RS	0	0	0	0	0	0	0
2	SDM	0	0	0	0	0	0	0
3	Asuransi Center	0	0	0	0	0	0	0
4	IRNA 2C	0	0	0	0	0	0	0
5	IRNA 3C Anak	0	0	0	0	0	0	0
6	IRNA 3A & 4A	0	0	0	0	0	0	0
7	IRNA 5C	0	0	0	0	0	0	0
8	IRNA 6A & 7A	0	0	0	0	0	0	0
9	Maternitas	0	0	0	0	0	0	0
10	Neonatologi	0	0	0	0	0	0	0
11	IGD	0	0	0	0	0	0	0
12	ICU	0	0	0	0	0	0	1
13	HCU	0	0	0	0	0	0	0
14	IKO	0	0	0	0	0	0	0
15	Gizi	0	0	0	0	0	0	1

16	Farmasi	0	0	0	0	0	0	0
17	Laboratorium	0	0	0	0	0	0	0
18	Radiologi	0	0	0	0	0	0	0
19	Rekam Medis	0	0	0	0	0	0	0
20	Pendaftaran	0	0	0	0	0	0	0
21	CSSD	0	0	0	0	0	0	0
22	Laundry	0	0	0	0	0	0	0
23	Keuangan & Akuntansi	0	0	0	0	0	0	0
24	PIPP	0	0	0	0	0	0	1
25	MPP	0	0	0	0	0	0	0
26	Umum Cleaning Service	0	0	0	0	0	0	0
27	SIMRS	0	0	0	0	0	0	0
28	DRIVER	0	0	0	0	0	0	0
29	Security	0	0	0	0	0	0	0
30	IRJA	0	0	0	0	0	0	0
31	Rehab Medik	0	0	0	0	0	0	0
32	Kasir Parkir	0	0	0	0	0	0	0
33	Parkir	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	3

Analisis :
 Konseling staf dilaksanakan sesuai kebutuhan karir telah dilakukan

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi

Jenis	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Supervisi (2x/bulan)	0	100%	50%	100%	100%	100%	0%					

Analisaais:
 Belum terlaksana 103lastic103e

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi

3.5.1.7 Mutasi

Tabel Daftar Staf Mutasi

NO	NAMA STAF	UNIT ASAL	UNIT BARU
1	-	-	-

Analisis : Pada bulan Juni 2025 tidak terdapat rotasi staf.

3.5.2 IPSRS

3.5.2.1 Pemeliharaan Alat Medis

Perhitungan capaian berdasarkan jumlah kunjungan per unit oleh elektromedis ke unit-unit di rumah sakit (33 unit) dalam satu bulan

3.5.2.1.1 Tabel Capaian Maintenance Alat Medis

	Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Capaian Maintenance Ruangan	90%	84.61	66.6	92.3	76,92	89,74	69.2%						

BULAN	TOTAL ALAT	CAPAIAN	PROSENTASE
Januari	268	154	57.46%
Februari	270	135	50.00%
Maret	276	153	55.43%
April	276	150	54.34%
Mei	275	142	51.64%
Juni	276	165	59.78%
Juli	276	166	60.14%

TOTAL ALAT (PERBAIKAN)	TOTAL ALAT
Januari	21
Februari	22
Maret	21
April	17
Mei	26
Juni	15
Juli	25

Analisa :
Pada bulan ini, capaian maintenance alat berdasarkan ruangan 82.05% dan jumlah alat 60,14%. Beberapa factor yang menyebabkan fluktuatif adalah alat medis masih dipakai oleh pasien (Irna), ruangan atau unit masih ada tindakan pasien (OK) dan jumlah perbaikan alat rusak adalah 25 dalam satu bulan. Pada ABK dibutuhkan 2 atem untuk alat sejumlah 276 dan mengcover perbaikan serta maintenance.

Rencana Tindak Lanjut :
Koordinasi dengan PT untuk ATEM sesuai ABK

3.5.2.2 Pemeliharaan Alat Non Medis

3.5.2.2.1 Air Conditioner

3.5.2.2.1.1 Tabel Capaian Pemeliharaan AC Split

BULAN	MAINTENANCE / 1 BULAN	MAINTENANCE / 2 BULAN	MAINTENANCE / 3 BULAN	TOTAL
TARGET/BULAN	42	30	23	95
JANUARI	11	6	16	33
FEBRUARI	23	17	11	51
MARET	14	41	6	61

APRIL	7	30	6	43
MEI	19	18	18	45
JUNI	7	16	2	25
JULI	15	21	12	48
AGUSTUS				
SEPTEMBER				
OKTOBER				
NOVEMBER				
DESEMBER				

Analisa :

Pada Awal Juni dengan adanya instruksi untuk perbantuan maintenance seluruh AC di 3 klinik Mutiara Sehat membuat pelaksanaan maintenance AC dari tim IPSRS bertambah. Akan dilakukan pemetaan kembali terkait target maintenance AC dan pembuatan system monitoring dan evaluasi. Bulan Juli ini sebagai evaluasi untuk perubahan pedoman penjadwalan maintenance di bulan agustus.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.3 Genset

1.5.2.2.3.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Genset

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
2	Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
3	Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
4	April	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
5	Mei	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
6	Juni	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
7	Juli	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target

Analisis :

Pada bulan ini, pemeliharaan genset dilakukan 4x dan sudah terlapor dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi berkala

1.5.2.2.4 Panel Listrik

3.7.2 Tabel Capaian Pemeliharaan Panel

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
2	Februari	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
3	Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
4	April	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
5	Mei	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
6	Juni	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
7	Juli	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :
Pemeliharaan panel 106lastic di Gedung A,B,C,D,E dan LVMDP dilakukan 4x dalam satu bulan dan dilakukan rekapan dokumentasi. Kegiatan ini sudah berjalan sesuai target

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi

1.5.2.2.5 Liquid Oksigen

1.5.2.2.5.1 Tabel Pencatatan Liquid Harian

TANGGAL	STOK LIQUID	SEBELUM PENGISIAN	PENGUNAAN	SATUAN	KETERANGAN	PENGIRIMAN	SATUAN
01/07/2025	3468	3174	294	MMHG			MMHG
02/07/2025	3174	2895	279	MMHG			MMHG
03/07/2025	2895	2674	221	MMHG			MMHG
04/07/2025	2674	2448	226	MMHG			MMHG
05/07/2025	2448	2225	223	MMHG			MMHG
06/07/2025	2225	1721	504	MMHG			MMHG
07/07/2025	1721	3509	0	MMHG	sesudah pengisian	1788	MMHG
08/07/2025	3509	3287	222	MMHG			MMHG
09/07/2025	3287	3045	242	MMHG			MMHG
10/07/2025	3045	2859	186	MMHG			MMHG
11/07/2025	2859	2629	230	MMHG			MMHG
12/07/2025	2629	2392	237	MMHG			MMHG
13/07/2025	2392	2157	235	MMHG			MMHG
14/07/2025	2157	1869	288	MMHG			MMHG
14/07/2025	1869	1271	598	MMHG			MMHG
15/07/2025	1271	3437	0	MMHG	sesudah pengisian	2116	MMHG
16/07/2025	3437	3141	296	MMHG			MMHG
17/07/2025	3141	2882	259	MMHG			MMHG
18/07/2025	2882	2595	287	MMHG			MMHG
19/07/2025	2595	2318	277	MMHG			MMHG
20/07/2025	2318	1648	670	MMHG			MMHG
21/07/2025	1648	3298	0	MMHG	sesudah pengisian	1650	MMHG
22/07/2025	3248	2985	263	MMHG			MMHG
23/07/2025	2985	2705	280	MMHG			MMHG
24/07/2025	2705	2377	328	MMHG			MMHG
25/07/2025	2377	2132	245	MMHG			MMHG
26/07/2025	2132	1898	234	MMHG			MMHG
27/07/2025	1898	1466	432	MMHG			MMHG
28/07/2025	1466	3353	0	MMHG	sesudah pengisian	1887	MMHG
29/07/2025	3353	2996	357	MMHG			MMHG

30/07/2025	2996	2771	225	MMHG			MMHG
31/07/2025	2771	2460	311	MMHG			MMHG
Jumlah total pemakaian oksigen bulan ini			8449	MMHG			MMHG
Jumlah total pengisian liquid oksigen bulan ini						7441	MMHG
Rata-rata penggunaan oksigen per hari			547,5172414	MMHG			
Rata- rata pengisian liquid per bulan ini						2976,4	MMHG

Analisis :
 Kegiatan sudah dilakukan dengan baik sesuai target, setiap hari dilakukan pengecekan. Stok oksigen selalu terjaga.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan Evaluasi

1.5.2.2.6 IPAL

1.5.2.2.6.1 Tabel Capaian Pemeliharaan IPAL

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :
 Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan. Pencatatan debit IPAL juga dilakukan dan di dokumentasikan.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi melalui link :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fuh93fV8dr-elBhq4_WnFYCEM3i7Q8OnspbTdrherYs/edit?gid=1709907740#gid=1709907740

1.5.2.2.7 Filter Air

3.7.3 Tabel Capaian Pemeliharaan Filter Air

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi melalui
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1utB1tcAU1Xi-rY4On3PymLDuNIIV0egQRdVkhgSayw/edit?gid=392489547#gid=392489547>

1.5.2.2.8 Lift

1.5.2.2.8.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Lift

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi melalui link
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/16wmsJe6qBbbD63O5DgfOA6YujFNommAsXIHlsi0g3o0/edit?gid=289224812#gid=289224812>

1.5.2.2.9 UPS
1.5.2.2.9.1 Tabel Capaian Pemeliharaan UPS

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target

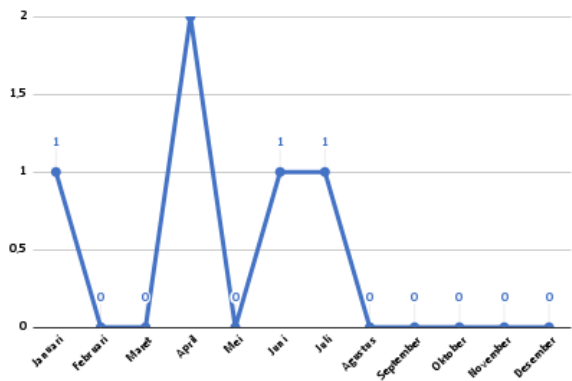
Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W11Uen83_wiMyVk-BL2oB4Nc24b7pgBOK6Lufn7skng/edit?usp=sharing

1.5.3 Security
3.5.3.1 Tabel Angka Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Angka kejadian kehilangan barang	1	0	0	2	0	1	1				

3.5.3.2 Grafik Kejadian Kehilangan Barang



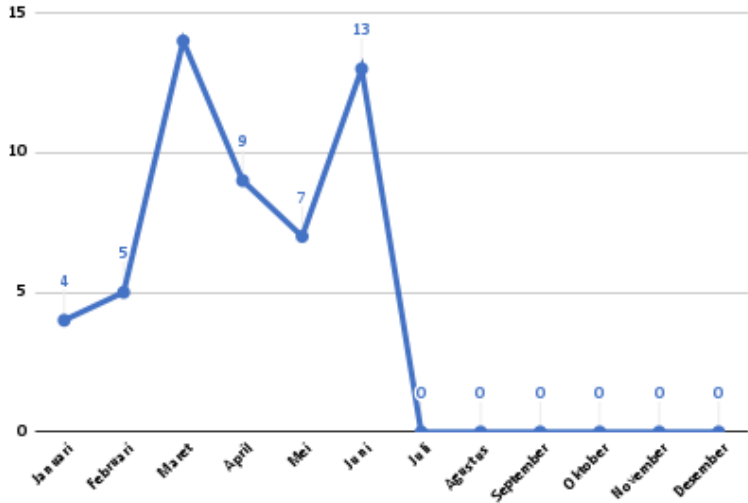
Analisa :
Pada tanggal 30 Juli 2025, ditemukan cincin perhiasan milik pengunjung, sudah dilakukan telusur dan pengumuman namun belum diambil oleh pemilik, sekarang diamankan di ruang security.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.7.4 Tabel Angka Potensi Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Angka kejadian kehilangan barang	4	5	14	9	7	13	7				

3.7.5 Grafik Angka Kejadian Kehilangan Barang



ANGKA KEJADIAN BARANG BERPOTENSI HILANG		
TANGGAL	KETERANGAN	RTL
14 – 07 -2025	Ditemukan hp milik pengunjung di depan ruang tunggu iko diamankan di pos IGD	Sudah diambil pemilik

15 – 07 – 2025	Kunci motor milik karyawan tertinggal di parkiran kr 2 karyawan	Sudah diambil pemilik
22 – 07 – 2025	Kunci motor milik karyawan tertinggal di parkiran kr 2 karyawan	Sudah diambil pemilik
22 – 07 – 2025	Kunci mobil milik pengunjung tertinggal di parkiran kr 4 pengunjung	Sudah diambil pemilik
25 – 07 -2025	Ditemukan hp milik pengunjung di area poli diamankan di pos IGD	Sudah diambil pemilik
28 – 07 – 2025	Kunci motor milik karyawan tertinggal di parkiran kr 2 karyawan	Sudah diambil pemilik
31 – 07 – 2025	Kunci motor milik karyawan tertinggal di parkiran kr 2 karyawan	Sudah diambil pemilik

Analisis :

Barang hilang sudah dikembalikan ke pemilik. Alur berjalan baik. Pencatatan telah dilakukan dengan baik.

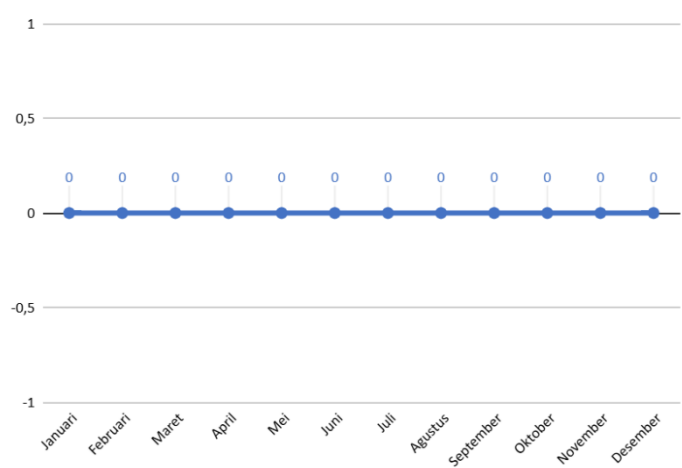
Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

3.5.3.3 Tabel Angka Kekerasan di Lingkungan Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1.	Angka kejadian kekerasan	0	0	0	0	0	0	0				

3.5.3.4 Grafik Angka Kejadian Kekerasan



Analisis :

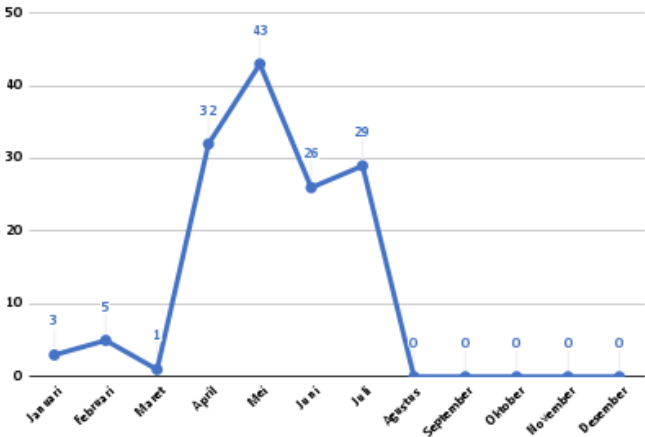
Tidak terdapat kejadian kekerasan karena pelayanan dilakukan dengan baik oleh seluruh karyawan dan tidak ada oknum yang menciptakan kerusakan.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

3.5.3.5 Tabel Angka Kejadian Merokok di Area Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	Angka kejadian merokok di area Rumah Sakit	3	5	1	32	45	26	29					



Analisis :

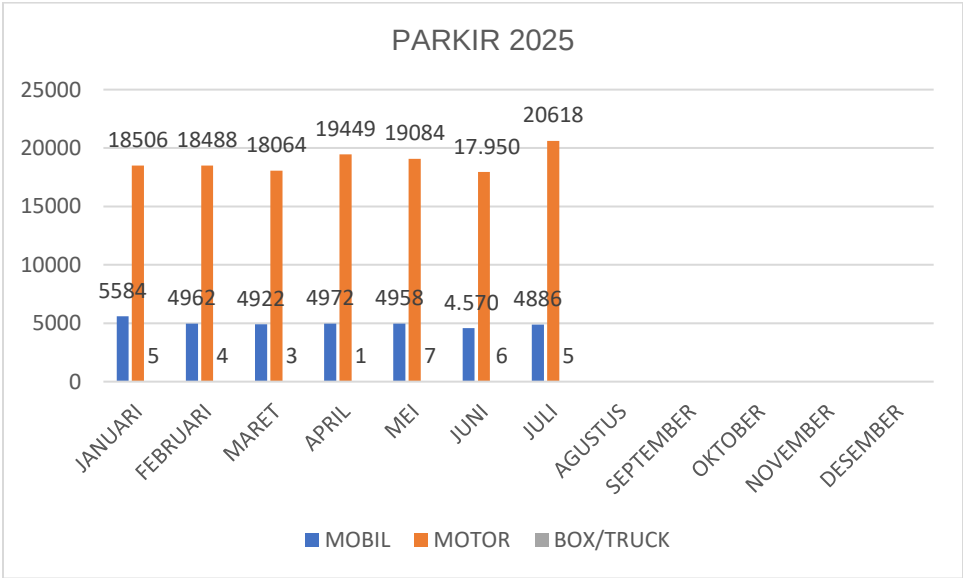
Angka 29 ini terindikasi masih belum terekap semua, hal ini ditunjukkan dari rata-rata per hari yang telah diedukasi karena merokok bisa lebih dari 1x. Beberapa factor yang mempengaruhi, posisi kursi taman pot depan IGD yang tidak dapat diberi tulisan dan menjadi tempat makan. Patroli security yang regular sering terlewat karena saat ada patrol memang tidak terpantau ada perokok.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring evaluasi. Pencatatan melalui WA grup dan operan shift dengan instrument dashboard spreadsheet.

3.5.4 Parkir

3.5.4.1 Grafik Jumlah Parkir Keluar Non Member



Analisis :
Progres parkir bulan ini secara system naik karena kunjungan naik.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.5 Humas Marketing

3.5.5.1 Perjanjian Kerjasama (PKS)

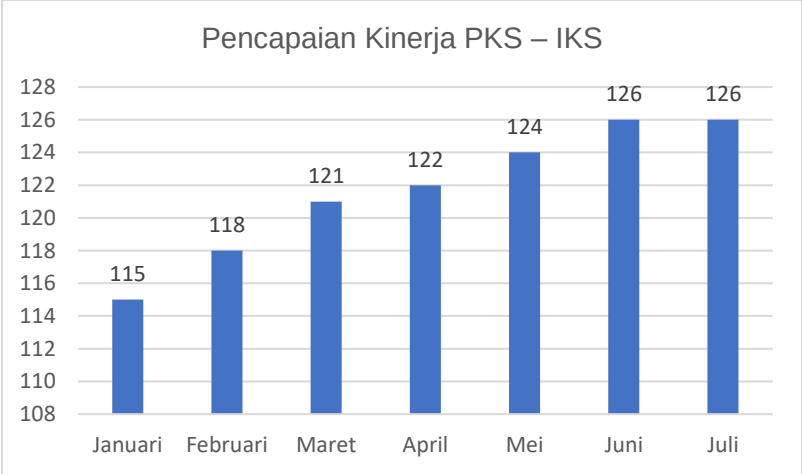
3.5.5.1.1 Pencapaian Kinerja PKS – IKS Juni 2025

No	Bulan	Target	Jumlah					Total Kurang
			Berlaku	ED	Baru	Kurang Baru	Progres	
1	Januari 2025	1 IKS baru	115	6	0	0	(review pihak kedua) 1 (113lastic113 evaluasi) 1 (tdk diperpanjang)	4
2	Februari 2025	1 IKS baru	118	1	1	0	3 (Proses Tanda Tangan Pihak kedua)	3
3	Maret 2025	1 IKS baru	121	1	1	0	1 (Proses review)	1
4	April 2025	1 IKS baru	122	1	1	0	1 (Proses Review Pihak ke 2)	1
5	Mei 2025	1 IKS baru	124	0	1	0	1 (Proses Review Pihak ke 2)	1
6	Juni 2025	2 IKS Baru	126	0	1	1	(2 Proses Review Pihak ke 2)	2
7	Juli 2025	1 IKS Baru	126	1	0	0	1 (Proses Review)	1
Analisis ; 1. Pada bulan Juli 2025, PKS dengan Rumah Sakit Panti Nirmala dalam progress, Follow Up Review PKS dengan Pihak Perusahaan Baru PT Mane Indonesia. 2. Draft yang dikirim ke Pihak kedua dalam tahap Review Rencana Tindak Lanjut : 1. Memfollow up PKS yang sudah dikirim ke pihak kedua								

3.5.5.1.2 Tabel Progres IKS Baru Juli 2025

NO	NAMA PKS	PROGRES PENGURUSAN	KENDALA
1	PT Nayaka Era Husada	Review pihak kedua	Selesai
2	Klinik Brawijaya Lawang	Review pihak kedua	Selesai
3	PT. Asuransi Mandiri Inhealth Manage Care Indonesia	Review pihak kedua	Selesai
4	PT. Kasoem Hearing	Proses TTD	Selesai
5	PT Global Excel	Review	Perbedaan template draft PKS
6	PT Malang Intermedia Pers	Review	Proses Perpanjangan
7	PT BNI Life Insurance	Penambahan Addendum	Selesai

8	Dispenduk Kab. Malang Ketan Ireng	Review (114lastic terakhir bulan April masih menunggu pihak sekda)	Proses pihak Dispenduk
9	PT Softex Indonesia (Kimberly-Clark Softex)	Review	Proses Perpanjangan
10	Kirim Proposal Nestle Event Lacto Club	Proses Event	Kirim Dokumen Tambahan
11	PT Mane Indonesia	Review	Proses Pihak Kedua
12	PT Pindad (Persero)	Review	Proses Pihak Kedua
13	RS Panti Nirmala	Review	Proses Review



3.5.5.2 Medical Check Up (MCU)

3.5.5.2.1 Pencapaian Hasil Kinerja MCU dan Vaksin Juni 2025

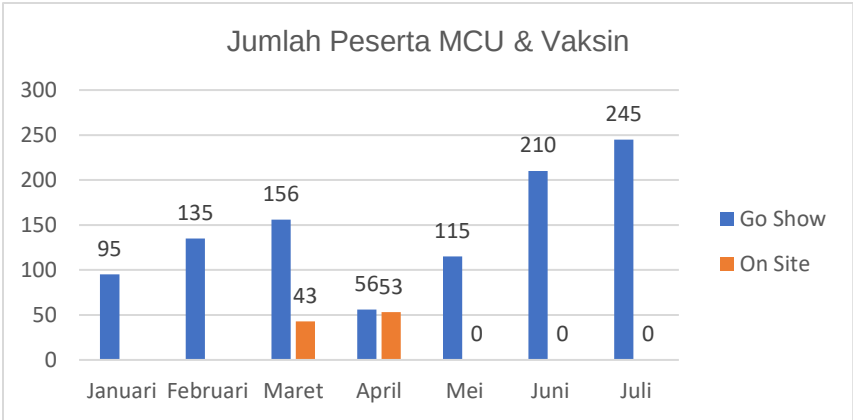
NO	BULAN	TARGET	JUMLAH PASIEN GOSHOW	ON SITE
1	Januari	25	95	-
2	Februari	25	135	-
3	MARET	150	156	43
4	APRIL	150	56	53
5	MEI	150	115	-
6	JUNI	150	210	-
7	JULI	150	254	
8	AGUSTUS	150		
9	SEPTEMBER	150		
10	OKTOBER	150		
11	NOVEMBER	150		
12	DESEMBER	150		

Analisis ;

Jumlah peserta MCU dan Vaksin bulan Mei Meningkat 20,95% dari bulan Juni. Hal ini dikarenakan, promosi dan pendekatan tentang vaksin internasional sudah mulai dikenal masyarakat.

Rencana Tindak Lanjut :

- Melakukan Promosi rutin melalui Social Media dengan update berkala
- Kunjungan ke SMA dan SMK untuk menawarkan program MCU



3.5.5.2.2 Tabel Evaluasi Hasil Penawaran MCU Tahun 2025

NO	BULAN	INSTANSI	HASIL
1	Januari	PT Berca Kawan Sejati Cab. Malang Official	Tidak ada konfirmasi dan Jawaban setelah di lakukan Follow Up
2	Februari	PT Pesta Pora	Tidak ada konfirmasi dan Jawaban setelah di lakukan Follow Up
		PT Green Mountains Natural Food	Konfirmasi untuk Peserta 106 orang
3	Maret	Meteor Cell Singosari	Sudah terlaksana
		PT Green Mountains Natural Food	Konfirmasi untuk Perubahan Peserta menjadi 53 orang dan pengajuan dengan Bus MCU
4	April	PT Green Mountains Natural Food	Sudah terlaksana
5	Mei	PT Kencana Tiara Gemilang	Sudah terlaksana 10 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
		Laboratorium Radika Diagnostik	Sudah terlaksana 11 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
6	Juni	PT Puninar Jaya	Sudah terlaksana 7 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
		Laboratorium Radika Diagnostik	Sudah terlaksana 1 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
7	Juli	PT Puninar Jaya	Sudah terlaksana 5 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
		PT Indonesian Marine	Sudah terlaksana 5 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit

3.5.5.2.3 Kegiatan Kunjungan Eksternal

3.5.5.2.3.1 Tabel Jumlah Kunjungan Eksternal

NO	KETERANGAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Jumlah Kunjungan	5	10	2	2	2	17	6				

Analisa :
Kunjungan eksternal bulan Juli beekurang karena adanya program FKTP Gathering yang mengundang FKTP mitra sehingga interaksi akan dibangun pada sesi acara tersebut.

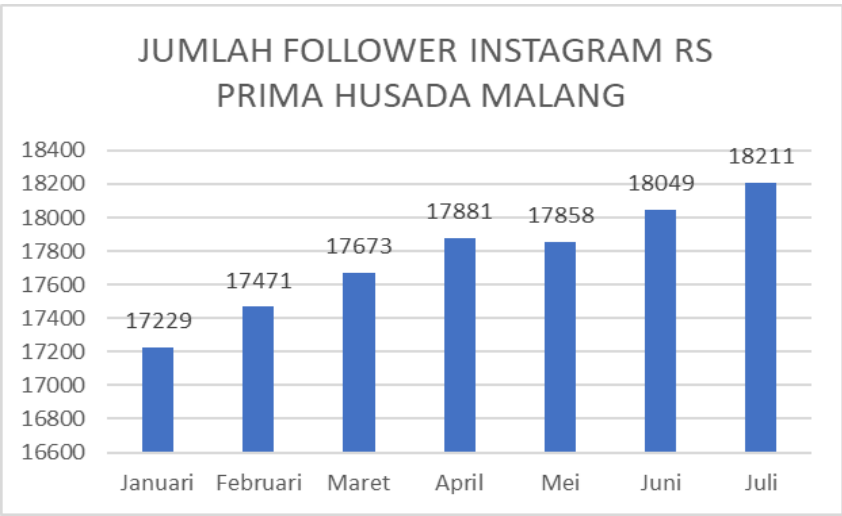
Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi berkala.

4.5.5.2.4 Digital Marketing

4.5.5.2.4.1 Daftar Kegiatan Digital Marketing

Platform Instagram

JUMLAH KONTEN BARU	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
FEED FOTO	3	7	9	10	10	9	10					
REELS	5	5	11	5	1	1	6					
STORY	6	10	14	8	12	10	18					
TOTAL	14	22	34	28	23	19	34	0	0	0	0	0
JUMLAH TOTAL POSTINGAN (BARU + LAMA)	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
FEED FOTO	6	11	16	19	10	12	14					
FEED VIDEO	0	0	0	0	1	1	6					
REELS	3	4	5	7	1	1	6					
STORY	29	33	28	38	12	29	74					
TOTAL	38	48	49	64	24	20	100	0	0	0	0	0
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH FOLLOWER (CUT OFF TANGGAL 1)	17,229	17,471	17.673	17.881	17850	18049	18.211					
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH PENINGKATAN FOLLOWER	496	242	202	208	374	286	346	0	0	0	0	0
TARGET	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300



Analisa :

Jumlah Follower Instagram RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebesar 0,90%. Dari bulan Juni Dan telah memenuhi target 300 follower, Hal ini dikarenakan adanya jadwal baru unu postingan Instagram secara regular terlihat dari story 116lastic116e pada bulan juni 29 postingan, bulan ini 74 postingan.

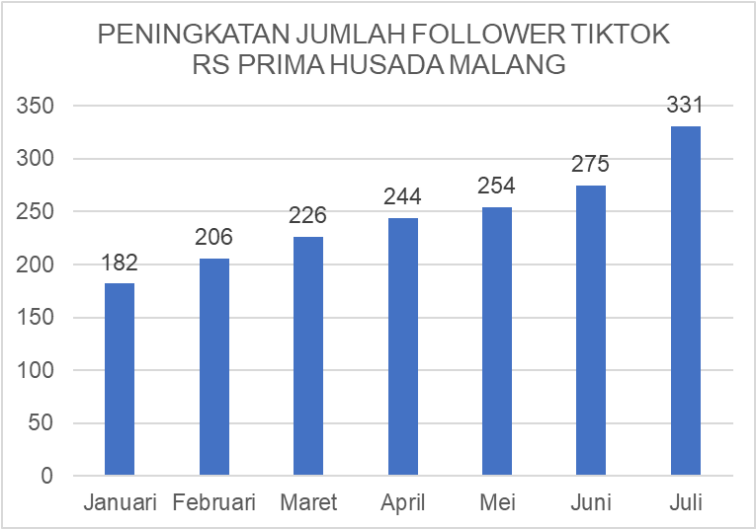
Rencana Tindal Lanjut :

- 1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS setiap harinya
- 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers

Platform Tik Tok

JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH KONTEN BARU	2	3	4	0	2	1	3					
TARGET	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH FOLLOWER (CUT OFF TANGGAL 1)	182	206	226	244	254	275	331					
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH PENINGKATAN FOLLOWER	16	24	20	18	10	21	36	0	0	0	0	0
TARGET	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH LIKE	45	72	1023	1085	1187	1222						



Analisa :
Jumlah Follower Tiktok RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebesar 20,36%. Dari bulan Juni, Namun masih belum mencapai target follower 100.

Rencana Tindal Lanjut :

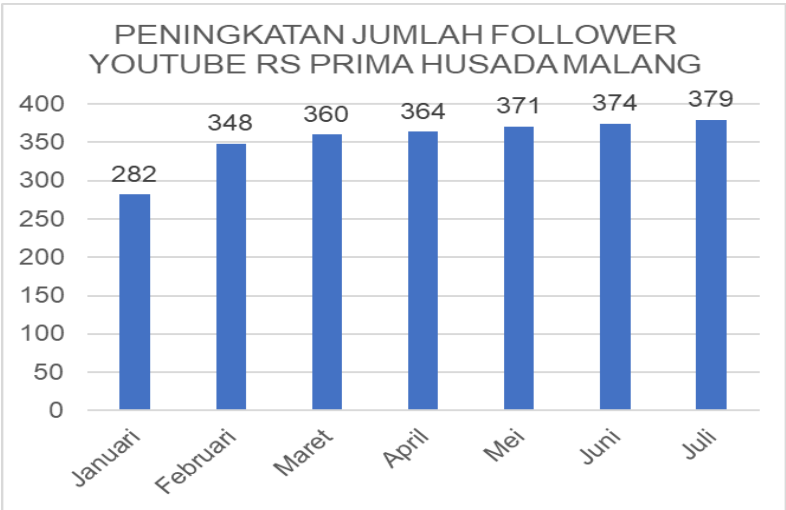
- 1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS kolaborasi dengan PKRS
- 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
- 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Platform Youtube

JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH KONTEN BARU	0	2	0	0	0	0	0					
TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH SUBS	282	348	360	364	371	374	379					
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH	4	66	12	4	7	3	5	0	0	0	0	0

PENINGKATAN SUBS												
TARGET	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

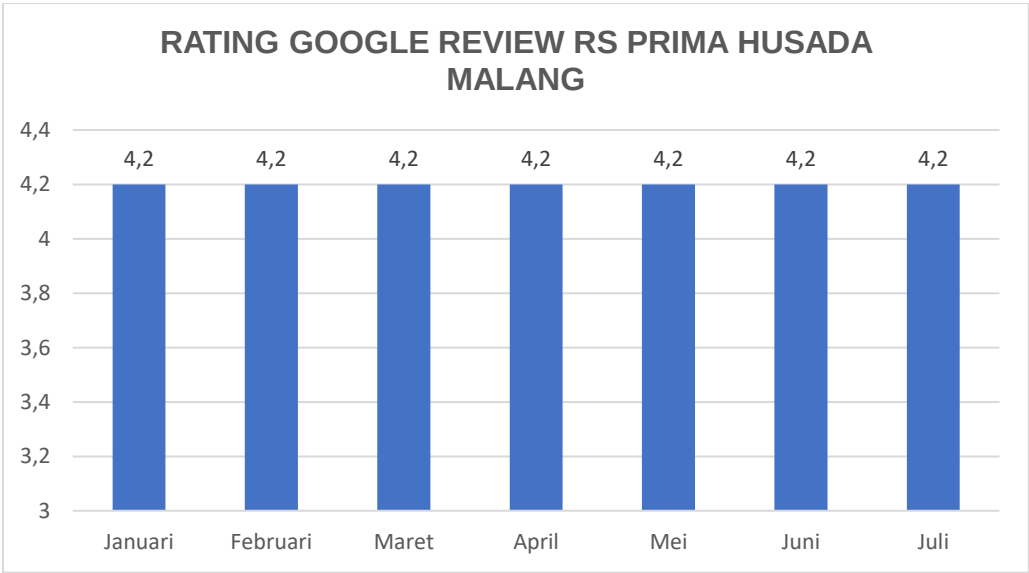


Analisa :
 Jumlah Follower Youtube RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebesar 1,34% dari bulan Juni. Hal ini dikarenakan, youtube masih belum tereksplre dengan baik untuk beberapa fitur. PKRS dan Humas Marketing lebih berfokus pada media social yang bersifat interaktif, uptodate.

- Rencana Tindal Lanjut :**
1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS kolaborasi dengan PKRS
 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Google Review

PROGRESS	JAN	FEB	MAR	AP	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH RATING	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2					



NO	BULAN	KOMENTAR POSITIF	KOMENTAR NEGATIF
1	Jan-25	18	6
2	Feb-25	13	6

3	Mar-25	7	5
4	Apr-25	25	10
5	May-25	15	7
6	Jun-25	19	3
7	Jul-25	60	3
8	Aug-25	0	0
9	Sep-25	0	0
10	Oct-25	0	0
11	Nov-25	0	0
12	Dec-25	0	0

Analisa :
Progres untuk Rating Google Review RS Prima Husada Malang tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dari bulan Juni. Hal ini dikarenakan inputan untuk googl review tidak signifikan. Pada Bulan ini sudah da 119last untuk peningkatan google review dan menghasilkan 60 komentar positif, naik 3x lipat 119lastic119er bulan lalu.

Rencana Tindal Lanjut :
Meningkatkan Survei kepuasan pasien dengan melakukan pengisian Google Review

3.5.5 Penjaminan

3.5.5.1 Piutang

3.5.5.1.2 Analisa Progres Penyelesaian Piutang

NO	DESKRIPSI	SALDO AWAL PIUTANG	PEMBAYARAN (BULAN SEBELUMNYA)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN SEBELUMNYA)	SISA PIUTANG (BULAN SEBELUMNYA)	PENAMBAHAN PIUTANG (BULAN BERJALAN)	PEMBAYARAN (BULAN BERJALAN)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN BERJALAN)	SISA PIUTANG (BULAN BERJALAN)	SALDO AKHIR PIUTANG	UMUR PIUTANG					JUMLAH PIUTANG
		a	b	c	(a-b-c=d)	e	f	g	(e-f-g=h)	dh	0-30 HARI	31-60 HARI	61-90 HARI	91-120 HARI	>120 HARI	Total
PERIODE JULI 2025 :																
1	Asuransi	200.614.019	112.381.686	2.151.166	86.081.168	173.239.318	18.042.595	509.036	154.687.687	240.768.855	210.291.747	-	10.804.477	5.985.629	13.837.003	240.768.856
2	Perusahaan	246.863.762	127.632.330	0	119.231.432	607.647.673	54.557.574	0	553.090.098	672.321.530	982.340.232	23.299.636	777.022	1.063.919	64.964.421	672.321.530
3	Mandiri inhealth	92.032.938	40.522.497	4.431.729	47.078.712	31.623.808	-	-	31.623.808	78.702.520	78.336.480	-	-	-	372.039	78.702.520
4	Jasa Raharja	22.518.190	21.597.272	0	920.917	72.819.387	46.737.897	0	26.081.500	27.002.418	-	-	-	-	27.002.418	27.002.418
5	BPJS Ketenagakerjaan	494.804.944	487.491.920	2.812.421	24.500.603	844.958.362	-	-	844.958.362	669.308.965	676.400	-	22.028.210	-	446.704.347	669.308.965
									Total Saldo	1.688.104.289	891.357.764	66.797.106	1.586.787	34.654.372	72.877.932	1.688.104.289

Keterangan : Cut off 31 Juli 2025 sebesar Rp 1.688.104.289

3.5.5.2 Klaim Pending

NO	MASALAH	DAMPAK	TINDAK LANJUT
RAWAT INAP			
1.	Reseleksi kode O80.9 menjadi O83. 8	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
2	Reseleksi kode diagnosa utama	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
3	Rujuk dihari yg sama	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
4	Bukti pendukung pel tidak ada hasil pemeriksaan sputum	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
5	Readmisi	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
6	Reseleksi kode tindakan excisi pada tindakan necrotizing facitis	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
7	Kode gabung Hhd dengab gagal jantung + gagal ginjal	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
8	Reseleksi kode syok	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending

RAWAT JALAN			
1	Kunjungan pre op satu tagihan dengan ranap op	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
2	Fragmentasi	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
3	Reseleksi kode usg	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending

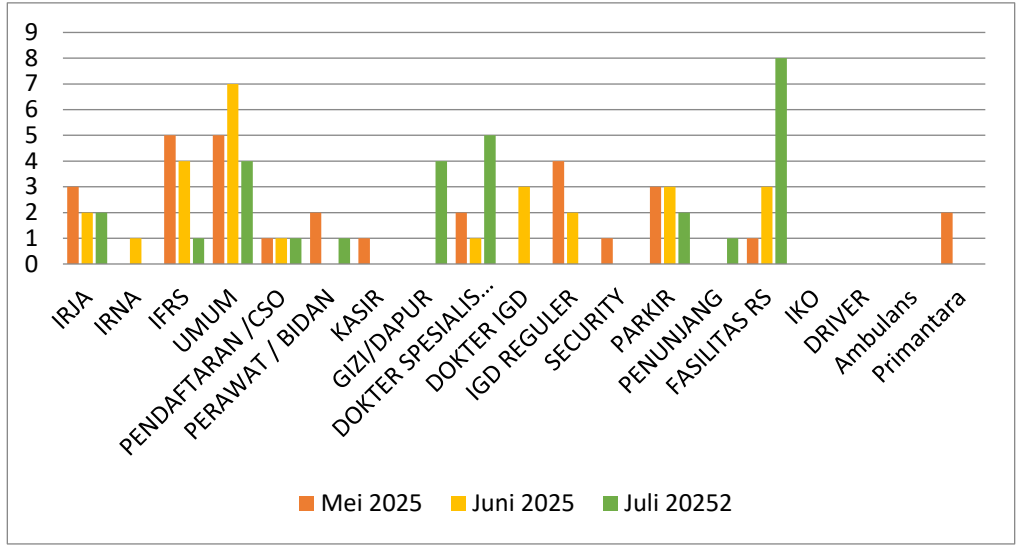
3.5.6 PIPP – MOD – MPP

3.5.6.1 Laporan Komplain Pasien

1.5.6.1.1 Tabel Distribusi Laporan Komplain Pasien Per Unit Bulan Juni 2025

NO	JUMLAH KOMPLAIN PASIEN TERHADAP UNIT	MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025
1.	IRJA	3	2	2
2.	IRNA	0	1	0
3.	IFRS	5	4	1
4.	UMUM	5	7	4
5.	PENDAFTARAN /CSO	1	1	1
6.	PERAWAT / BIDAN	2	0	1
7.	KASIR	1	0	0
8.	GIZI/DAPUR	0	0	4
9.	DOKTER SPESIALIS (KOMITE MEDIS)	2	1	5
10.	DOKTER IGD	0	3	0
11.	IGD REGULER	4	2	0
12.	SECURITY	1	0	0
13.	PARKIR	3	3	2
14.	PENUNJANG	0	0	1
15.	FASILITAS RS	1	3	8
16.	IKO	0	0	0
17.	DRIVER	0	0	0
18.	Ambulans	0	0	0
19.	Primantara	2	0	0
Total		30	27	29

3.5.7.1.1 Grafik Laporan Komplain Pasien Per Unit Juli 2025



Analisis :

Jumlah pasien komplain selama Bulan Juli 2025 mengacu pada komplain pasien. Asal complain pasien ditemukan dari beberapa unit yang ada di RS.

1. Jumlah complain Pada bulan Juli 2025 Meningkatkan dibanding pada bulan sebelumnya. Pada bulan Mei 2025 sebanyak 30 pasien pada bulan juni sebanyak 27 pasien Sedangkan pada bulan Juli 2025 sebanyak 28 pasien
2. Komplain terbanyak pada bulan Juli 2025 yaitu dari bagian Fasilitas RS sebanyak 8 kasus, DPJP sebanyak 5 kasus, Bagian UMUM dan gizi masing – masing sebanyak 4 kasus, Parkir dan IRJA masing – masing sebanyak 2 kasus, Farmasi, CSO, Radiologi dan perawat masing – masing sebanyak 1 kasus yang disampaikan secara kuesioner, WA maupun tatap muka langsung.
3. Jumlah complain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 6 kasus complain dengan rincian :
 1. Parkir sebanyak 2 kasus yaitu terkait pembayaran parkir yang terlalu mahal, permintaan diberikan kartu bebas parkir untuk pasien rawat inap,
 2. Fasilitas RS sebanyak 4 kasus yaitu tersedia cenel TV yang banyak sehingga bisa menjadi hiburan pasien, ruangan fasilitas kelas 1 diperlebar

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

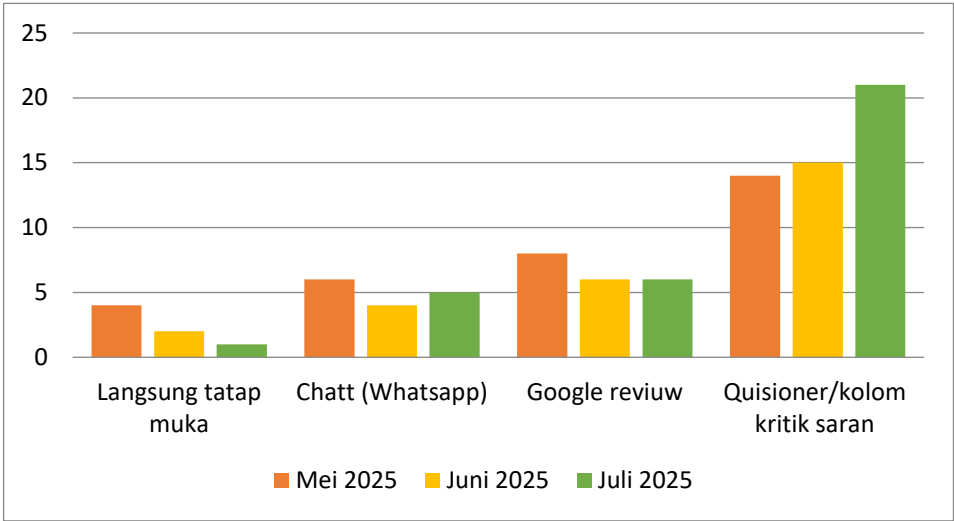
3.5.7.2 Tabel Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan Juli 2025

NO	JENIS PASIEN KOMPLAIN	MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025
1.	Langsung tatap muka	4	2	1
2.	Tidak Langsung :			
a	Chatt (Whatsapp)	6	4	5
b	Google review	8	6	6
3.	Quisioner/kolom kritik saran	14	15	21

Rincian KESSAN

KESSAN (Kesan dan Pesan Setelah Layanan) merupakan aplikasi dari BPJS Kesehatan untuk mendorong FKTP dalam meningkatkan layanan bagi peserta JKN-KIS serta memenuhi kewajiban terhadap kontrak kerjasama dengan BPJS Kesehatan

3.5.7.3 Grafik Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan Juli 2025



Analisis :
Pada bulan Juli 2025 jumlah jenis pasien complain terbanyak didapatkan dari Quisioner yaitu sebanyak 21 kasus complain. Sedangkan terbanyak kedua yaitu dari Google viuw sebanyak 6 kasus.

Rencana Tindak Lanjut :
Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.4 Tabel Waktu Tanggap dan Penyelesaian Komplain Bulan Juli 2025

NO	JENIS PASIEN KOMPLAIN	WAKTU TANGGAP		WAKTU PENYELESAIAN		< 3 HR MANAJERIAL RS	7 HR KE PT
		STANDARD < 5 '	PENCAPAIAN (DARI WAKTU TOTAL DIBAGI JML KOMPLAI ATAU RATA2 WAKTU TANGGAP)	STANDARD < 60 '	PENCAPAIAN		
1.	Langsung tatap muka	100%	100%	100%	100%	0	0
2.	Chatt (WA/Tele/SMS/IG)	100%	100%	100%	100%	0	0
3.	Google reviuw	100%	100%	100%	8	3	0
					70%	30%	
4.	Quisioner/kolom kritik saran	100%	100%	100%	8	8	0
					50%	50%	
5.	KESSAN	100%	0	100%	100%	0	0

Analisis :
Waktu tanggap dan penyelesaian complain pasien pada bulan Juli 2025 masih ada yang belum sesuai target 100% yaitu complain melalui Quisioner dengan capaian 50% dan dari google revium sebayak 30% hal ini dikarenakan ada beberapa kasus complain yang tidak bisa langsung diselesaikan seperti fasilitas RS yang memerlukan diskusi dengan manajemen. Jumlah complain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 6 kasus complain dengan

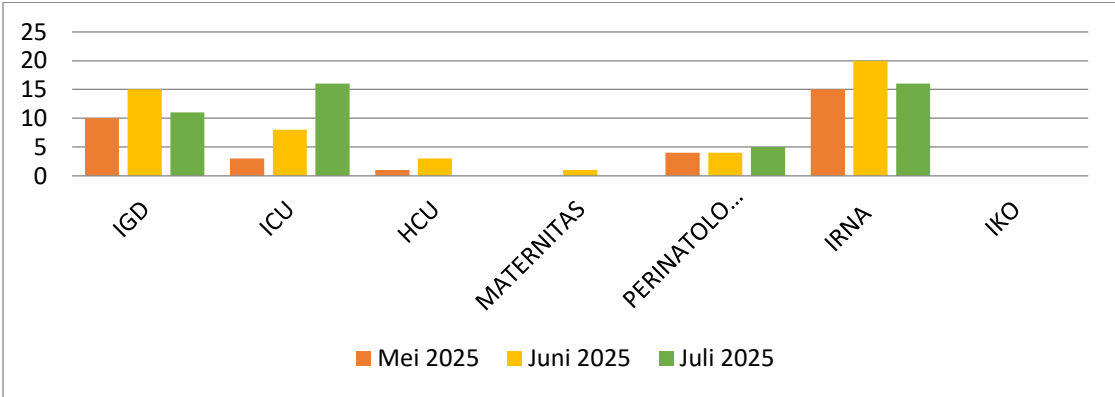
- rincian :
- 1) Parkir sebanyak 2 kasus yaitu terkait pembayaran parkir yang terlalu mahal, permintaan diberikan kartu bebas parkir untuk pasien rawat inap,
 - 2) Fasilitas RS sebanyak 4 kasus yaitu tersedia cenel TV yang banyak sehingga bisa menjadi hiburan pasien, ruangan fasilitas kelas 1 diperlebar

Rencana Tindak Lanjut :
Penyelesaian 123lastic123 dilakukan dengan melakukan telusur lapangan sederhana dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.5 Laporan Pasien Rujuk
3.5.7.5.1 Tabel Distribusi Pasien Rujuk Per Unit Bulan Juli 2025

NO	UNIT PERUJUK	MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025
1.	IGD	10	15	11
2.	ICU	3	8	16
3.	HCU	1	3	0
4.	MATERNITAS	0	1	0
5.	NEONATOLOGI	4	4	5
6	IRNA	15	20	16
7	IKO	0	0	0
Total		33	51	48

3.5.7.5.2 Grafik Jumlah Pasien Rujuk Eksternal Bulan Juli 2025



3.7.7 Tabel Rincian Pasien Rujuk Juli 2025

NO	NAMA PASIEN	UNIT	DIAGNOSIS	DPJP	RS TUJUAN	ALASAN RUJUK	LAMA RAWAT	PLAVON HABIS
1	WARTINAH	ICU	CVA 3th attack	dr Syahrir, Sp.N	RST	Pro stroke unit	5	TIDAK
2	By. Ny IIN KHOIROTUL	NEO	RDS dd MAS	dr. Fiona, Sp. A	RST Soepraun	Pro tatalaksana subspesialistik neonatologi, sub. neurologi anak	3	TIDAK
3	MOH KHUSEN Z A	IRNA	CVA Infark, DM	dr. Farid Sp.S raber dr. aji sp.pd	RS Lavalet	Pro unit stroke dan DSA	6	TIDAK
4	Ny. Asniwati	IRNA	SH + multiple ulcus upper GI + hipoalbumin + syok + anemia + ensefalopati hepatikum	dr. Ardhany, Sp. PD	RSSA	Pro perawatan lebih lanjut (bagian SP. PD, KGEH)	5	TIDAK
5	Ny. Diah Hindarwati	IRNA	DOC dt Uremic Encephalopatyy dd septic Encephalopatyy, DM Type 2, Susp Abdominal Mass, TF, CKD	dr Aji SP PD	RSUD Lawang	pro HD dengan SP. KGEH	7	TIDAK

6	TN. MAS'UD	IRNA	NSTEMI, Syok Cardiogenic, PVC	dr. Mira Sp. JP	RS UMM	Pro PCI	3	TIDAK
7	Tn. Billy Jerry Mongkol	IRNA	STEMI Inferior	dr Ira, Sp.JP	RST Supraoen	Pro PCI	2	TIDAK
8	Tn. Ngatemin	IGD	COB, Open Fr Parietal sinistra, SDH, edema serebri, susp dislokasi shoulder sinistra	dr Fachriy Sp BS	RSI Unisma	Pro craniotomy elevasi	2	Tidak
9	Tn. Parman	ICU	UAP, Total AV Block,	dr Mira Sp JP	RS UMM	pro immediate invasive strategy dan pemasangan temporary	2	Tidak
10	Tn. SUJOKO	IGD	Stemi inferior dan RV infarct	dr Mira Sp JP	RSI Aisiyah	Pro Primary PCI	2	Tidak
11	Ny Sri Mulyani	IRNA	Stemi	dr Ira, Sp.JP	RST Supraoen	Pro Primary PCI	3	TIDAK
12	An. stefia shallom ozora	IGD	abdominal pain susp neoplasma ovarium	dr. humaira SP.OG	RSSA	Rujuk Pro laparatomy back up bedah digestive	1	TIDAK
13	Neni Ponirawati	IRNA	Trauma Spondylolisthesis	dr. Oka, Sp.OT	RSSA	Pro MRI dan Stabilisasi Posterior	3	TIDAK
14	Rumakya	ICU	CVA ICH Capsula Interna Dextra	dr Dewi, Sp.S	RST	Pro stroke unit	2	TIDAK
15	Tn. Erwin Indrawan	IRNA	SAH, IVH, Hidrocephalus, post VP Shunt	dr. Fachriy Sp.BS	RSSA	pro CT Angiography	7	TIDAK
16	Ny. Muntaini	IRNA	DM Hipoglikemia, Gangren Necrotic diabeticum manus sinistra	dr Ard hany Sp PD	RSSA	Perawatan SPPD- KEMD dan SpB-TKV	4	TIDAK
17	Ny. RUSMINI	IRNA	LBP + Reflek positif	dr Ira Sp JP	Karsa Husada	Pro MRI	2	Tidak
18	Tn. AS'AD BASTHONI	IGD	CF OS Radius Ulna Sinistra + Trauma Abdomen	dr Arianto Sp OT	Persada Hospital	Pro operasi (Resiko Trobus dan ruptur arteri ulnaris)	1	Tidak
19	Tn. Mukiyat	IRNA	masive efusi pleura sinistra susp pneumonia ddx TB	dr Ardhi Sp PD	RS Lavalete	pro penatalaksanaan lanjutan curiga kanker paru, pertimbangan pemasangan WSD krm efusi pleura masif	4	Tidak
20	Ny. Marfuah	IRNA	Coma Syock Condition, DM Hiper, PAC, TF, ISK. CKD ST IV	dr. Aji, Sp. PD	RS Lavalete	pro HD	3	TIDAK
21	Tn. Adi Susanto	IRNA	Varises Esofagus grade III, HT portal, Anemia, CAD	dr. heri, Sp. PD raber dr. Yoga, Sp. JP	RSSA	Pro Endoscopy scleroterapi	2	TIDAK
22	Tn. Yoyok Aliyok	IRNA	TU Paru D, ARDS	dr. Farid, Sp. N raber dr. Andy, Sp. P, konsul dr. Robby. Sp. An	RSUB	Pro tatalaksana Tumor paru	2	TIDAK
23	Tn. Mariadi	ICU	AKI st III, Krisis DM Hiperglikemia, Eksfoliatif, Dermatitis, Syok Sepsis	dr. Ardhi Sp. PD K/ dr. Vita Sp. KK	RS Lavalete	Pro HD	3	TIDAK
24	SDR. NIZAR AHMAD AL GHIFARI	IGD	Pneumothorax	dr. Elvi, Sp.P	RSSA	Pro chest tube	1	TIDAK
25	Tn Iskak	ICU	Nstemi, Ileus obstructive Post op laparotomy	dr Zaki, Sp.B raber dr Mira	RST	Pro PCI	3	TIDAK
26	Tn.Kuseran	IGD	ADHF dt HHD,CKD	dr. Mira,Sp.Jp	RSUD Lawang	Pro HD	1	TIDAK
27	An. M. Khaidar Ali Baihaki	IGD	Sindrom nefrotik	dr Dicky, Sp.A konsul dr Andy, Sp.B, dr Edi, Sp.U	RS Wava Husada	Laparatomy join urologi dan Bedah anak	1	TIDAK
28	Ny. Rini Astuti	ICU	Nstemi	dr Ira, Sp.JP	RS UMM	Pro PCI	2	TIDAK
29	Ny. KARSİYAH	IGD	Koma Hipoglikemia, Acute on ckd hiperkalemia, Overload Syndrome	dr. Ardhi, Sp. PD	RS UB	Pro HD CITO	1	TIDAK
30	Tn. SUWITO	ICU	STEMI Inferoposterior, DM Type 2	dr. Ira, Sp. JP	RSU Islam Aisiyah Malang	Pro PCI	2	TIDAK
31	Tn. EKA AGUS DIAN K	IGD	hemoptoe, Uremic Lung, Acute On CKD	dr. Ardhi, Sp. PD	RSI Aisiyah	Pro HD CITO	2	TIDAK

32	BY NY MANDA	NEO	Pneumonia, premature, NEC	dr. Dicky, Sp. A	RSSA	Tatalaksana subspesialistik neonatologi	4	TIDAK
33	ny SITI NGATIN	ICU	Doc uremic encephalopathy, DOC, CKD, AKI, Trombositopenia, Susp Pneumonia	dr. Ardhi, Sp. PD	RS KARSA HUSADA BATU	Pro HD	2	TIDAK
34	Tn. Sugeng	ICU	colic abdomen ec Dyspepsia syndrom, AKI dd CKD, TB Paru, Fatty Liver, RF	dr. Heri Sp.PD Konsul dr. Andy Sp.P, dr. Robby Sp. An	RS Lavalette	Pro Ventilator dengan Back Up HD	3	TIDAK
35	ny. FITRIA SRI RAHAYU	ICU	Status epilepticus, encephalopathy, ckd st III	dr. Dewi Sp. S	RS Lavalette	pro subspesialis epilepsiPro Ventilator dengan Back Up HD	4	TIDAK
36	Ny. DJUMIHARSIYAH	ICU	Status epilepticus, CVA infark	dr. Zora Sp.Pd raber dr Dewi, Sp.S	RS Lavalette	Pro unit stroke	5	TIDAK
37	BY ny NADIYA	NEO	Neo bronchopneumonia + suspek nec	dr Fiona SpA	RS Lavalette	pro subspesialis konsultan neonatologi	5	TIDAK
38	tn AGUS SUWARSO	ICU	CVA ICH	dr. Dewi Sp. S	RS Lavalette	Pro unit stroke	2	TIDAK
39	By. Ny. MARITA	NEO	Neonatal bronchopneumonia, bblr, susp.downsyndrome	dr. Dicky, Sp. A	RS Lavalette	pro subspesialis konsultan neonatologi	2	TIDAK
40	TN. SUPPRIYO	IGD	Pneumothorax	dr. Elvi, Sp.P	RSSA	pro THORACOSINTESIS	1	TIDAK
41	ny ERMA SETYOWATI DK	ICU	CVA ICH	dr. Dewi, Sp. S konsul dr. fachriy, Sp. BS	RS Lavalette	Pro unit stroke	2	TIDAK
42	AGAM ARAY EL FATIH	IRNA	Ileus obstruksi dan hidrosefalus post vp shunt	dr Dicky Sp A	RS Soetomo	Pro bedah Anak	2	TIDAK
43	BUDI WIYANTO	IGD	STEMI anterior extensif	dr. Yoga Sp. Jp	RSUMM	Pro Bedah primary PCI	2	TIDAK
44	BY. NY. RETNOSARI	NEO	RDS, NEONATAL BRONCHOPNEUMONIA	dr. Fiona, Sp. A	RS LAVALETTE	Pro subspesialis konsultan neonatologi	2	TIDAK
45	Tn Hasbolah	ICU	Susp ME Bakteri. Post General status epileptikus dt epilepsy sumtomatic	dr Fahima Sp N	RS Lavalettee	Pro Lumbal Pungsi	7	TIDAK
46	An. Muhammad Nizam	IRNA	Susp ME	dr. dicky Sp.A	RSSA	Pro subspesialis	2	TIDAK
47	Tn. Tri Agung Budi Lestari	ICU	1. COS E2V4M5 2. EDH Frontal 3. SDH Temporal Kanan 4. Maxillofacial Fracture: Fraktur Os Sphenoid Dextra, Os Temporal Dextra, Os Maxilla Dextra, Os Mandibula Dextra	dr Fachri, Sp.BS	RS KARSA HUSADA BATU	Pro bedah plastik	2	TIDAK
48	Tn. Fardiono	ICU	CVA ICH 45cc	dr. Syahrir, Sp.N	RSUD Lawang	Pro Stroke Unit	1	TIDAK

Analisis :

1. Terjadi peningkatan jumlah pasien yang dirujuk ke RS lain dalam bulan Juli 2025.
 Pada bulan Mei 2025 sebanyak 33 pasien pada bulan Juni 2025 sebanyak 47. Sedangkan pada bulan juli 2025 sebanyak 48 pasien.
2. Alasan rujuk karena sarana dan prasarana tidak dimiliki oleh RSPH Malang, seperti :
 - a) Pro PCI
 - b) Pro CVCU
 - c) Pro stroke unit
 - d) Pro HD
 - e) Pro Bedah digestif
 - f) MRI
 - g) Pro bedah saraf lanjutan
 - h) Membutuhkan alat khusus

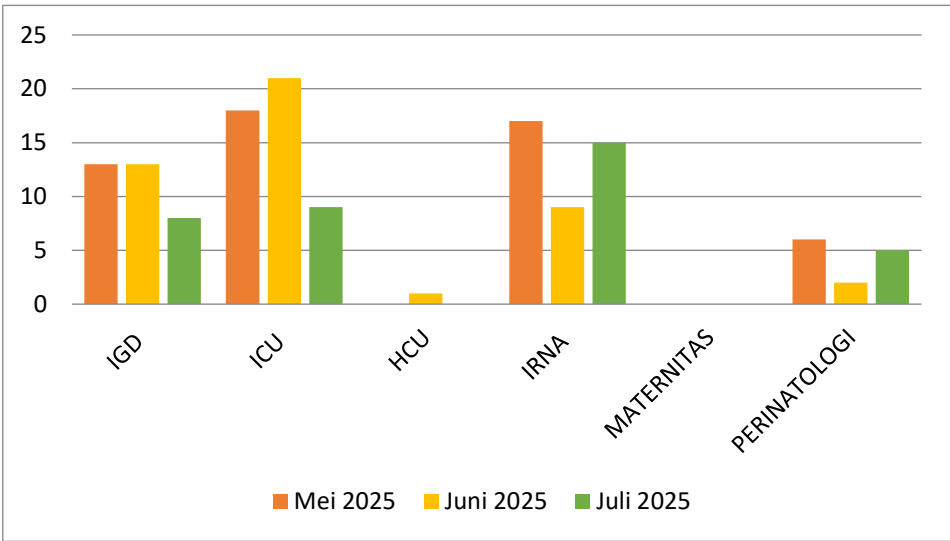
Rencana Tindak Lanjut:

- 1. Dilakukan evaluasi alasan terhadap rujukan pasien keluar yang semakin meningkat
- 2. Dilakukan komunikasi dengan DPJP melalui rapat komdik terkait plavon minus.

3.5.7.5.3 Jumlah Pasien Meninggal Bulan Juli 2025

NO	UNIT ASAL PASIEN MENINGGAL	Mei 2025	Juni 2025	Juli 2025
1.	IGD	13	13	8
2.	ICU	18	21	9
3	HCU	0	1	0
4.	IRNA	17	9	15
5.	MATERNITAS	0	0	0
6	NEONATOLOGI	6	2	5
Total		47	46	37

Grafik Jumlah Pasien Meninggal Juli 2025



Tabel Rincian Pasien Meninggal Juli 2025

NO	NAMA PASIEN	UNIT	DIAGNOSIS	DPJP
1	NY. LU'LU' AINI MANTSURO	IRNA	DOC ec DM Hiperglikemia, Susp.TF, AKI	dr Aji SP PD
2	Tn. Djoko Hadi Dahlan	ICU	ARDS, CVA ICH PONS, HT	dr Farid Sp N
3	Tn. ZAINUL ARIFIN	ICU	POST OP ABSES GLUTEUS DEXTRA SINISTRA	dr. Zaky, Sp.; B Raber dr. Heru, Sp. An
4	Ny. SITI RAHAJUNINGSIH	IGD	Shock Condition susp Shock Sepsis dd Hipovolemik, ARDS, Pneumonia	dr. Shafira
5	By. Ny. SUWARNI EKA WIJAYANTI	NEO	neonatal imatur, RDS	dr. Dicky, Sp. A
6	Tn. Saim	ICU	ARDS, TU PARU	dr Elvi, Sp.P
7	NY. DEWI SANAWIYAH	IRNA	DM HIPERGLIKEMIA	dr Ardhi, SP.PD
8	By. Ny. Narendra Prameswari	NEO	IUFD	dr Humaira SP OG
9	AISYAH FITRIA PUTRI HERFINA	IRNA	syok septic	dr Dicky Sp A
10	SUSI HARINI	IRNA	Colic Abdomen, Febris	dr Heri Sp PD

11	TUMINAH	IRNA	CA Hepar metastase, anemia hemoragic	dr Heri Sp PD
12	LILIK SRIYONO	ICU	hidrocephalus	dr. Fahri Sp.BS
13	GUNAWAN	ICU	Respiratory failure	dr. Andy Sp.P
14	NASTITIK	IGD	Syok Hemoragic Transient Response	dr. Fachriy sp.bs
15	YOHANA SRI WINARTI	IGD	susp cva ich DOC	dr. Dewi, Sp. S
16	KARIONO	IGD	DOC DT SEPSIS	dr. Ardhany, Sp. PD
17	RADITYA WAHYU NING PUTRA RAGIL	IRNA	SuspMeningitis, Edema cerebri, Hidrocephalus	
18	MARISAH	IRNA	DM Hipoglikemi	dr Ardhany, S.PD
19	PUJANTORO	IGD	Cardiac Arrest	dr. Shafira
20	Tn. AKHMAD	IGD	ARDS + Syok Kondition	dr. Shafira
21	Ny. Raminten	ICU	DOC + ARDS + Pneumonia + Syock Septic	dr. Andy Sp. P
22	Ny. Suparwati	IRNA	DM Hiperglikemi + HT Emergency + CVA Trombosis 2nd Attack + CSVD	dr. Ardhany, Sp. PD
23	Tn. Siswari	IRNA	Syok condition dd syok hipovolemik	dr. Heri, Sp. PD
24	NY. UMMI CHANIFAH	IRNA	CKD, Anemia	dr Ardhany Sp PD
25	TN. MUSILAN	ICU	ARDS+DOC + Susp.CVA	dr Fahima Sp S
26	NY. JUWITA	ICU	ARDS + NSTEMI + SYOCK CARDIOGENIC+ SUSP CVA 2ND + HEMATEMESIS	dr yoga Sp JP
27	BY. NY. NINDYA AMALIA	NEO	IUFD	dr Aida, Sp.OG
28	NY NINIK FARIDA	IGD	DOA	dr Isrotul
29	Ny. RUKAYAH	IRNA	Colic Abdomen, Susp. CVA	dr. Ardhany
30	Ny. SANITI	IRNA	Hernia Inguinalis	dr. Zaki, Sp.B
31	By Ny Adilla	NEO	BBLR	dr. Humaira Sp.OG
32	ny AYU SINDY SEPTIANA	ICU	KRISIS HIPERTIROID	dr Zora, Sp.PD raber dr Fahimma, Sp.N
33	Ny. MUFIDAH	IRNA	CVA ICH, Syok Sepsis Pneumoni Aspirasi, ARDS	dr. Syahrir Sp. S konsul dr. Elvi Sp. P konsul dr. Robby Sp. An
34	Ny. Sri Mintarningsih	IRNA	Pneumonia, DM Gastropaty, ulkus diabeticum, candidiasis oral	dr Ardhi SP PD
35	BY. NY. DWI KARTIKA MUKTI	NEO	RDS, IMATUR, BBLASR	dr Dicky Sp A
36	Ny. Li'ah	IRNA	hematemesis	dr Ardhany Sp PD
37	Ny. Sukati	IGD	CVA Infark	dr Farid, Sp.S

Analisa :

1. Jumlah pasien meninggal dunia pada bulan Juli 2025 sebanyak 37 pasien
2. Jumlah terbanyak yaitu dari IRNA : 15 pasien ICU : 9 pasien IGD : 8 pasien, HCU sebanyak 0 pasien dan Neonatologi sebanyak 5 pasien.
3. Pada bulan Juli 2025 Jumlah kasus DOA di IGD sebanyak 1 kasus.
4. Pengisian EWS sudah dilakukan di IGD dan IRNA.

Rencana Tindak Lanjut

Dilakukan evaluasi terhadap pasien datang ke IGD dengan kasus DOA

3.5.7.6 Laporan MPP

3.5.7.6.1 Tabel Rekap Berdasarkan Skrining Pasien

NO	IDENTIFIKASI / SKRINING PASIEN	BULAN / JUMLAH		
		MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025
1	Usia lanjut	-	-	-
2	Kasus penyakit kronis / terminal katastropik	-	-	-
3	Riwayat penggunaan alat bantu (kursi roda, walker, tongkat, dll)	-	-	-
4	Perkiraan biaya tinggi	-	-	-
5	Kemungkinan sistem pembiayaan yang kompleks (2 asuransi)	-	-	-
6	Pasien dengan fungsi kognitif rendah	-	-	-
7	Potensial 128lastic128 tinggi	-	-	-
8	Kasus yang melebihi rata-rata lama rawat	-	-	-
9	Kasus yang diidentifikasi rencana pemulangnya	-	-	-
10	Berisiko membutuhkan kontinuitas pelayanan	-	-	-
11	Berpotensi masalah hukum	-	-	-
12	Naik kelas pelayanan	-	-	-
13	Lain – lain	-	-	-

3.5.7.6.2 Tabel Jumlah Lain-Lain (Permasalahan Cara Bayar)

NO	IDENTIFIKASI / SKRINING PASIEN LAIN-LAIN (PERMASALAHAN CARA BAYAR)	BULAN / JUMLAH		
		MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025
1	Habis PKS	-	-	-
2	BPJS status Denda	-	-	-
3	BPJS status Premi	-	-	-
4	BPJS status Denda dan Premi	-	-	-
5	BPJS staus Usia lebih dari 21 tahun	-	-	-
6	BPJS status keluar atas kemauan sendiri	-	-	-
7	BPJS status penangguhan pembayaran	-	-	-
8	Rencana pengurusan BPJS	-	-	-
9	BPJS status tidak ditanggung	-	-	-
10	BPJS tidak aktif akhir bulan	-	-	-
11	BPJS peralihan Mandiri ke PBI	-	-	-

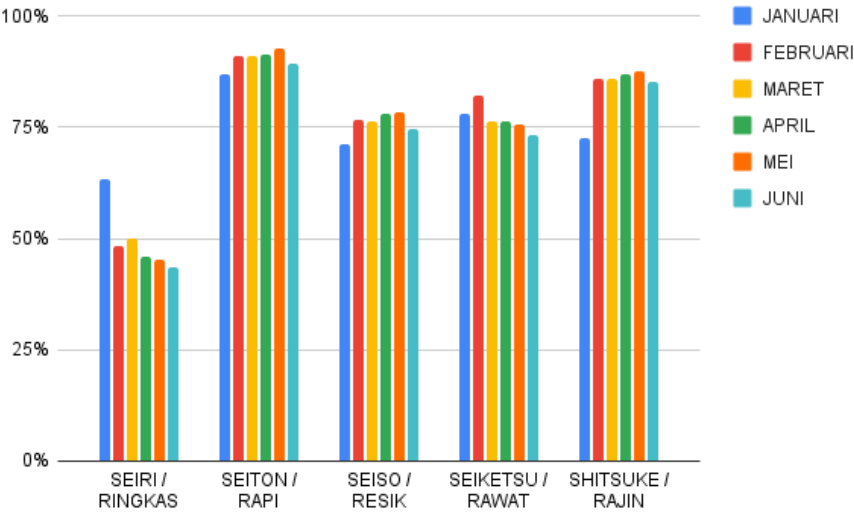
3.5.8 Cleaning Service

3.5.8.1 Indikator Kerja Cleaning Service

KATEGORI	DESKRIPSI
Seiri	Penempatan Alat Kebersihan Di Janitor/ Trolly
	Penempatan Alat Kebersihan Di Janitor/ Trolly
Seiton	Kerapian Baju Dan Kebersihan, Penampilan Petugas Cs
	Kerapian Baju Dan Kebersihan, Penampilan Petugas CS
Seiso	Membersihkan Area Kerja Secara Rutin Sesuai Jadwal
	Membersihkan Area Kerja Secara Rutin Sesuai Jadwal
Seiketsu	Mematuhi Sop Kebersihan
	Mematuhi SOP Kebersihan
Shiketsu	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan
	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan
	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan

3.5.8.2 Tabel Produktifitas *Cleaning Service*

NO	JENIS SPV	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI
1	SEIRI / RINGKAS	63%	48%	50%	50%	45%	44%
2	SEITON / RAPI	87%	91%	91%	91%	93%	89%
3	SEISO / RESIK	71%	77%	76%	76%	78%	75%
4	SEIKETSU / RAWAT	78%	82%	76%	76%	76%	73%
5	SHITSUKE / RAJIN	72%	86%	86%	86%	88%	85%



Analisa :
Produktifitas Unit CS dalam penilaian ini masih dalam monev karena memakai instrument supervise yang baru. Hasil masih fluktiatif dan dalam relative baik.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi

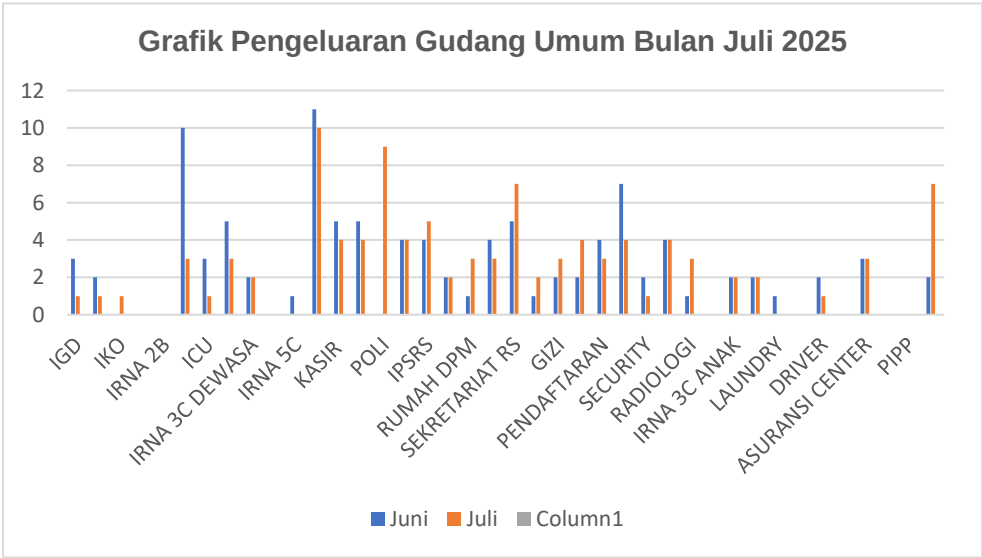
3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum

3.5.9.1 Tabel Laporan Pencatatan Pengeluaran Barang

NO	UNIT ASAL	JUMLAH BARANG		PERSENTASE
		JUNI	JULI	
1	IGD	2	1	↓-100%
2	MATERNITAS	2	1	↓-100%
3	IKO	0	1	↑ 0%
4	IRNA 2A	0	0	↓0%
5	IRNA 2B	0	0	↓0%
6	IRNA 2C	10	5	↓-100%
7	ICU	3	2	↓-50%
8	IRNA 3A+4A	5	3	↓-66,66%
9	IRNA 3C DEWASA	2	2	↓0%

10	IRNA 4C	0	0	↓0%
11	IRNA 5C	1	0	↓0%
12	MS PTP , MS LAWANG,MS KARLOS	11	10	↓-10%
13	KASIR	5	4	↓-25%
14	DAPUR	5	4	↑ -25%
15	POLI	0	9	↑100%
16	CLEANING SERVICE	4	4	↓0%
17	IPSRS	4	5	↑20%
18	GUDANG FARMASI	2	2	↓0%
19	RUMAH DPM	1	3	↑66,66%
20	SEKRETARIAT PT	4	3	↓-33,33%
21	SEKRETARIAT RS	5	7	↑28,57%
22	CSSD	1	2	↑50%
23	GIZI	2	3	↑33,33%
24	REKAM MEDIS	2	4	↑50%
25	PENDAFTARAN	4	3	↓-33,33%
26	DEPO FARMASI	7	4	↑-75%
27	SECURITY	2	1	↓-100%
28	LABORATORIUM	4	4	↑0%
29	RADIOLOGI	1	3	↑66,66%
30	FISIOTERAPI	0	0	↓0%
31	IRNA 3C ANAK	2	2	↑0%
32	NS NICU	2	2	↑0%
33	LAUNDRY	1	0	↓0%
34	LANTAI 6A,7A,8A	0	0	↓0%
35	DRIVER	2	1	↓-100%
36	SIMRS	0	0	↓0%
37	ASURANSI CENTER	3	3	↓0%
38	DPW	0	0	↓0%
39	PIPP	0	0	↑0%
40	RS DH	2	7	↑71,42%

3.5.9.2 Grafik Jumlah Pengeluaran Barang Berdasarkan Asal Unit



Analisis :
Pada grafik diatas dapat kita lihat bahwa data barang paling banyak ada pada unit Mutiara sehat , Poli dan RSDH

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Mendisiplinkan kepatuhan jadwal pengambilan barang
- 2. Memberi edukasi ke unit agar tidak salah input barang atau salah unit
- 3. Menyarankan ke seluruh unit agar punya data inventaris ATK secara terperinci

3.5.10 IT SIMRS

3.7.8 Capaian Tata Laksana Keluhan

NO	JENIS KELUHAN	JUMLAH LAPORAN	JUMLAH TERSELESAIKAN	PROSENTASE (%)
1	Keluhan terkait software	37	37	100%
2	Keluhan terkait hardware	146	146	100%

Analisis : Untuk Keluhan dapat terselesaikan oleh Tim IT
Rencana Tindak Lanjut : Monitoring dan Evaluasi

3.7.9 Rekapitulasi Kejadian Downtime

NO	TANGGAL KEJADIAN DOWNTIME	JENIS DOWNTIME (TERENCANA/TIDAK TERENCANA)	LAMA DOWNTIME	PENYEBAB DOWNTIME	RTL
1.	28/7/2025	Tidak terencana	30 menit (06.30-07.00)	Server Bridging dan Sipp down	Edukasi menunggu estimasi 30 menit info dari IT bpjs
2.	28/7/2025	Tidak terencana	90 menit (21.00-22.30)	Down provider D-Net	Edukasi menunggu estimasi 60 menit info dari Teknisi Dnet

Analisis : Untuk Keluhan dapat terselesaikan oleh Tim IT
Rencana Tindak Lanjut : Monitoring dan Evaluasi

3.6 Komite dan Tim

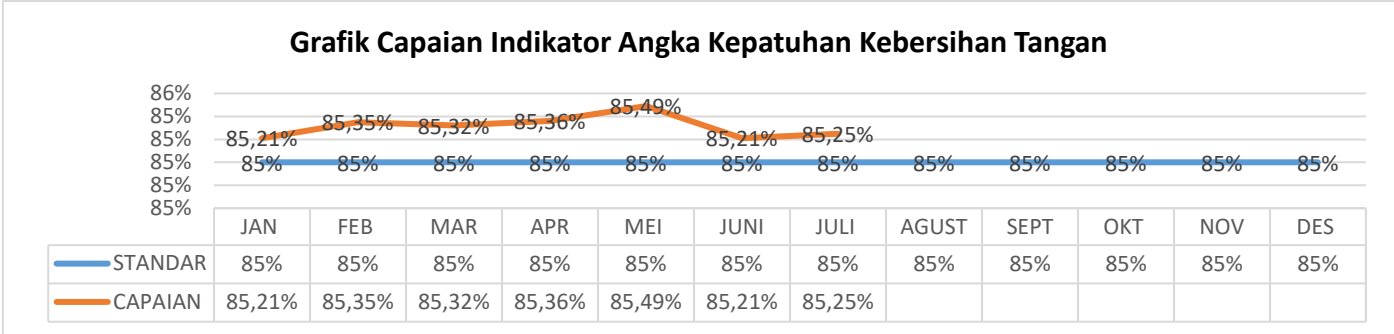
3.6.1 Komite Mutu

3.6.1.1 Indikator Mutu Nasional

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Juli '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	85,21%	85,35%	85,32%	85,36%	85,49%	85,21%	85,25%						85,29%
2.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	93,01%	93,06%	93,1%	93,22%	93,54%	96,3%	93,79%						93,05%
3.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	99,55%	99,92%	99,77%	99,96%	99,88%	100%	93,93%						99,74%
4.	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%
5.	Waktu Tunggu Rawat Jalan	≥ 80%	89,16%	89,38%	99,1%	98,21%	97,58%	97,33%	96,23%						92,54%
6.	Penundaan Operasi Elektif	≤ 5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						0%
7.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	75,9%	76,21%	74,93%	74,19%	72,26%	78,28%	66,22%						75,68%
8.	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100%	96,9%	97,31%	100%	100%	100%	100%	100%						98,07%
9.	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%
10.	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%
11.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	99,75%	98,64%	99,1%	99,44%	97,65%	99,09%	96,33%						99,16%
12.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥ 80%	100%	99,92%	100%	100%	100%	100%	100%						99,97%
13.	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	99,81%	99,79%	100%	99,88%	99,76%	97,12%	99,46%						99,86%

3.6.1.1Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

3.6.1.1.1 Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan



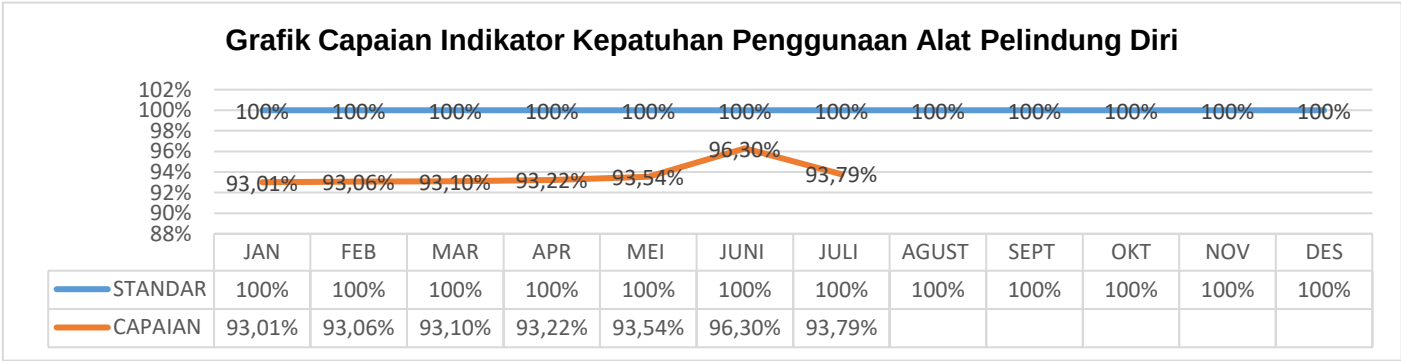
Dari grafik indikator angka keptuhan kebersihan tangan bulan Januari tahun 2025 diketahui bahwa capaian telah mencapai standart yaitu 85,21% dan pada bulan Februari capaian meningkat menjadi 85,35%, capian di bulan Maret yaitu 85,32%, capaian di bulan April yaitu 85,36%, capaian di bulan Mei 85,49%, capaian di bulan Juni adalah 85,21 dan capaian di bulan Juli adalah 85,25% dengan rata rata bulan Januari hingga Juli yaitu 85,31%. Meskipun belum mencapai 100% tetapi nilai tersebut telah mencapai standart. Petugas masih dengan anggapan bahwa tangannya dalam kondisi masih bersih dan terkadang karena kondisi harus segera dilakukan tindakan pada pasien jadi lupa tidak melakukan cuci tangan karena memang belum terbiasa. Di harapkan capaian ini dapat ditingkatkan di bulan berikutnya.

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin hingga 100%.				
DO	1. Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. 3. Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. 4. Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik.				
STUDY	Dari grafik indikator angka keptuhan kebersihan tangan bulan Januari tahun 2025 diketahui bahwa capaian telah mencapai standart yaitu 85,21% dan pada bulan Februari capaian meningkat menjadi 85,35%, capian di bulan Maret yaitu 85,32%, capaian di bulan April yaitu 85,36%, capaian di bulan Mei 85,49% dan capaian di bulan Juni adalah 85,21 dengan rata rata bulan Januari hingga Juni yaitu 85,32%. Meskipun belum mencapai 100% tetapi nilai tersebut telah mencapai standart. Petugas masih dengan anggapan bahwa tangannya dalam kondisi masih bersih dan terkadang karena kondisi harus segera dilakukan tindakan pada pasien jadi lupa tidak melakukan cuci tangan karena memang belum terbiasa. Di harapkan capaian ini dapat ditingkatkan di bulan berikutnya				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter	Satu bulan

			2. Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. 3. Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. 4. Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik.	3. Karu 4. IPCLN/PCN	
--	--	--	--	-------------------------	--

3.6.1.1.1 Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

3.7.10 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri



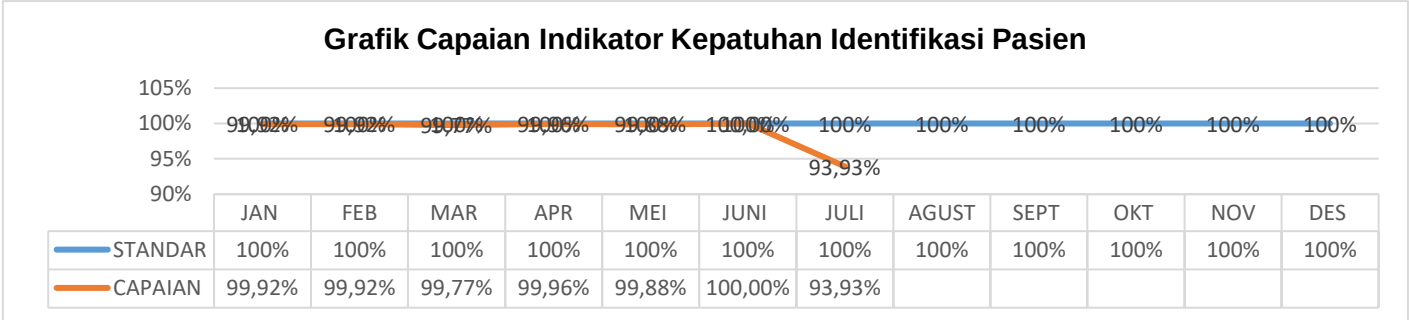
Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan penggunaan alat pelindung alat pelindung diri pada bulan Januari hingga Juli Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan penggunaan APD semaksimal mungkin hingga 100%.
DO	1. Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. 2. Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 3. Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 4. Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD petugas dapur). 5. Sudah dikeluarkan edaran terkait penggunaan jas dokter. 6. Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.
STUDY	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart. Capaian di bulan Januari tahun 2025 yaitu 93,01%, bulan

	Februari sebesar 93,06%, bulan Maret sebesar 93,1%, bulan April 93,22%, bulan Mei 93,54%, bulan Juni 96,3% dan bulan Juli 93,79% dengan rata-rata 93,71%. Dari hasil monitoring dan supervise, masih ditemukan petugas perawat yang memakai APD tidak sesuai dengan jenis tindakan dan transmisi penyakit, misalnya seperti injeksi lewat selang infus / hanya TTV ke pasien non infeksi namun menggunakan handscoon. Kepatuhan APD petugas dapur terutama pengolah makanan masih sangat kurang terutama penggunaan masker. Untuk petugas medis, masih ditemukan DPJP yang masih menggunakan handscoon meskipun hanya visite tidak melakukan tindakan. Untuk petugas CS ditemukan masih menggunakan handscon medis untuk mengepel yang seharusnya menggunakan handscoon kerja				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	Tercapainya kepatuhan APD hingga maksimal 100%.	1. Berkolaborasi dengan IPCD untuk melakukan edukasi terhadap para DPJP. 2. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan. 3. Lakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 4. Berikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 5. Berikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. 6. Tanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu Bulan

3.6.1.1.2 Kepatuhan Identifikasi Pasien

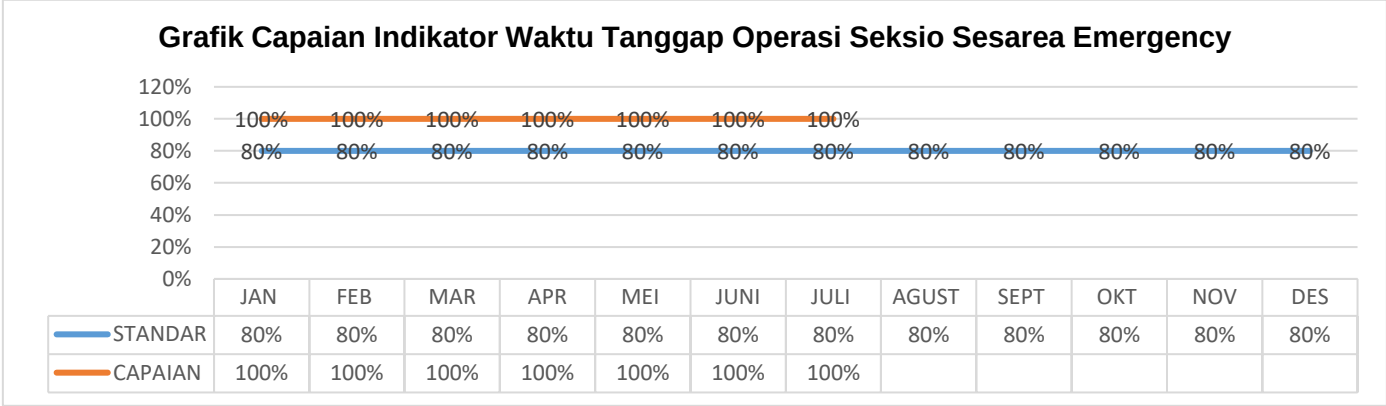
3.7.11 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pas



Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Januari hingga Mei Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, pada bulan Junictahun 2025 capaian telah meningkat menjadi 100%,namun kembali menurun di bulan Juli yaitu 93,93%.

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	1. Melakukan 136lastic136e pada petugas di unit secara berkelanjutan 2. Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan 136lastic136e dan sosialisasi terkait identifikasi pasien 3. Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart dengan capaian bulan Januari tahun 2025 yaitu 99,92 %, bulan Februari sebesar 99,92%, bulan Maret sebesar 99,77% capaian di bulan April yaitu 99,96%, capaian di bulan Mei 99,88% dan capaian meningkat di bulan Juni menjadi 100%,namun Kembali menurun pada bulan Juli yaitu 93,93% dengan rata rata 99,10%. Supervisi secara berkelanjutan serta memberikan teguran secara langsung cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	1. Terus melakukan 136lastic136e pada petugas unit 2. Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan tepat.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu Bulan

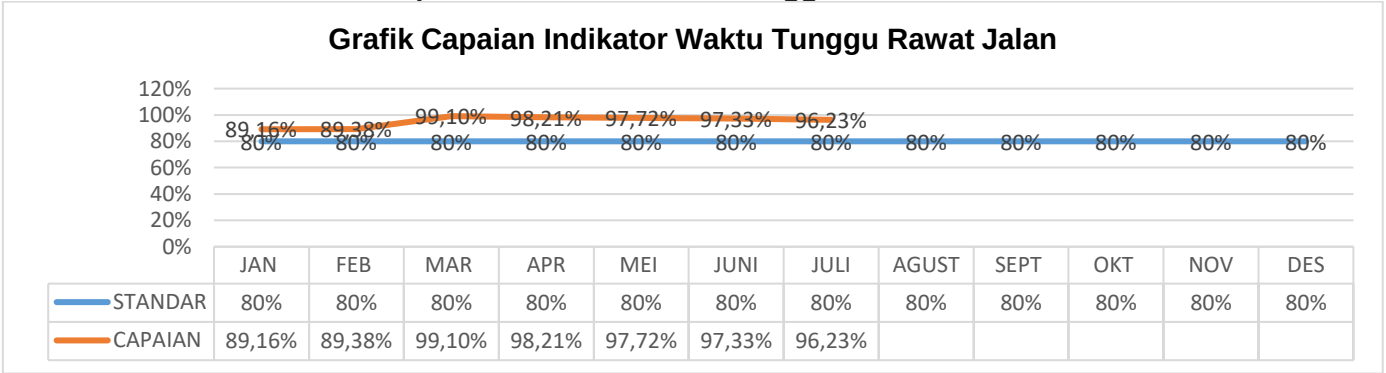
3.6.1.1.3 Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency



Dari grafik indikator waktu tanggap SC emergency bulan Januari hingga bulan Juli tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini berkat kerjasama yang baik antara unit Instalasi Gawat Darurat, Unit Maternitas dan Instalasi Kamar Operasi serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian waktu SC emergency. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

3.6.1.1.1 Waktu Tunggu Rawat Jalan

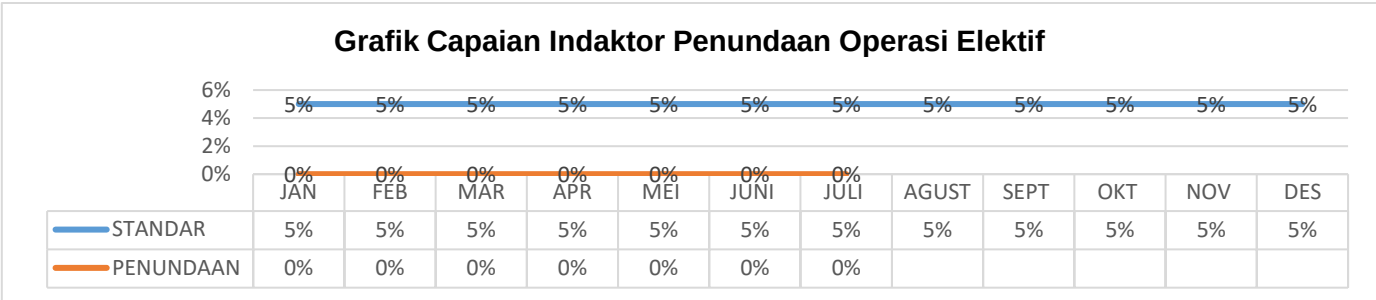
3.7.12 Grafik Capaian Indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan



Berdasarkan grafik capaian indikator waktu tunggu rawat jalan pada bulan Januari Tahun 2025 capaian telah mencapai standart dengan capaian 98,16%, capaian di bulan Februari 89,38%, capaian di bulan Maret 99,1%, capaian di bulan April 98,22%, capaian di bulan Mei 97,71%, capaian di bulan Juni adalah 97,33% dan capaian di bulan Juli adalah 96,23% dengan rata-rata 95,28%. Hal ini berkat kerjasama yang baik antara manajemen dan juga DPJP yang sudah berusaha datang tepat waktu dan evaluasi berkelanjutan yang telah dilakukan manajemen terhadap keterlambatan DPJP. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan dibulan berikutnya.

3.6.1.1.2 Penundaan Operasi Elektif

3.7.13 Grafik capaian Indikator Penundaan Operasi Elektif

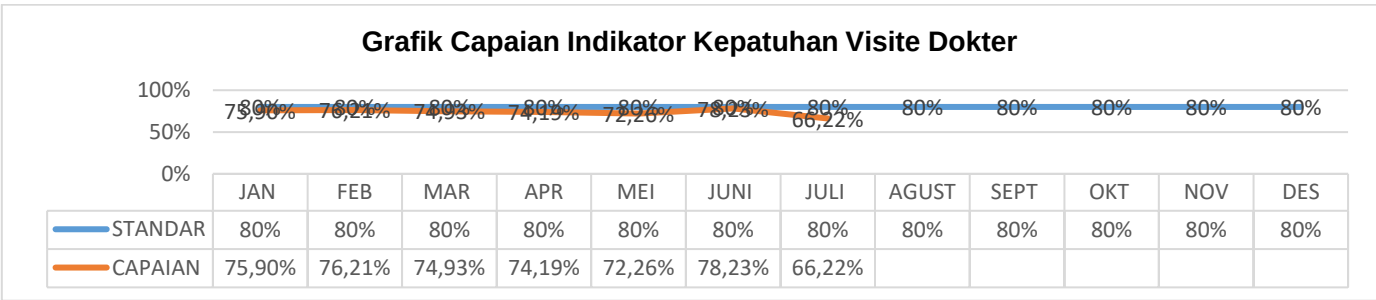


Dari grafik indikator penundaan operasi elektif bulan Januari hingga Juli tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 0%, hal ini berkat kerjasama yang baik antara unit Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Kamar Operasi serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian indikator penundaan operasi elektif . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025.

3.1.7 Kepatuhan Waktu Visite Dokter

3.6.1.1.3 Kepatuhan Waktu Visite Dokter

i. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Visite Dokter

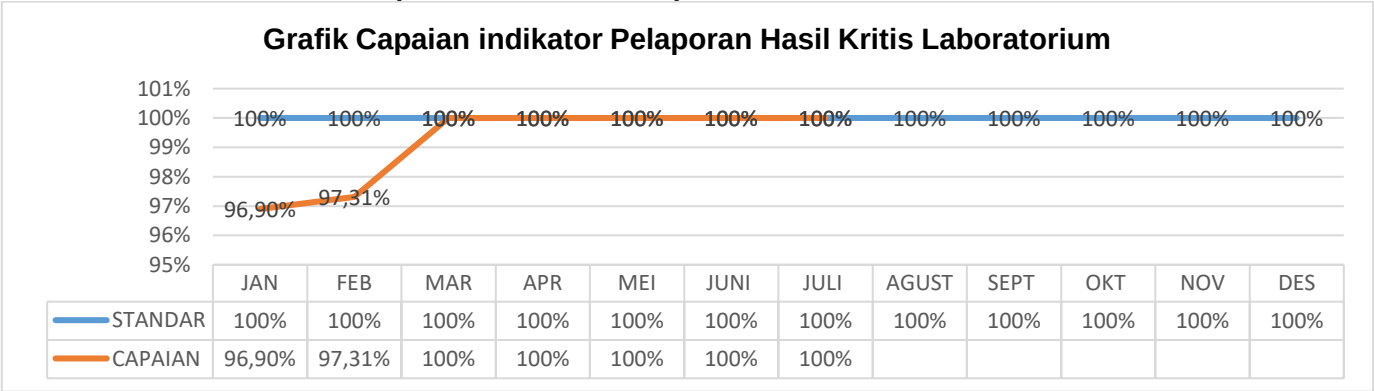


Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan visite Dokter pada bulan Januari hingga Juli Tahun 2025 belum mencapai standart, hal ini disebabkan karena Seluruh dokter Klinisi di Rumah Sakit Prima Husada adalah dokter tamu dari luar, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan waktu visite dokter hingga dapat mencapai standart 80%.				
DO	Memberikan masukan pada SDM dan Kabid pelayanan untuk melakukan rekrutmen home dokter lebih banyak				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui persentase kepatuhan waktu visite dokter pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian 75,9%, capaian di bulan februari yaitu 76,21%, capaian di bulan Maret yaitu 74,93%, capaian di bulan April yaitu 74,19%, capaian di bulan Mei yaitu 72,26%, capaian di bulan Juni yaitu 78,23%, capaian di bulan Juli yaitu 66,22% dengan rata-rata 75,99%. Dari hasil supervisi didapatkan. nnya Angka kepatuhan waktu visite Dokter belum mencapai standart karena masih banyak dokter yang visite diatas jam 14.00 karena masih bertugas di RS asal karena RS Prima Husada belum memiliki dokter tetap. Dokter visite jam 07.00-14.00 : dr. Ira, Sp.JP, dr. Mira, Sp.JP, dr. Anton, Sp.B, dr, dr. Dicky,Sp.A , dr. Elvi, Sp.P, dr. Dewi, Sp.S, dr. Ardhi, Sp.PD, dr. Humairoh, Sp.Og. , dr. Nimim, Sp.THT.KL, dr, dr. Aji, Sp.PD. Dokter visite jam 14.00-21.00 : dr. Heriyatmo, Sp.PD, dr. Andi, Sp.P, dr. Farid, Sp.S, dr. Yoga, Sp.JP (Tidak menentu), dr. Ardani, Sp.DP (tidak menentu)				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Capaian Kepatuhan Visite dokter bisa meningkat pada bulan selanjutnya	Melakukan KIE dan komunikasi dengan DPJP terkait waktu visite dokter, hal ini menjadi PR yang cukup besar bagi tim mutu dan manajemen karena 139lastic139 besar DPJP tidak hanya bertugas di RS Prima Husada.	Manajemen RS	Satu Tahun

ii. Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

3.7.14 Grafik Capaian Indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

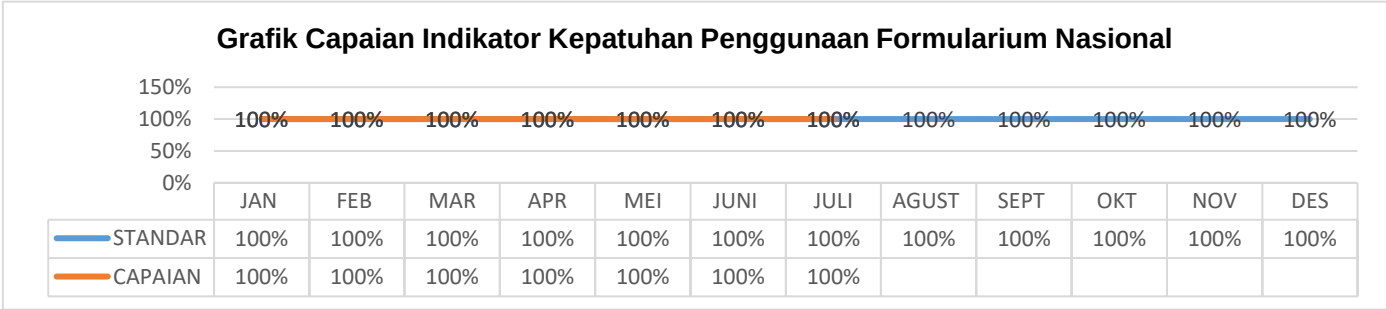


Berdasarkan grafik capaian indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium pada bulan Januari dan Februari Tahun 2025 diketahui capaian belum mencapai standart dan capaian meningkat hingga 100% di bulan Maret hingga Juli. Capaian meningkat pada bulan Maret hinga Juni yang telah mencapai standart 100%.

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan pelaporan hasil kritis laboratorium hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan 140lastic140e baik dari komite mutu maupun kepala instalasi laboratorium supaya seluruh petugas laboratorium segera melaporkan hasil kritis dan melakukan dokumentasi dengan baik dan lengkap.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui indikator pelaporan hasil kritis laboratorium pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian 96,9% dan bulan Februari 97,31%. Capaian meningkat pada bulan Maret hingga Juli yang telah mencapai standart 100%. Berdasarkan hasil supervisi masih ada petugas yang melaporkan hasil kritis laboratorium tetapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan lengkap.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	Capaian pelaporan hasil kritis laboratorium dapat mencapai standart 100% pada bulan berikutnya	1. Menganalisa jumlah hasil kritis laboratorium yang terlapor dan tidak terlapor 2. Memasukkan catatan ketidak patuhan staf kedalam evaluasi kinerja staf secara langsung kepada petugas laboratorium yang tidak melaporkan hasil kritis laboratorium ataupun yang melapor tapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan baik dan lengkap.	1. Komite mutu 2. Kepala instalasi laboratorium	Satu Tahun

3.6.1.1.4 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

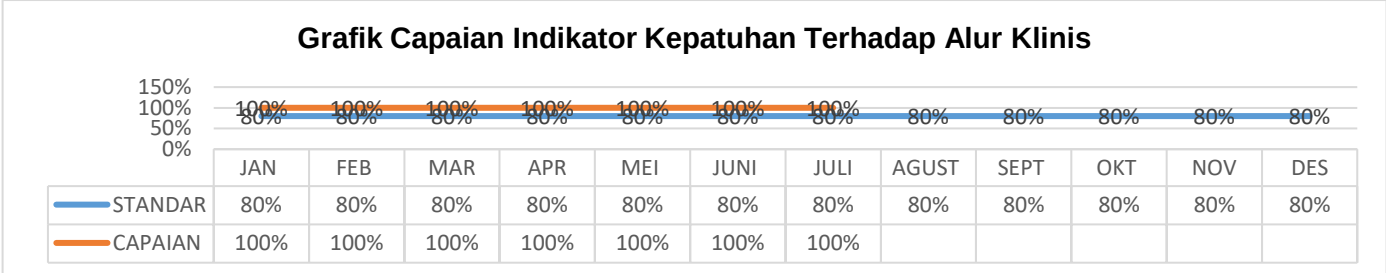
3.6.1.1.9.1 Grafik Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional



Dari grafik indikator Formularium Nasional bulan Januari hingga Juli tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini kerjasama yang baik antara dokter penanggungjawab pasien, instalasi farmasi dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepatuhan penggunaan formularium Nasional . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025.

3.6.1.1.5 Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*)

3.7.15 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis



Dari grafik indikator kepatuhan terhadap alur klinis bulan Januari hingga Juli tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini kerjasama yang baik antara dokter penanggungjawab pasien, instalasi farmasi dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepatuhan penggunaan formularium Nasional . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

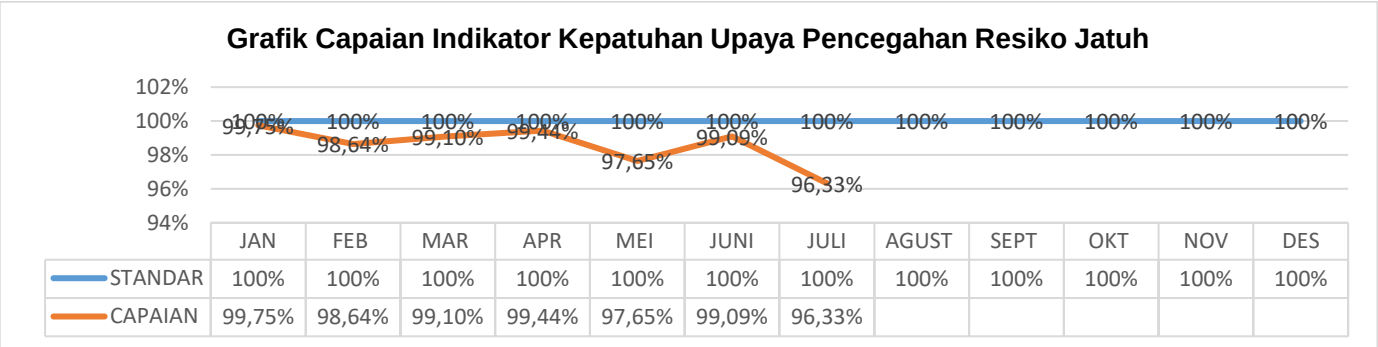
Daftar Clinical Pathway Bulan Juli 2025

Diagnosa	Jumlah	Patuh	Tidak Patuh
DF			
CVA Infark			
Gastritis			
Batu Ureter			
DM			
GEA			
CHF			
FAM			
TB Paru			
HT			
CA Mammae			
HIV			

STEMI			
NSTEMI/UAP			
Pneumonia			
Sectio Caesarea	37		
Partus Normal	42		
Jumlah	79	79	

3.6.1.1.6 Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

3.7.16 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari hingga Juli Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan 142last pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%					
DO	Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan 142last pencegahan resiko jatuh					
STUDY	Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian yaitu 99,75%, capaian di bulan Februari yaitu 98,64%, capaian di bulan Maret yaitu 99,1%, capaian di bulan April yaitu 99,44%, capaian di bulan Mei yaitu 97.65%, capaian di bulan Juni adalah 99,09% dan capaian di bulan Juli adalah 96,33% dengan rata-rata 96,57%. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien agar selalu memasang handrell tetapi seringkali keluarga pasien tidak memasang kembali handrell ketika pasien telah dari kamar mandi.					
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator kepatuhan	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan	Capaian indikator kepatuhan terhadap	Melakukan 142lastic142e berjenjang mulai dari PJ shift, kepala ruangan, kepala bidang keperawatan		Perawat instalasi rawat	Satu Bulan

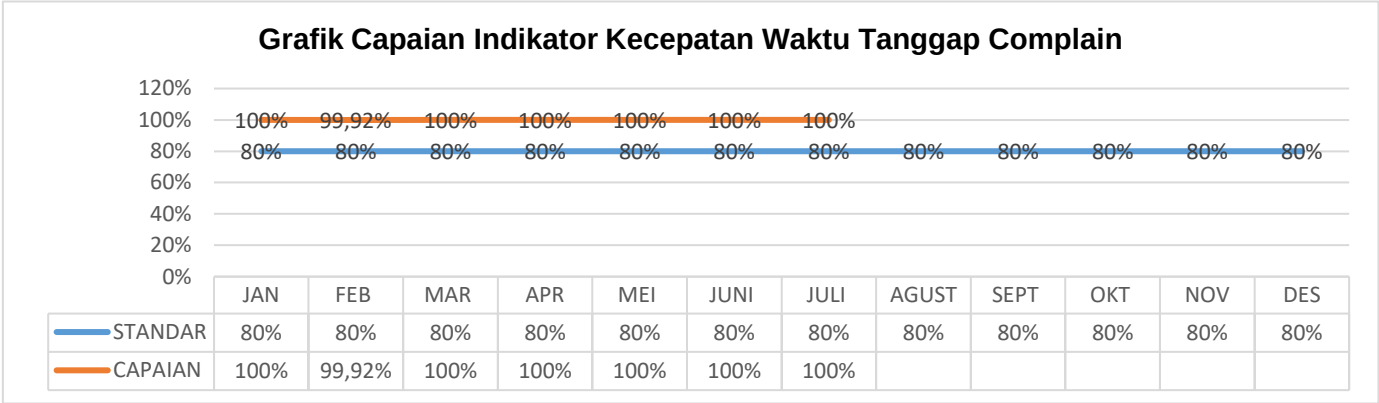
143 last pencegahan resiko jatuh	143 last pencegahan resiko jatuh	143 last pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%.	dan tim mutu guna memastikan perawat ruangan telah melakukan KIE kepada pasien dan keluarga tentang 143 last pencegahan resiko jatuh harus lebih ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan.	inap	
----------------------------------	----------------------------------	--	--	------	--

3.6.1.1.7

Kecepatan Waktu Tanggap Komplain

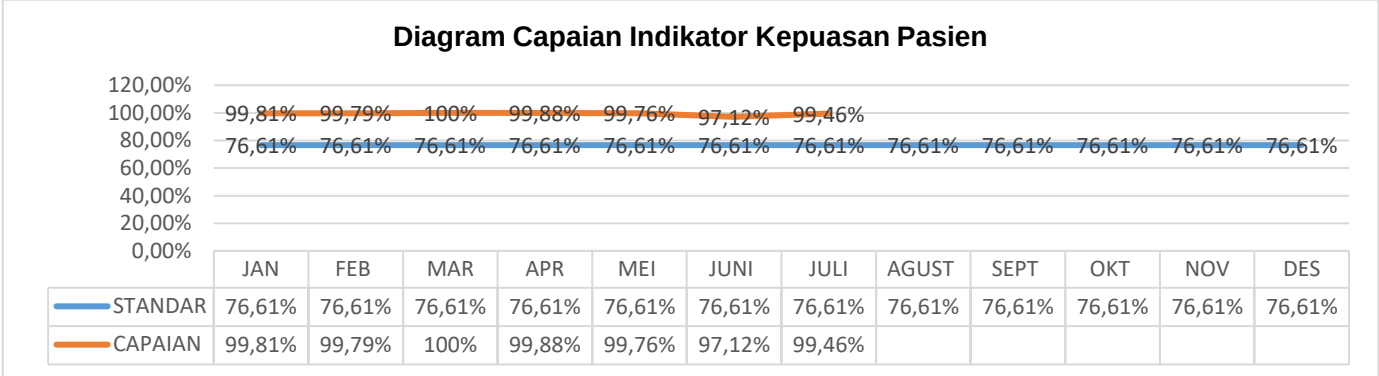
3.6.1.1.12.1

Grafik Capaian Indikator Kecepatan Waktu Tanggap Komplain



3.6.1.1.12.2 Kepuasan Pasien

3.6.1.1.12.2.1 Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien



Dari grafik indikator kepuasan pasien bulan Januari hingga Juli tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart lebih dari 76,61% dengan rata-rata 99,40%, meskipun belum mencapai nilai sempurna 100% tetapi capaian ini telah melebihi standart. Hal ini karena kerjasama yang baik antara seluruh karyawan Rumah Sakit Prima Husada Malang dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepuasan pasien . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

3.6.1.1.1 Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,55%	99,92%	99,77%	99,96%	99,88%	100%	93,93%						99,1%
2.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis (IRNA,IRJA, IGD,IKO)	100%	99,55%	99,92%	99,73%	99,51%	99,33%	99,93%	99,37%						99,62%
3.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi (IRNA,IGD,IKO)	100%	100%	100%	100%	100%	90,86%	100%	100%						98,7%
4.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	91,38%	98,85%	100%						98,60%
5.	Kejadian Ketidaklengkapan Lembar Operan Pasien (IRNA,IRJA, IGD,IKO)	0	0	0	0	0	0	0	0						0%
6.	Angka Kelengkapan Penyiapan Dan Pengelolaan Obat Yang Perlu di Waspada / High Alert (Farmasi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%

7.	Kepatuhan penyiapan, pengelolaan, pemberian sesuai standar obat elektrolit pekat (Farmasi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%
8.	Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi Sesuai Prosedur (IGD,IRNA,IKO)	100%	100%	100%	99,57%	99,77%	90,41%	97,63%	98,22%						97,94%
9.	Kepatuhan Pengisian Daftar Tilik Keselamatan Pasien Operasi (IKO)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%
10.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan) (IRNA,IRJA,IGD,IKO)	100%	98,64%	98,64%	99,32%	99,63%	98,74%	99,31%	99,48%						99,1%
11.	Kepatuhan 145last pencegahan risiko jatuh	100%	98,64%	98,65%	98%	99,44%	97,65%	98,48%	96,33%						98,57%
12.	Kepatuhan kebersihan tangan	85%	85,21%	85,35%	85,32%	85,36%	85,49%	85,21%	85,25%						85,31%

3.6.1.1.2 Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Apendicitis akut	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%
2.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi STT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%

3.6.1.1.3 Tujuan Strategis

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Juli '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	99,81%	99,79%	100%	99,98%	99,76%	97,12%	99,46%						99,40%

2.6.1.14 Perbaikan Sistem

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kesesuaiaan Penarikan Data SIMRS Dengan Data Manual Pada Laporan Unit	100%	80,39%	81,69%	82,73%	87,5%	89,35%	86,4%	80%						85,10%

1.6.1.2.5 Mutu Unit

1.6.1.2.5.1 Instalasi Gawat Darurat

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Batas waktu pasien menunggu tempat tidur kurang dari 6 jam (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	99,71%	99,7%	97,2%	99,48%	98,79%						
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	98,2%	98,36%	98,37%	98,44%	98,72%	96,03%	95,23%						
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
5.	Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
6.	Kepatuhan 146last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
7.	Kepuasan pasien	85%	97,36%	97,29%	100%	98,2	98,92%	98,45%	98,92%						
8.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
9.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
10.	Kepatuhan pelaporan pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
11.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
12.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis di IGD	100%	100%	100%	100%	95,43%	92,7%	100%	100%						

13.	Angka tindak lanjut screening nyeri pasien di IGD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
14.	Angka kepatuhan triage untuk penyakit menular di IGD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
15.	Respon time IGD kurang dari 5 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
16.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	4,65%	3,7%	2,38%	1,9%	1,67%	5,43%	1,96%						
17.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
18.	Kepatuhan pemasangan gelang identitas pasien kurang dari 30 menit setelah pasien terdaftar rawat inap	100%	73,21%	73,32%	75,11%	100%	100%	100%	100%						
19.	Kejadian merujuk pasien berdasarkan aspek pilihan pasien	0	0	0	0	0	0	0	0						
20.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
21.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (koma, gaduh gelisah, geriatric, menular, anak, remaja, risiko bunuh diri)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
22.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
23.	Kegiatan merujuk pasien (horizontal)	0	1	4	3	2	1	0	0						

1.6.1.2.5.2 IRNA 2A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	-	-	-	-	-	-	-				
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	-	-	-	-	-	-	-				
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	5.	-	-	-	-	-	-				
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	-				-	-	-				

5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-				
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-				
7.	Kepatuhan 148last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	-	-	-	-	-	-	-				
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	-	-	-	-	-	-	-				
9.	Kepuasan pasien	85%	-	-	-	-	-	-	-				
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	-	-	-	-	-	-	-				
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	-	-	-	-	-	-	-				
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	-	-	-	-	-	-	-				
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	-	-	-	-	-	-	-				
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	-	-	-	-	-	-	-				
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	-	-	-	-	-	-	-				
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	-	-	-	-	-	-	-				
17.	Angka efektivitas discharge planning	100%	-	-	-	-	-	-	-				
18.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	-	-	-	-	-	-	-				
19.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	-	-	-	-	-				
20.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-	-	-				

21.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	-	-	-	-	-	-	-				
22.	Kepatuhan penandaan 149lasti operasi sesuai prosedur	100%	-	-	-	-	-	-	-				

3.7.17
IRNA 3A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	92,8%	94,7%	95,23%	95,31%	97,22%	96,32%	96,88%						
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	93,7%	94,5%	94,61%	95,22%	96,34%	97,24%	96,9%						
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	90,6%	89,82%	92,22%	93,33%	98,85%	94,58%	72,31%						
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-						
7.	Kepatuhan 149last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	88,98%	100%	100%	100%	96,03%	100%	100%						
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	88,98%	100%	100%	100%	98,71%	96,93%	100%						
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	96,04%	100%	100%	100%	100%						
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	97,93%	100%	100%	100%						
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	95,48%	100%	100%	100%						
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	87,25%	100%	100%						
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	0	-	4,52%	1,81%	-						
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	0	-	100%	100%	-						
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
21.	Kepatuhan penandaan 150lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	95,31%	100%	82,4%	100%	100%						
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0						
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	97,75%	93,79%	100%	100%						

3.7.18 IRNA 4A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25		
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	98,74%	100%	100%	100%						
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	96,72%	96,88%	97,12%	97,22%	98,21%	98,24%	97,22%						

3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	98,6%	96,9%	96,7%	97,8%	98,88%	97,32%	96,34%						
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,86%						
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	88,98%	95,17%	96,38%	99,46%	98,3%	92,93%	95,52%						
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-						
7.	Kepatuhan 151last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	97,14%	100%	89,11%	89,19%	97,62%	100%	67,38%						
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	97,14%	100%	100%	95,15%	97,79%	100%	90,27%						
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,55%						
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	89,8%	41,67%	100%						
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	95,38%	100%	100%	100%						
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	90,75%	96,52%	100%	100%						
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	82,41%	100%	41,84%						
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	76,32%	100%						
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	-	-	2,1%	2,3%	-						

19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	100%	100%	-						
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	98,7%	59,7%	100%						
21.	Kepatuhan penandaan 152lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	98,06%	84,21%	92,14%	58,82%	82,4%						
22.	Kejadian merujuk pasien (Hirizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0						
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	96,32%	100%	100%	100%						

3.7.19 IRNA 2C

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	96,55%	100%	100%						
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	98,9%	97,5%	99,2%	99,31%	99,44%	98,79%	97,88%						
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	95,8%	97,3%	97,8%	98,2%	88,24%	91,23%	93,52%						
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	81,25%	81,44%	82,47%	80,15%	78,62%	80,95%	74,42%						
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-						
7.	Kepatuhan 152last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	87,91%	94,07%	94,92%	89,05%	86,09%	96,15%						
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	87,91%	100%	100%	97,78%	97,14%	100%						
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	97,73%	100%	100%						
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95,65%	100%						
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	93,75%	100%	53,85%	100%						
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%						
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,5%	100%						
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	85,71%	75%	100%						
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	-	-	-	-	-						
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-	-	-						
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
21.	Kepatuhan penandaan 153lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	85,71%	45,45%	100%						
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0						
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	97,79%	70,83%	90,48%						

3.7.20 IRNA 3C ANAK

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,15%	100%						
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	96,7%	97,1%	97,54%	97,57%	97,22%	97,81%	96,22%						
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	94,8%	96,1%	96,19%	96,34%	96,1%	97,8%	98,24%						
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	100%	80,72%	100%	100%	100%	100%	100%						
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-						
7.	Kepatuhan 154last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	88,1%	100%	100%	100%	100%	100%						
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	88,1%	100%	100%	100%	100%	100%						
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0,43%	1,53%	1,53%	-						
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	100%	100%	100%	-						
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
21.	Kepatuhan penandaan 155lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0						
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

3.7.21 IRNA 5C

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	92,11%	98,95%	98,78%	100%	100%						
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	99,6%	99,8%	99,7%	99,78%	99,72%	98,92%	97,44%						
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	98,7%	99,1%	99,5%	99,62%	99,66%	99,71%	99,62%						
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	99,61%	94,65%	97,96%	99,4%						
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	81,25%	81,44%	80,68%	81,44%	75%	68,75%	90,71%						

6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-						
7.	Kepatuhan 156last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	87,91%	100%	100%	84,15%	69,57%	96,43%						
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	87,91%	97,27%	99,51%	97,9%	91,67%	97,73%						
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	98,71%	92,24%	96,88%	100%	100%						
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	88,24%	100%	100%	100%	91,3%						
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	99,38%	100%	100%						
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	97,47%	97,47%	80,77%	100%						
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	75%	95,12%	100%	56,25%	100%						
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	92,64%	98,88%	100%	100%	99,12%						
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0,97%	1,06%	0,43%	0%	100%	100%	0%						
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%	-	0%	-	-						
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	99,01%						

21.	Kepatuhan penandaan 157lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	100%	100%	0						
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	100%						
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%						

3.7.22 IRNA 6A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,78%						
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	89,2%	90,3%	93,3%	93,7%	95,6%	95,92%	99,72%						
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	99,1%	97,3%	97,1%	97,31%	98,5%	98,88%	99,66%						
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,65%						
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	82,14%	78,72%	82,02%	68,31%	63,64%	65,94%	75%						
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-						
7.	Kepatuhan 157last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89,13%	84,15%						
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,9%						
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,88%						
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,38%						
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,47%						
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89,66%	100%						
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	1,75%	0%	0,32%	0%	0%	0%	0%						
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	-	100%	-	-	-	-						
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
21.	Kepatuhan penandaan 158lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0						
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

3.7.23 IRNA 7A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	89,98%	93,4%	96,12%	96,16%	97,22%	98,27%	96,62%						
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	87,24%	89,22%	92,33%	92,41%	94,62%	96,71%	97,66%						
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	99,1%	88,42%	98,68%						
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	80,36%	80,58%	63,95%	67,13%	53,89%	69,44%	68,1%						
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-						
7.	Kepatuhan 159last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	95,69%	100%	100%						
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	87,15%	100%	100%						
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	81,18%	100%	100%						

16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	1,23%	0%	0,64%	0%	0%	1,32%	-						
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	-	100%	-	-	100%	-						
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
21.	Kepatuhan penandaan 160lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	1	1	0	0	0	0						
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

3.7.24 10 IRNA 8A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agt'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	97,8%	99,8%	99,62%	99,64%	98,92%	99,02%	97,2%						
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	92,1%	95,6%	95,71%	95,82%	97,21%	98,34%	97,22%						
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	97,92%	99,01%	100%						
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	80,36%	72,79%	82,52%	73,6%	52,88%	66,67%	68,1%						

6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-						
7.	Kepatuhan 161last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	92,86%	100%	100%						
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-						
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-						
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

21.	Kepatuhan penandaan 162lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0						
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

3.7.25 ICU

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	89.9%	95,5%	97,7%	97,8%	98,22%	99,51%	97,22%						
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	99,2%	99,8%	99,6%	99,8%	99,88%	99,72%	98,2%						
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	95,64%	97,81%	100%	100%	100%	100%	100%						
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	96,72%	96,89%	100%	100%	92,14%	94,32%	74,66%						
6.	Kepatuhan 162last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	92%	93,2%	88,2%	100%	100%	100%	100%						
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesauaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
8.	Kepuasan pasien	85%	-	-	-	-	-	-	-						
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
12.	Angka kelengkapan lembar operan pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
14.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
15.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
16.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0	0	0	0	1,4%	-	-						
17.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	100%	-	-						
18.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
19.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk ICU	100%	100%	100%	93,33%	100%	100%	100%	100%						
20.	Angka kelengkapan pengkajian pasien tahap akhir kehidupan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
21.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	92,37%	100%	100%	100%	100%						
22.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (koma, gaduh gelisah, geriatric, menular, pelayanan intensive)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
23.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0						
24.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

3.7.26 HCU

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	88,99%	96,22%	97,61%	98,17%	99,24%	98,22%	85,22%						
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	99,5%	99,2%	99,36%	99,42%	99,56%	98,91%	99,2%						
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	95,71%	98,92%	100%	100%	100%	100%	100%						
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	96,21%	96,71%	95,32%	100%	94,8%	97,3%	74,66%						
6.	Kepatuhan 164last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	94%	97,1%	82,18%	100%	100%	100%	100%						
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
8.	Kepuasan pasien	85%	-	-	-	-	-	-	-						
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
12.	Angka kelengkapan lembar operan pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
14.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
15.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

16.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0	0	0	0	0	-	-						
17.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-	-	-						
18.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
19.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk ICU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
20.	Angka kelengkapan pengkajian pasien tahap akhir kehidupan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
21.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
22.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (koma, gaduh gelisah, geriatric, menular, pelayanan intensive)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
23.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0						
24.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

3.7.27 IRJA

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kelengkapan pengkajian medis rawat jalan (mutu prioritas unit)	100%	100%	100%	100%	S	100%	100%	100%						
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	99,2%	98,72%	99,02%	99,32%	98,72%	96,32%	95,62%						
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	98,35	98,71%	99,24%	99,44%	98,94%	97,44%	96,8%						
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	99,11%	100%	100%	100%	100%						

5.	Waktu tunggu rawat jalan	≥ 80%	89,16%	89,3%	99,11%	99,02%	98,72%	97,33%	96,23%						
6.	Kepatuhan 166last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
7.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
8.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
9.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
10.	Angka kelengkapan pengkajian keperawatan rawat jalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
11.	Ketepatan waktu jam praktek dokter	100%	78,92%	77,8%	72,59%	79,58%	79,64%	81,86%	78,6%						
12.	Kejadian merujuk pasien	0	0	0	48		15	17	21						
13.	Angka kelengkapan inform concent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
14.	Angka kelengkapan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
15.	Kelengkapan profil pasien rawat jalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

3.7.27 MATERNITAS

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kematian ibu (mutu prioritas unit)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						
2.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
3.	Waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergensi.	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

4.	Kepatuhan waktu visite dokter.	≥80%	25,95%	24,56%	34,51%	39,04%	39,06%	43,75%	62,22%						
5.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
6.	Kepatuhan 167last pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
7.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
8.	Kejadian keterlambatan operasi 167lastic caesaria (SC) > 30 menit	<5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						
9.	Angka keterlambatan penyediaan darah > 60 menit	<10%	0%	0%	0%	57,14%	0%	0%	0%						
10.	Kejadian perdarahan post partum	0	0	2	5	4	2	0	0						
11.	Kejadian partus macet	0	0	0	13	8	12	15	11						
12.	Kejadian eklamsi	0	1	0	0	0	0	0	0						
13.	Kejadian pre eklamsi	0	5	2	4	4	1	3	1						
14.	Kejadian infeksi nifas	0	0	0	0	1	0	0	0						
15.	Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP	100%	13,6%	12,5%	18,75%	11,67%	22%	14,42%	16,31%						
16.	Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	100%	13,6%	12,5%	18,75%	11,67%	22%	14,42%	16,31%						
17.	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran	0	108	77	86	102	72	90	98						
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						
19.	Kepuasan pasien	≥ 76,61	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
20.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
21.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

22.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
23.	Angka kelengkapan lembar operan pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
24.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
25.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
26.	Kelengkapan forum edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
27.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
28.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						
29.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
30.	Angka kelengkapan pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
31.	Kejadian tidak dilakukan edukasi RSSIB pada pasien post partum dan post SC	0	0	0	0	0	0	0	0						
32.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
33.	Kejadian tidak dilakukannya IMD pada bayi baru lahir	0	0	0	0	0	0	0	0						

3.7.28 NICU

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian kematian bayi (mutu prioritas unit)	0	0	1	2	0	1	1	3						
2.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	98,31%	99,02%	99,45%	99,57%	99,88%	99,98%	99,8%						
3.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	99,98%	99,79%	99,71%	99,74%	99,81%	99,84%	99,67%						

4.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
5.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	85,11%	85,51%	81,18%	84,09%	78,13%	87,3%	76,2%						
6.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
8.	Kepuasan Pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	95,51%	98,86%	100%						
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
12.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,88%	98,88%						
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
14.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
15.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	88,46%	94,92%	96,8%						
16.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
17.	Kelengkapan Follow Up Setelah Discharge	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
18.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,92%	100%						
19.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						

20.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-	-	-						
21.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
22.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk NICU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
23.	Angka Kelengkapan Pengkajian Pasien Tahap Akhir Kehidupan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
24.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
25.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (170lastic170)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
26.	Kejadian Merujuk Pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0						

1.6.1.2.6.16 PICU

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (Anak) (mutu prioritas unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
2.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	99,23%	99,44%	99,44%	99,61%	99,88%	98,74%	98,8%						
3.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	99,11%	98,79%	98,79%	98,82%	98,92%	98,73%	98,78%						
4.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
5.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
6.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesauaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

8.	Kepuasan Pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
12.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
14.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
15.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
16.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
17.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						
18.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-	-	-						
19.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
20.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk PICU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
21.	Angka Kelengkapan Pengkajian Pasien Tahap Akhir Kehidupan	0%	-	-	-	-	-	-	-						
22.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
23.	Kejadian Merujuk Pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0						

3.7.29 IKO

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian tidak dilakukannya skiren pada pasien operasi yg seharusnya diskiren (mutu prioritas unit)	0	0	0	0	0	0	0	0						
2.	Kepatuhan identifikasi pasien.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
3.	Penundaan operasi elektif.	≤ 5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						
4.	Kepatuhan 172last pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%	100%	95,61%	100%	100%						
5.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
6.	Kejadian keterlambatan operasi> 30 menit	0	0	0	0	0	0	0	0						
7.	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring fisiologis pemulihan anestesi dan sedasi dalam	0	0	0	0	0	0	0	0						
8.	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring fisiologis selama anestesi	0	0	0	0	0	0	0	0						
9.	Kejadian tidak dilaksanakannya pengkajian pra sedasi dan pra anestesi	0	0	0	0	0	0	0	0						
10.	Kejadian diskrepansi diagnose pre dan post op	0	0	0	0	0	0	0	0						
11.	Kejadian tidak dilaksanakan SSC	0	0	0	0	0	0	0	0						
12.	Kejadian tidak lengkapnya pengkajian pra bedah	0	0	0	0	0	0	0	0						
13.	Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan 172lasti operasi	0	0	0	0	0	0	0	0						
14.	Kejadian ketidaklengkapan form daftar tilik pasien operasi	0	0	0	0	0	0	0	0						
15.	Kejadian Ketidakpatuhan Prosedur Pasien Yang Menggunakan Implan	0	0	0	0	0	0	0	0						

16.	Kejadian ketidaklengkapan formular penandaan pasien operasi	0	0	00	0	0	0	0	0						
17.	Ketidakhadiran dokter anak saat operasi SC	0	0	0	81,98%	19,84%	21,05%	42,31%	32,6%						
18.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan inform consent	100%	100%	100%	100%	98,37%	92,98%	98,22%	100%						
19.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Apendicitis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
20.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi STT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
21.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
22.	Kepatuhan pencatatan pesan lewat telepon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
23.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
24.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
25.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
26.	Kepatuhan pelaksanaan asesmen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
27.	Kelengkapan forum edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

28.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
29.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
30.	Kelengkapan Asesmen pra sedasi dan pra anastesi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

3.7.30 Laboratorium

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian ketidaktersediaan Reagen esensial di laboratorium (mutu prioritas unit)	0	0	0	3	0	5	0	0						
2.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
3.	Pelaporan hasil kritis laboratorium	100%	96,9%	97,31%	100%	100%	100%	100%	100%						
4.	Ketersediaan kantong darah sesuai golongan	100%	100%	100%	100%	100%	98,44%	100%	100%						
5.	Survilen harian hemofiglen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1005	100%						
6.	Angka kepatuhan Prosedur penggunaan produk darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
7.	Kejadian salah input hasil laboratorium	0	0	0	0	0	0	0	0						
8.	Waktu tunggu hasil laboratorium >140 menit	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						
9.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
10.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
11.	Kepatuhan Pelaporan Kritis Gula Darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

12.	Angka kepatuhan pengelolaan POCT (proses pelaporan nilai kritis, kualifikasi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
13.	Waktu tunggu hasil laborat cito <30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

3.7.31 Radiologi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	97,88%	100%	100%	98,74%	100%	100%	100%						
2	Angka ketidaklengkapan permintaan form radiologi	0%	2,12%	3,54	5,5%	6,99%	7,4%	6,22%	5,2%						
3	Kepatuhan pelaporan nilai kritis hasil radiologi <30 menit	0	0	0	0%	100%	100%	100%	100%						
4.	Kepatuhan edukasi pada prosedur radiasi	100%	100%	100%	100%	99,49%	100%	100%	100%						
5.	Angka kelengkapan inform consen pada prosedur radiasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
6.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
7.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

3.7.32 Gizi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian pasien baru tidak mendapatkan makan (mutu prioritas unit)	0	0	0	0	0	0	0	0						
2.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
3.	Kejadian kesalahan pemberian diit	0	0	0	4	1	2	0	0						
4.	Kejadian adanya benda asing dalam makanan	0	0	0	0	0	0	0	0						

5.	Kelengkapan pengkajian gizi (awal dan lanjut)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
6.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	99,44%	99,67%	99,21%	99,42%	99,82%	98,92%	99,28%						
7.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	99,01%	99,23%	98,92%	99,22%	99,54%	99,31%	99,42%						

3.7.33 Farmasi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agst '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka ketersediaan obat-obatan emergency (mutu prioritas unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
2.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
3.	Kepatuhan penggunaan formularium Nasional	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
4.	Kejadian kesalahan penyiapan obat	0	0	0	1	0	1	0	4						
5.	Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA	0	0	0	0	0	0	0	0						
6.	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%	68,85%	61,98%	74,45%	75,13%	69,23%	55,10%	48,88%						
7.	Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.	0%	48,68%	44,17%	59,59%	60,78%	53,23%	31,35%	24,03%						
8.	Kejadian kesalahan pemberian obat	0	0	0	1	0	3	1	1						
9.	Kejadian kesalahan penulisan etiket obat.	0	0	0	2	0	1	0	1						
10.	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0	0	0	0	0						
11.	Kejadian kesalahan input e-resep	0	0	0	2	0	1	0	0						
12.	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0	0	0	0	0						
13.	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0	0	0	20	13	0	0	0						

14.	Kejadian obat pasien rawat jalan yang tidak diambil	0	0	0	29	22	42	32	0						
15.	Kepatuhan penggunaan panduan antibiotik dan efektifitas jangka panjang dan jangka pendek	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
16.	Kepatuhan penyimpanan obat obatan emergency disimpan secara seragam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
17.	Kepatuhan proses pengelolaan obat recal hingga pengembalian atau pemusnahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
18.	Angka Kepatuhan pengelolaan obat kedaluwarsa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
19.	Angka Kepatuhan penyimpanan dan pengelolaan obat yang perlu di waspadi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
20.	Kepatuhan penyimpanan, pengelolaan dan pemberian obat elektrolit pekat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
21.	Angka Kepatuhan peresepan dan interuksi medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
22.	Angka kepatuhan dispensing	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
23.	Angka kepatuhan pemberian obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
24.	Angka kelengkapan pencatatan efek samping obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
25.	Angka Kepatuhan Pelaporan Medication Error	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
26.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%	100%	84,29%	89,92%	100%						
27.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	100%	93,10%	97,66%	100%	100%	100%						
28.	Kepatuhan pelaksanaan panduan penggunaan single dose vial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

29.	Kepatuhan penggunaan risk based approach monitoring penggunaan obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
30.	Angka kepatuhan pengkajian risiko penggunaan obat yang dibawa pasien dari rumah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

3.7.34 Pengadaan Farmasi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sep '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kekosongan stok farmasi	0%	0%	0%	0,42%	0,24%	0,35%	0,45%	0,26%						
2	Angka kepatuhan kolaborasi tim pengadaan obat	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%						

3.7.35 PPI

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sep '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	IDO (Infeksi Daerah Operasi)	≤ 2 %	0,27%	0,29%	0,29%	0,48%	0,53%	0,27%	0,23%						
2.	IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)	≤3,5‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰						
3.	VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	≤ 5,8 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰						
4.	ISK (Infeksi Saluran Kencing)	≤ 4,7 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰						
5.	Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	≤ 5 %	0,21%	0,23%	0,23%	0,1%	0,5%	0,61%	0,73%						
6.	Angka Decubitus	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						
7.	Angka kepatuhan kebersihan tangan	>85%	85,21%	85,35%	85,32%	85,36%	85,49%	85,32%	85,25%						
8.	Angka kepatuhan penggunaan APD oleh petugas	100%	93,01%	93,06%	93,1%	93,39%	93,59%	93,74%	93,79%						
9.	Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan	100%	93,44%	93,21%	93,27%	93,42%	93,51%	93,74%	93,77%						
10.	Kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan)	0	0	0	0	0	0	0	1						

3.7.36 PIPP

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka Terhubungnya Display TT Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
2.	Angk Terhubungnya Operasi Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
3.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain < 1 kali dari 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
4.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain < 1 kali dari 24 jam	100%	100%	1005	100%	100%	100%	100%	100%						
5.	Kepuasan Pasien	76,61%	99,81%	99,79%	100%	99,88%	99,76%	97,12%	99,46%						
6.	Kepatuhan Petugas Dalam Mengumpulkan Kuesioner Kompalin dan Kepuasan Pelanggan (Indikator baru 2024)	100%	14,12	18,94%	16,09%%	16,89%	18,12%	16,32%	14,22%						
7.	Angka Kepuasan Pasien BPJS	100%	99,9%	99,89	100%	100%	99,98%	100%	100%						
8.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
9.	Kelengkapan Follow Up Setelah Discharge	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

3.7.37 SDM

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian keterlambatan pengurusan SIP/SIK.	0	0	0	0	0	0	1	0						
2	Angka kedisiplinan staf terhadap finger print.	100%	78%	98,51%	98,69%	98,79%	98,69%	98,66%	99,03%						
3	Angka keterlambatan kehadiran staf	0%	37%	2,39%	1,91%	2,31%	1,48%	2,03%	2,41%						
4.	Angka pemenuhan kompetensi sesuai dengan unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
5.	Angka kelengkapan file kepegawaian dimasing masing unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

3.7.38 Rekam Medis

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat Inap (mutu prioritas unit)	100%	91,86%	29,3%	35,83%	51,74%	50,36%	36,06%	80,93%						
2.	Angka kejadian nomor rekam medis ganda	0%	0,14%	0,23%	0,35%	0,47%	0,32%	0,23%	0,49%						
3.	Angka kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat jalan	100%	91,86%	70,8% %	98,04%	1,57%	7%	6,67%	100%						
4.	Angka kelengkapan Rekam Medis Pasien IGD	100%	100%	100%	90,25%	88,2%	10,23%	2,05%	100%						
5.	Kejadian Kendala Pada SIMRS Dalam Upaya Menunjang Pelayanan Rekam Medis Elektronik	0	0	0	0	0	0	0	0						
6.	Kelengkapan Keakuratan Pada Penginputan Data Pasien Di SIMRS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
7.	Keterlambatan Pengumpulan DRM Pasien Rawat Inap Lebih Dari 24 Jam	0%	7,56%	7,89%	9,56%	15,3%	12,21%	10,47%	7,54%						
8.	Angka keterbacaan dokumen rekam medis	100%	100%	100%	98,17%	95,87%	95,88%	96,2%	95,94%						

3.7.39 K3RS

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka kepatuhan petugas melakukan pengecekan APAR.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
2	Kejadian kebakaran di ruangan.	0	0	0	0	0	0	0	0						
3	Kejadian tenaga Kesehatan sakit akibat kerja	0	0	0	0	0	0	0	0						

3.7.40 Asuransi Center

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian dokumen rawat jalan tidak layak klaim	0	0	0	0	0	0	0	0						
2.	Angka pending klaim BPJS	0%	3,05%	2,54%	3,23%	3,23%	1,62%	1,19	1,12%						
3.	Prosentase readmisi pasien rawat inap	0%	0,91%	1,9%	2,22%	2,18%	2,05%	1,31	1,42%						
4.	Angka kelengkapan berkas klaim di SIMRS	100%	98,99%	98,96%	99,26%	98,89%	98,9%	98,8%	99,22%						

5.	Kejadian Pasien Tidak Di SEP	0	1	2	0	0	0	0	0						
----	------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

3.7.41 IPSRS

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka Keterlambatan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x 24 jam	0%	46%	65%	78%	61%	68%	78%	80%						
2.	Angka keterlambatan respon dan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x 24 jam (alat medis)	0%	97%	92%	94%	95%	95%	97%	95%						

3.7.42 UMUM

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Keterlambatan barang datang di Gudang	0	7	8	7	2	4	2	2						
2	Ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit	0	10	8	2	2	4	3	7						

3.7.43 Cleaning Service

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka ketidakpatuhan penggunaan spillkit	0%	47,5%	59,26%	23,53%	45%	85,22%	35,4%	28,88%						
2.	Kejadian 181lastic181 Kebersihan Kamar Mandi	0%	0	0	0	0	0	0	0						

3.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	88,72%	91,33%	92,47	94,21%	96,62%	97,88%	98,21%						
4.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	92%	94,07%	94,28	96,82%	98,24%	99,02%	99,37%						

3.7.44 KESEKRETARIATAN

	No	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka keterlambatan pengumpulan laporan bulanan unit tanggal 4 setiap bulannya	0%	50%	40,48%	56,52%	50%	22,5%	47,62%	26,19%						
2	Angka ketidaklengkapan pengumpulan dokumen meeting RS 1x 24 jam hari kerja	0%	27,27%	23,08%	31,82%	27,78%	38,1%	9,09%	18,18%						
3	Angka tindakan lanjut balasan surat masuk eksternal lebih dari 2x24 jam	0%	29,41%	29,41%	34,88%	34,78%	31,25%	20%	13,51%						

3.7.45 Laundry

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka keterlambatan penyediaan linen	0%	2,14%	1,78%	2,23%	1,32%	2,06%	2,5%	1,15%						
2	Kejadian linen ruang perawatan hilang	0	0	0	0	0	0	0	0						
3.	Kejadian Tercampur Benda Asing	0	0	0	1	1	1	0	2						
4.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	98,82%	99,32%	99,04%	99,22%	99,85%	100%	100%						
5.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	97,23%	96,22%	96,48%	96,92%	98,72%	100%	100%						

3.7.46 CSSD

No	Judul	Stan	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian ditemukannya instrument hilang	0	0	0	0	0	1	1	0						

2	Kejadian instrument kurang	0	0	1	1	1	1	1	1						
3.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
4.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	96,77%	97,11%	97,88%	98,22%	100%	100%	100%						

3.7.47 Humas dan Pemasaran

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka kunjungan rawat inap >90 pasien perhari	100%	98,71%	98,71%	99,86%	79,78%	84,44%	86,73%	89,32%						
2	Angka kunjungan rawat jalan >350 pasien perhari	100%	86,69%	93,82%	93,82%	79,81%	86,21%	88,21%	91,7%						
3.	Angka kunjungan pasien rencana operasi 15 pasien perhari	100%	92,34%	91,22%	92,46%	76,14%	79,22%	81.44%	75%						
4.	Angka kunjungan MCU dan vaksin 150 perbulan	100%	100%	98,82%	97,92%	72,67%	70,22%	76,22%	100%						

1.6.1.2.6.36 IT

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian downtime	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	Respon time penanganan internet dan billing error < 30 mnt	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
3	Respon Time untuk penanganan computer < 15 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

3.6.1.2.6.37 Kamar Jenazah

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Pencatatan kematian pasien di kamar mayat (registrasi) < 2jam	100%	100%	100%	100%	0	0	0	100%						
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	-	-	-	100%	100%	100%							

3.	Kepatuhan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	1005	1005	100%	100%	100%	100%						
----	--	------	------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

3.7.48 PKRS

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan pelaksanaan edukasi kelompok	100	53,26%	68,38%	78,88%	82,44%	92,34%	82,75%	86,45%						

3.6.1.2.6.38 DRIVER

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Resptime Panggilan Driver < 10 menit On Side	100%	99,2%	99,68%	99,88%	100%	100%	100%	100%						
2	Resptime Panggilan Driver < 30 menit On Call	100%	100%	99,92%	99,82%	98,88%	98,64%	100%	100%						
3	Kepatuhan pemeliharaan alat transportasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
4	Angka kelengkapan alat emergency untuk ambulance emergency	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
5	Kepatuhan pelaksanaan decontaminasi pasca transport pasien menular pada ambulance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

3.6.1.2.6.39 SECURITY

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian ditemukannya merokok, 184lastic rokok di lingkungan RS (mutu prioritas unit)	0	6	11	7	14	21	13	18						
2	Kejadian Barang Hilang Di Area Rumah Sakit	0	0	0	0	0	0	1	1						

3	Kejadian potensial barang hilang	0	7	9	13	9	8	9	7						
4	Kejadian kekerasan di lingkungan RS	0	0	0	0	0	0	0	0						

1.6.2 Komite PPI

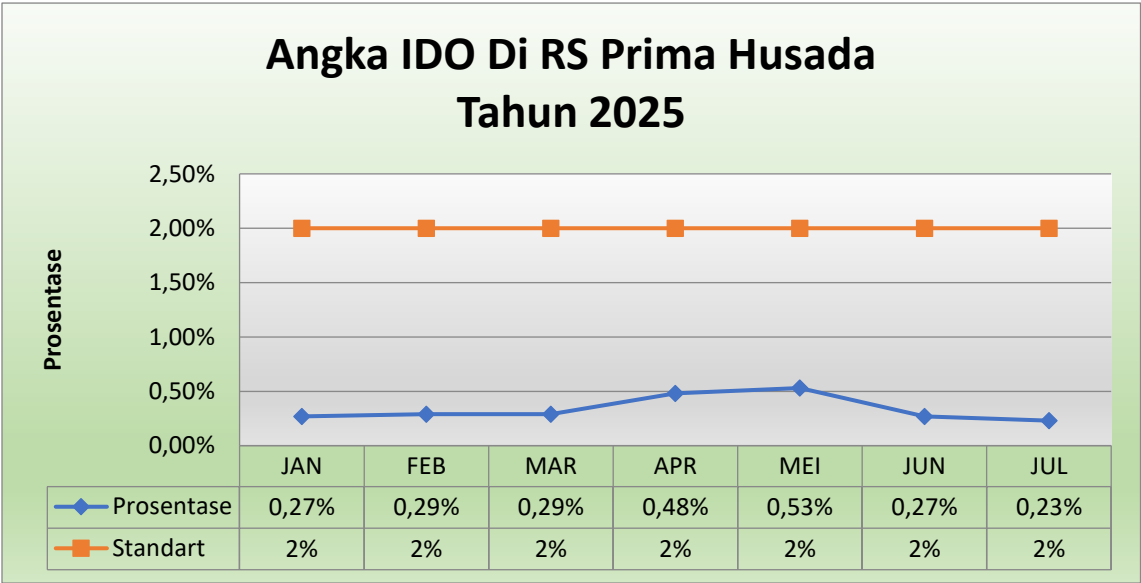
1.6.2.2 Hasil Surveilans dan Mutu PPI

1.6.2.2.5 IDO (Infeksi Daerah Operasi)

1.6.3.5.1 Tabel Data IDO berdasarkan Jenis Tindakan Operasi Sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

Jenis Tindakan Operasi di RS	SSI		
	Jumlah Kasus	Jumlah Tindakan Operasi	Insiden (%)
Bedah Orthopedi	0	95	0%
Seksio Sesaria	1	69	1,45%
Apendiktomi	0	4	0%
Herniotomi	0	14	0%
Katarak	0	47	0%
CABG	-	-	-
Tumor Payudara	0	9	0%
Semua Operasi	1	444	0,23%

1.6.3.5.2 Grafik Angka Infeksi Daerah Operasi (IDO)



Analisa	Dari grafik diatas diperoleh data terdapat kejadian IDO pada 1 orang pasien yang menjalani operasi SC. Dari hasil assesmen pasien diperoleh data bahwa pasien berusia 42 tahun (resti) dengan kehamilan kedua. Dari hasil lab darah pasien tidak ditemukan tanda-tanda abnormal. Pasien baru pertama kali menjalani operasi SC, dimana sebelumnya pasien melahirkan normal dan mengalami toxoplasma oculopathy. Pasien sedikit merasa takut dan membatasi mobilisasinya. Sedangkan dilihat dari segi peralatan pasien sudah dilakukan sterilisasi dengan indikator internal & eksternal, namun pasien tidak melakukan mandi sebelum operasi dilakukan dan saat itu pasien operasi darurat karena letak janin yang belum pada posisinya pada jam 13.30 tidak bersamaan dengan pasien lain dan pasien menggunakan OK pada urutan ke 4 pada hari itu dengan jeda waktu dengan operasi sebelumnya 4 jam. Tidak ditemukan puss pada luka hanya saja luka sedikit terbuka pada bagian ujungnya.				
Masalah saat ini	1. Belum adekuatnya edukasi perawatan pasien pasca operasi terutama perawatan setelah operasi pada ibu yang beresiko tinggi dan belum pernah menjalani operasi sebelumnya. 2. Mandi dengan cairan antiseptic/sabun belum berjalan baik terutama pada pasien dengan operasi cyto.				
Permasalahan sebelumnya	1. Belum adekuatnya edukasi perawatan pasien pasca operasi terutama perawatan setelah operasi pada ibu-ibu muda dengan kehamilan pertama. 2. Kondisi leukositosis beresiko tinggi terjadi infeksi pada luka jika dilakukan operasi.				
Tindakan yang dilakukan	1. Monitoring proses edukasi pasien pasca operasi terutama pemahaman pasien saat perawatan setelah operasi termasuk kontroling mobilisasi. 2. Memberikan edukasi pada pasien untuk tetap mobilisasi secara normal dan makan makanan yang bergizi dan banyak minum air untuk melancarkan ASI. 3. Melakukan kolaborasi dengan DPJP terkait penggunaan antibiotik. 4. Mengkonfirmasi petugas perawatan untuk tetap menganjurkan pasien mandi/seka dengan cairan antiseptik/sabun untuk meminimalisir terjadinya IDO. 5. Memberikan edukasi tambahan terkait menjaga kebersihan diri terutama area sekitar luka operasi. 6. Monitoring pelaksanaan audit bundle IDO lainnya baik pre-intra-post operasi.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Memastikan bundle IDO berjalan dengan baik.	Resiko IDO pada pasien berkurang/hilang.	Pasien operasi	1. Berkolaborasi dengan PPA terkait kondisi penyakit penyerta serta memberikan edukasi untuk mencegah agar risiko infeksi tidak menjadi aktual. 2. Memastikan bundle IDO (pre, durante, dan post op dilakukan dengan baik) 3. Penggunaan alat tetap diperhatikan proses sterilisasi central di CSSD terutama jika dilakukan operasi estafet dengan kasus yang sama (SC). 4. Melakukan monitoring persiapan pasien operasi khususnya pasien dianjurkan untuk mandi antiseptic/sabun untuk mengurangi resiko infeksi.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/PCN	Satu bulan
Lanjutkan evaluasi pemahaman	5. Meminimalisir kesalahpahaman penangkapan terkait	Pasien post operasi.	1. Koordinasi dengan perawat ruangan untuk memastikan pasien dan sudah mendapatkan edukasi terkait perawatan saat di rumah.	1. Perawat /Bidan 2. Karu 3. IPCLN/PCN	Satu bulan

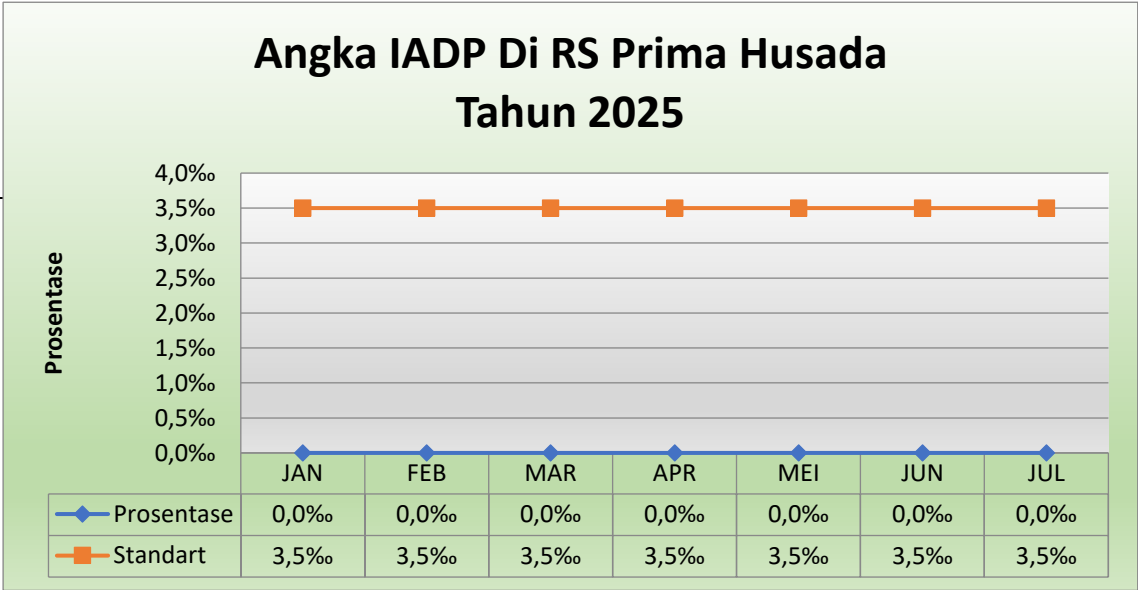
pemberian edukasi perawatan pasien pasca operasi	edukasi perawatan pasien post operasi.		2. Pastikan pasien paham saat diedukasi dengan menanyakan kembali inti edukasi yang telah diberikan. (Memastikan komponen edukasi tersampaikan dengan baik/Komunikasikan-komunikasikan-pesan-media-feedback) 3. Lakukan edukasi pada saat pasien terdapat pendamping keluarga terutama yang satu rumah dengan pasien. 4. Bantu berikan dorongan afirmasi positif atas keadaan yang terjadi pada pasien agar tidak mengganggu proses penyembuhan agar pasien lebih semangat untuk sembuh. 5. Berikan tambahan edukasi terkait kontrol pikiran pasien terutama terkait pantangan yang tidak perlu dipercaya di masyarakat.		
--	--	--	--	--	--

3.6.1.1.2 IADP

3.6.1.1.2.1 Tabel Data IDP Berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAIs Kemenkes

Ruang	SSI		
	Jumlah Kasus	Jumlah Lama Hari Pemakaian CVC	Insiden (%)
ICU	0	6	0‰
HCU	0	0	0‰
NICU	0	0	0‰
PICU	0	0	0‰

3.7.49 Grafik Angka Infeksi Aliran Darah Primer (IADP)



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus IADP pada 6hari total lama pemasangan CVC pada pasien bulan ini.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi IADP				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi IADP				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan tindakan pemasangan CVC. 2. Melakukan evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. 3. Melakukan monitoring kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. 4. Melakukan monitoring 5. perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle IADP.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle IADP.	Pasien dengan pemakaian CVC.	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. 3. Monitoring evaluasi kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. 4. Monitoring evaluasi perawatan pemasangan CVC rutin,	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

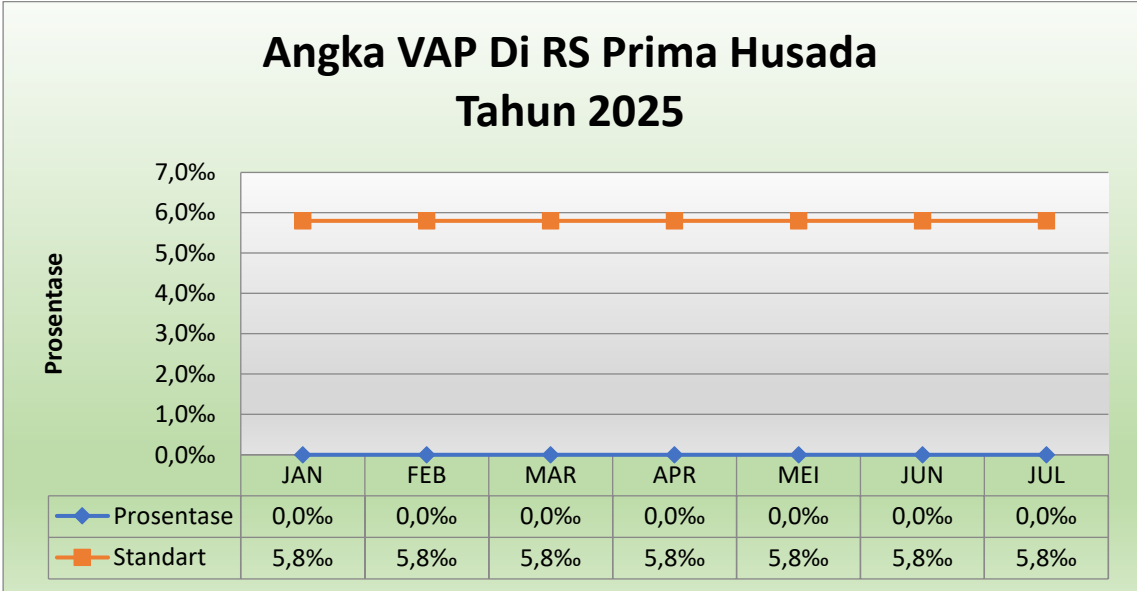
			penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.		
--	--	--	---	--	--

3.6.1.1.3 VAP

3.6.1.1.3.1 Tabel Data VAP berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

Ruang	VAP		
	Jumlah Kasus	Jumlah Lama Hari Pemakaian Ventilator	Insiden (%)
ICU	0	105	0‰
HCU	0	0	0‰
NICU	0	0	0‰
PICU	0	1	0‰

3.6.1.1.3.2 Grafik Angka Pneumonia Akibat Penggunaan Ventilator (VAP)



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus VAP pada 106 hari total lama pemasangan ventilator pada pasien bulan ini.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi VAP				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi VAP				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan evaluasi perawatan pasien dengan terpasang ventilasi mekanik. 2. Melakukan audit monitoring saat pemasangan ventilator. 3. Melakukan observasi tanda-tanda dehidrasi (bibir kering) pada pasien yang terpasang ventilator. 4. Melakukan evaluasi saat pasien dilakukan penghisapan 190lasti / suction. 5. Melakukan koordinasi dengan Kabid keperawatan terkait edaran kewajiban melakukan oral hygiene pada pasien yang terpasang ventilator dan mendokumentasikan di CPPT/Askep.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

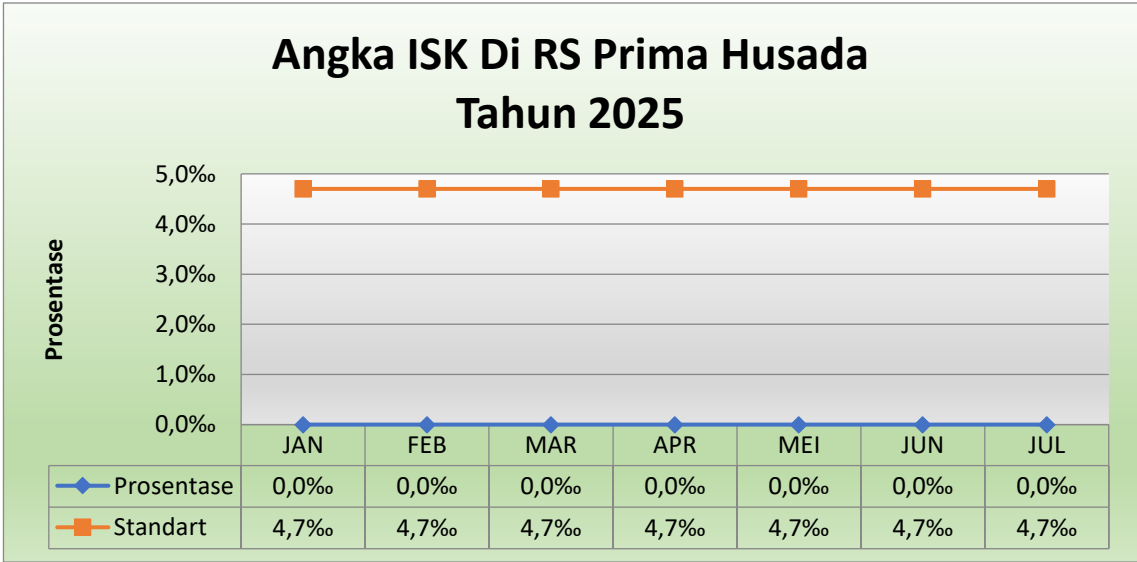
Tingkatkan kepatuhan bundle VAP, khususnya pelaksanaan oral hygiene.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle VAP (oral hygiene).	Pasien yang terpasang ventilator mekanik	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan ventilator. 3. Monitoring evaluasi posisi tepat pasien <i>head of bed</i> >30°-45°. 4. Monitoring evaluasi tindakan pemasangan ventilator. 5. Monitoring kegiatan oral hygiene dan pendokumentasian di RM. 6. Pemberian tindakan oral hygiene mewajibkan juga diedukasikan pada keluarga pasien, agar keluarga ikut aktif mengingatkan petugas untuk melakukan tindakan tersebut.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPC�	Satu bulan
--	---	--	--	--	------------

3.6.1.1.4 ISK

3.6.1.1.4.1 Tabel Data berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR ((Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

Ruang	ISK		
	Jumlah Kasus	Jumlah Lama Hari Pemakaian Ventilator	Insiden (‰)
ICU	0	241	0‰
HCU	0	28	0‰
NICU	0	0	0‰
PICU	0	0	0‰

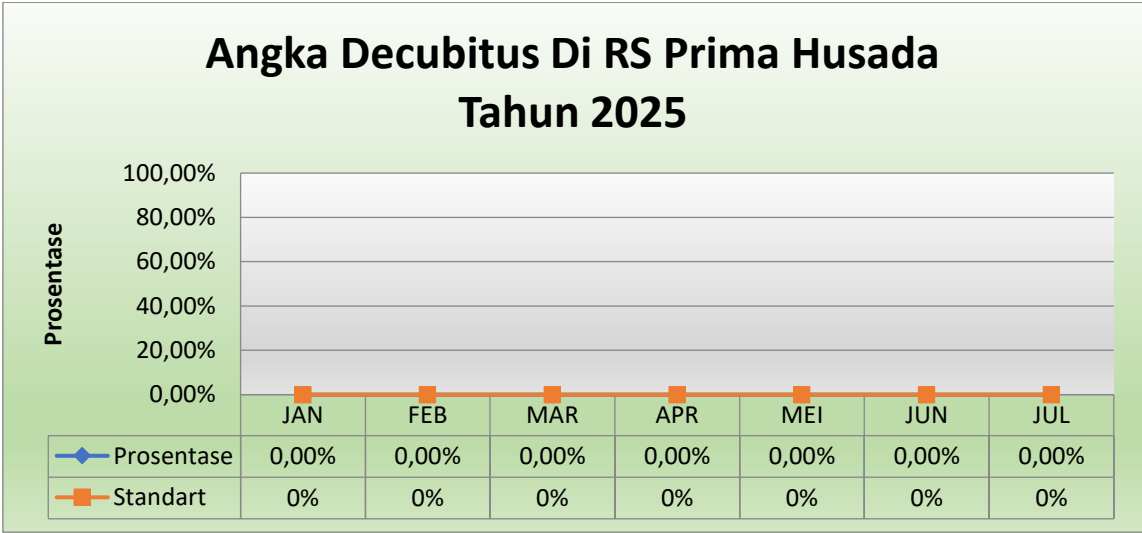
3.7.50 Grafik Angka Infeksi Saluran Kencing (ISK)



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus ISK pada total 1151 hari lama pemakaian kateter pasien.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi ISK				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi ISK				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan perawatan pasien. 2. Melakukan monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. 3. Melakukan monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. 4. Melakukan monitoring perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle ISK.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle ISK.	Pasien yang terpasang kateter	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. 3. Monitoring evaluasi teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. 4. Monitoring evaluasi perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/PCPN	Satu bulan

3.6.1.1.5 Decubitus

3.6.1.1.5.1 Grafik Angka Decubitus

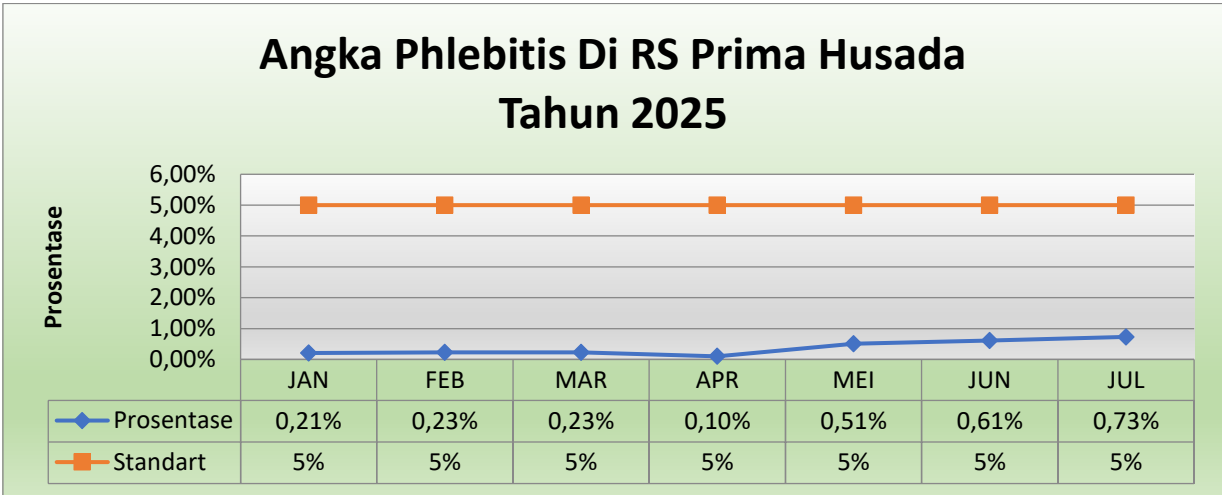


Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus decubitus pada 25 pasien tirah baring lama.
Masalah saat ini	Tidak terjadi decubitus
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi decubitus
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan proses perawatan pasien. 2. Melakukan monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). 3. Melakukan monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin.

	4. Memastikan personal hygiene dilakukan dengan rutin oleh petugas.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan pencegahan 193lastic193e.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan pencegahan dekubitus.	Pasien yang tirah baring lama (> 3x24 jam)	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). 3. Anjurkan penggunaan 193 last anti decubitus atau alternatif lain 4. Monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin. 5. Lakukan perawatan luka rutin jika sudah terdapat luka supaya tidak melebar.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

3.6.1.1.6 Phlebitis

3.7.51 Grafik Angka Infeksi Jarum Infus (Phlebitis)

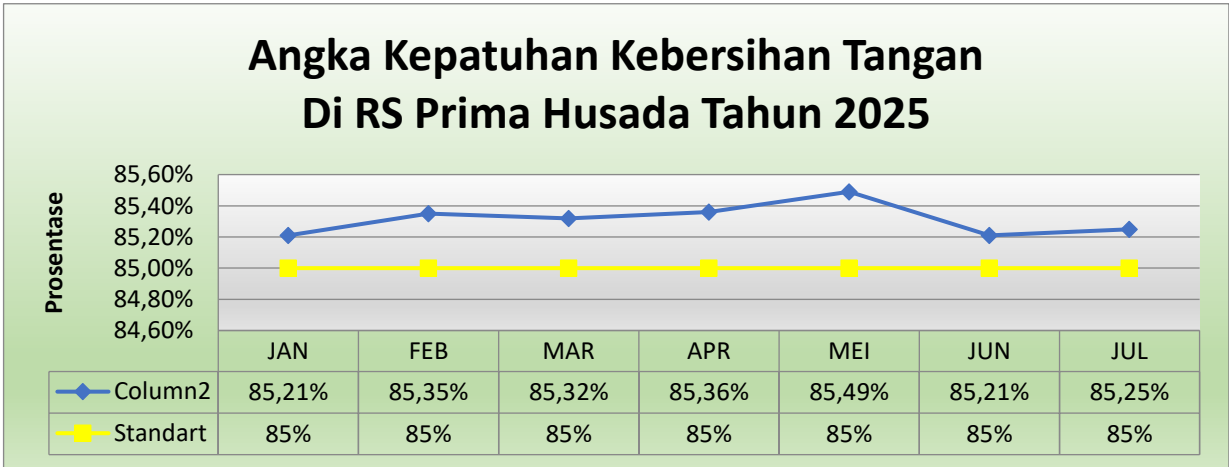


Analisa	Masih ditemukan kasus Phlebitis pada bulan ini dari total 3133 pasien yang terpasang infus setiap harinya dengan prosentase 0,73%, masih memenuhi standar nasional. Dari data yang diperoleh terdapat peningkatan kasus, 23 pasien yang mengalami phlebitis, 6 diantaranya merupakan pasien berusia >60 tahun, 6 pasien anak-anak dan sisanya pasien dewasa, dimana 50% masuk pada faktor usia beresiko phlebitis. 4 diantara 23 pasien tersebut mengalami phlebitis karena mendapatkan cairan pekat seperti manitol dan 1 orang mendapat 2 antibiotik dobel serta 1 pasien lokasi pemasangannya tidak sesuai (di pergelangan). Pasien lainnya tidak mendapatkan cairan pekat hanya mendapat 1 antibiotik dan injeksi pekat seperti metamizole. Pemasangan plester tidak transparan juga membuat kesulitan untuk memantau kondisi luka tusukan infus. Dari 6 pasien yang ditanyai, tidak ditemukan pasien yang rawat inap mengalami infus slong (cairan infus pada indikator selang infus habis). Terdapat peningkatan kesadaran petugas terhadap pelaporan phlebitis dan pemahaman skor phlebitis sehingga terjadi peningkatan laporan kejadian phlebitis juga, setelah dilakukan sosialisasi oleh bidang keperawatan terkait pemasangan infus dan phlebitis.
Masalah saat ini	1. Penggunaan cairan pekat masih menjadi penyebab terjadinya phlebitis, termasuk juga infus pekat dan antibiotik dobel. 2. Faktor internal pasien seperti usia pasien yang beresiko phlebitis juga berpengaruh, perlunya edukasi lanjut terkait ini.
Permasalahan sebelumnya	1. Penggunaan cairan pekat masih menjadi penyebab terjadinya phlebitis, seperti KCL meskipun sudah diberikan dengan pengencer cairan infus. 2. Kesadaran pelaporan masih belum meningkat, pemahaman skoring phlebitis belum merata.

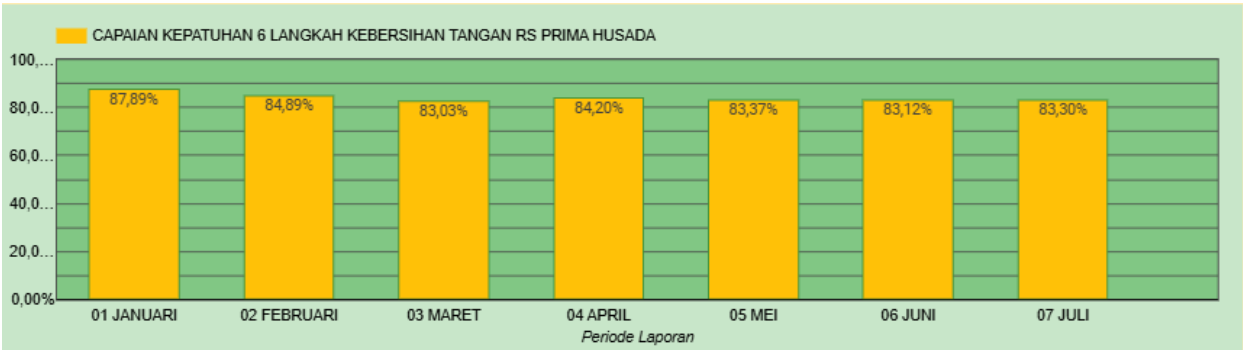
Tindakan yang dilakukan	1. Mengkoordinasikan dengan kabid dan komite keperawatan terkait sosialisasi pemasangan infus yang benar dan penanganan phlebitis. 2. Mengajukan pada perawat pemasangan infus benar-benar harus menentukan posisi vena yang tepat dan memberikan edukasi setelah melakukan pemasangan infus terutama pada pasien beresiko tinggi. 3. Mengajukan perawat untuk melakukan monitoring luka tusukan infus terutama pada pasien yang terpasang cairan pekat setiap hari setelah melakukan injeksi. 4. Menyarankan petugas untuk memberikan kompres hangat pada pasien yang mendapatkan cairan pekat pada area tangan yang terpasang infus untuk merilekskan pembuluh darah dan cairan pekat/darah tidak gampang menggumpal.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Perbaikan kepatuhan bundle phlebitis.	Memperbaiki kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle phlebitis.	Pasien yang terpasang infus	1. Monitoring penyuntikan yang aman benar dilakukan. 2. Monitoring penggunaan cairan pekat maupun double antibiotic diberikan secara aman. 3. Monitoring kondisi luka tusukan infus setiap selesai melakukan injeksi. 4. Memberikan injeksi obat secara perlahan untuk mengurangi nyeri dan memperkecil resiko phlebitis. 5. Mengedukasi perawat unit untuk mengeset tetesan infus secara benar supaya hitungan jam habis infus dapat diperkirakan dan tidak sampai kehabisan. 6. Monitoring kepatuhan pemakaian APD terutama sarung tangan saat pemasangan infus dan kebersihan tangan sebelum memakai sarung tangan. 7. Monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan infus. 8. Tertibkan pencatatan petugas yang melakukan pemasangan infus pada plester infus pasien beserta tanggal pemasangan untuk mengontrol mutu skill dari perawat.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/PCPN	Satu bulan

3.6.1.1.7 Kebersihan Tangan

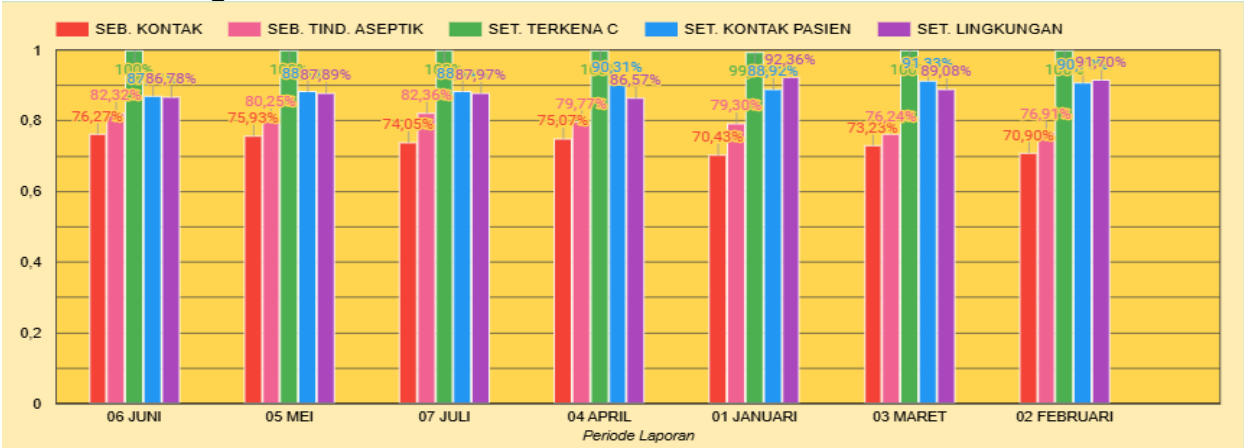
3.7.52 Grafik Angka Kepatuhan kebersihan Tangan (*Hand Hygiene*)



1.6.1.1.7.2 Grafik Kepatuhan 6 Langkah Kebersihan (Hand Hygiene)



1.6.1.1.7.3 Grafik Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan berdasarkan 5 Momen Cuci Tangan

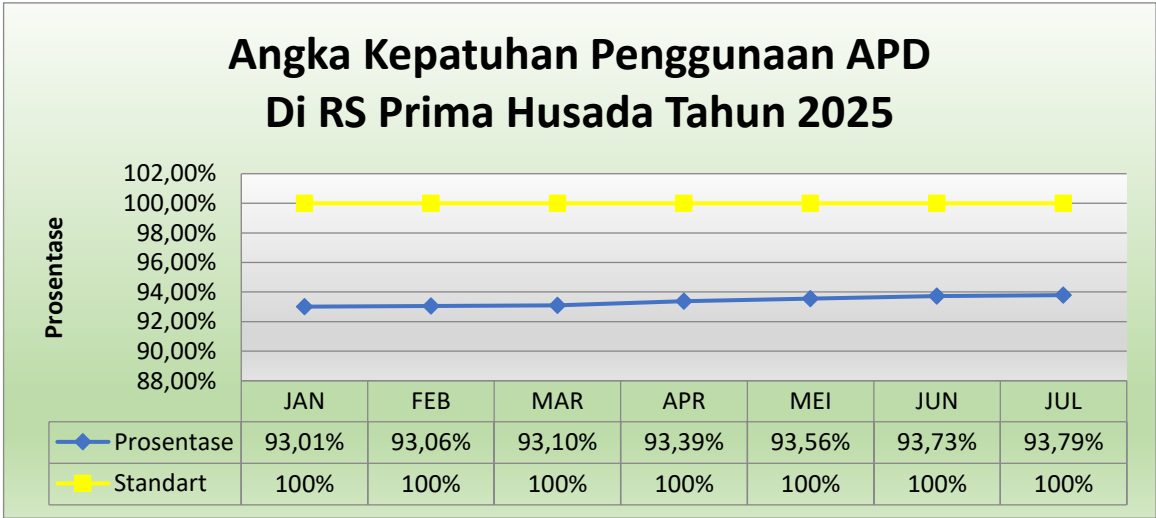


Analisa	Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,25%. Masih belum bisa mencapai target 100% karena memang masih ditemukan petugas yang tidak melakukan cuci tangan terutama pada momen sebelum kontak pasien (70,90%) dan sebelum melakukan tindakan aseptik (76,91%). Terjadi sedikit peningkatan kepatuhan kebersihan tangan hal ini disebabkan karena supervisi yang dilakukan tidak hanya oleh IPCN tetapi Kabid dan Karu juga turut bantu mengingatkan untuk melakukan 5 moment 6 langkah cuci tangan dengan baik.. Dilihat dari segi kepatuhan 6 langkah cuci tangan, 83,30% dari petugas dapat melakukan 6 langkah cuci tangan dengan baik, karena pada saat diklat KE juga dipastikan kemampuan satu per satu petugas untuk melakukan 6 langkah cuci tangan. Namun memang karena belum menjadi kebiasaan dari petugas sehingga masih ada yang tidak urut melaksanakan 6 langkah cuci tangannya.				
Masalah saat ini	Petugas paham terkait 5 momen 6 langkah cuci tangan tetapi tidak dijalankan sepenuhnya saat pelayanan ke pasien (belum terbiasa), hanya pada saat ada event saja terjadi peningkatan, belum menjadikan suatu kebiasaan petugas.				
Permasalahan sebelumnya	Petugas paham terkait 5 momen 6 langkah cuci tangan tetapi tidak dijalankan sepenuhnya saat pelayanan ke pasien (belum terbiasa).				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Mengajarkan cuci tangan yang benar saat melakukan audit di ruangan. 3. Memberikan proses pembelajaran dengan membuat video pendek edukasi cuci tangan supaya lebih mudah untuk mengingat. 4. Melakukan kontrol monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. 3. Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. 4. Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik. 6. Lakukan sosialisasi ke petugas langsung pada saat melakukan supervisi untuk mengingatkan kebiasaan petugas dalam kebersihan tangan.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan
---------------------------------	---	----------------------------------	--	--	------------

3.6.1.1.8 Kepatuhan APD

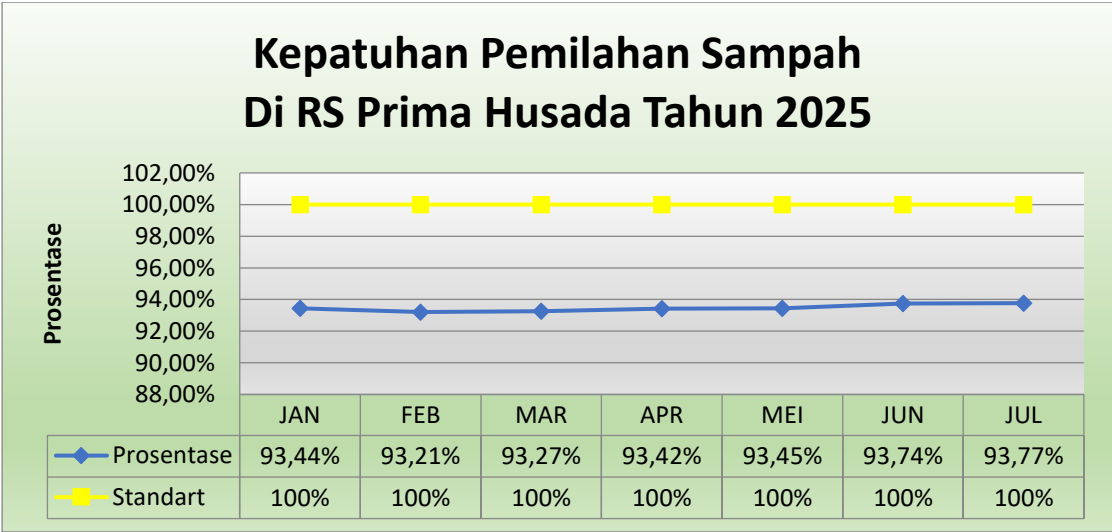
3.6.1.1.8 .1 Grafik Angka Kepatuhan Penggunaan APD oleh Petugas



Analisa	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 93,79%. Dari hasil monitoring dan supervise, terjadi sedikit peningkatan kepatuhan pemakaian APD, kepatuhan petugas nakes dalam pemakaian APD sudah baik, namun masih tetap tidak pada dokter DPJP yang sering berlebihan memakai APD, seperti visite saja namun memakai APD lengkap mulai skort masker, nurse cap, dan sarung tangan. Selain itu, Penggunaan APD berlebih juga ada pada petugas penunjang seperti apoteker rawat inap yang memberikan edukasi namun memakai APD mulai dari sarung tangan, masker bedah didobel N95 padahal hanya edukasi pada pasien HIV. Selain itu, juga sering dijumpai petugas farmasi tidak memakai masker saat menyiapkan obat puyer. Dari unit CSSD juga sering tidak memakai sepatu boots saat mencuci alat kotor.
---------	--

Masalah saat ini	Kurangnya kesadaran petugas terhadap penggunaan APD yang sesuai untuk menghindari penyebaran infeksi dengan mementingkan keuntungan pemakaian APD pribadi dan tidak melihat kerugiannya pada orang lain.				
Permasalahan sebelumnya	Kesadaran petugas sedikit meningkat terkait pemakaian APD dikarenakan adanya event tertentu saja, belum tertanam dan belum menjadikan kebiasaan sehari-hari jika tidak ada event.				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. 2. Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 3. Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 4. Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD, konfirmasi Karu dan SDM). 5. Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Tingkatkan sosialisasi pada petugas langsung saat melakukan supervisi unit. 2. Koordinasi dengan IPCD untuk membantu meningkatkan pemahaman terkait APD pada para DPJP. 3. Berkolaborasi dengan SDM terkait ketidak disiplin petugas dalam pemakaian APD. 4. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan. 5. Lakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 6. Berikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. 7. Tanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

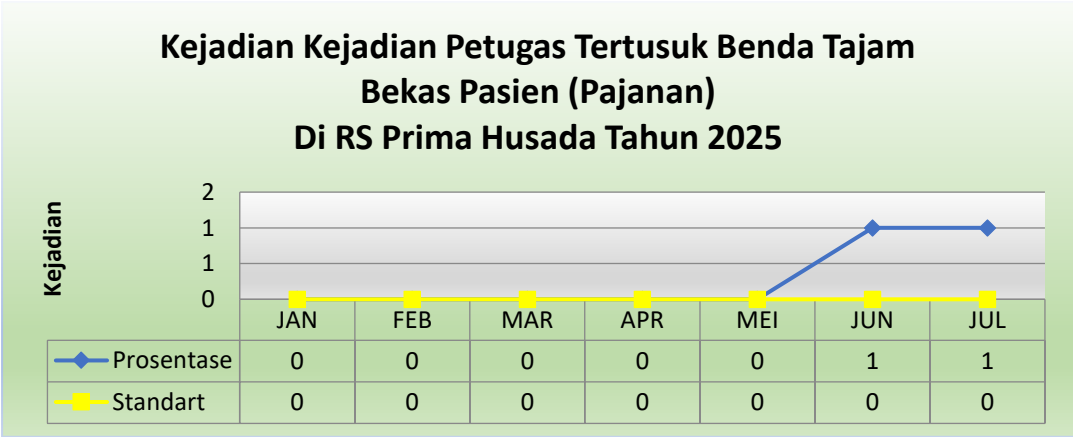
3.6.1.1.9 Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius
3.6.1.1.9.1 Grafik Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan



Analisa	Prosentase kepatuhan pemilahan sampah infeksius dan non infeksius keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 93,77%. Dari hasil monitoring dan supervise, memang masih ditemukan petugas yang tidak melakukan pemilahan dengan baik saat melakukan tindakan terutama pembuangan bungkus spuit yang sering dibuang juga jadi satu dengan spuitnya di safety box/sampah infeksius dan yang paling sering adalah bungkus alkes seperti alcohol swab termasuk bungkus spuit di sampah infeksius. Sehingga akan menambah jumlah sampah yang seharusnya bisa menjadi sampah non infeksius akhirnya menjadi infeksius juga karena tidak dipilah diawal.				
Masalah saat ini	Petugas tidak patuh melakukan pemisahan sampah saat melakukan tindakan sehingga sampah yang seharusnya non infeksius menjadi infeksius.				
Permasalahan sebelumnya	Petugas tidak patuh melakukan pemisahan sampah saat melakukan tindakan sehingga sampah yang seharusnya non infeksius menjadi infeksius.				
Tindakan yang dilakukan	1. Menganjurkan menyiapkan kresek hitam dan kresek kuning pada saat akan melakukan tindakan yang sekiranya akan menghasilkan banyak sampah non infeksius dan infeksius atau 2 bengkok. 2. Memberikan proses pembelajaran langsung petugas unit dan Karu/PJ saat itu yang salah melakukan pembuangan sampah dan segera menganjurkan untuk membenarkan bila memungkinkan dan memberitahukan pemilahan sampah yang benar. 3. Melakukan monitoring pemilahan sampah saat melakukan tindakan. 4. Melakukan supervisi pada tempat sampah yang ada di unit-unit. 5. Menjelaskan terkait proses pembayaran saat membuang sampah infeksius pada pihak ke-3 tergantung dari berat timbangan sampah, untuk menyadarkan bahwa kesalahan pembuangan sampahnya dapat merugikan rumah sakit.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemilahan sampah unit.	Meningkatkan kepatuhan pemilahan sampah unit.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Peletakkan tempat sampah baik infeksius dan non infeksius harus ditata dengan benar. 2. Lakukan edukasi ulang pada staf tentang pemilahan sampah. 3. Berikan proses pembelajaran pada petugas unit saat itu yang salah melakukan pembuangan sampah dan segera menganjurkan untuk membenarkan bila memungkinkan. 4. Sampaikan kesalahan pembuangan unit pada kepala unit dan IPCLN unit dalam forum rapat PPI maupun grup WA (untuk menciptakan efek jera).	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.1.10 Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam

3.6.1.1.10.1 Grafik Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam Bekas Pasien (Pajanan)



Analisa	Ditemukan 1 kali kejadian tertusuk jarum bekas pasien pada petugas (Cleaning service) di ruang maternitas, dikarenakan jarum yang menembus badan safety box dan mengenai tangan petugas saat petugas akan membetulkan posisi gantungan safety box, padahal isi safety box masih belum mencapai ¾ bagian.				
Masalah saat ini	Safety box tidak tahan tusukan (tembus jarum).				
Permasalahan sebelumnya	Jarum suntik yang bengkok meskipun sudah di tutup.				
Tindakan yang dilakukan	1. Menganjurkan untuk melakukan tatalaksana awal pajanan (mencuci dibawah air mengalir dan sabun, memberi alkohol 70%/betadine). 2. Melaporkan kejadian pada K3 dan SDM dan mencatat untuk selanjutnya dijadwalkan untuk MCU karyawan khusus (pemeriksaan HIV dan HbsAg). 3. Menganjurkan untuk tidak memegang area badan safety box, untuk menghindari jika ada jarum yang tembus, disarankan memegang tali safety box saja.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan proses pemilahan sampah yang benar dan pengelolaan benda tajam yang baik.	Menurunkan kejadian pajanan sesuai dengan standar 0 kejadian.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Monitoring proses pemilahan sampah khususnya benda tajam saat melakukan tindakan. 2. Monitoring penggunaan safety box pada troli tindakan. 3. Biasakan petugas untuk membersihkan peralatan yang digunakan langsung tanpa mengoperkan pada shift berikutnya. 4. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan untuk mencegah paparan. 5. Monitoring teknik recapping tutup jarum.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.3 Tim PKRS

3.6.3.1 Edukasi Kelompok Unit

UNIT	TARGET	MEI	JUNI	JULI	%	MANDOK	KETERANGAN
IRNA 2C	4x/Bulan	100%	100%	75%	Tercapai	Lampiran B	Bagus dipertahankan
ICU\HCU	4x/Bulan	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	Lampiran B	ICU/HCU tidak ada kenaikan dari bulan MEI
IRNA 3C	4x/Bulan	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	Lampiran B	IRNA 3c tidak ada kenaikan dari bulan MEI
MATERNITAS	4x/Bulan	100%	100%	75%	Tercapai	Lampiran B	MATERNITAS Tercapai dan mengalami kenaikan terlihat dari bulan Apret hingga Juni
PERINATOLOGI	4x/Bulan	100%	75%	100%	Tercapai	Lampiran B	PERINATOLOGI tercapai pertahankan
IRNA 5C	4x/Bulan	0%	25%	100%	Tidak Tercapai	Lampiran B	IRNA 5C tidak tercapai dan mengalami penurunan
IRNA 2A,3A,4A	4x/Bulan	50%	75%	100%	Meningkat	Lampiran B	IRNA 2A,3A,4A ada peningkatan kecil terlihat dari bulan Apret
IRNA 6A,7A,8A	4x/Bulan	50%	0%	0%	Meningkat	Lampiran B	IRNA 6A,7A,8A

							mengalami penurunan dari bulan Feb, Apr, hingga Apr
IGD	4x/Bulan	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	Lampiran B	IGD Tidak mengalami peningkatan terlihat di bulan April hingga sekarang
FARMASI	4x/Bulan	75%	25%	50%	Meningkat	Lampiran B	FARMASI ada peningkatan
GIZI	4x/Bulan	50%	0%	100%	Menurun	Lampiran B	Gizi tidak tercapai dan mengalami penurunan
IRJA	4x/Bulan	50%	25%	100%	Menurun	Lampiran B	IRJA tidak tercapai dan mengalami penurunan

ANALISIS : Berdasarkan data edukasi kelompok unit pada bulan Juli Petugas PKRS tiap unit tidak terlaksana dengan baik, dari data tersebut Unit ICU, IRNA 3C, 5C, IRNA 2A,3A,4A, IRNA 6A,7A,8A FARMASI, IGD, IRJA belum melaksanakan Edukasi Kelompok dengan maksimal, dan beberapa UNIT mengalami penurunan

RTL : Menyampaikan kepada KARU unit yang belum tercapai kinerjanya untuk mengejar ketertinggalan edukasi, edukasi dilakukan di bulan April.

3.6.3.2 Pembinaan Komunitas Berbasis RS Prima Husada

UNIT	TARGET	KEGIATAN	MEI	JUNI	JULI	%	MANDOK	KET
Komunitas Geriatri	2X/Bulan	Senam	100%	50%	100%	Tercapai	Ada	
		Hypnoterapi						
		KIE						
Komunitas Ibu Hamil	2X/Bulan	Senam	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
		Hypnoterapi						
		KIE						
Komunitas Shirothul Jannah Perempuan	2X/Bulan	Pengajian	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
		Karya wisata						
Komunitas Shirothul Jannah Laki Laki	2X/Bulan	Pengajian	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
Bimbingan Doa	8X/Bulan	Mendoakan Pasien	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
General Meeting Karyawan	1x/2Bulan		100%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	
Pembinaan Fatayat	1X/Tahun							

3.6.3.3 KIE Upaya Preventif Promotif PROGNAS

UNIT	TARGET	MEI	JUNI	JULI	%	BUKTI DI FORM EDUKASI TERINTEGRASI ATAU KOLABORASI	KET
PONEK	4X/Bulan	0%	25%	75%	Tidak Tercapai	√	-
HIV	4X/Bulan	0%	0%	0%	Tidak	-	Belum terlaksana

					Tercapai		
STUNTING dan WASTING	4X/Bulan	50%	25%	0%	Tidak Tercapai	√	-
KELURAGA BERENCANA RUMAH SAKIT (KABERUSA)	4X/Bulan	0%	0%	50%	Tidak Tercapai	√	-
TB DOTS	4X/Bulan	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	Belum terlaksana

ANALISIS : Bulan Juli PROGNAS belum tercapai.
RTL : Koordinasi dengan Kepala Bidang Umum dan Pelayanan untuk dapat Meningkatkan produktivitas Tim Prognas.

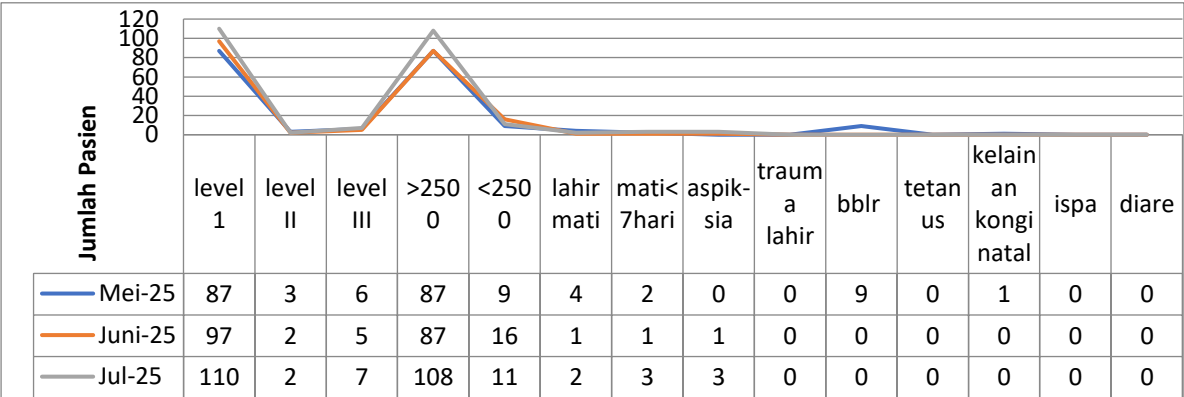
3.6.4 Tim Prognas

3.6.4.1 PONEK

3.6.4.1.1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Ponek Juli 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MEI 2025	BULAN JUNI 2025	BULAN JULI 2025
1				
	a. Level 1	87	97	110
	b. Level II	3	2	2
	c. Level III	6	5	7
2				
	a. ≥ 2500 gram	87	87	108
	b. ≤ 2500 gram	9	16	11
3				
	a. Kelahiran Mati	4	1	2
	b. Mati Neonatal < 7 Hari	2	1	3
4				
	a. Asphyxia	0	1	3
	b. Trauma Kelahiran	0	0	0
	c. BBLR	9	16	11
	d. Tetanus Neonatorum	0	0	0
	e. Kelainan Congenital	1	0	0
	f. ISPA	0	0	0
	g. DIARE	0	0	0
5	Lain-lain	0	0	0

3.6.4.1.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Di RS Prima Husada Bulan Juli 2025



Analisis :

- 1. Pada jenis pelayanan pasien neonatal level 1 di bulan Juli 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 110 bayi. Dan pada level 2 sama dengan bulan sebelumnya yaitu 2 bayi. Dan pada level 3 juga meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 7 bayi. Jumlah bayi bulan Juli 2025 meningkat seiring dengan jumlah persalinan pada bulan Juli 2025
- 2. Pada jenis pelayanan bayi lahir hidup ialah >2500 gram di bulan Juli 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 108 bayi.
- 3. Dan jumlah bayi lahir hidup <2500 gram (BBLR) di bulan Juli 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 11 bayi. Masih adanya kelahiran < 2500 gram dikarenakan kelahiran belum cukup bulan atau IUGR.
- 4. Kasus BBLR pada bulan Juli 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 11 bayi.
- 5. Ada 2 kasus kelahiran mati pada bulan Juli 2025, sedangkan pada bulan Juni sebanyak 1 kasus. Dan Mei 4 kasus.
- 6. Ada 3 kasus kematian neonatus <7 hari pada bulan Juli, sedangkan pada bulan Juni 2025 ada 1 kasus dan 2 kasus pada bulan Mei 2025. Kematian bayi pada bulan Juli diakibatkan karena bayi lahir BBLR dan BBLASR

Rencana dan Tindak Lanjut :

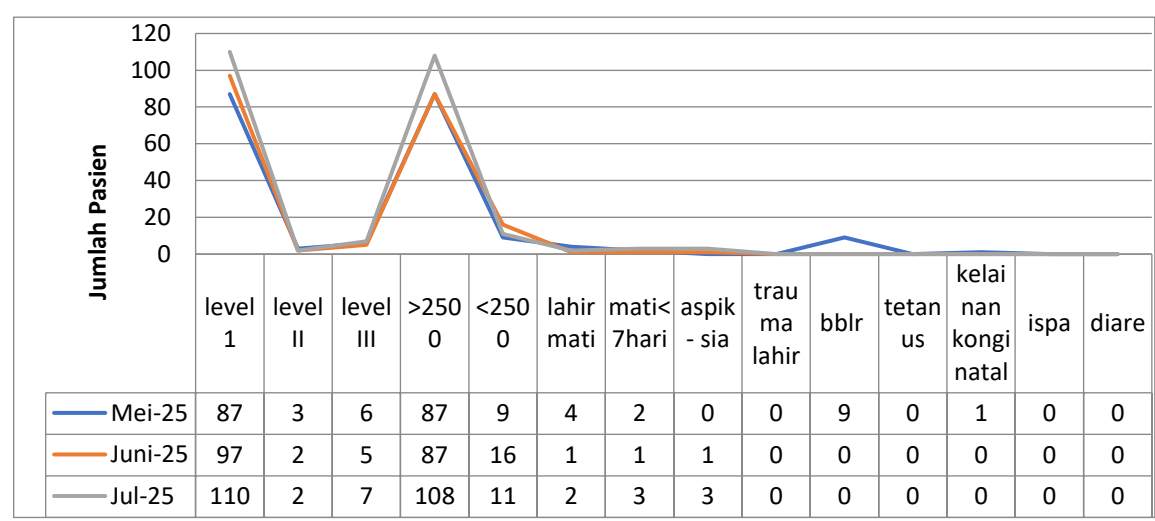
- 1. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.
- 2. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi saat ibu hamil, guna mencegah bayi lahir dengan IUGR.
- 3. Melakukan edukasi pada ibu hamil agar melakukan pemeriksaan rutin untuk memantau kehamilan

3.6.4.1.3 Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal

3.6.4.1.3.1 Tabel Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Ponek Juli 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MEI 2025	BULAN JUNI 2025	BULAN JULI 2025
1				
	a. Level 1	87	97	110
	b. Level II	3	2	2
	c. Level III	6	5	7
2				
	a. ≥ 2500 gram	87	87	108
	b. ≤ 2500 gram	9	16	11
3				
	a. Kelahiran Mati	4	1	2
	b. Mati Neonatal < 7 Hari	2	1	3
4				
	a. Asphyxia	0	1	3
	b. Trauma Kelahiran	0	0	0
	c. BBLR	9	16	11
	d. Tetanus Neonatorum	0	0	0
	e. Kelainan Congenital	1	0	0
	f. ISPA	0	0	0
	g. DIARE	0	0	0
5	Lain-lain	0	0	0

3.6.4.1.3.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Di RS Prima Husada Juli 2025



Analisis :

- 1. Pada jenis pelayanan pasien neonatal level 1 di bulan Juli 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 110 bayi. Dan pada level 2 sama dengan bulan sebelumnya yaitu 2 bayi. Dan pada level 3 juga meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 7 bayi. Jumlah bayi bulan Juli 2025 meningkat seiring dengan jumlah persalinan pada bulan Juli 2025
- 2. Pada jenis pelayanan bayi lahir hidup ialah >2500 gram di bulan Juli 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 108 bayi.
- 3. Dan jumlah bayi lahir hidup <2500 gram (BBLR) di bulan Juli 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 11 bayi. Masih adanya kelahiran < 2500 gram dikarenakan kelahiran belum cukup bulan atau IUGR.
- 4. Kasus BBLR pada bulan Juli 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 11 bayi.
- 5. Ada 2 kasus kelahiran mati pada bulan Juli 2025, sedangkan pada bulan Juni sebanyak 1 kasus. Dan Mei 4 kasus.
- 6. Ada 3 kasus kematian neonatus <7 hari pada bulan Juli, sedangkan pada bulan Juni 2025 ada 1 kasus dan 2 kasus pada bulan Mei 2025. Kematian bayi pada bulan Juli diakibatkan karena bayi lahir BBLR dan BBLASR

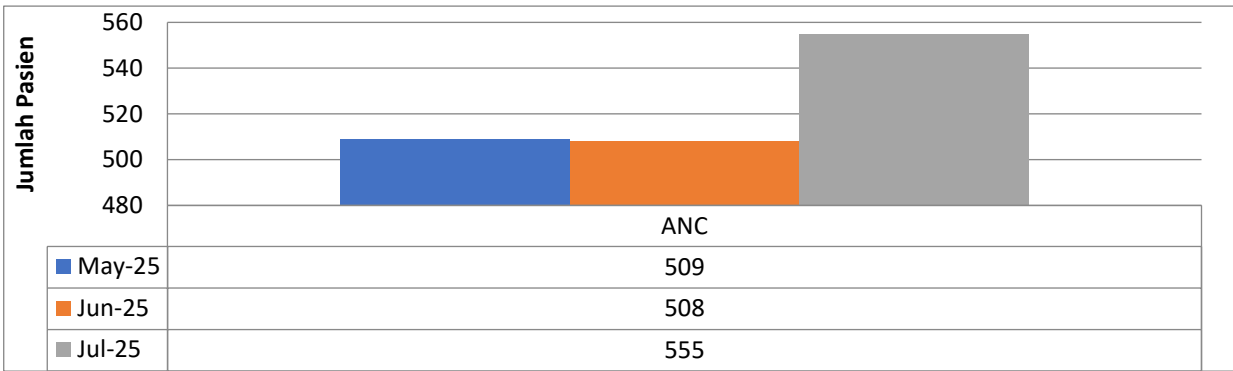
Rencana dan Tindak Lanjut

- 1. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.
- 2. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi saat ibu hamil, guna mencegah bayi lahir dengan IUGR.
- 3. Melakukan edukasi pada ibu hamil agar melakukan pemeriksaan rutin untuk memantau kehamilan

3.7.53 Pelayanan Ante Natal Care (ANC)
Tabel Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Ponpek Juli 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN MEI 2025	BULAN JUNI 2025	BULAN JULI 2025
1	ANC	509	508	555

Grafik Jumlah Pelayanan Ante Natal Care Di RS Prima Husada Juli 2025



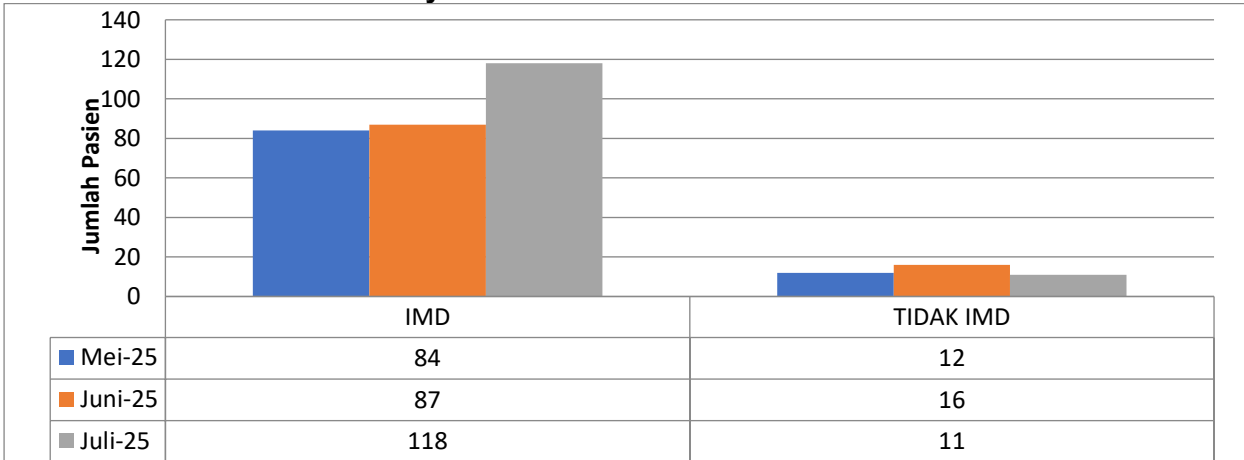
Analisis :
Pelayanan ANC pada bulan Juli 2025 mengalami meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 555 kunjungan.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan promosi terkait pemeriksaan ANC seperti USG 4 dimensi serta kegiatan senam hamil yang diharapkan menarik minat para ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya di RS.

3.7.54 Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
Tabel Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Juli 2025

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MEI 2025	BULAN JUNI 2025	BULAN JULI 2025
1	IMD	84	87	118
2	Tidak IMD	12	16	11

Grafik Jumlah Pelayanan IMD di RS Prima Husada Bulan Juli 2025



Analisis :

- 1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Juli 2025 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 118 bayi. Dan tidak semua bayi baru lahir dilakukan IMD, dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk dilakukannya IMD.
- 2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Juli menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 11 bayi, Sedangkan pada bulan Juni sebanyak 16 bayi, dan bulan Mei sebanyak 12 bayi.
- 3. Berikut ini bayi yang tidak dilakukan IMD pada bulan Juli 2025

No	Nama Bayi	Diagnosa	Perawatan BBL
1	By Ny Vivi suriyani	RDS + BBLSR	CPEP + Inkubator
2	By Ny Ngestin Nur	RDS	CPEP + Inkubator
3	By Ny Anis Puspita sari	NCB + BBLR	Cuvis
4	By Ny Aisyah Alimah Dzakiyah	NCB + BBLR	Cuvis
5	By Ny Manda Kumala	RDS+BBLR	CPEP + Inkubator
6	By Ny Shinta Febriana	NCB+BBLR	Cuvis
7	By Ny Nadiya F	RDS+BBLSR+NKB	CPEP + Inkubator
8	By Ny Ike Trisnawati	RDS	CPEP + Inkubator
9	By Ny Vira	NKB + BBLR	Cuvis
10	By Ny Adilla	NKB + RDS	Infant Warmer + Oksigen
11	By Ny Dwi Kartika M	NKB + BBLASR	Inkubator + Oksigen

- 4. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

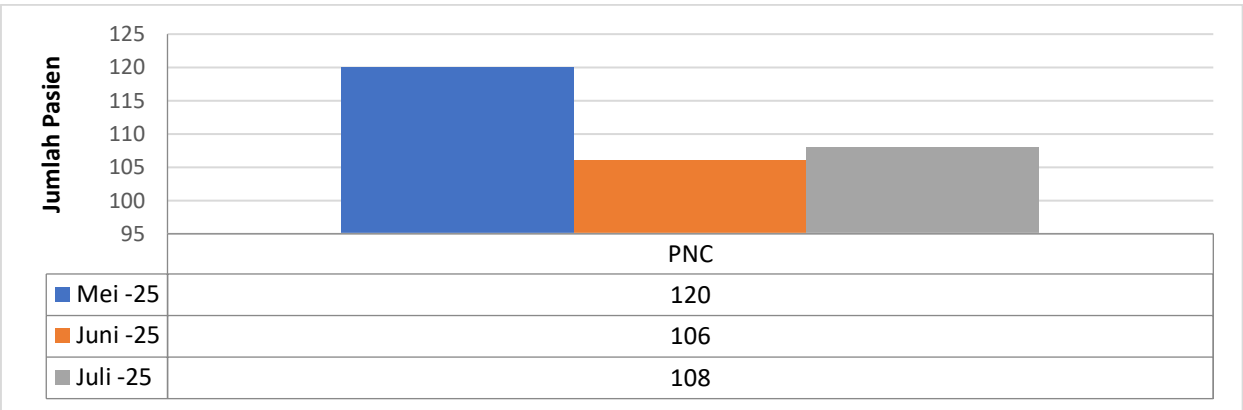
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusui dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat atautkah tidak.

3.7.55 Pelayanan Post Natal Care (PNC)
Tabel Pelayanan Post Natal (PNC) Ponек Juli 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN MEI 2025	BULAN JUNI 2025	BULAN JULI 2025
1	PNC	120	106	108

Grafik Jumlah Pelayanan Post Natal Care di RS Prima Husada Bulan Juli 2025



Analisis :

Pelayanan PNC pada bulan Juni 2025 penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 108 kunjungan.

Rencana dan Tindak Lanjut :

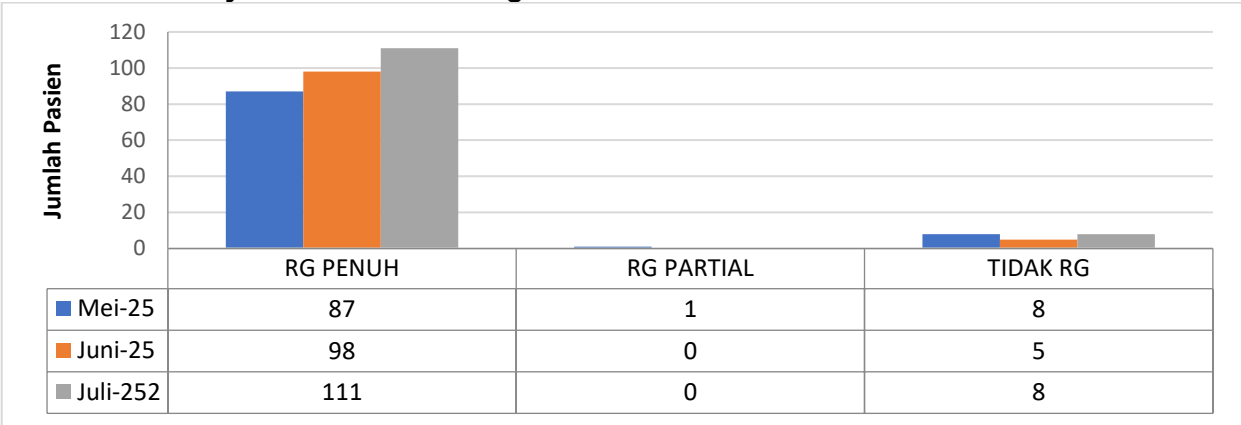
Melakukan Edukasi ke pasien pasca bersalin untuk melakukan pemeriksaan PNC di RS Prima Husada

β

3.1.2.2.1.5 Pelayanan Rawat Gabung
Tabel Pelayanan Rawat Gabung Ponek Juli 2025

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MEI 2025	BULAN JUNI 2025	BULAN JULI 2025
1	Rawat gabung penuh	87	98	111
2	Rawat gabung partial	1	0	0
3	Tidak Rawat gabung	8	5	8

Grafik Pelayanan Rawat Gabung Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juli 2025



Analisis :

1. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung pada bulan Juli 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 111 bayi. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung dengan syarat bayi dan ibu dalam kondisi sehat
2. Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung pada bulan Juli 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 8 bayi.
3. Berikut bayi yang tidak dilakukan rawat gabung

No	Nama	Diagnosa	Perawatan BBL
1	By Ny Vivi suriyani	RDS + BBLSR	CPEP + Inkubator
2	By Ny Ngestin Nur	RDS	CPEP + Inkubator
3	By Ny Manda Kumala	RDS+BBLR	CPEP + Inkubator
4	By Ny Nadiya F	RDS+BBLSR+NKB	CPEP + Inkubator
5	By Ny Ike Trisnawati	RDS	CPEP + Inkubator
6	By Ny Vira	NKB + BBLR	Cuvis
7	By Ny Adilla	NKB + RDS	Infant Warmer + Oksigen
8	By Ny Dwi Kartika M	NKB + BBLASR	Inkubator + Oksigen

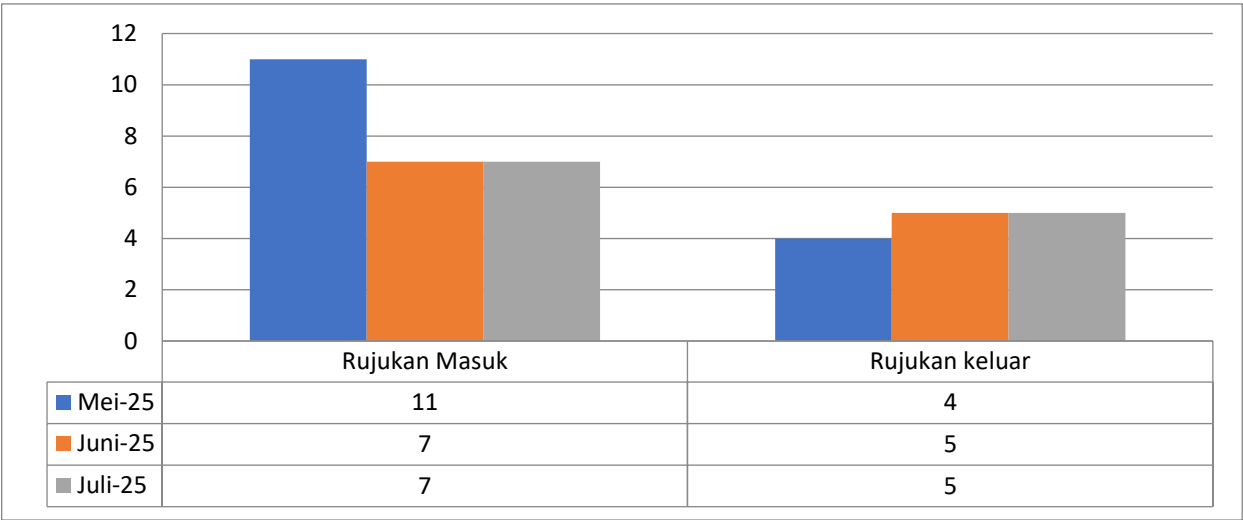
4. Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung adalah bayi yang membutuhkan perawatan khusus yaitu diletakkan di cuvis atau incubator karena berat bayi < 2500 gram atau masih belum memungkinkan dilakukan rawat gabung karena masih menggunakan alat bantu pernafasan dan observasi.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan skrining awal untuk pasien yang layak dilakukan rawat gabung ibu dan bayi.

3.1.2.2.1.6 Pelayanan Jejaring Rujukan
Tabel Pelayanan Jejaring Rujukan Ponpek Juli 2025

NO	RUJUKAN	BULAN MEI 2025	BULAN JUNI 2025	BULAN JULI 2025
1	Rujukan Masuk	11	7	7
2	Rujukan keluar	4	5	5

Grafik Pelayanan Rujukan RS Prima Husada Bulan Juli 2025

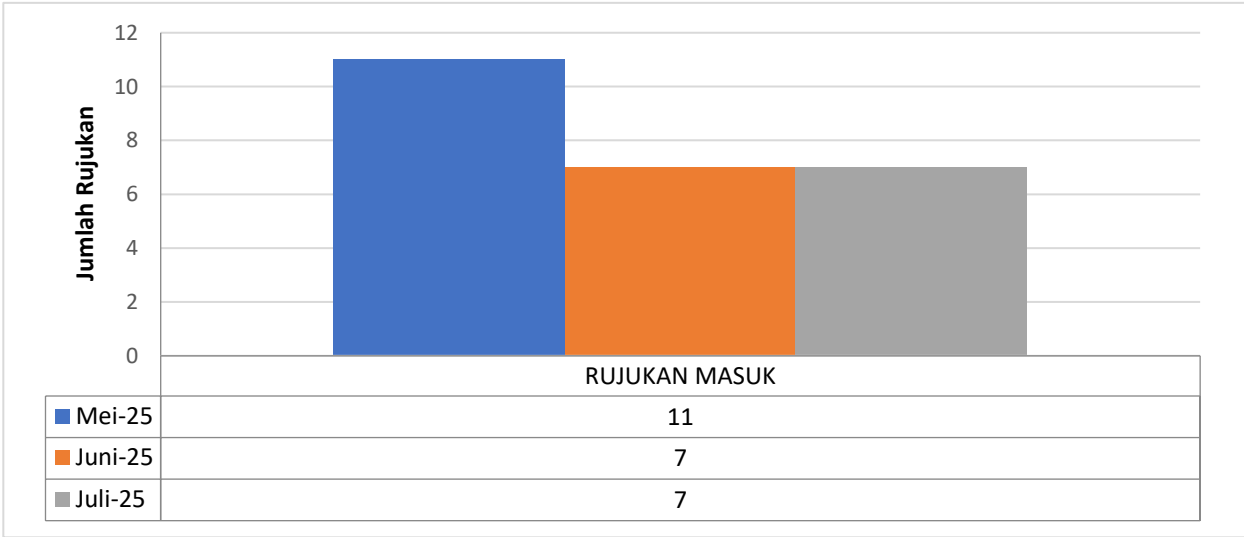


3.1.2.2.1.6.1 Rujukan Masuk
Tabel Rujukan Masuk Ponpek Juli 2025

Bulan Mei 2025			
1	Triya Nanda	G2 P1001 Ab000 uk 37-38 mgg dg KIFA + IUD Insitu	Klinik Mutiara Sehat
2	Pinarti	P2002 Ab000 dg Post Partum + HPP ec Sisa plasenta	RSUD Lawang
3	Fernanda Alya	G1 P0000 Ab000 uk 30-32 mgg dg PPI	BPM Siti Nurcahyaningasih
4	Carrolyn	G1 P0000 Ab000 uk 39-40 mgg dg KPD + KIFL	BPM Titik
5	Ni'matul	G1 P0000 Ab000 Uk 39-40 mgg dg kala 2 lama	PKM Singosari
6	Sumiasih	G4 P3003 Ab000 uk 39-40 mgg dg KPD + letak Obliq	PKM Singosari
7	Novi Prajna	G2 P1001 Ab000 uk 8-10 mgg dg vomiting +OF	Klinik Mutiara Sehat
8	Wiwin Defa	G1 P0000 Ab000 UK 38-39 mgg dg KIFA + KPD	PKM Ardimulyo
9	Syafira	G1P0000 AB000 Uk 39-40 mgg dg KPD + KIFL	BPM Siti R
10	Sayidah	G2 P0000 Ab100 Uk 37-38 mgg dg KPD	PKM Singosari
11	Siska	G2 P1001 Ab000 uk 28-30 mgg dg PPI	BPM Tri
Bulan Juni 2025			

1	Sri Wahyuni	G2 P1001 Ab000 UK 37-38 mgg dg KIFA + letsu	PKM Singosari
2	Nimas Ayu M	G1 P0000 Ab000 UK 38-39 mgg d PEB	BPM Lilik A
3	Indahwati	G2 P1001 AB000 UK 35-36 mgg dg HT + Gemeli + PPR0M	BPM Subaedah
4	Angesti Pina	G2 P1001 Ab000 UK 38-39 mgg dg KPD	Klinik Mutiara Sehat
5	Viqi Ijatul	G2 P1001 Ab000 UK 41-42 mgg dg Kala 2 Lama	BPM Sumaiyah
6	Siti Rosita	G2 P1001 Ab000 UK 41-42 mgg dg KIFL + APB EC Plasenta Previa + IUFD	PKM Singosari
7	By Ny lin K	RDS OK Neonatal	PKM Singosari
Bulan Juli 2025			
1	By Ny Marita	Asfiksia	PMB Tri
2	Ny Anis Puspita Sari	G1 P0000 Ab000 UK 37-38 mgg dg PEB	PKM Singosari
3	Ny Evi Yuniarti	G3 P2002 Ab000 UK 40-41 mgg dg KPD + KIFL	PKM Ardimulyo
4	Ny Nurul Sa'adah	G2 P1001 Ab000 Uk 8-10 mgg dg Abotus Inkomplit	PMB Tri W
5	Ny Dita Puri A	G1 P0000 Ab000 Uk 38-39 mgg dg KIFA	Klinik Mutiara Sehat
6	Ny Shifatul Husni	G1 P0000 Ab000 Uk 41-42 mgg dg KIFL	PMB Titik Sunaryati
7	Ny Vira	G1 P0000 Ab000 Uk 34-36 mgg dg PEB	Klinik Muslimat

Grafik Pelayanan Rujukan Masuk RS Prima Husada Bulan Juli 2025



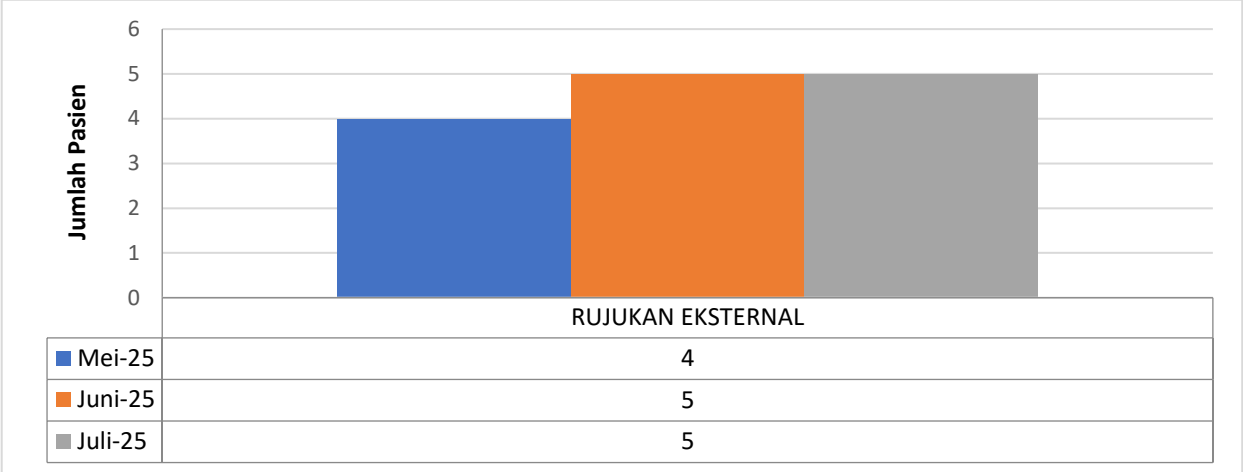
Analisis :
 Jumlah rujukan masuk pada bulan Juni dan Juli 2025 sama, yaitu 7 rujukan, sedangkan pada bulan Mei sebanyak 11 rujukan.

Rencana dan Tindak Lanjut
 Bekerja sama dengan tim PKRS untuk melakukan promosi kesehatan dan mengajak BPM atau RS setempat untuk bekerja sama.

3.1.2.2.7.2 Rujukan Keluar
Tabel Rujukan Keluar Ponek Juli 2025

Bulan Mei 2025						
1	By Ny Eka Fani	1 hari	NICU	Neonatal bronchopneumonia, grandula thymus prominen, NEC	Pro ventilator	RS Lavalette
2	By Ny Arisa	3 hari	NICU	BBLR + hipoglikemia refrakter	Pro konsultan perinatologi dg konsultan endokrinologi	RS Lavalette
3	By Ny Kartina	2 hari	NICU	Neonatal pneumonia + BBLR	Pro ventilator	RS Soepraoen
4	By Ny Khusnul	3 hari	NICU	Neonatal pneumonia + BBLR	Pro ventilator	RS Lavalette
Bulan Juni 2025						
1	Ny Churi	30 th	Maternitas	P3104 Ab100 dg Post SC +VSD+ Hematuria + Akut Abdomen	Pro penatalaksanaan lebih lanjut	RS Saiful Anwar
2	By Ny Any	2 hari	NICU	RDS + BBLSR	Pro Ventilator	RS Saiful Anwar
3	By Ny Indah	4 hari	NICU	BBLASR + obs distress nafas dd RDS	Pro NIPPV dan tata laksana subspesialistik neonatologi	RS Lavalette
4	By Ny lia	3 hari	NICU	RDS + BBLSR + NKB	Pro NIPPV dan tata laksana subspesialistik neonatologi	RS Lavalette
5	By Ny lin	3 hari	NICU	RDS dd MAS, Neonatal seizure, susp HIE, neonatal pneumonia	Tatalaksana supneurologi anak, subspesialistik neonatologi	RST Soepraoen
Bulan Juli 2025						
1	Stefia Shallom	16 th	IGD	Abdominal pain susp Neoplasma Ovarial	Pro laparotomi back up bedah digestive	RS Saiful Anwar
2	By Ny Manda Kumalasari	3 hari	NICU	RDS + BBLR	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Saiful Anwar
3	By Ny Nadia	4 hari	NICU	RDS + BBLSR + NKB	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Lavalette
4	By Ny Marita	1 hari	NICU	RDS + Susp DS	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Lavalette
5	By Ny Retnosari	1 hari	NICU	RDS + Bronchopneumonia + NEC	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Lavalette

Grafik Pelayanan Rujukan Eksternal di RS Prima Husada Bulan Juli 2025



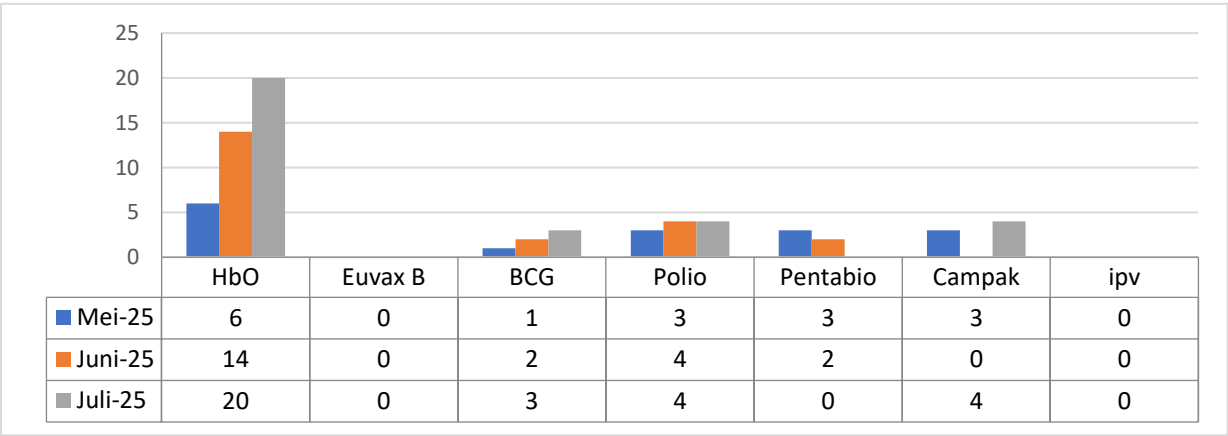
Analisis :
Pada bulan Juni dan Juli 2025 jumlah rujukan eksternal sama yaitu 5 pasien dirujuk, sedangkan pada bulan Mei 4 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut :
Menambah jumlah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga meminimalisasikan untuk dilakukan rujukan keluar.

3.1.2.2.12.8 Pelayanan Imunisasi
Tabel Pelayanan Imunisasi Ponek Juli 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN MEI 2025	BULAN JUNI 2025	BULAN JULI 2025
1	HbO	6	14	20
2	Euvax B	0	0	0
3	BCG	1	2	3
3	Polio	3	4	4
4	Pentabio	3	2	0
5	Campak	3	0	4
6	IPV	0	0	0

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juli 2025



Analisis :

1. Tidak ada penggunaan vaksin euvax B pada periode Juli 2025 maupun 2 bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan banyak nya pasien bayi baru lahir dengan status BPJS, sehingga tidak menggunakan vaksin euvax B
2. Bayi yang melakukan Imunisasi Hbo pada bulan Juli sebanyak 20 bayi, sedangkan bulan Juni sebanyak 14 bayi, dan bulan Mei sebanyak 6 bayi. Hal ini dikarenakan minimnya ketidakterersediaan vaksin HB0 di RS prima Husada malang, dikarenakan stok vaksin dari dinas Kesehatan kabupaten malang terbatas sehingga Puskesmas hanya bisa memberikan sedikit ke RS swasta, sehingga bayi yang baru lahir yang belum mendapat imunisasi HB0 diarahkan untuk imunisasi Hbo di Puskesmas wilayah masing-masing sebelum usia 7 hari
3. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan Juli dan 2 bulan sebelumnya
4. Bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan Juli sebanyak 3 bayi, sedangkan Juni sebanyak 2 bayi, dan pada bulan Mei sebanyak 1 bayi.
5. Bayi yang melakukan Imunisasi campak pada bulan Juli sebanyak 4 bayi, sedangkan pada bulan Juni tidak ada, dan bulan Mei sebanyak 3 bayi
6. Bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan Juni dan Juli sama, yaitu 4 bayi, sedangkan bulan Mei 2025 sebanyak 3 bayi
7. Tidak ada bayi yg imunisasi Pentabio pada bulan Juli, sedangkan pada bulan Juni sebanyak 2 bayi, dan pada bulan Mei sebanyak 3 bayi. imunisasi pentabio diberikan bersamaan dg rota dan PCV, sedangkan vaksin tersebut ada pembatasan dari puskesmas.

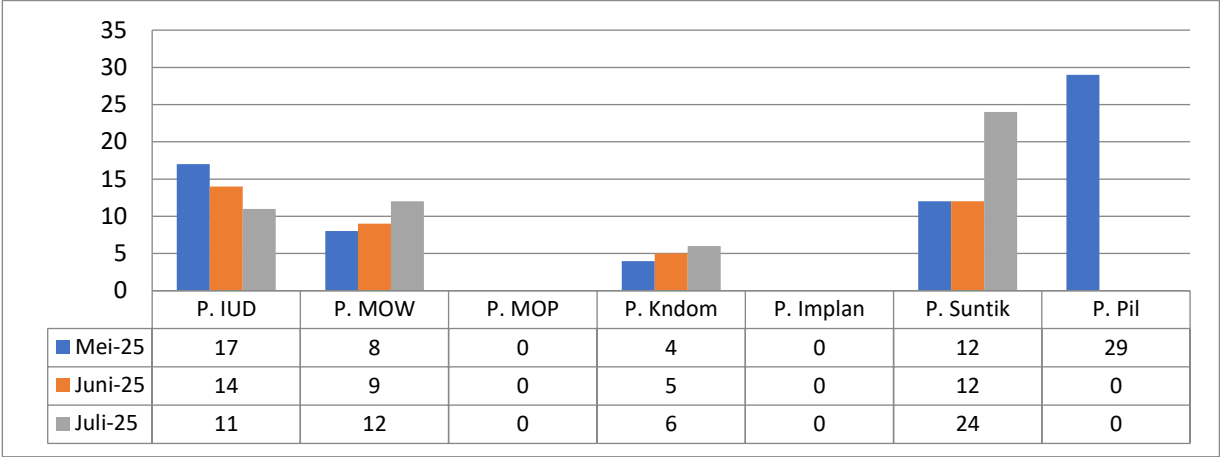
Rencana dan Tindak Lanjut

1. Membuat surat permintaan berupa laporan bulanan kepada puskesmas untuk pemenuhan kebutuhan vaksin di rumah sakit.
2. Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

3.2.2.1.2.9 Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
Tabel Pelayan Keluarga berencana (KB) Ponok Juli 2025

NO	JENIS	JUMLAH PASANG		
		BULAN MEI 2025	BULAN JUNI 2025	BULAN JULI 2025
1	IUD	17	14	11
2	MOW	8	9	12
3	MOP	0	0	0
4	Kondom	4	5	6
5	Implant	0	0	0
6	Suntikan	12	12	24
7	Pil	29	0	0

Grafik Pelayanan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juli 2025



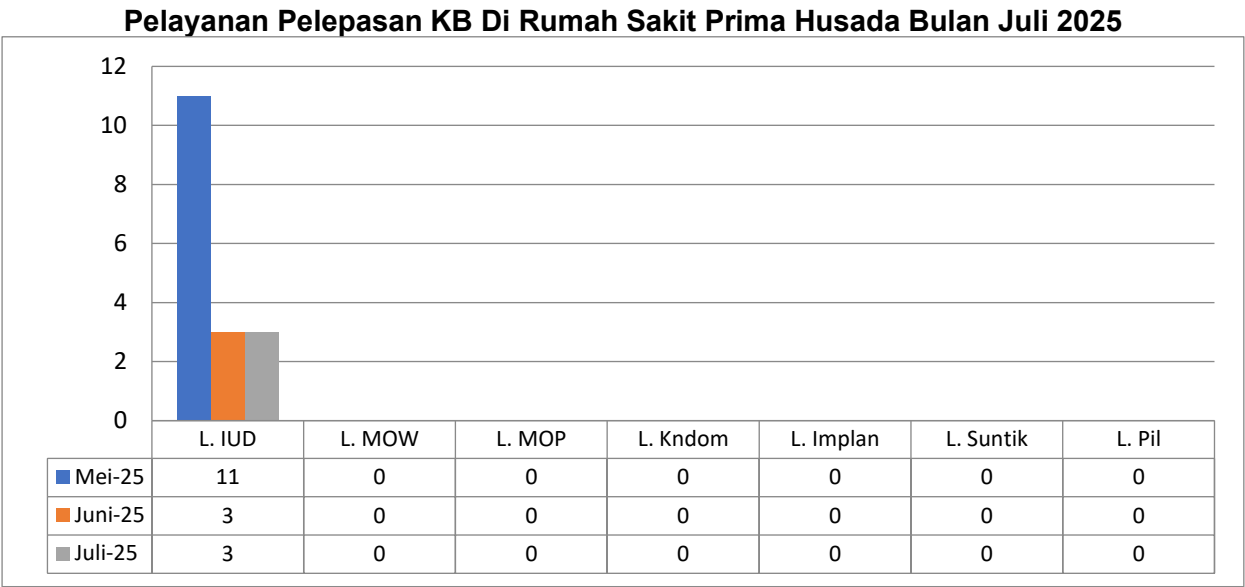
Aanalisis :

- 1. Pemasangan KB IUD pada bulan bulan Juli 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 11 akseptor yang terdiri dari 3 akseptor IUD Nova T dan 8 akseptor IUD copper T, pemakaian KB belum maksimal dikarenakan KB IUD coper T pasca salin ada biaya jasa dokter Rp. 400.000, biaya gratis jika dipasang oleh bidan tetapi pasien tidak berkenan, memilih KB di faskes tingkat 1
- 2. Pasien yang menggunakan metode MOW pada bulan Juni 2025 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 12 pasien. Untuk pemasangan KB MOW dilakukan sesuai dengan indikasi pasiennya, seperti pada pasien grande multipara dan primi tua sekunder. Tindakan MOW dilakukan jika ada indikasi dari DPJP.
- 3. Pasien yang menggunakan metode kondom pada bulan Juni sebanyak 6 akseptor, meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 5 pengguna di bulan Juni dan Mei 4 pengguna
- 4. Tidak ada pasien yang menggunakan metode Pil pada bulan Juni dan Juli, sedangkan Mei sebanyak 29 pengguna.
- 5. Pasien yang menggunakan metode suntik pada bulan Juli meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 24 pengguna, sedangkan bulan Juni dan Mei sama, yaitu 12 pengguna.

Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

NO	JENIS	JUMLAH LEPAS		
		BULAN MEI 2025	BULAN JUNI 2025	BULAN JULI 2025
1	IUD	11	3	3
2	MOW	0	0	0
3	MOP	0	0	0
4	Kondom	0	0	0
5	Implant	0	0	0
6	Suntikan	0	0	0
7	Pil	0	0	0



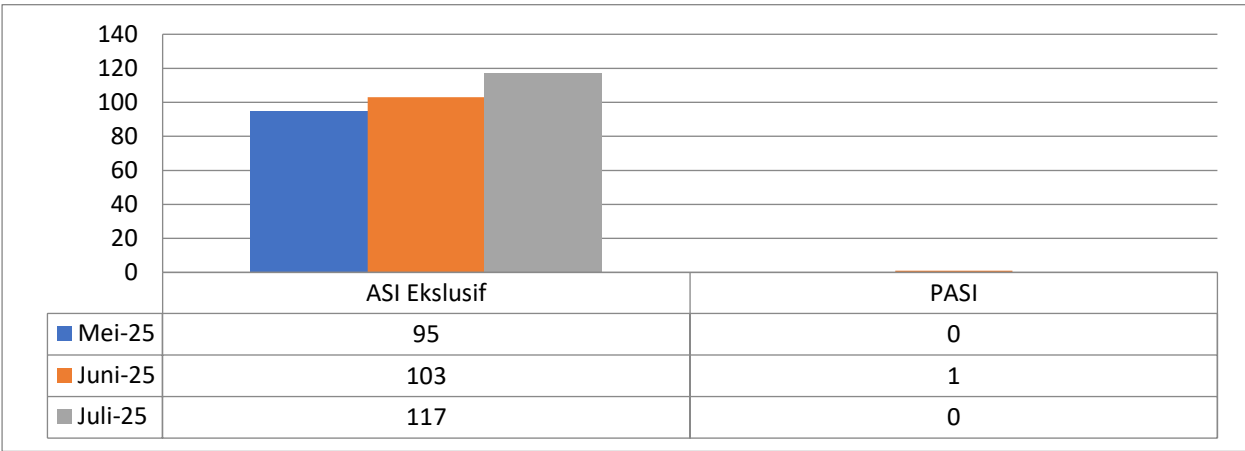
- Analisis :**
1. Pelepasan KB IUD pada bulan Juli dan Juni sama yaitu 3 Akseptor, sedangkan pada bulan Mei sebanyak 11 Akseptor
 2. Tidak ada pelepasan KB Implan pada bulan Juli 2025 dan juga 2 bulan sebelumnya

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

3.3 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif
Tabel 5.10 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif Juli 2025

NO	PEMBERIAN ASI	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MEI 2025	BULAN JUNI 2025	BULAN JULI 2025
1	Asi eksklusif	95	103	117
2	Asi /PASI	0	1	0

Grafik Pelayanan Pemberian Asi Eksklusif Di RS Prima Husada Bulan Juli 2025

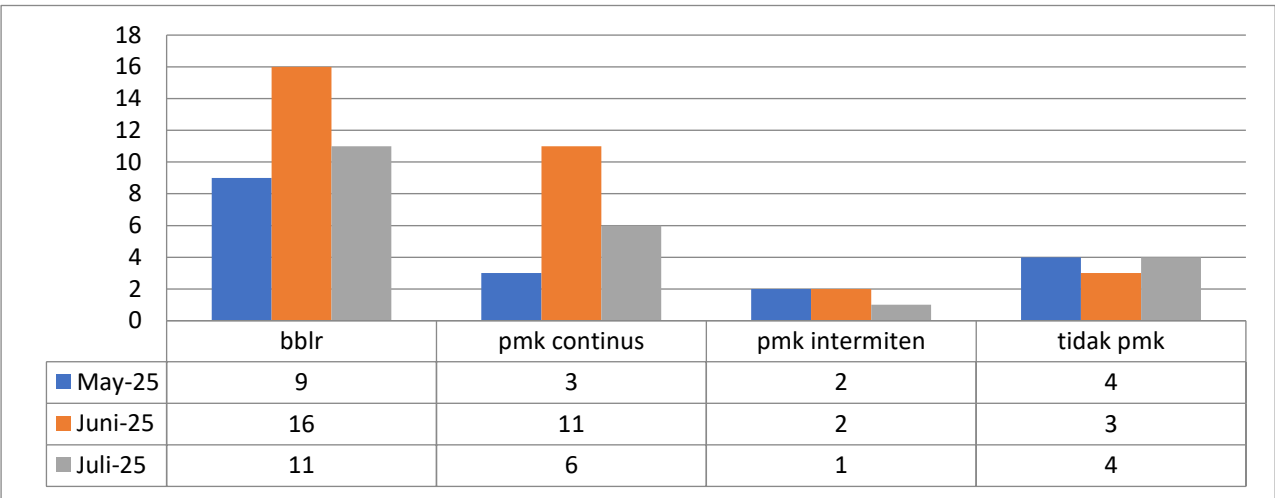


- Analisis :**
1. Pelayanan pemberian ASI eksklusif pada bulan Juli meningkat yaitu 117 bayi, sedangkan pada bulan Juni sebanyak 103 bayi, dan Mei sebanyak 95 bayi. Hal ini dikarenakan meskipun ada bayi dengan BBLR juga tetap diberikan ASI eksklusif
 2. Bayi yang mendapat PASI pada bulan Juli dan Mei 0, sedangkan bulan Juni sebanyak 1 bayi. Diperbolehkan menggunakan sufor pada bayi dengan kondisi tertentu, dan pastinya atas rekomendasi dari dokter spesialis anak

Rencana dan Tindak Lanjut :
Dilakukannya Edukasi dengan adanya kelas ibu menyusui saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Sehingga ada kegiatan tanya jawab, demonstrasi dan bertukar ilmu terkait pemberian ASI eksklusif

3.2.2.1.2.10 Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR
Tabel Pelayanan Perawatan metode kangguru (PMK) Pada BBLR di Ponek Juli 2025

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MEI 2025	BULAN JUNI 2025	BULAN JULI 2025
1	Bayi BBLR	9	16	11
2	PMK continuos	3	11	6
3	PMK Intermiten	2	2	1
4	Tidak PMK	4	3	4



Grafik Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR di RS Prima Husada Jul 2025

- Analisis :**
- 1. Bayi yang dilakukan PMK continus dan PMK intermiten adalah bayi dengan berat badan <2500gram.
 - 2. Pelayanan perawatan metode kangguru (PMK) dengan metode intermiten pada BBLR di bulan Juli sebanyak 1 bayi, sedangkan pada bulan Juni dan Mei 2025 sama, yaitu 2 bayi. Hal ini dikarenakan bayi sesak memakai c-pap dan perawatan inkubator.
 - 3. Sedangkan metode PMK continus pada bulan Juli menurun sebanyak 6 bayi dengan BBLR kondisi bayi stabil, sedangkan pada bulan Juni 2025 sebanyak 11 bayi, dan bulan Mei sebanyak 3 bayi. hal ini seiring dg jumlah BBLR yang ada
 - 4. Ada 4 bayi yang tidak dilakukan PMK pada bulan Juli dan Mei, sedangkan bulan Juni ada 2 bayi.

Berikut daftar bayi yang tidak dilakukan PMK

No	Nama	Diagnosa	Perawatan BBL	Alasan
1	By Ny Manda Kumalasari	RDS+BBLR	CPEP + Inkubator	Bayi di Rujuk
2	By Ny Nadiya F	RDS+BBLSR+NKB	CPEP + Inkubator	Bayi di rujuk
3	By Ny Adilla	NKB + RDS	Infant Warmer + Oksigen	Meninggal
4	By Ny Dwi Kartika M	NKB + BBLASR	Inkubator + Oksigen	Meninggal

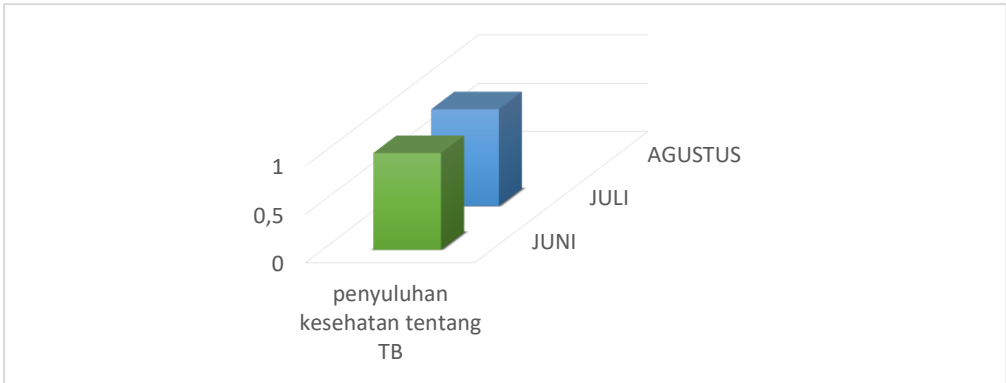
Rencana dan Tindak Lanjut
Perawatan Metode Kangguru sesuai dengan SPO yang berlaku

1.1.2.2. TB DOT'S

3.7.56 Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Tentang Tuberculosis

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH KEGIATAN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1	Penyuluhan kesehatan tentang tuberculosis	1	1	

Grafik Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan di RS Prima Husada



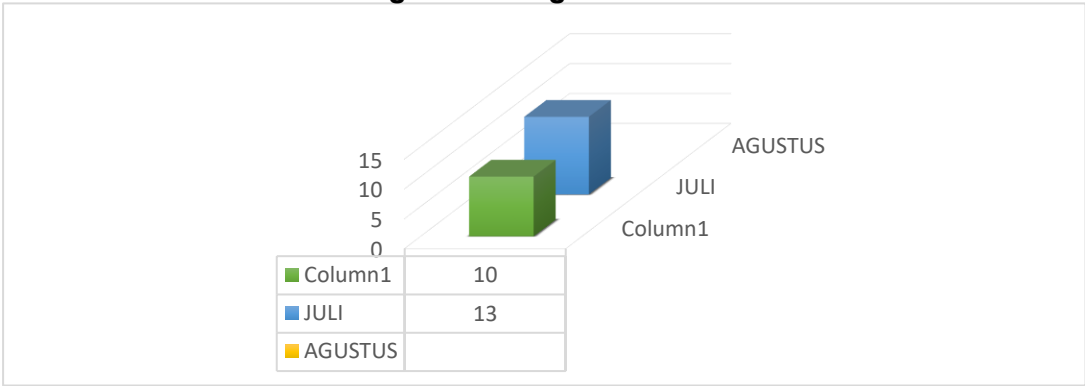
Analisis:
Peserta audiens ditujukan kepada pasien dan keluarga pasien, dengan harapan peserta memahami hasil penyuluhan.

Rencana dan Tindak Lanjut:
Harus diadakan promosi kesehatan secara berkala terkait TBC seperti; pentingnya patuh dalam pengobatan TBC, kapan waktu yang tepat minum obat TBC, apa tanda gejala TBC, dll.

3.1.2.2.2 Skrining Pasien

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	Pemberian Masker	10	13	

Grafik Jumlah Pasien Dengan Skrining Awal Pemberian Masker di RS Prima Husada



- Analisis :**
- 1) Pada bulan Juni 2025 terdapat 10 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart
 - 2) Pada bulan Juli 2025 terdapat 13 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart
 - 3) Pada bulan Agustus 2025 terdapat 0 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart

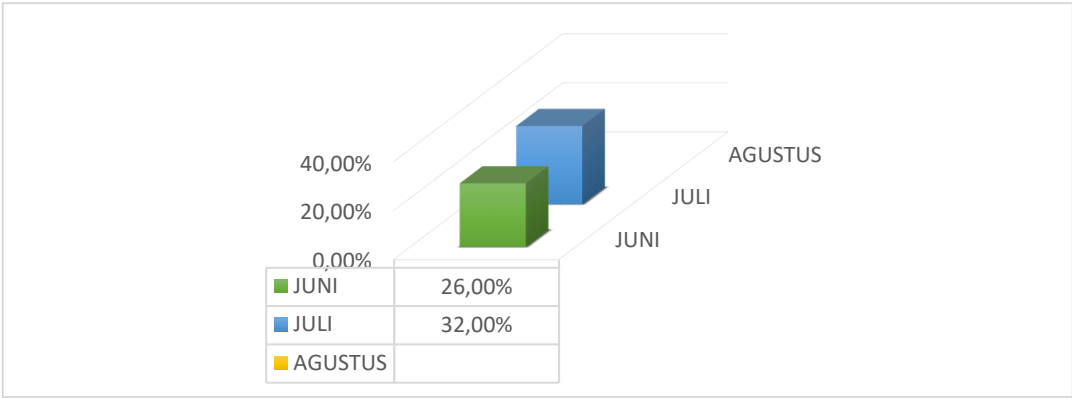
Rencana dan Tindak Lanjut:

- 1. Memfasilitasi ketersediaan masker
- 2. Edukasi pemakaian masker (meliputi fungsi, waktu penggunaan, dan siapa saja yang perlu menggunakan)

**3.1.2.2.3 Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi
Bakteriologis**

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	Proporsi pasien (terduga dan baru) tekonfirmasi bakteriologis	26	32	

Grafik Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis di RS Prima Husada



Analisis :

- 1) Pada bulan Juni 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 26 orang
- 2) Pada bulan Juli 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 32 orang
- 3) Pada bulan Agustus 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 0

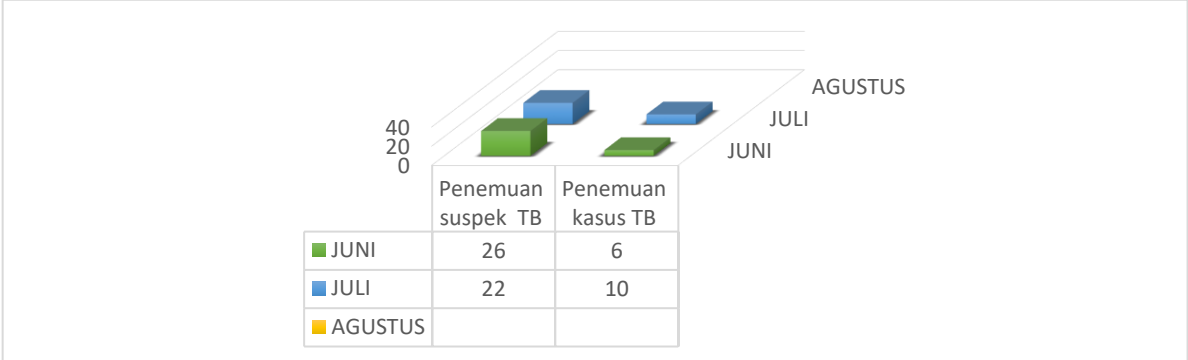
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan edukasi terhadap keluarga pasien dengan kontak TB untuk melakukan skrining TB

3.1.2.2.4 Penemuan Kasus TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	Penemuan suspek TB	26	22	
2	Penemuan kasus TB	6	10	

Grafik Penemuan Kasus TB Baru di Rumah Sakit Prima Husada



Analisis :

- 1. Pada bulan Juni 2025 terdapat 26 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 6 pasien
- 2. Pada bulan Juli 2025 terdapat 22 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 10 pasien
- 3. Pada bulan Agustus 2025 terdapat 0 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 0 pasien

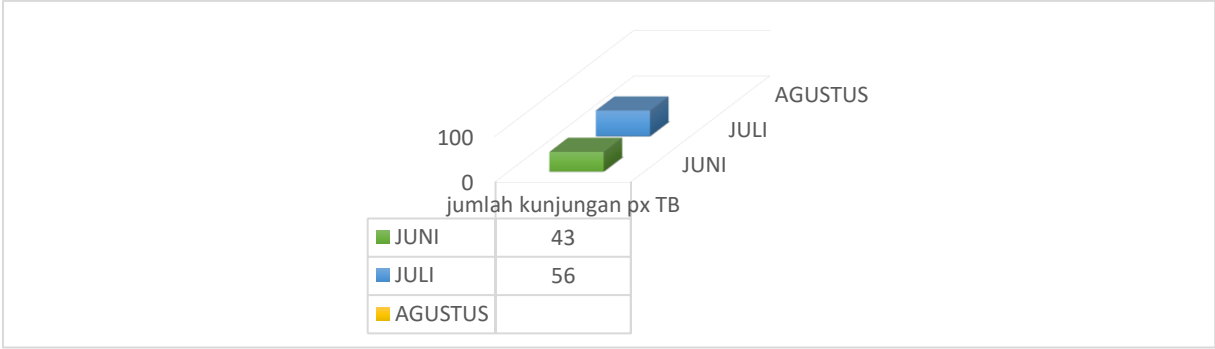
Rencana dan Tindak Lanjut:

Menginformasikan kepada pasein dan keluarga pasien untuk melakukan pengobatan dengan teratur dan sesuai jadwal, serta mengedukasi kepada keluarga pasien untuk melakukan skrinning TB

3.1.2.2.5 Jumlah Kunjungan pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	Pasien TB Kunjungan Keseluruhan	43	56	

Grafik Jumlah Kunjungan Pasien TB Baru di Rumah Sakit Prima Husada



Analisis:

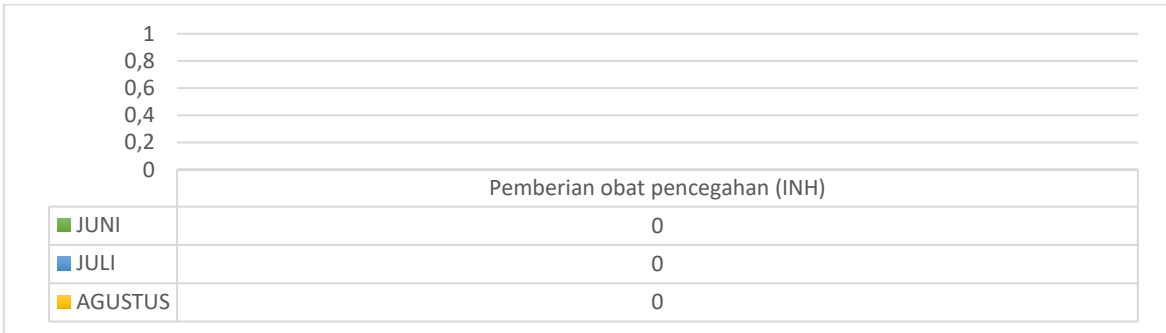
- 1. Jumlah keseluruhan kunjungan bulan Juni 2025 di poli pasien TBC mencapai 43 pasien.
- 2. Jumlah keseluruhan kunjungan bulan Juli 2025 di poli pasien TBC mencapai 56 pasien.
- 3. Jumlah keseluruhan kunjungan bulan Agustus 2025 di poli pasien TBC mencapai 0 pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Meningkatkan kunjungan pasien

3.1.2.2.6 Pemberian Obat Pencegahan

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	Pemberian obat pencegahan (INH)	0	0	0

Grafik Pemberian Obat Pencegahan di Rumah Sakit Prima



Analisis :
Tidak ada yang mendapat obat pencegahan (INH), hal ini dikarenakan kurang pengetahuannya pasien dan keluarga pasien mengenai pengobatan pencegahan (INH)

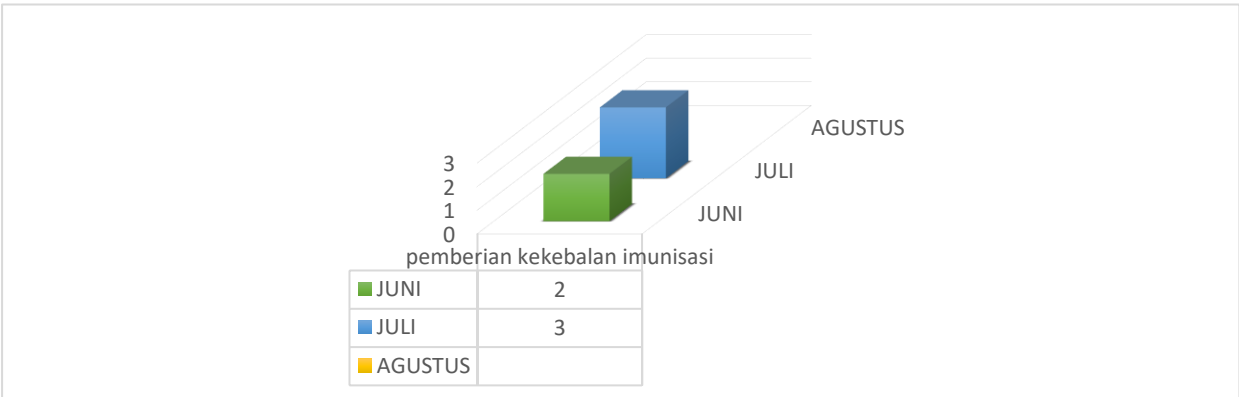
Rencana dan Tindak Lanjut

1. Memberikan edukasi kepada keluarga pasien bahwa jika ada salah satu keluarga yang terdiagnosa TB kemudian memiliki saudara dengan usia dibawah 17 tahun, agar segera memeriksakan dan bersedia di berikan obat pencegahan (INH)
2. Pemberian obat INH ditujukan pada anak usia dibawah 5 tahun yang memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak terdiagnosa TB

3.1.2.2.7 Pemberian Imunisasi BCG

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	Pemberian imunisasi BCG	2	3	

Grafik Pemberian Kekebalan Imunisasi di RS Prima Husada



Analisis :

- 1. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 2 pasien yang diimunisasi pada bulan Juni
- 2. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 3 pasien yang diimunisasi pada bulan Juli
- 3. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 0 pasien yang diimunisasi pada bulan Agustus

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1. Dilakukan screening pasien dalam memberikan vaksin BCG
- 2. Setelah dilakukan vaksin BCG dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemberian vaksin yang akan dilakukan pencatatan dan pelaporan tiap bulanya

3.1.2.2.8 Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD	100%	100%	

Analisis :

Semua staf sudah patuh dalam penggunaan APD, hal ini menunjukkan kesadaran bahwa sangat penting menjaga diri agar tidak tertular pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :

Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

3.1.2.2.9 Kepatuhan Pengunjung Pasien Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	Kepatuhan pengunjung pasien terhadap APD	100%	100%	

Analisis:

Hasil diatas menunjukan (100%) kepatuhan terhadap APD. Hal ini terjadi karna peningkatan kesadaran pengunjung akan cara penulara.n karena disebabkan covid yang terus menularkan virus

Rencana dan Tindak Lanjut :

Memperkuat kepatuhan pengunjung dengan cara wajib memberikan masker kepada pengunjung saat di nerstation dengan menanyakan keluarga dari pasien isolasi

3.1.2.2.10 Penempatan Pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	Penempatan pasien TB	100%	100%	

Analisis:

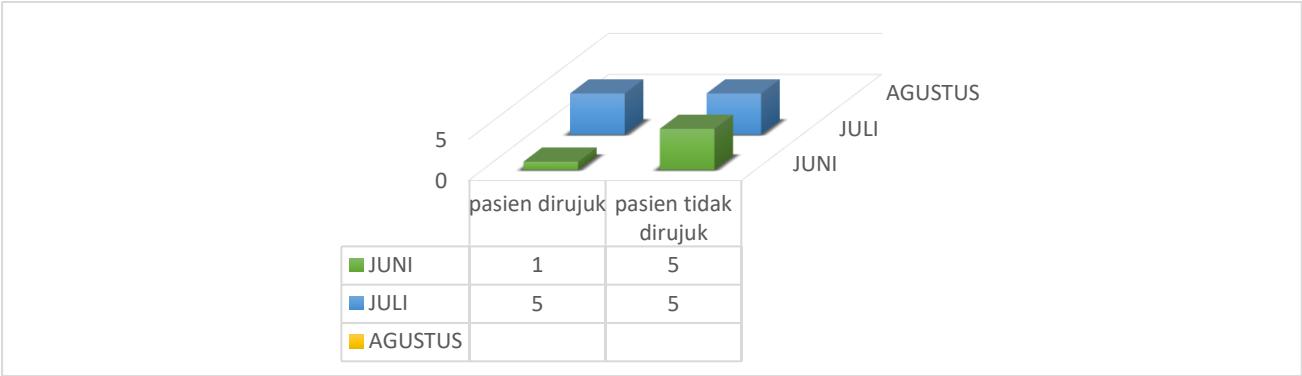
Semua pasien TB sudah ditempatkan di ruang isolasi, hal ini menunjukkan kesadaran staff medis agar antar pasien satu dengan lainnya tidak tertular.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan penempatan dengan benar

3.1.2.2.11 Pasien TB yang dirujuk

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	Pasien TB yang dirujuk	1	5	
2.	Pasien TB yang tidak dirujuk	5	5	

Grafik Pasien TB yang dirujuk Di Rumah Sakit Prima Husada



- Analisis :**
- 1. Pada bulan Juni 2025 terdapat 1 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
 - 2. Pada bulan Juli 2025 terdapat 5 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
 - 3. Pada bulan Agustus 2025 terdapat 0 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan pelayanan yang terbaik untuk pasien sesuai pilihan pasien untuk berobat.

3.1.2.2.12 Stok OAT

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	OAT Anak	3	3	
2.	OAT Harian Dewasa	18	11	
3.	Ethambutol	1008	896	
4.	Pirazinamid	940	890	
5.	Isoniazid	1380	1380	
6.	Rimfapicin 450 mg	1570	1570	
7.	Rimfapicin 300 mg	36	0	

Grafik Stok Obat TBC Di Rumah Sakit Prima Husada



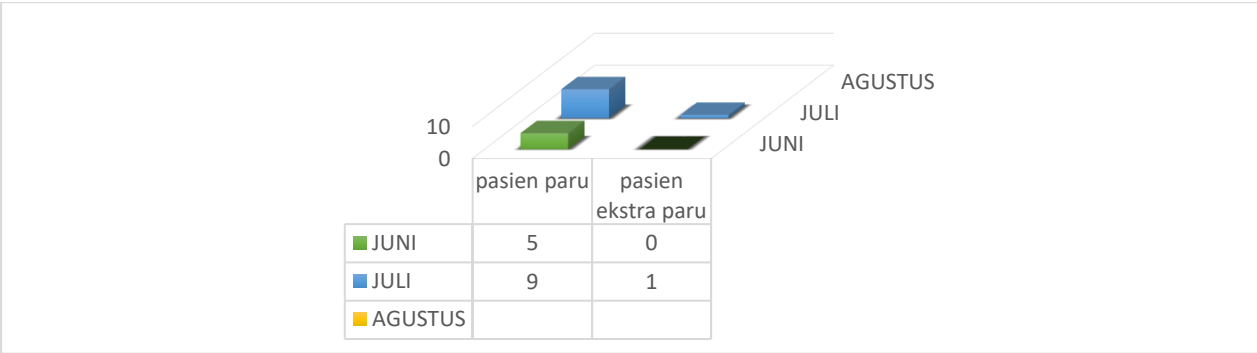
Analisis :
Setiap 1 bulan sekali farmasi akan melakukan pengadaan obat terkait permintaan ke Dinkes

Rencana dan Tindak Lanjut :
Menetapkan pengambilan obat dengan sesuai jadwal.

3.1.2.2.13 Pasien Paru dan Ekstra Paru

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	Pasien paru	5	9	
2.	Pasien Ekstra paru	0	1	

Grafik Pasien Paru dan Ekstra Paru di Rumah Sakit Prima Husada



Evaluasi :

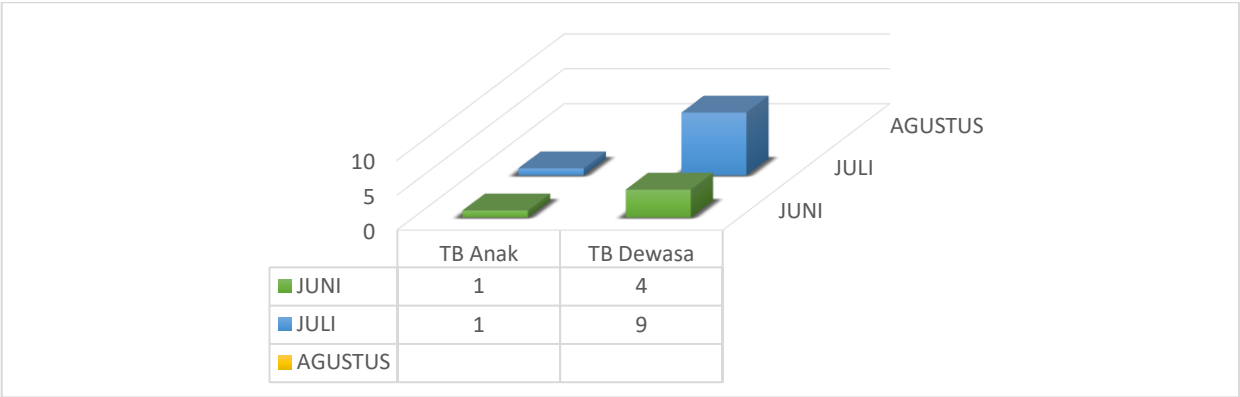
- 1. Pada bulan Juni 2025 terdapat 5 pasien paru dan 0 pasien ekstra paru
- 2. Pada bulan Juli 2025 terdapat 8 pasien paru dan 1 pasien ekstra paru
- 3. Pada bulan Agustus 2025 terdapat 0 pasien paru dan 0 pasien ekstra paru

Rencana dan Tindak Lanjut :
Memberikan pengobatan yang sama pada ekstra paru meski pengobatannya akan lebih lama

3.1.2.2.14 Pasien Anak Dan Pasien Dewasa TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	Pasien Anak	1	1	
2.	Pasien Dewasa	5	9	

Grafik Pasien Anak dan Pasien Dewasa di Rumah Sakit Prima



- Analisis :**
- 1. Pada bulan Juni terdapat 1 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 5 pasien
 - 2. Pada bulan Juli terdapat 1 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 9 pasien
 - 3. Pada bulan Agustus terdapat 0 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 0 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan pencatatan TB sesuai kategori pasien.

3.1.2.2.15 Kepatuhan Dokter Terhadap PPK TB

NO	KEGIATAN	NAMA PASIEN	PATUH	TIDAK PATUH	ALASAN
1.	dr. Andy, Sp. P	Tn. M	V		
2.	dr. Catur Elvi p., Sp. P	Ny. M	V		
		Ny. J	V		
		Ny. R	V		

Analisis :

Semua dokter sudah patuh akan PPK (Panduan Praktek Klinis) TB, baik dari anamnesis, kriteria diagnosis, pemeriksaan penunjang, dan Edukasi. Akan tetapi pada *point* edukasi sosial (pencarian kontak serumah) tidak dilakukan

Rencana dan Tindak Lanjut :

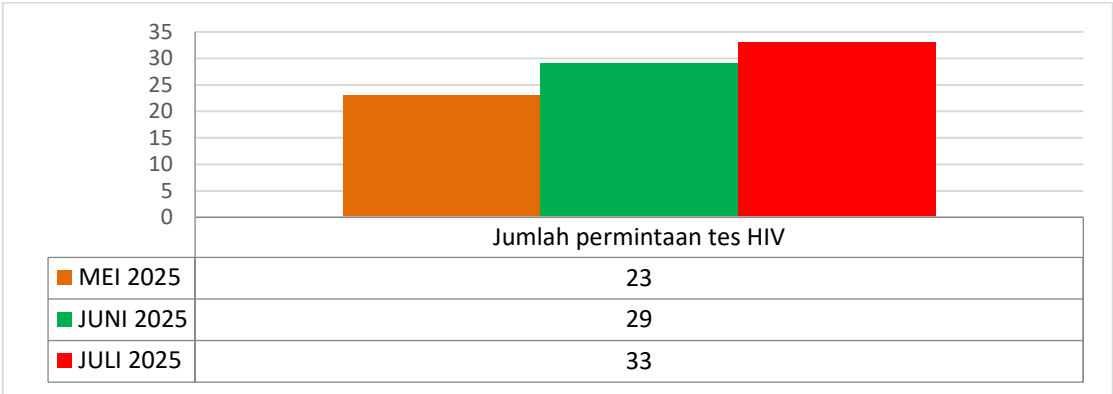
Tetap mempertahankan kepatuhan dokter sesuai dengan PPK TB yang berlaku di RS Prima Husada Kabupaten Malang

3.1.2.3 HIV

Jumlah Permintaan Tes HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025
1	Permintaan Test HIV	23	29	33

**Grafik Jumlah Permintaan Tes HIV Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Juli 2025**



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah permintaan test HIV pada bulan Mei 2025 sebnyak 23 pmeriksaan pada bulan juni 2025 sebanyak 29 pemeriksaan. Sedangkan pada bulan Juli 2025 sebanyak 33 pemeriksaan.
Hal ini dikarenakan terdapat pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya.

Rencana Tindak Lanjut :

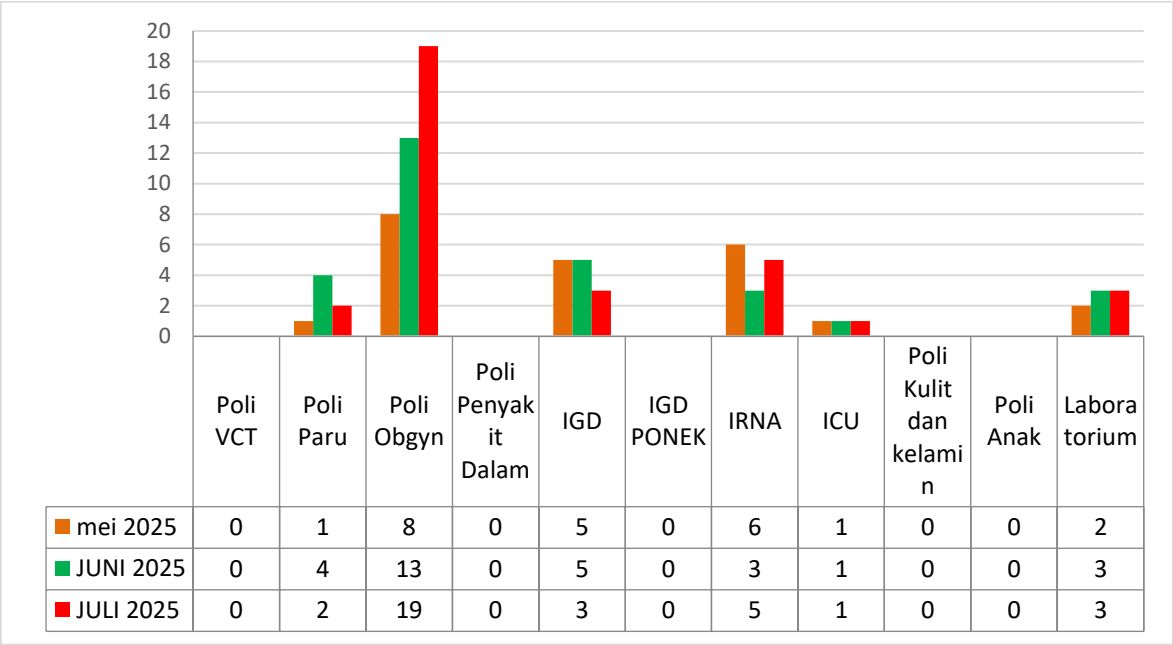
Dilakukan skrining ulang pada pasien-pasien yang terduga HIV, pasien hamil trimester 3 dan juga pasien-pasien mandiri yang ingin dilakukan pemertiksaan HIV sesuai sukarela baik pasien IGD, rawat jalan maupun rawat inap.

3.7.57 Asal Permintaan Tes HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025
1	Poli VCT	0	0	0
2	Poli Paru	1	4	2
3	Poli Obgyn	8	13	19

4	Poli Penyakit Dalam	0	0	0
5	IGD	5	5	3
6	IGD PONEK	0	0	0
7	IRNA	6	3	5
8	ICU	1	1	1
9	Poli Kulit dan kelamin	0	0	0
10	Poli Anak	0	0	0
11	Laboratorium	2	3	3

Grafik Jumlah Asal Permintaan Tes HIV di RS Prima Husada Bulan Juli 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah asal permintaan test HIV di Poli kandungan tetap tinggi dibandingkan dari unit lain pada bulan Mei 2025 sebanyak 7 pasien, pada bulan Juni sebanyak 13 pasien. Sedangkan pada bulan Juli 2025 sebanyak 19 pasien.

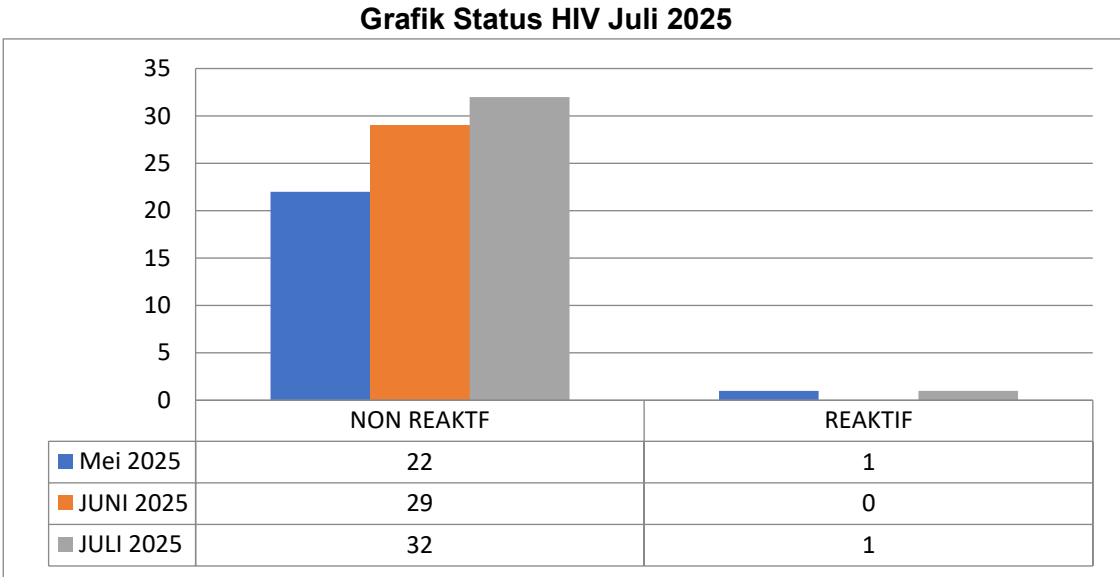
Hal ini dikarenakan sudah tersdianya Reagen HIV dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk program ibu hamil sehingga pasien dengan kriteria hamil trimester II sudah bisa dilakukan screening HIV.

Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan sosialisasi terkait Permintaan testing HIV dilakukan baik di IGD, rawat jalan, maupun rawat jalan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sehingga capaian permintaan testing HIV bisa berjalan.

3.1.2.3.2 Status HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025
1	Non Reaktif	22	29	32
2	Reaktif	1	0	1

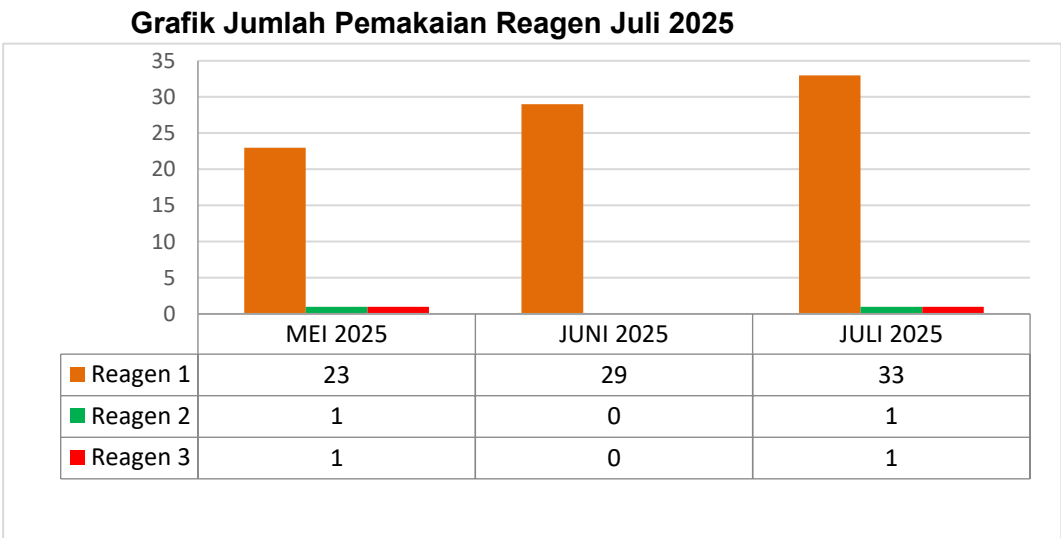


Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan pasien dengan status HIV reaktif yang dilakukan pemeriksaan di RS prima Husada Malang pada pada bulan Mei 2025 sebnyak 1 pasien pada bulan juni 2025 tidak ada pasien dengan status HIV reaktif Sedangkan pada bulan juli 2025 sebanyak 1 pasien dari poli rawat jalan

Rencana Tindak Lanjut :
Rumah sakt prima husada malang masih belum bisa melakukan pelayanan pasien dengan HIV/AIDS, apabila ditemukan pasien dengan HIV reaktif maka akan kami lakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah MOU dengan RS Prima Husada Malang.

3.7.58 Jumlah Pemakaian Reagen

No	URAIAN	BULAN		
		MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025
1	Reagen 1	23	29	33
2	Reagen 2	1	0	1
3	Reagen 3	1	0	1



Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pemakaian reagen pada bulan mei 2025 memakai reagen 3 dikarenakan ada pasien reaktif sebanyak 1 pasien. pada bulan Juni 2025 hanya memakai reagen 1 sebanyak 29 pasien. Sedangkan pada bulan Juli 2025 memakai

reagen 3 dikarenakan ada pasien reaktif sebanyak 1 pasien

Rencana Tindak Lanjut :

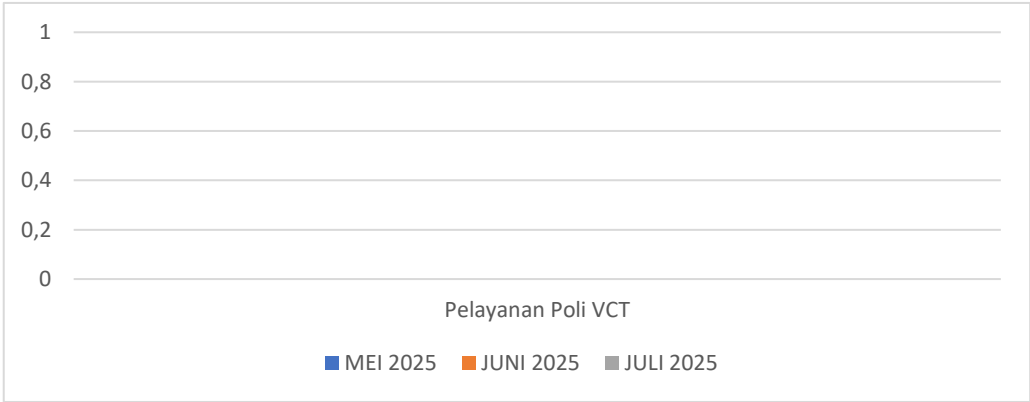
Pemakaian reagen HIV tergantung dari hasil pemeriksaan dengan Reagen 1. Apabila dilakukan pemeriksaan dengan Reagen 1 hasil Non Reatif maka tidak dilanjutkan pemakaian Reagen 2 dan 3.

Tetapi apabila saat pemeriksaan dengan Reagen 1 ditemukan hasil Reaktif maka pemeriksaan dilanjutkan dengan penggunaan Reagen 2 dan Reagen 3

3.7.59 Pelayanan Poli Vct (Voluntary Conseling And Testing)

No	URAIAN	BULAN		
		MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025
1	Pelayanan Poli VCT	0	0	0

Grafik Pelayanan Poli VCT Juli 2025



Analisis pelayanan Poli VCT

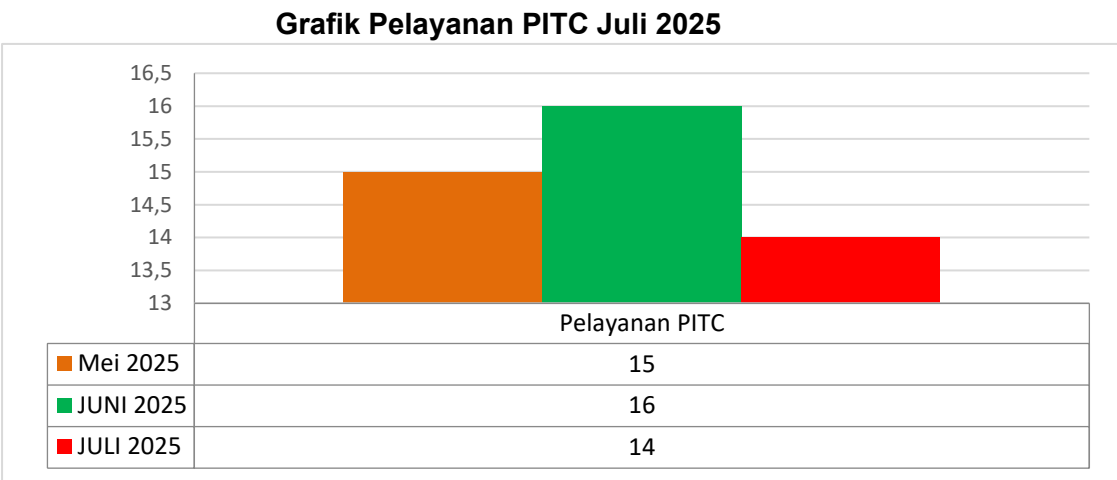
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa tidak ada kunjungan di poli VCT di RS Prima Husada. Hal ini dikarenakan kurang tahunya masyarakat terkait pentingnya deteksi pemeriksaan HIV/AIDS

Rencana Tindak Lanjut

Pelayanan Poli VCT di Rumah Sakit Prima Husadabelum berdiri sendiri, melainkan masih bergabung dengan oli penyakit Dalam di Rawat jalan. Hal ini dikarena asih belum adanya kunjungan pasien ke poli VCT

3.7.60 Pelayanan PITC (Provider Initiated Testing and Counseling)

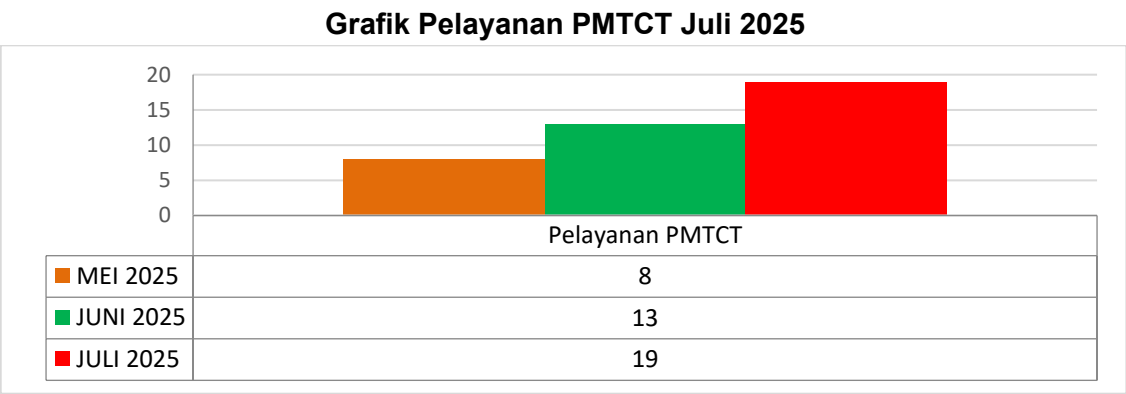
No	URAIAN	BULAN		
		MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025
1	Pelayanan PITC	15	16	14



Analisis :
Dari data diatas terdapat keimpulan bahwa telah dilakukan edukasi pemeriksaan HIV oleh petugas kesehatan untuk dilakukan testing HIV pada bulan pada bulan Mei 2025 sebanyak 15 pasien. pada bulan Juni 2025 sebanyak 16 pasien. Sedangkan pada bulan Juli 2025 sebanyak 14 pasien. Hal ini dikarenakan testing dan konseling dilakukan saat pasien menunjukan gejala HIV dan dilakukanya sreening baik di ruangan maupun IGD

Rencana Tindak Lanjut :
Dilakukan peningkatan terkait penjangrian pasien dengan dialkukanya edukasi pasien tentang testing HIV kepada pengunjung atau 227lastic227er sehingga pasien paham tentang pentingnya dilakukan pemeriksaan HIV.

3.7.61 Pelayanan Pmtct (Prevention to Mother Of Child Transmision)				
No	URAIAN	BULAN		
		MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025
1	Pelayanan PMTCT	8	13	19



Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HIV sebagai screening dan deteksi pencegahan penularan dari ibu ke Bayi. Pada bulan pada bulan Mei 2025 sebnya 8 pasien. pada bulan Juni 2025 sebanyak 13 pasien. Sedangkan pada bulan juli 2025 sebanyak 19 pasien.
Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

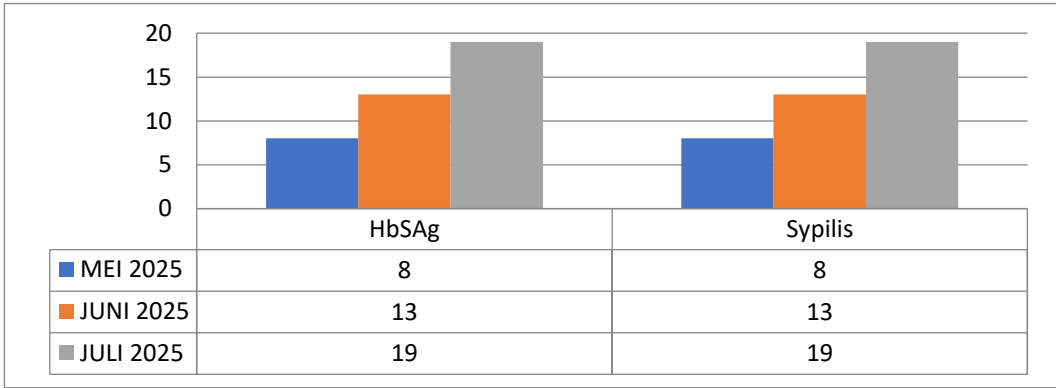
Rencana Tindak Lanjut :

Reagen pemeriksaan HIV yang diperoleh dari dinas kesehatan sudah tersedia di RS Prima Husada Malang sehingga Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

3.7.62 Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025
1	HbSAg	8	13	19
2	Sypilis	8	13	19

**Grafik Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil
Juli 2025**



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HbSAg dan Sypilis pada bulan pada bulan pada bulan April 2025 sebanyak 15 pasien pada bulan Mei 2025 sebanyak 8 pasien. Sedangkan pada bulan Juni 2025 sebanyak 13 pasien Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan triple eliminasi dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan Triple eliminasi di RS Prima Husada Malang untuk pemeriksaan HbSAg dan Sypilis bisa dilakukan.

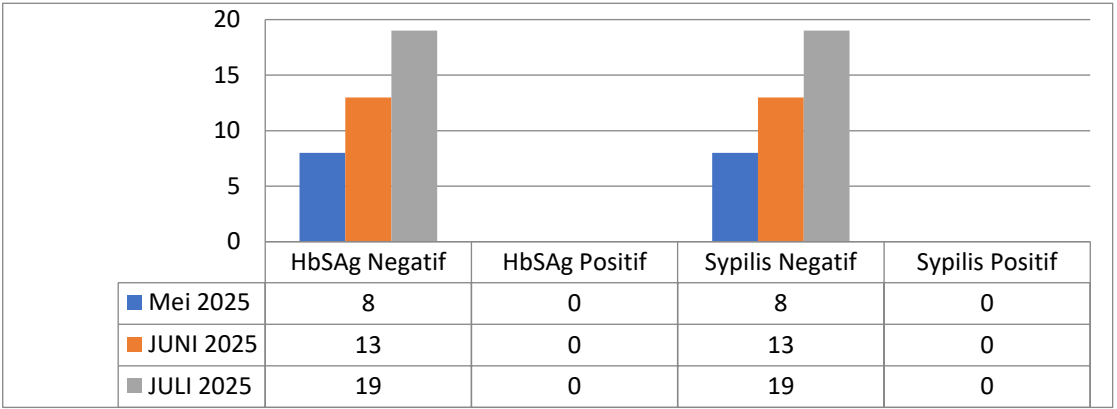
Rencana Tindak lanjut :

Pemeriksaan Triple eliminasi untuk ibu hamil bersifat wajib dan dilakukan 1 kali saat awal kehamilan. Di RS Prima Husada skrining pemeriksaan triple eliminasi sudah berjalan dan dilakukan saat kunjungan pada Trimester 2.

3.7.63 Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025
1	HbSAg			
	Negatif	8	13	19
	Positif	0	0	0
2	Sypilis			
	Negatif	8	13	19
	Positif	0	0	0

Grafik Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil
Juli 2025



Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data bahwa pada bulan Mei Juni dan Juli 2025 tidak ditemukan pasien dengan HbSAg maupun Shypilis dengan hasil positif. Sedangkan pada bulan april 2025 ditemukan 1 pasien positif Syphilis.

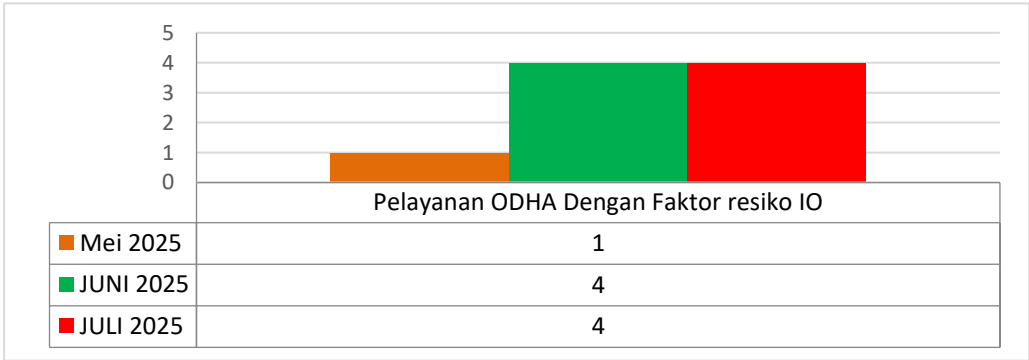
Rencana Tindak Lanjut :

1. Pada pasien HbSAg
Saat kelahiran aka nada pemberian vaksin Hepatitis kepada bayi yaitu Hiper Heb dan juga Hb.O unijec yang diberikan saat bayi baru lahir sampai dengan maksimal 24 jam pemberian. Untuk ibu dengan HbSAg akan dilakukan pemberian vaksin hepatitis oleh Puskesmas sesuai domisili pasien.Penanganan pasien dengan HbSAg Rumah Sakit Prima Husada Malang Kolaborasi dengan puskesmas sesuai dengan domisili pasien.
2. Pada pasien Sypilis
Di rumah sakit Prima Husada Malang sudah bisa melakukan pengobatan pasien dengan syphilis positif. Sehingga tidak lagi melakukan rujuk keluar.

3.7.64 Pelayanan Odha Dengan Factor Resiko Infeksi Oportunistik

No	URAIAN	BULAN		
		MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025
1	Pelayanan ODHA Dengan Faktor resiko IO	1	4	4

Grafik Pelayanan Odha dengan Faktor Resiko IO Juli 2025



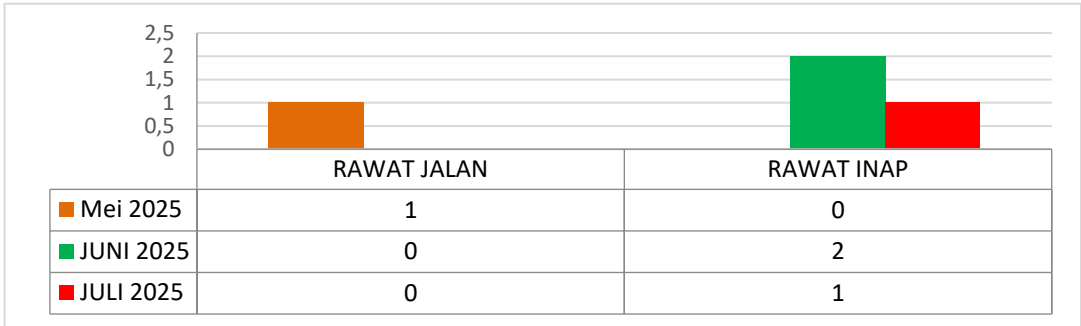
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa terdapat pasien dengan diagnose TB positif yang dilakukan pemeriksaan HIV di RS Prima Husada. Pada Mei 2025 sebanyak 1 pasien. pada bulan Juni 2025 sebanyak 4 pasien. Sedangkan pada bulan Juli sebanyak 4 pasien. Hal ini dikarenakan dilakukanya screening pasien TB di RS Prima Husada Malang.

Rencana Tindak Lanjut :
Pasien-pasien dengan diagnose TB positif di Rumah Sakit Prima Husada Malang sudah patuh dilakukan screening pemeriksaan HIV/AIDS sesuai dengan SPO.
Diharapkan bisa saling kerjasama antar tim yaitu TIM TB dan Tim HIV.

3.7.65 Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS

No	URAIAN	BULAN		
		MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025
1	Rawat Jalan	1	0	0
2	Rawat Inap	0	2	1

Grafik Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS Juli 2025



Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa Pada bulan Mei 2025 terdapat 1 Pasien yang dirujuk dari rawat jalan. pada bulan juni 2025 terdapat 2 pasien yang dirujuk dari rawat inap Sedangkan pada bulan Juli 2025 terdapat 1 pasien yang dirujuk Pasien Dilakukan rujuk dikarenakan RS Prima husada malang belum bisa menangani pasien yang ditemukan positif HIV .

Rencana Tindak Lanjut :
Pelaksanaan Rujukan dilakukan apabila hasil pemeriksaan HIV Reaktif. Rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Prima Husada Malang.

3.1.2.4 Stunting & Wasting

3.7.66 Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting

Tabel Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting Juli 2025

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1	Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf , pasien, dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting	Melakukan promosi kesehatan dengan melaksanakan edukasi pasien dan sosialisasi kepada seluruh staff mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan stunting dan wasting.
2	Program 1000 HPK	Pemberian Penyuluhan tentang pentingnya pengasuhan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien
3	Suplementasi Folat Pada Ibu hamil	Suplementasi Folat Pada ibu hamil dilaksanakan di poli kandungan di RS Prima Husada Malang
4	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil	Pemberian PMT pada ibu hamil dilaksanakan pada saat kegiatan senam hamil di RS Prima Husada Malang

5	Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	1. Kegiatan konseling IMD dilaksanakan sesaat setelah ibu melahirkan 2. Konseling IMD dan ASI eksklusif dilaksanakan pada saat ibu telah memasuki rawat inap maternitas 3. Penyuluhan tentang pentingnya IMD dan pemberian ASI eksklusif juga dilaksanakan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan
6	Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita dilaksanakan di ruang rawat inap dan melakukan pendampingan di poli anak RS prima husada
7	Pemberian imunisasi	Pemberian imunisasi dilaksanakan di poli anak RS prima husada malang sesuai dengan jadwal praktek dokter spesialis anak dan di rawat inap sesaat setelah bayi baru dilahirkan.
8	Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Pemberian makanan tambahan balita gizi kurang dilaksanakan apabila ditemui balita dengan gizi kurang di rawat inap
9	Penerapan Rumah Sakit 231 lasti Ibu Bayi	1. Menyelenggarakan pelayanan konseling kesehatan maternal dan neonatal. 2. Konseling pemberian ASI eksklusif. 3. Penyediaan Pojok Laktasi untuk mendukung pemberian ASI eksklusif
10	Rumah Sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting dan wasting	1. Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Stunting, Gizi Kurang, Gizi Buruk pada Balita 2. Memastikan kasus, penyebab dan tatalaksana lanjut oleh dokter spesialis anak. 3. Melakukan evaluasi pelayanan, audit kesakitan dan kematian, pencatatan dan pelaporan gizi buruk dan stunting.
11	Rumah Sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta merupakan jejaring rujukan	Tidak terdapat kunjungan/ Pendampingan klinis kepada balita gizi kurang yang telah KRS dari RSPHM.
12	Program Pemantauan dan Evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait edukasi yang sudah diberikan, serta membuat laporan dan evaluasi kegiatan.

Analisis

1. Melakukan tindakan pelayanan penurunan dan penanggulangan stunting dan wasting di Rumah Sakit.
2. Melakukan edukasi mengenai pencegahan dan penanggulangan stunting dan wasting kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien di rumah skait.

3.1.2.4.2 Kinerja Produktivitas
Tabel Peningkatan Efektifitas Intervensi Gizi Spesifik

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	LOKASI	MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025
Program 1000 HPK	Penyuluhan mengenai kehidupan 1000 hari pertama	Pengunjung RS Prima Husada Malang	IRJA anak dan Kandungan	1	1	1
Suplementasi Asam folat pada ibu hamil	1. Penyuluhan tentang pentingnya	Ibu Hamil	Senam Hamil , Poli Kandungan,	1	1	1

	konsumsi asam folat pada ibu hamil 2. Pembagian tablet tambah darah dan asam folat		Hall gedung baru lantai 5			
Pemberian PMT Ibu Hamil	Pemberian PMT dengan tinggi kalori terutama pada ibu hamil terindikasi KEK	Ibu Hamil	Hall gedung baru lantai 5	1	1	1
Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Penyuluhan mengenai pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Ibu hamil	IRJA anak dan kandungan, irna maternitas	1	1	1
Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	1. Penyuluhan tentang stunting, makanan sehat pada bayi dan balita 2. Pembagian PMBA	IRNA Anak	IRJA	1	1	1
Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Melakukan Pencatatan dan plotting pada buku KIA setelah pengukuran berat badan dan tinggi badan	Pasien Anak	IRJA anak	1	1	1

	anak					
Pemberia n Imunisasi	Memastik an ketersedia an imunisasi agar selalu tersedia di poli anak	Pasien anak dan Bayi baru lahir	IRJA anak	1	1	1
Pemberia n vitamin A	Bekerja sama dengan puskesma s terdekat untuk mendukun g program pemerinta h mengenai pemberian vitamin A	Pasien anak	IRJA anak	0	0	0
Pemberia n Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Memberik an PMT tinggi kalori dengan membantu menyusun menu yang sesuai dengan ketersdiaa n bahan pangan di lingkunga n	Pasien anak	Rawat Inap	1	1	1
Pemberia n Taburia pada Baduta	Bekerja sama dengan puskesma s terdekat untuk mendukun g program pemerinta h mengenai pemberian bubuk taburia	Pasien anak	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0
Pemberia n Obat cacing pada ibu hamil	Bekerja sama dengan puskesma s terdekat untuk mendukun g program	Ibu Hamil	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0

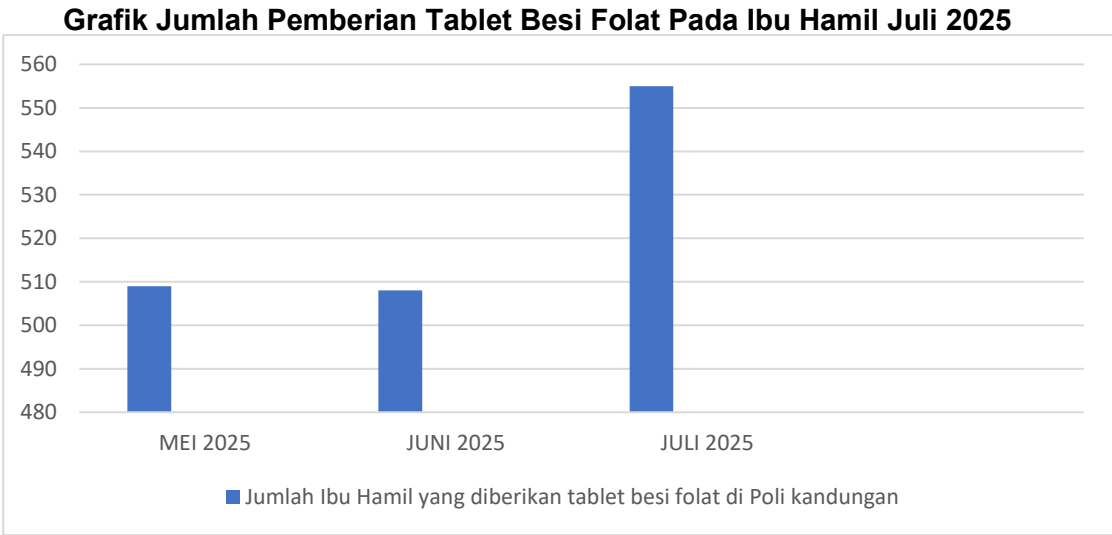
	pemerintah mengenai pemberian obat cacing pada ibu hamil					
--	--	--	--	--	--	--

Analisis :
 Sebagian besar intervensi spesifik yang dapat dilaksanakan di rumah sakit telah dilaksanakan. Pemberian bubuk Taburia dan Mineral mix dilakukan pemberian kepada pasien apabila terdapat pasien rujukan dari puskesmas. Karena bubuk taburia dan mineral mix hanya terdapat di puskesmas. Sehingga jika ada pasien teridentifikasi wasting pihak RS baru mendapat distribusi dari puskesmas wilayah balita tersebut tinggal.

Rencana Tindak Lanjut :
 Bekerjasama dengan puskesmas setempat agar dapat melakukan pendampingan intervensi spesifik di posyandu disekitar wilayah rumah sakit dan melakukan pemantauan kepada balita stunting.

3.1.2.4.3 Pemberian Tablet Besi Folat Bagi Ibu Hamil
Tabel Distribusi Tablet Besi Folat pada Ibu Hamil di RS Prima Husada Malang

BULAN	MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025
Jumlah Ibu Hamil yang diberikan tablet besi folat di Poli kandungan	509	508	555



Analisis :
 Pemberian asam folat diberikan kepada ibu hamil pada usia kandungan trimester pertama. Sedangkan pemberian tablet zat besi diberikan pada usia kandungan trimester 2 dan 3. Jumlah pemberian tablet besi folat naik dari sebelumnya 508 di bulan Juni menjadi 555 pada bulan Juli yang mendapat tablet besi folat untuk ibu hamil.

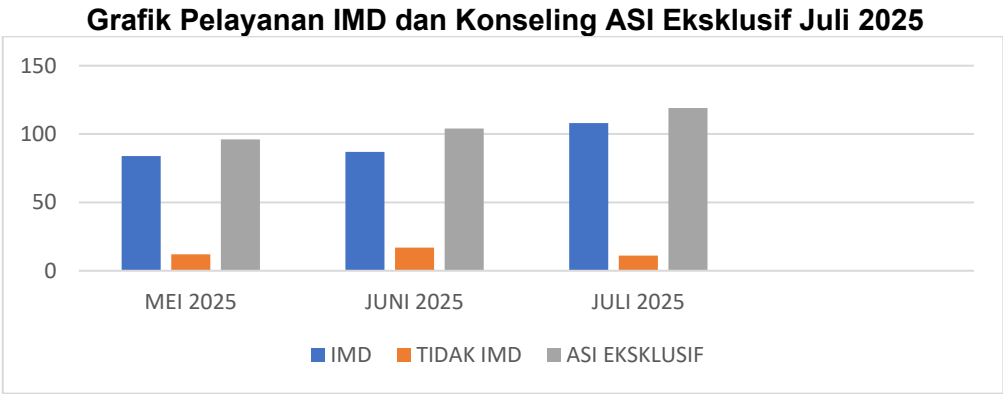
Rencana Tindak Lanjut:

- 1. Koordinasi dengan tim farmasi untuk mendukung penyediaan tablet tambah darah, agar program suplementasi tablet tambah darah kepada ibu hamil terus berlanjut
- 2. Koordinasi dengan tim humas rumah sakit agar ibu hamil yang bergabung semakin banyak agar program suplementasi tablet besi folat semakin baik.

3.1.2.4.4 Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

Tabel Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MEI 2025	BULAN JUNI 2025	BULAN JULI 2025
1	IMD	84	87	108
2	Tidak IMD	12	17	11
3	Mendapat Konseling ASI Eksklusif	96	104	119



Analisis :

- 1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Juli sebanyak 108 bayi.
- 2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Juli 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 11 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.
- 3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
- 4. 100% ibu melahirkan telah mendapatkan edukasi menyusui. Untuk mendukung pemberian ASI secara eksklusif. Jumlah Ibu mendapat konseling ASI Eksklusif meningkat pada bulan Juli 2025 yaitu sebanyak 119 pasien.

Rencana Tindak Lanjut:

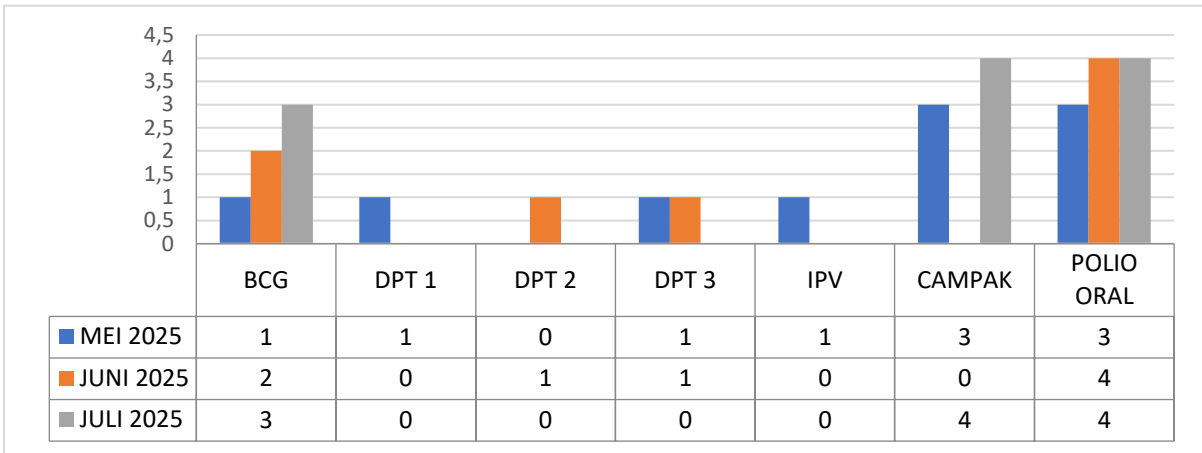
Tingkatkan koordinasi dengan dokter kandungan dan bidan rumah sakit dalam pemberian edukasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif serta mendokumentasikan bukti telah melakukan edukasi kepada ibu melahirkan pada lembar edukasi.

3.1.2.4.5 Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

Tabel Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN MEI 2025	BULAN JUNI 2025	BULAN JULI 2025
1	BCG	1	2	3
2	DPT 1	1	0	0
3	DPT 2	0	1	0
4	DPT 3	1	1	0
5	DPT 4	1	0	0
5	IPV	0	0	0
6	Campak	3	0	4
7	Polio Oral	3	4	4

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Juli 2025



Analisis:

- 1. Terdapat 3 balita yang melakukan imunisasi BCG di bulan Juli 2025.
- 2. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi DPT 1, DPT 2, DPT 3, dan IPV pada bulan Juli 2025.
- 3. Pada periode Juli 2025 terdapat 4 bayi yang melakukan Imunisasi Polio dan campak.

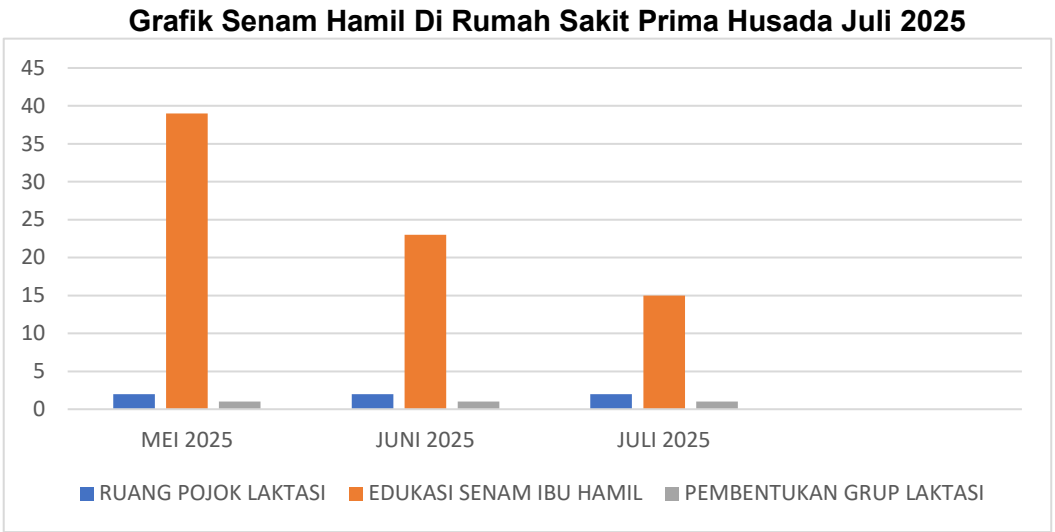
Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit. Bekerjasama dengan pihak puskesmas untuk keersediaan vaksin di RS.

3.1.2.4.6 Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

KEGIATAN PENERAPAN RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI	MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025
Ruang Pojok Laktasi	2	2	2
Senam Hamil	39	23	15
Pembentukan Grup Laktasi	1	1	1



Analisis :

- 1. Pojok laktasi sudah tersedia untuk ibu dan bayi yang akan menyusui di wilayah Rumah Sakit Prima Husada Malang sebanyak 2 ruangan, di lantai 1 dan di lantai 2.
- 2. Grup Laktasi dibentuk untuk memberikan tips menyusui.
- 3. Pada bulan Juli edukasi pada senam ibu hamil dilakukan dengan memberikan penyuluhan Gizi Seimbang pada Ibu Hamil sebanyak 15 peserta pasien rawat jalan di poli obgyn.

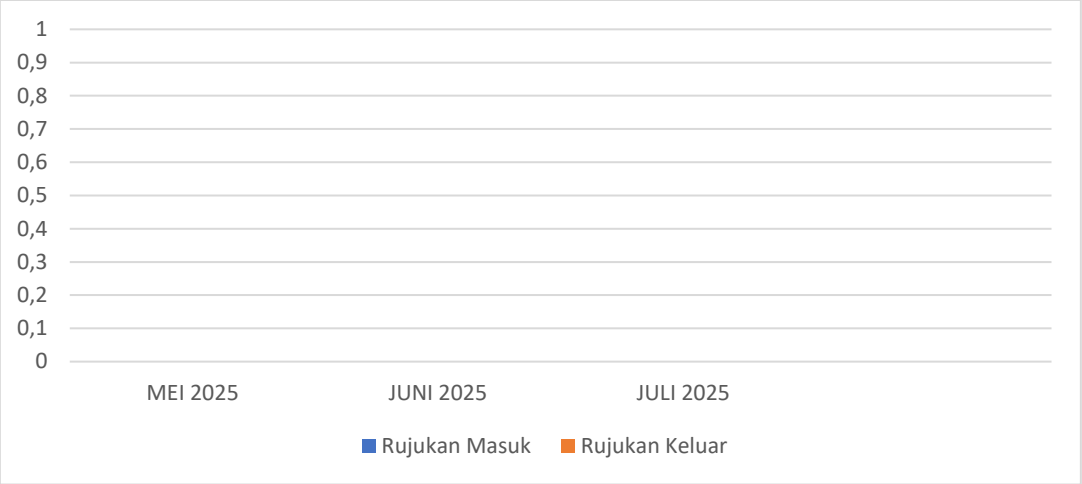
Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Mengajukan perlengkapan untuk keperluan menyediakan pojok laktasi yang nyaman bagi bayi, balita, dan ibu menyusui seperti pampers dan tissue basah jika terdapat pasien atau pengunjung yang membutuhkan.
- 2. Melakukan edukasi mengenai pentingnya mengikuti senam ibu hamil pada ibu hamil yang tidak memiliki kondisi penyulit saat hamil.

**3.1.2.4.7 Pelayanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting Dan Wasting
Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi**

RUJUKAN MASUK				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Asal Rujukan
Maret	-	-	-	-
April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-
RUJUKAN KELUAR				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Tujuan Rujukan
Maret	-	-	-	-
April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-

Grafik Pelayanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting dan Wasting Bulan Juli 2025



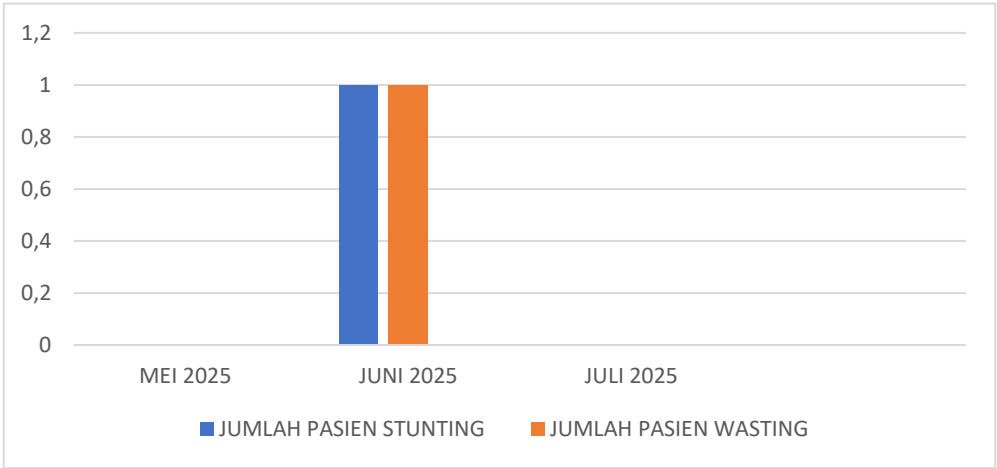
Analisis :
Tidak Terdapat pasien stunting atau wasting yang dirujuk keluar RS maupun rujuk masuk RS

Rencana Tindak Lanjut:
Perlu diadakan kerjasama lagi dengan puskesmas dan klinik faskes pertama untuk bekerjasama dalam menjaring pasien stunting dan wasting.

3.1.2.4.8 Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan
Tabel Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

BULAN	MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025
Jumlah Pasien Stunting	0	1	0
Jumlah Pasien Wasting	0	1	0

Grafik Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan



Analisis :
Pada bulan Juli 2025 tidak terdapat pasien stunting dan wasting.

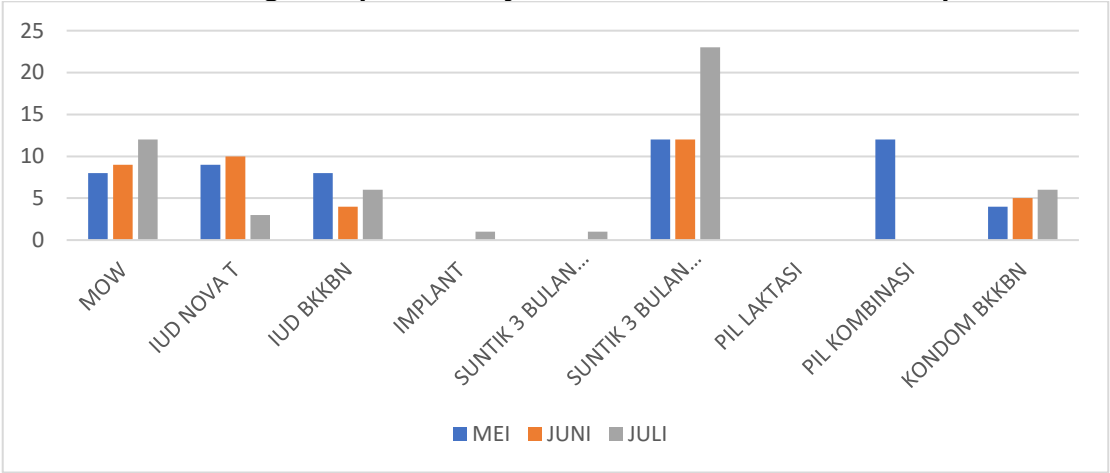
Rencana Tindak Lanjut :
Tim Stunting dan Wasting RS Prima Husada telah melakukan kunjungan rumah pasien Bersama ahli gizi Puskesmas Lawang, bidan desa setempat, dan kader wilayah kerja.

3.1.2.5 KBRs

3.7.67 Angka Capaian Pelayanan KB per Metode Kontrasepsi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MEI 2025	BULAN JUNI 2025	BULAN JULI 2025
1	MOW	8	9	12
2	IUD Nova T	9	10	3
3	IUD BKKBN	8	4	6
4	IMPLANT	0	0	0
5	SUNTIK 3 BULAN KOMBINASI	0	0	0
6	SUNTIK 3 BULAN PROGESTIN	12	12	23
7	SUNTIK 1 BULAN	0	0	0
8	PIL KOMBINASI	29	0	0
9	PIL LAKTASI	0	0	0
10	KONDOM BKKBN	4	5	6

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Per Metode Kontrasepsi



- Evaluasi :**
- 1. Peserta MOW pada bulan Mei tetap(8) Juni naik (9) Juli naik (12)
 - 2. Peserta IUD Nova T pada bulan Mei naik(9) Juni (10) Juli turun (3)
 - 3. Peserta IUD BKKBN Mei (8) Juni turun(4) Juli naik (6)
 - 4. Peserta KB suntik 3 bulan kombinasi, pada bulan Mei (0) Juni (0) Juli (1)
 - 5. Peserta KB suntik progestin Mei tetap(12) Juni (12)Juli naik (23)
 - 6. Peserta KB pil kombinasi pada bulan Mei naik (29) Juni (0)Juli (0)
 - 7. Peserta KB Kondom pada bulan Mei naik(4) Juni (5) Juli (6)

- Analisis :**
- 1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
 - 2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.

3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.

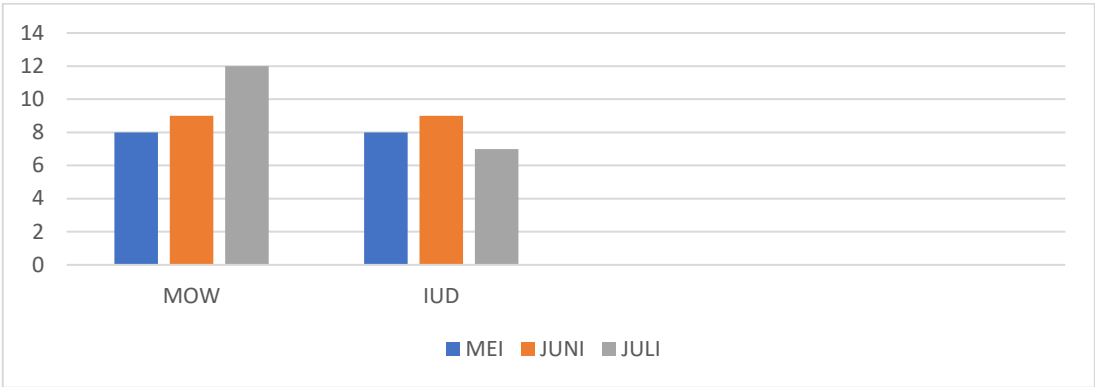
Rencana Tindak Lanjut :

Demi meningkatkan capaian KB maka rumah sakit akan melakukan pelatihan internal bagi para bidan dalam pemasangan IUD pasca plasenta,dan akan diadakan safari KB setiap 2 bulan sekali

Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan Dan Pasca Persalinan

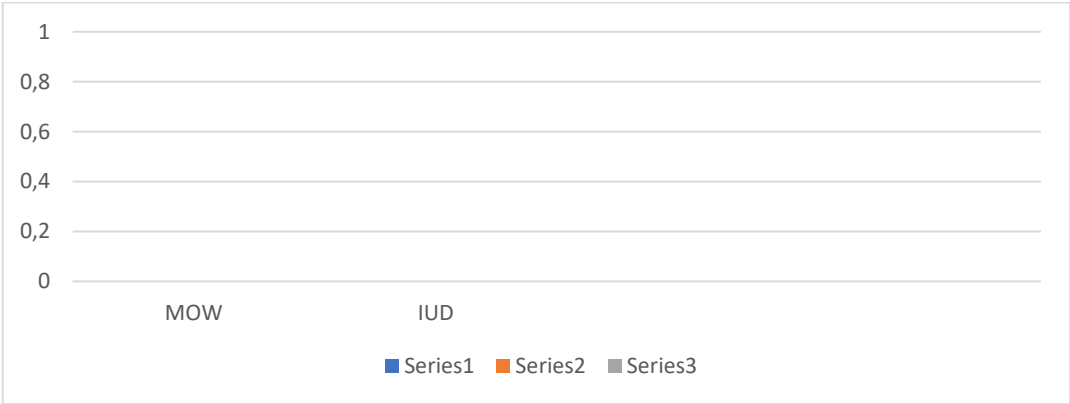
NO	JENIS PELAYANAN PASCA PERSALINAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MEI 2025	BULAN JUNI 2025	BULAN JULI 2025
1	MOW	8	9	12
2	IUD	8	9	7

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan



NO	JENIS PELAYANAN PASCA KEGUGURAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MEI 2025	BULAN JUNI 2025	BULAN JULI 2025
1	MOW	0	0	0
2	IUD	0	0	0

Grafik Angka Capaian Pelayan KB Pasca Keguguran



Evaluasi :

- 1. Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan pada bulan Mei-Juni-Juli meningkat
- 2. Angka capaian pelayanan KB pasca keguguran pada bulan Mei-Juni-Juli menetap.

Analisis :

1. Peningkatan jumlah sasaran pada triwulan pertama kemungkinan didapatkan karena sasaran KB sudah mengetahui pentingnya KB dari pengetahuan yang didapatkan saat sosialisasi yang dilakukan tim setiap bulannya.
2. Capaian pelayanan KB pasca keguguran menetap dikarenakan peserta mempunyai alasan ingin segera hamil lagi.

Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.

3.2.3 Tim PPRA

3.2.3.1 Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif Triwulan III Tahun 2025

3.2.3.1.1 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Mei 2025

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	Rubi'ati	P/61	dr. Heri, Sp.Pd	204084	DM Type 2	04/05/2025	07/05/2025	4	Levofloxacin po	2	1x0,75	3	0,5	6
									Metronidazole inf		2x0,5	4	1,5	2,67
2	Kasiati	P/49	dr. Humaira, Sp.OG	203066	Endometriosis	06/05/2025	08/05/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
3	Ainun Ulumi	P/22	dr. Aida, Sp.OG	206805	SC	08/05/2025	10/05/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
4	Ida Rahmawati	P/27	dr. Aida, Sp.OG	071885	SC	09/05/2025	11/05/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
5	Santoso	L/80	dr. Mira, Sp.JP	081276	Heart Failure	10/05/2025	13/05/2025	4	Asam Pipemidate	2	2x0,4	3,2	0,8	4
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2
6	Ari Anita	P/36	dr. Andi, Sp.BP	231095	Necrotizing Fascitis	12/05/2025	15/05/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Cefoperazone		2x1	4	4	1
7	Muchlis Hanafi	L/62	dr. Ardhi, Sp.Pd	186772	OF	13/05/2025	15/05/2025	3	Levofloxacin po	2	1x0,5	1	0,5	2
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
8	Elisabet G	P/27	dr. Ard hany, Sp.Pd	231152	TF	14/05/2025	18/05/2025	4	Levofloxacin po	2	1x0,5	1,5	0,5	3
									Levofloxacin inj		1x0,5	1,5	0,5	3
9	Sri Widodo	P/62	dr. Ard hany, Sp.Pd	058182	TF	15/05/2025	18/05/2025	4	Levofloxacin po	2	1x0,5	1	0,5	2

									Levofloxacin inj		1x0,5	1,5	0,5	3
10	Badriyah	P/61	dr. Anton, Sp.B	116956	Necrotizing Fascitis	16/05/2025	18/05/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
11	Titus Sukriwani	L/64	dr.Ardhany, Sp. Pd	229894	DM Type 2	17/05/2025	21/05/2025	5	Levofloxacin inj	1	1x0,5	2,5	0,5	5
12	Catur Priyo	L/31	dr. Ardhi, Sp. Pd	231309	Febris	19/05/2025	22/05/2025	4	Ciprofloxacin po	1	2x0,5	3,5	1	3,5
13	Sumini	P/ 61	dr.Andy, Sp. P	143421	Hemoptysis	21/05/2025	23/05/2025	3	Azitromycin	1	1x0,5	1,5	0,3	5
14	Adi Sumarto	L/48	dr. Oka, Sp.OT	231518	Injury of unspecified body region	21/05/2025	23/05/2025	3	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
15	Fikri	L/44	dr. Ardhi, Sp.Pd	231562	Cronic Fever	22/05/2025	25/05/2025	4	Ceftriaxone	2	2x1	7	2	3,5
									Levofloxacin inj		1x0,5	1,5	0,5	3
16	Siti Djumainah	P/56	dr. Zora, Sp.Pd	231203	Septic syok	22/05/2025	27/05/2025	6	Metronidazole inf	2	3x0,5	9	1,5	6
									Ceftriaxone		2x1	11	2	5,5
17	Ahmad Fikri	L/21	dr. Zaky, Sp.B	231019	Ganglion Curpi	23/05/2025	25/05/2025	3	Ceftizoxime	2	1x2	2	4	0,2
									Cefixime		2x0,1	0,4	2	3
18	Asri Ramasari	P/ 30	dr.Andy, Sp. P	201226	Atshma	24/05/2025	27/05/2025	4	Azitromycin	1	1x0,5	1,5	0,3	5
19	Siti Rochmah	P/53	dr. Andi, Sp.B	231691	Susp Appendic	25/05/2025	28/05/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	6	2	3
20	Nurhayati	P/65	dr. Zaky, Sp.B	101888	Colic Abdomen	26/05/2025	29/05/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	6	2	3

3.2.3.1.2 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Juni 2025

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1.	Dewi Agung	P/46	dr. Zaki, Sp.B	155781	Gangrenen	03/06/2025	04/06/2025	2	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
2.	HJ. Praptini	P/69	dr. Ira, Sp.JP	223270	ALO	04/06/2025	07/06/2025	4	Levofloxacin inf	2	1x0,5	0,5	0,5	1
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
3.	Syafa Nabila	P/16	dr. Anton, Sp. B	232241	Abdominal pain	06/06/2025	09/06/2025	4	Ceftriaxone	1	2x1	8	2	4
4.	Tasmi	P/85	dr. Zaki, Sp.B	232263	Hemoroid	07/06/2025	08/06/2025	2	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,57
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
5.	Sa'i	L/65	dr. Andi A, Sp. B	232330	Carcinoma thyroid	08/06/2025	11/06/2025	4	Cefoperazone	1	2x1	6	4	1,5
6.	Tri Agustinayanti	P/34	dr. Ardhi, Sp.Pd	232331	TF	08/06/2025	11/06/2025	4	Asam Pipemidate	2	2x0,4	1,6	0,8	2
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2
7.	Asniwati	P/61	dr. Ardhanay, Sp.Pd	232373	Cholelithiasis	09/06/2025	12/06/2025	4	Levofloxacin inf	2	1x0,5	1	0,5	2
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
8.	Mutmainah	P/82	dr. Ira, Sp.JP	232361	Ventricular premature	09/06/2025	11/06/2025	3	Ceftriaxone	2	2x1	4	2	2
									Azitromycin		1x0,5	1,5	0,3	5
9.	Misri	L/41	dr. Yoga, Sp.JP	206726	NSTEMI	09/06/2025	12/06/2025	4	Levofloxacin inf	2	1x0,75	1,5	0,5	3
									Ceftriaxone		2x1	7	2	3,5
10.	Nike Chusnul	P/30	dr. Humaira, Sp.OG	214788	SC Eracs	10/06/2025	12/06/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
11.	Nasrul Ilham M	L/25	dr. Pradana, Sp. U	175034	Hydronephrosis	10/06/2025	12/06/2025	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
12.	Erista Yustiana	P/28	dr. Humaira, Sp.OG	224330	SC Eracs	10/06/2025	12/06/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
13.	Ngatoko	L/68	dr. Elvi, Sp. P	232410		10/06/2025	15/06/2025	6	Ceftriaxone	2	2x1	2	2	1

					Pulmonary Hypertension				Meropenem		2x1	7	3	2,3
14.	Solicha	P/28	dr. Farid, Sp.N	135511	Stroke	13/06/2025	17/06/2025	5	Levofloxacin inf	2	1x0,5	1,5	0,5	3
									Ceftriaxone		2x1	8	2	4
15.	Clarisa Venta	P/25	dr. Zaki, Sp.B	199240	Neoplasm of breast	17/06/2025	19/06/2025	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,57
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
16.	Sri Ari Bawaning	P/62	dr. Elvi, Sp.P	217237	Asthma	20/06/2025	24/06/2025	5	Ceftriaxone	2	2x1	5	2	2,5
									Azitromycin		1x0,5	1,5	0,3	5
17.	Harwati H	P/70	dr. Mira, Sp. JP	180211	Syok condition	21/06/2025	26/06/2025	6	Cefoperazone	1	3x1	14	4	3,5
18.	Isnaniyah	P/60	dr. Zaki, Sp.B	211220	Gangren Necrotic	22/06/2025	24/06/2025	3	Cefoperazone	3	1x2	2	4	0.5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
									Metronidazole inf		3x0,5	1,5	1,5	1
19.	Endang Tri	P/54	dr. Zaki, Sp.B	227974	Diabetic foot	22/06/2025	24/06/2025	3	Cefoperazone	3	1x2	2	4	0.5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
									Metronidazole inf		3x0,5	1,5	1,5	1
20.	Latifatul Z	P/23	dr. Aida, Sp.OG	232991	Premature	22/06/2025	24/06/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1

3.2.3.1.3 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Juli 2025

No.	Nama	Jenis Kelamin /umur	Dokter	No. RM	Diagnosis KRS	Tgl MRS	Tgl KRS	LOS (Hari)	Antibiotik	Jumlah Antibiotik	Dosis (gram)	Total Dosis (gram)	ATC
1	Ardiansyah	L/30	dr. Arianto, Sp.OT	233336	Open wound of other of hand	30/06/2025	02/07/2025	3	Cefoperazone	2	1x1	1	4
									Ceftriaxone		2x1	3	2
2	Reva Aldo	L/29	dr. Anton, Sp.B	233308	Gangren Anogenital	30/06/2025	02/07/2025	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2
									Ceftriaxone		2x1	4	2
3	Ni Luh Elinda	P/23	dr. Humaira, Sp.OG	162043	SC	04/07/2025	06/07/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3
									Cefadroxile		2x0,5	2	2

4	Mukiyat	L/55	dr. Ardhi, Sp.Pd	016856	TF + ISK	08/07/2025	12/07/2025	5	Ceftriaxone	2	2x1	7	2
									Asam Pipemidat		2x0.4	1,6	0,8
5	Umul Habibah	L/51	dr. Andy, Sp.P	233948	Asthma	11/07/2025	14/07/2025	4	Azithromycin	1	1x0,5	1,5	0,3
6	Nadila Munip	P/23	dr. Humaira, Sp.OG	232809	Oligohydramnios	14/07/2025	16/07/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3
									Cefadroxile		2x0,5	2	2
7	Alipah	P/62	dr. Ard hany, Sp. Pd	105460	DM	15/07/2025	19/07/2025	5	Levofloxacin inf	1	1x0,5	1,5	0,5
8	Ngateni	P/63	dr. Ardhi, Sp.Pd	110454	Hiperglikemi + ISK	15/07/2025	19/07/2025	5	Ceftriaxone	2	2x1	7	2
									Asam Pipemidat		2x0.4	2,4	0,8
9	Dullah	L/49	dr. Aji, Sp.Pd	234155	DF	16/07/2025	18/07/2025	2	Levofloxacin inf	2	1x0,75	2,25	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2
10	Kalsum	P/72	dr. Anton, Sp.B	198907	Necrotizing facitis	21/07/2025	23/07/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2
									Ceftriaxone		3x1	4	2
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2
11	Musilan	L/54	dr. Fahima, SP.N	234508	CVA ICH	23/07/2025	25/07/2025	3	Cefoperazone	1	2x1	3	4
12	Marsan	L/75	dr. Ira, Sp.JP	140599	NSTEMI	23/07/2025	26/07/2025	4	Azitromycin	2	1x0,5	1,5	0,3
									Ceftriaxone		2x1	5	2
13	Artinilis	L/48	dr. Ira, Sp.JP	203877	ALO	23/07/2025	26/07/2025	4	Azitromycin	2	1x0,5	1,5	0,3
									Ceftriaxone		2x1	6	2
14	Parman	L/74	dr. Catur, Sp.P	234586	Acute Respiratory Acute	24/07/2025	27/07/2025	4	Meropenem	2	3x1	9	3
									Ceftriaxone		2x1	3	2
15	Samsul Arifin	L/55	dr. Anton, Sp.B	221994	Gangren necrotic diabeticum	25/07/2025	27/07/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2
									Ceftriaxone		3x1	4	2
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2
16	Sunardi	L/71	dr. Edi, Sp. U	198133	BPH	26/07/2025	28/07/2025	3	Cetfizoxime	1	1x2	2	4
17	You wan	L/20	dr. Sigit, Sp.BP	234721	Multiple vulnus	27/07/2025	29/07/2025	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2

									Ceftriaxone		2x1	4	2
18	M Misbahul M	L/17	dr. Zaki, Sp.B	175470	Lymphadhenopati	27/07/2025	29/07/2025	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4
									Ceftriaxone		2x1	4	2
19	Nengah Ratna T	P/25	dr. Humaira, Sp.OG	229454	KPD	27/07/2025	29/07/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3
									Cefadroxile		2x0,5	2	2
20	Rizky Eka	L/19	dr. Oka, Sp.OT	233174	Union Phalenx	27/07/2025	29/07/2025	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2
									Ceftriaxone		2x1	4	2

3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT

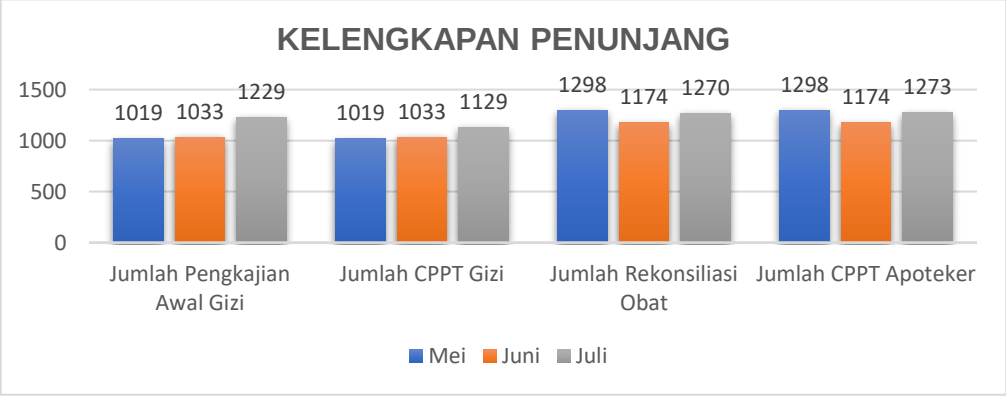
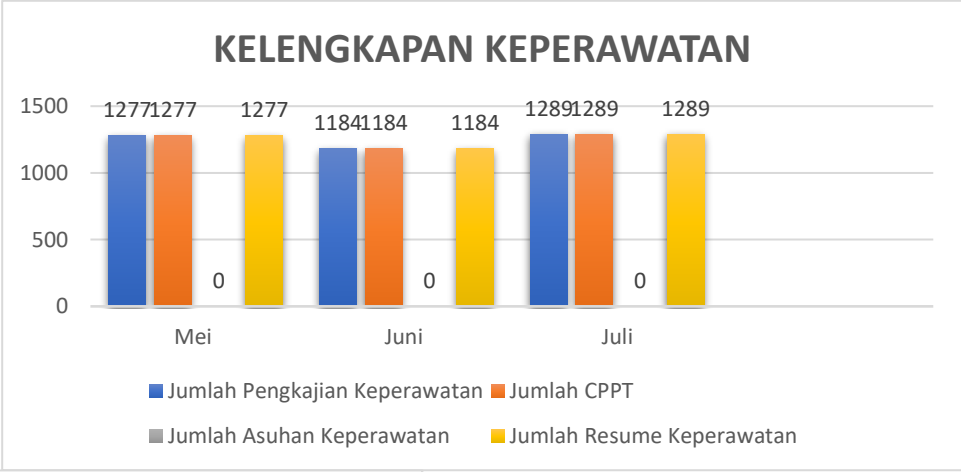
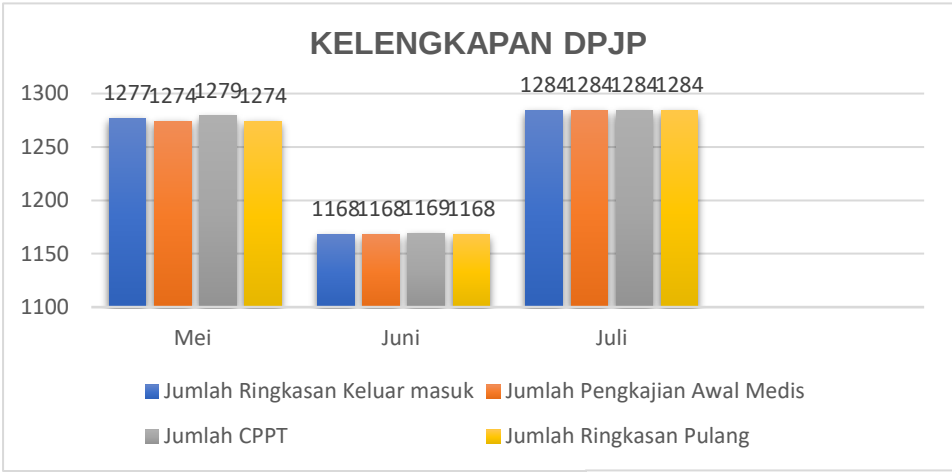
3.6.6.1 Tabel Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Bulan Juli Tahun 2025

KELENGKAPAN																
DPJP																
BULAN	Ringkasan Keluar Masuk				Pengkajian Awal Medis				CPPT				Ringkasan Pulang			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	1055	98.1	20	1.9	1019	94.8	56	5.2	1026	95.4	49	4.6	1061	98.7	14	1.3
Maret	1201	99.17	10	0.83	1128	93.15	83	6.85	1196	98.76	15	1.24	1187	98.02	24	1.98
April	1204	99	12	1	1148	94	69	6	1200	99	16	1	1185	97	31	3
Mei	1265	98	12	2	1175	92	99	8	1229	94	50	6	1246	97	28	3
Juni	1164	99.87	4	0.13	1127	96.87	41	3.13	1150	98.31	19	1.69	1162	99.72	6	0.28
Juli	1281	99,89	3	0,10	1281	99,89	3	0,11	1281	99,89	3	0,11	1281	99,89	3	0,11

KELENGKAPAN																
PERAWAT																
BULAN	Pengkajian Keperawatan				CPPT				Asuhan Keperawatan				Resume Keperawatan			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	1070	99.5	5	1048	1048	1048	1048	1.8	1056	98.2	1	0.1	1074	99.9	1	0.1
Maret	1200	98.68	16	1.32	1189	97.78	27	2.22	1214	99.84	2	0.16	1193	98.11	23	1.89
April	1240	99	10	1	1233	99	17	1	1242	99	8	1	1229	98	21	2
Mei	1270	99	7	1	1240	98	37	2	-	-	-	-	1267	99	10	1
Juni	1184	100	0	0	1177	99.49	7	0.51	-	-	-	-	1182	99.80	2	0.20
Juli	1289	100	0	0	1289	100	0	0	-	-	-	-	1289	100	0	0

KELENGKAPAN																
BULAN	AHLI GIZI								APOTEKER							
	Pengkajian Awal Gizi				CPPT				Rekonsialisasi Obat				CPPT			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	944	92	82	8	944	92	82	8	1010	98	16	2	912	89	114	11
Maret	1049	97.6	26	2.4	1074	99.9	1	0.1	1066	99.2	9	0.8	1067	99.3	8	0.7
April	1249	99.9	1	0.1	1250	100	0	0	1247	99.8	3	0.2	1250	100	0	0
Mei	753	72	266	25	1019	100	0	0	1298	100	0	0	1298	100	0	0
Juni	661	66	372	34	1032	99.91	1	0.09	1173	99.95	1	0.05	1172	98.8	2	1.2
Juli	666	58	563	48	1124	99,65	5	0,35	1269	96,67	1	3,33	1272	96,67	1	3,33

3.1.1.7 3.1.1.6 Grafik Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Bulan Juli 2025



Analisis :

1. Ketidaklengkapan DRM Ahli Gizi mengalami peningkatan pada dokumen pengkajian awal medis gizi sebanyak 563 dokumen tidak lengkap.
2. Pengkajian keperawatan 100% lengkap pada Bulan Juli 2025.
3. Masih ditemukan ketidaklengkapan pengkajian awal medis oleh DPJP pada Bulan Julsi 2025.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Menginformasikan kepada KARU hasil audit ketidaklengkapan DRM untuk melengkapi kekurangannya.
2. Melakukan supervise secara berkala.
3. Trial ERM Rawat Inap, diperlukan warning jika form belum terisi lengkap sehingga tidak bisa melanjutkan ke menu berikutnya.
4. Sosialisasi saat Rapat Unit, cara pengisian DRM.
5. Membuat raport ketidaklengkapan .
6. Kolaborasi dengan Kabid Pelayanan dan Kabid Keperawatan.

3.7 Permasalahan Rumah Sakit

3.7.68 Permasalahan Instalasi Kamar Operasi (IKO)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Unit			
1	DPJP komplain karena tidak bisa akses ERM di IKO	P	1. Telusur penyebab nama pasien tidak muncul di billing 2. Pasien masuk cito dari IGD, sehingga billing pasien masih kunjungan IGD 3. Pasien belum di rawatinapkan by billing 4. Pasien yang Rencana operasi cito bisa tempatkan di billing sementara (ruang mawar)
		D	Lakukan pengecekan pasien operasi cito dan pastikan harus didaftar dan masuk billing rawat inap
		S	Monitoring dan supervisi apakah masih ada ketidaktelitian petugas dalam memasukkan data pasien di simrs
		A	Lakukan evaluasi dan koordinasi ulang dengan programmer apabila ada kesulitan atau kendala dalam proses masuk billing
2	Ditemukan jarum di area Laundry sebagai akibat kelalaian petugas iko yang tidak melakukan pengecekan sesuai dengan SOP	P	1.Revisi SOP laundry: wajib double -check alat tajam oleh petugas dan supervisor 2.Sosialisasikan perubahan ke seluruh tim laundry
		D	Terapkan SOP untuk double chek di laundry
		S	Evaluasi selama 2 minggu
		A	Lakukan evaluasi terhadap SOP yang baru jika berhasil lakukan dengan rutin

3.7.69 Permasalahan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Kabid/ Komite Terhadap Unit			
1	Pemasangan infus dari IGD yang menyebabkan flebitis di rawat inap	P	Sosialisasi ulang SPO pemasangan infus kepada seluruh perawat IGD

			Supervisi langsung oleh kepala ruangan
		D	Sosialisasi selama 1 minggu secara berturut turut dengan tehknik coaching Kepala ruangan dan tim mutu melakukan supervisi harian selama 2 minggu
		S	Lakukan pendampingan pada jam sibuk Perlu membuat dokumentasi cepat
		A	Evaluasi berkala melalui audit kepatuhan pemasangan infus Menjadwalkan peserta mencari pasien untuk dilakukan penginfusan
2	Pelayanan di IGD ada komplain terkait komunikasi dan keramahan petugas	P	1. Mengidentifikasi kebutuhan komunikasi pasien dan keluarga pasien di IGD 2. Memberikan pelatihan kepada petugas IGD tentang teknik komunikasi 3. Review Kembali SPO komunikasi efektif yang harus dilakukan petugas IGD dalam melayani pasien
		D	Observasi komunikasi staf kepada pasien dan keluarga pasien di IGD
		S	1.Evaluasi kualitas komunikasi: Mengevaluasi kualitas komunikasi di IGD melalui survei pasien dan keluarga pasien 2.Analisa Data: Menganalisis data yang diperoleh dari survei untuk mengetahui apakah kualitas komunikasi di IGD telah meningkat
		A	1.Mengambil tindakan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi dan analisa data
3	SPRI nandon di IGD karena belum diselesaikan	P	Identifikasi penyebab data pasien belum masuk di simrs IGD Identifikasi kendala dokter yang tidak segera mengisi SPRI
		D	1. Koordinasi dengan programmer untuk memberikan alternatif pengisian, dengan melink kan pengkajian awal dengan SPRI 2. Pengisian SPRI dapat diakses terlebih dahulu, berbeda dengan alur sebelumnya
		S	Mengevaluasi pengisian rekam medis setelah dilakukan sosialisasi dan pendampingan untuk ERM
		A	Membuat video tutorial dalam pengisian dan melakukan evaluasi setelah pendampingan dan observasi
4	Pengisian register tidak lengkap, diagnose register tidak spesifik seperti di pengkajian awal medis	P	1. Identifikasi penyebab data diagnosis yang kurang spesifik 2. Mengingatkan staf perawat agar mengcopy paste diagnose yang ada di lembar pengkajian awal medis dokter IGD tanpa harus ketik manual (menggunakan daya ingat)

		D	Lakukan monitoring dan supervisi pengecekan register harian
		S	Lakukan penulisan register dicicil setelah memeriksa pasien agar tidak menumpuk di akhir shift terutama jika terjadi lonjakan pasien atau crowded
		A	Evaluasi kembali apabila perawat masih ada kendala dalam penulisan
5	Waktu tunggu IGD lebih dari 6 jam sehingga menyebabkan penumpukan pasien dan pasien baru tidak masuk	P	Identifikasi penyebab waktu tunggu IGD yang lama
		D	- PJ atau Karu harus mengatur sirkulasi perpindahan pasien di IGD - Plotting perawat belum dibentuk sehingga masing-masing perawat masih belum jelas harus memegang pasien apa saja - Koordinasi dengan dokter IGD dan PIPP, untuk memindah pasien yang stabil ke ruangan
		S	Operan antar shift harus jelas dan terdokumentasi
		A	Pendampingan operan pasien dan penunjukan plotting yang sesuai harus dipatuhi setiap shift

3.7.70 Permasalahan Rawat Inap

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Masih ada complain pasien rawat inap melalui kuesioner atau WA MOD karena complain tersebut yang tidak terkaji oleh Karu rawat inap saat pasien di ruangan	P	Karu harus keliling ke pasien di tiap ruangan unitnya untuk menanyakan kendala pelayanan selama rawat inap
		D	1. Review ulang terkait alur handling complain 2. Tangani segera jika kendala bisa diselesaikan Tingkat karu, contoh AC tidak dingin, ruangan kotor, remote rusak, lampu mati dll 3. Apabila ada kendala administrasi dan penjamin, bisa koordinasi dengan MOD
		S	Monitoring dan supervisi apakah kegiatan sudah dilakukan secara kontinu di unit
		A	Kolaborasi dengan MOD untuk meminta feedback kepuasan pasien dari unit rawat inap untuk perbaikan pelayanan rawat inap
2	Komplain terkait perawat rawat inap yang kurang ramah	P	Ingatkan Kembali staf perawat yang tidak melakukan 5S
		D	Lakukan survei kepuasan pasien secara acak sesuai dengan jadwal perawat yang akan dinilai
		S	1. Jika hasil ada perbaikan, maka cukup dengan teguran lisan 2. Jika setelah sosialisasi dan teguran lisan, masih ditemukan tidak ramah atau sesuai dengan pakta integritas, laporkan ke SDM dan komite etik keperawatan
		A	Penilaian staf harus dimasukkan evkin koordinasi

			dengan SDM
3	Banyaknya pemasangan infus yang kurang standart di IRNA	P	Sosialisasi ulang SPO pemasangan infus kepada seluruh perawat IRNA Supervisi langsung oleh kepala ruangan
		D	Sosialisasi selama 1 minggu secara berturut turut Kepala ruangan dan tim mutu melakukan supervisi harian selama 2 minggu
		S	Lakukan pendampingan pada jam sibuk Perlu membuat dokumentasi cepat
		A	Evaluasi berkala melalui audit kepatuhan pemasangan infus Menjadwalkan peserta mencari pasien untuk dilakukan penginfusan
4	Trial ERM gizi	P	Identifikasi kendala pengisian atau error pada simrs gizi rawat inap
		D	Membuat group yang didalamnya ada ahli gizi sehingga jika ada masalah langsung bisa di tindak lanjuti saat itu juga
		S	Ada beberapa pengisian form yang masih belum bisa
		A	Setelah 3 kali perbaikan dari programmer, 1 bulan ERM gizi bisa full ERM dan tidak menggunakan hardcopy

3.7.71 Permasalahan Rawat Jalan

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Verifikasi dari tim KMKB, terutama pasien BPJS, tidak hanya lengkap tetapi harus sesuai dengan diagnosis pasien	P	Membuat grup dan link antara tim KMKB, rawat jalan dan unit RM
		D	1. Pengisian link tidak nya lewat E-casemix 2. Pengisian link kelengkapan disertai dengan nama staf yang bertugas agar target melengkapi menjadi jelas
		S	Di temukan banyak ERM yang masih kurang sesuai terutama pasien dengan pemeriksaan penunjang USG atau foto rontgen
		A	PIC dari verif, Kains RM dan Karu rawat jalan harus aktif di grup jika ada kekurangan yang harus dilengkapi sebelum closingan
2	Kekosongan obat di poli	P	Identifikasi penyebab kekosongan obat terutama fast moving
		D	Koordinasi dengan Kains Farmasi untuk membuat surat edaran substitusi obat apabila kosong distributor dan kekosongan dalam jangka waktu yang lama
		S	Surat edaran tersebut tidak hanya di japi ke DPJP terkait tetapi di share kan di grup Komite medik agar DPJP lain yang memang membutuhkan bisa mengetahui terkait substitusi obat
		A	Pengaktifan obat substitusi harus otomatis tertera di billing dan stok nya jelas agar bisa terinput oleh DPJP
3	Trial ERM Loadingan dengan fokus 5 dokumen klaim	P	Identifikasi kebutuhan untuk pelaksanaan trial ERM Loadingan , karena selama ini masih pakai hardcopy

		D	Trial dilakukan 1 minggu, apabila tidak ada kendala, akan dilanjutkan per 1 agustus 2025
		S	Ditemukan ada beberapa SPRI (surat perintah rawat inap) dari pasien lodingan yang tidak tertulis GCS nya sehingga membuat PR RW jalan
		A	Koordinasi dengan programmer untuk mengatasi kendala di simrs sehingga bisa berjalan lancar
		P	Identifikasi diagnosis rujukan dari FKTP yang non spesialisik
4	Komplain dokter terkait diagnose dari FKTP yang seharusnya tidak perlu dirujuk ke RS	D	Koordinasi antara PIC RS dengan FKTP untuk mengkonfirmasi kebenaran data dan keadaan pasien di FKTP
		S	Melakukan rujuk balik kepada FKTP dengan menginput Surat rujuk balik by simrs
		A	Apabila ditemukan kasus yang sama, lapor pada PIC BPJS dengan memfotokan rujukan pasien

3.7.72
Permasalahan Instalasi Farmasi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Hasil stok opname farmasi yang sudah stabil pada akhir tahun 2024 dan belum mencapai target selisih 0.	P	Pertanggungjawaban Selisih Hasil Stok Opname
		D	Berdasarkan Surat Edaran dari RS Nomor 218/I-SE/DIR/III/2025 tentang Pertanggungjawaban Selisih Hasil Stok Opname Farmasi disampaikan beberapa kebijakan
		S	Evaluasi hasil stok opname belum mencapai target 0
		A	- Penyesuaian / Adjustment stock (akibat dari adanya selisih hasil stock opname) dengan acuan selisih wajar sebesar 1% dari total persediaan TIDAK LAGI DIBERLAKUKAN per 1 Januari 2025. - Acuan selisih hasil SO sesuai dengan BA (Berita Acara) hasil SO. - Selisih Kurang (jumlah fisik barang yang ditemukan saat SO < jumlah yang tercatat dalam sistem) dilakukan analisis selisih terlebih dahulu dan menentukan unit yang terlibat kemudian hitung beban 60% kepada Manajemen Rumah Sakit (Direktur Rumah Sakit, Kabid Penunjang, Kabid Pelayanan Medis, Kabid Keperawatan, Kabid Umum & keuangan, Kains. Farmasi). Penanggung jawab rak dan unit terlibat sebesar 40% dari jumlah selisih SO. Pembebanan langsung pada periode berjalan. - Selisih Lebih (jumlah fisik barang yang ditemukan saat SO > jumlah yang tercatat dalam sistem) dilakukan analisis selisih terlebih dahulu, jika selisih lebih masih dalam selisih wajar tidak dibebankan, jika terdapat selisih lebih yang mengalami peningkatan ekstrim, maka diberlakukan pembebanan selisih lebih hasil SO berupa teguran tertulis dari direktur

			rumah sakit kepada unit penyebab selisih SO dan penanggung jawab rak. - Hasil dari perhitungan selisih akan disesuaikan dalam penggajian setiap bulan
2.	Pengambilan obat tertinggal sudah tidak ada batas waktu karena pelayanan farmasi 1x24 jam	P	Sosialisasi dan pemahaman petugas agar tidak menolak pasien yang mengambil obat tertinggal
		D	Sosialisasi ke Apoteker dan TTK
		S	Evaluasi informasi waktu pengambilan obat di farmasi : Senin – jumat pukul 06.30 – 21.00 WIB Sabtu – minggu pukul 06.30 – 14.00 WIB
		A	Farmasi melayani 24 jam jika ada pasien yang mengambil obat tertinggal
3.	Kasus pasien 254lastic254 karena akan pesan vaksin namun oleh farmasi diarahkan ke kasir untuk pembayaran, kasir menolak karena tidak tau nama vaksinnya sehingga di arahkan ke CSO, kemudian oleh CSO di arahkan ke marketing. Seharusnya unit bisa saling koordinasi melalui telpon dan konsul ke direksi untuk dibuatkan alur sehingga pasien tidak bingung.	P	Sosialisasi dan pemahaman petugas alur pelayanan vaksin non pemerintah
		D	Sosialisasi ke Apoteker dan TTK
		S	Belum ada alur yang jelas terkait dengan vaksin non pemerintah tanpa kontrol ke poli
		A	1. Melakukan edukasi ke pasien terkait harga vaksin dan biaya jasa dokter kemudian dibuatkan copy resep manual (yang berisi identitas pasien, nama vaksin, jumlah dan no telfon pasein) 2. Pasien diarahkan ke kasir untuk pembayaran. 3. Resep kemudian di fotokan untuk diorderkan oleh gudang farmasi. 4. Ketika vaksin datang akan dihubungi oleh marketing. 5. Farmasi melakukan cetak nota pasien dan follow up kepada kasir untuk pelunasan berdasar kwitansi manual sebelumnya. 6. Pasien melakukan suntik di poli vaksin
4.	Retur barang dari rawat inap : - Obat tak bertuan → gudang retur (secara sistem), namun fisiknya dikembalikan ke rak barang retur di depo farmasi → setelah diretur ke gudang, kains akan order obat dengan jumlah sesuai yang ada di gudang retur agar dapat dimasukkan kembali menjadi stok depo. - Obat bertuan → depo farmasi melalui fitur Retur Penjualan. Retur barang dari rawat jalan → depo farmasi melalui fitur Retur Penjualan	P	Pelaksanaan retur obat tidak bertuan dan obat bertuan berjalan rutin
		D	Sosialisasi alur retur obat untuk meminimalkan selisih stok
		S	Tidak perlu ada gudang retur karena menambah rantai proses retur yang tidak diperlukan. Untuk efisiensi, seluruh obat dari unit baik bertuan atau tidak harus dikembalikan melalui depo farmasi.
		A	1. Obat bertuan dikembalikan melalui fitur Retur Penjualan. 2. Obat tidak bertuan dikembalikan melalui fitur sesuai dengan kondisinya yaitu : - Penerimaan Barang Konsinyasi - Penerimaan Obat yang Dibeli Antar RS - Penerimaan Obat Tidak Bertuan 3. Fitur penerimaan farmasi lainnya dibuat berjenjang : diajukan oleh Kains Farmasi (dengan adanya fitur keterangan untuk menjelaskan alasan penerimaan obat lainnya) → 254lastic254er oleh PT → baru bisa menambah ke stok depo.

			Berita Acara tetap dilampirkan sebagai arsip RS. 4. Buat PJ retur tiap shift di depo yang bertanggung jawab terhadap proses retur mulai dari penerimaan barang fisik, penginputan ke sistem, penilaian obat layak/tidak, pengembalian obat retur di rak obat depo
5.	Perubahan alur stok opname	P	Perhitungan stok opname dimulai ketika pelayanan rawat jalan sudah sepi tidak menunggu PT datang pukul 19.00
		D	PJ rak mulai perhitungan dan PJ input dilanjutkan oleh shift siang serta dilanjutkan verifikasi perhitungan ulang yang selisih.
		S	Evaluasi alur stok opname
		A	Perhitungan stok opname bisa dicicil (shift pagi tidak perlu kembali ke RS jam 19.00) mulai jam 14.00 selesai pelayanan poli rawat jalan sampai selesai. 3.7.73 orang TTK depo perbantuan perhitungan di gudang. Petugas shift siang menjadi PJ input dan mobile penyiapan IGD. Resep yang di proses diatas jam 14.00, ditulis dikertas untuk nanti dikurangi di akhir perhitungan. Resep umum, minta nota manual ke kasir dan resep di proses setelah SO. Jam 19.00 mulai menginput hasil SO dan diserahkan ke bagian PT untuk validasi.
6.	Perubahan Alur Kombinasi ODD-UDD	P	Perubahan jadwal TTK dan alur kombinasi ODD-UDD
		D	Plotingan jaga rawat inap pada shift pagi dan siang dibuat 1 atau 2 orang sehingga yang lainnya 255last di rawat jalan. Pelayanan resep ODD shift siang ditiadakan dan komposisi shift malam 2 TTK.
		S	Waktu tunggu farmasi meningkat sehingga perlu ada evaluasi jadwal TTK dan alur Kombinasi ODD – UDD
		A	Perubahan alur kombinasi ODD – UDD pada Perawat/ Bidan : 1. Peresep obat dimulai pukul 19.00-21.00. 2. Lengkapi obat oral maupun injeksi dengan signa, aturan pakai (sebelum/sesudah makan), keterangan (menggunakan pagi, siang, malam). 3. KECUALI untuk obat yang berinteraksi dan indeks terapi sempit, berikan jam pemberian pada

			keterangan (akan di 256lastic oleh apoteker di DPOnya). - Pereseapan diatas jam 21.00 yang akan diambil segera, dituliskan pada keterangan “diambil sekarang”. - Pereseapan obat diatas jam 21.00 yang akan ikut ODD dan tidak diambil sekarang DIINPUTKAN KEMBALI dan DIPISAH dengan resep obat yang diambil segera. - Pereseapan obat diatas jam 21.00 yang terdapat obat puyer/racikan tetap diikuti ODD (dituliskan keterangan : pagi, siang, sore (diambil sekarang 2 bungkus/kapsul). - Jika ada pasien yang pindah ruangan setelah resep ODD selesai diinput, maka perawat asal ruangan pasien wajib WhatsApp dan telfon farmasi menginformasikan pasien pindah ke ruangan mana. - Perawat memberikan obat ke pasien secara UDD (dosis satu kali pemberian). Perubahan alur kombinasi ODD – UDD pada Farmasi : - Shift pagi, Jam 07.00 pagi (diberi 1 jam pengecekan) double check 1 orang untuk semua obat, TTK lain membantu IRJA dan pelayanan IGD dan RF. - Shift siang 256last pelayanan IRJA, tetap ada PJ IRNA untuk pelayanan IGD dan RF. - Shift malam mengerjakan obat ODD mulai dari print resep, etiket, penyiapan obat dan BMHP di depo dan juga pelayanan IGD. - Penyiapan obat tetap dipisah sesuai waktu pemberian (UDD).
7.	Terdapat selisih stok opname yang fluktuatif. April 2025 = +5.327.247 Mei 2025 = -237.537 Juni 2025 = +5.601.563 Belum berjalan scan barcode menunggu antrian Programmer PT.	P D S A	Perencanaan scan barcode. - Mengajukan proposal scan barcode dan mengajukan kebutuhan alat yang menunjang pelayanan. - Melakukan presentasi perencanaan scan barcode beserta tujuan dan manfaatnya. Scan barcode dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan akurasi data, pengendalian stok yang lebih baik, kepatuhan terhadap regulasi, pengurangan biaya operasional, tindak lanjut yang lebih efisien, integrasi sistem yang lebih baik, peningkatan pelayanan pasien. Pengajuan software aplikasi barcode ke progamer dan pengajuan alat scanner barcode, barcode printer, thermal paper ke Pengadaan Umum PT. DPM.
8.		P	Menggunakan KPO digital dalam pelayanan resep.

	Penulisan Kartu Pengambilan Obat (KPO) yang masih manual dan membuat waktu obat jadi lama. Prosentase waktu tunggu obat non racikan 54.88% dan waktu tunggu obat racikan 31.23%	D	Koordinasi dengan Programmer untuk membuat fitur KPO digital di SIMRS yang bisa diakses oleh DPJP dan Apoteker.
		S	Penulisan KPO masih manual sehingga memakan waktu dan penulisan yang tidak baku dan tidak terbaca. Komplain pasien akibat pasien tidak membawa KPO.
		A	1. Follow up ke Programmer. 2. Mendata KPO tertinggal sebagai bukti kuat bahwa KPO manual resiko hilang. KPO tertinggal ada 128 KPO.
9.	Obat tertinggal 2x24 jam	P	Perbaiki kebijakan obat tertinggal.
		D	Menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal untuk mengurangi penumpukan obat tertinggal.
		S	1. Obat tertinggal bulan Juni mengalami peningkatan namun masih ditemukan pasien mengambil obat lebih 2x24 jam. 2. Primantara sudah menghubungi pasien agar obat tertinggal dikirim oleh primantara namun banyak pasien menolak karna obat diambil sendiri ke farmasi.
		A	1. Admin primantara tiap hari menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal untuk mengurangi penumpukan obat tertinggal. 2. Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan. 3. Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru.
10.	Penambahan daftar obat near ED	P	Mempercepat pengeluaran barang near ED.
		D	Membuat surat edaran untuk DPJP supaya membantu mengeluarkan barang near ED dari Depo Farmasi maupun Gudang Farmasi.
		S	1. Obat near ED yang tidak segera dikeluarkan akan mejadi deathmoving dan menyebabkan kerugian terhadap rumah sakit.
		A	1. Kolaborasi dengan Komite Medik untuk membantu pengeluaran barang near ED. 2. Melakukan negoisasi dengan DPJP untuk menggunakan barang near ED sesuai dengan kebutuhan. 3. Kolaborasi dengan Pengadaan PT untuk melakukan retur obat near ED kepada distributor.
11.	Tempat penyimpanan vaksin tidak sesuai dengan standar, ditemukan indikator vaksin pemerintah yang berubah warna sehingga tidak layak digunakan.	P	Mengadakan VR di Depo Farmasi sesuai dengan standar penyimpanan vaksin.
		D	1. Memperbaiki VR yang ada supaya bisa digunakan kembali. 2. Mengedukasi perawat dan petugas farmasi terkait penyimpanan yang benar.
		S	Vaksin yang tidak layak diberikan kepada pasien bisa dikembalikan ke Puskesmas

			Wilayah, tetapi RS harus memikirkan bagaimana vaksin tidak sampai diretur.
		A	1. Vaksin pemerintah disimpan di VR Gudang Farmasi. 2. Perubahan alur pengambilan vaksin oleh perawat poli.
12.	Floorstok IKO	P	Mendisiplinkan perawat untuk menjalankan SPO.
		D	Koordinasi dengan Kabid Keperawatan.
		S	Kendala di FS IKO 258 lasti perawat anestesi belum menjalankan inputan resep terlebih dahulu kemudian disiapkan oleh farmasi dikarenakan tidak menyanggupi jika operasi berlangsung berturut-turut. Dan informasi SPO sudah diedarkan dan dijelaskan namun perawat belum menjalankan sesuai SPO.
		A	Monitoring dan evaluasi.
13.	Ditemukan resep IU (Ketidaksesuaian surat kontrol poli dengan jadwal ambil obat apotek online BPJS Kesehatan 30 hari). April 2025 = 47 resep Mei 2025 = 39 resep Juni 2025 = 38 resep	P	Koordinasi dengan Karu poli dan Kabid Keperawatan
		D	1. Sosialisasi fitur edit no apol. 2. Koordinasi dengan Karu poli dan Kabid Keperawatan untuk edukasi ke perawat perhitungan obat 30 hari agar surat kontrol sesuai.
		S	1. Perawat salah perhitungan obat 30 hari sehingga surat kontrol tidak sesuai 30 hari. 2. Farmasi banyak pendingan resep di SIMRS karena belum bisa input no apol. 3. Farmasi utang input obat di apol. 4. Jika sudah waktunya input apol farmasi telpon verifikator bahwa resep sudah dikerjakan.
		A	1. Alur fitur "Edit No APOL" : a. Input resep IU di apol b. Copy no apol c. Klik kanan sesuai resep yang telah dikerjakan di apol d. Klik "Edit No APOL" e. Paste no apol f. Klik OK 2. Alur perubahan surat kontrol ; a. Farmasi menemukan IU di apol b. Konfirmasi ke grup whatsapp Surat Kontrol jika merubah surat kontrol pakai HP IFRS dengan format : Form Order Perubahan Tanggal Kontrol Nama pasien : No. RM : DPJP : Tanggal perubahan : Alasan perubahan : IU/TK tanggal berapa c. Pendaftaran mengubah di V-Claim d. Apoteker KIE pasien menuju CSO untuk mengambil surat kontrol, jika obat di primantara maka farmasi mencetak surat kontrol dan di steples ke obatnya. e. Pasien mengambil obat ke farmasi jika sudah ke CSO.

3.7.74 Permasalahan Laboratorium

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	LIS belum berjalan karena menunggu bridging SIMRS	P	Membuat target pelaksanaan LIS di Labortaorium RSPH Malang.
		D	Mengingatkan programmer untuk segera menyelesaikan bridging.
		S	LIS belum bisa diaplikasikam dikarenakan belum bridging dengan SIMRS.
		A	Follow up berkala ke Programmer.
2.	Petugas belum kompeten dalam pelaksanaan crossmatch labu darah	P	Mendaftarkan pelatihan/magang secara bergilir.
		D	1) Melakukan pendampingan terhadap petugas yang melakukan crossmatch. 2) Melakukan pelatihan dengan vendor.
		S	Hasil crossmatch menentukan apakah labu darah bisa diberika kepada pasien atau tidak, jika hasil aglutinasi positif maka tidak bisa diberikan.
		A	1) Melakukan pencatatan pengulangan kegiatan crossmatch. 2) Permintaan labu darah cito ketika malam hari sementara permintaan ke PMI Lawang terlebih dulu. 3) Petugas magang secara bergilir setiap 2 minggu sekali.
3.	Tidak ada fitur nilai normal pada Billing SIMRS sehingga petugas melakukan klik manual.	P	Mengajukan fitur pengisian nilai normal kepada Programmer PT.
		D	Membuat surat pengajuan fitur batas atas dan batas bawah nilai normal untuk dilakukan pengisian oleh petugas laboratorium.
		S	Dengan adanya batas atas dan batas bawah yang ditentukan, system akan membaca hasil laboratorium setiap pasien apakah berada pada nilai normal atau tidak.
		A	Follow up ke Programmer PT.
4.	Reagen kadaluarsa dan datang terlambat.	P	Memperbaiki pengadaan reagen di Laboratorium.
		D	Melakukan analisa keterlambatan. Koordinasi dengan Kabid Pelayanan..
		S	Terdapat reagen yang kosong nasional seperti CKMB, DPJP memutuskan untuk menggunakan pemeriksaan Troponin.
		A	1. Melakukan perbaikan penataan FIFO FEFO pada kulkas Laboratorium. 2. Menjalankan kartu stok dan perencanaan SO. 3. Menentukan stok minimal untuk order reagen.
5.	Pengadaan rectal swab di Lab RS Prima Husada Malang	P	Mengajukan TOR pelayanan rectal swab.
		D	Diskusi dengan Kains Laboratorium RS, dr Ari Putri, Sp.PA
		S	Utilitas jarang tidak direkomendasikan, kecuali jika bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk MCU.
		A	Proses perhitungan unit cost, jika sudah maka akan diajukan TOR.

3.7.75 Permasalahan Rekam Medis

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Layanan Poli yang belum masuk kedalam E-RM -Poli KIA -Poli Gizi	P	Melakukan permintaan fitur kepada Programmer PT.
		D	Membuat flow chart alur pelayanan pada Poli KIA dan Poli Gizi untuk diterapkan pada E-RM.
		S	Kekurangan jika kunjungan Poli KIA dan Poli Gizi dilakukan pencatatan secara manual maka hasil konseling tidak terekap dengan baik dan tidak bisa diakses oleh DPJP, sehingga tidak bisa dilakukan tindakan lanjutan yang terintegrasi. Pencatatan manual resiko hilangnya sangat tinggi.
		A	Follow up ke Programmer PT. Hasil konseling disampaikan kepada asisten setiap DPJP.
2.	Kebijakan baru dari BPJS Kesehatan tentang Kunjungan Kontrol Poli Rawat Jalan	P	Menjalankan kebijakan baru dengan meminimalisir complain.
		D	Melakukan pemberitahuan melalui social media sebelum kebijakan dijalankan. Kolaborasi dengan Programmer PT untuk menambahkan fitur surat control fisioterapi.
		S	Perawat fisioterapi masih belum bisa menginput surat kontrol pasien bpjs yg berasal dari surat rujukan utama, sehingga masih pasien masih diarahkan ke pendaftaran untuk mencetak surat kontrol
		A	1. Menertibkan pasien control sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 2. Follow up ke Programmer PT.
3.	Pendaftaran masih mendaftarkan pasien pada waktu jam praktik dokter sudah selesai.	P	Membuat kebijakan terkait pendaftaran pasien.
		D	Mendisiplinkan petugas menjalankan SPO.
		S	Dokter spesialis Gigi Anak drg. Ajeng, Sp.KGA 260 lastic 260 karena ada 1 pasien yang didaftar oleh pendaftaran pada waktu jam prakteknya sudah selesai.
		A	1. Menutup pendaftaran poli spesialis di H-10menit sebelum jam praktik selesai. 2. Konfirmasi DPJP jika ada tambahan pasien yang mendekati jam praktik selesai.
4.	ERM Rawat Inap belum terlaksana, ERM rawat jalan masih ditemukan kendala.	P	Merealisasikan pelaksanaan ERM rawat Inap dan rawat Jalan pada tahun 2025.
		D	Kolaborasi dengan Programmer PT.
		S	ERM Rawat jalan sudah terlaksana, tetapi masih banyak ketidaklengkapan dalam penginputan ERM.
		A	1. Follow up terus menerus ke 260 lastic 260 er dengan cara screenshot permasalahan dan dikirimkan via whatsapp guna menindaklanjuti permasalahan tersebut agar proses validasi ERM berjalan 260lasti. 2. Trial ERM Rawat Inap Bulan Maret

			2025.
5.	Pasien BPJS TK dari IGD tidak diberikan pengantar rujukan ke Poli Spesialis.	P	Perbaikan alur rujukan pasien.
		D	Mendisplinkan petugas menjalankan SPO.
		S	Ada 1 pasien dari IGD yg tidak diberikan pengantar rujukan untuk ke poli spesialis bedah 261 lastic dan tidak diarahkan ke pendaftaran untuk informasi jadwal praktek dokter tersebut. Pasien ke pendaftaran pada hari H tidak membawa surat rujukan dan datang pada hari yang tidak ada jadwal dokter tersebut.
		A	Mengingatkan ke KARU IGD terkait alur pasien BPJS TK dan selalu mengarahkan pasien ke pendaftaran untuk informasi jadwal dokter apabila pasien ada kontrol Lanjutan.
6.	Ketidak lengkapan pengisian form rekam medis oleh PPA.	P	Perubahan alur analisa rekam medis.
		D	Mendisplinkan petugas menjalankan SPO.
		S	Ketidaklengkapan pengisian dokumen rekam medis oleh semua PPA.
		A	Sosialisasi ke semua PPA tentang ketepatan dan kelengkapan pengisian dokumen rekam medis sehingga tidak ada lagi DRM yang tidak lengkap.
7.	Surat Rujukan penuh masih manual belum SIMRS	P	Pengajuan fitur Rujuk Penuh di SIMRS ke programmer
		D	Karu koordinasi dengan programmer
		S	Surat rujukan penuh tidak lagi manual tetapi bisa langsung terhubung ke VCLAIM sehingga bisa mengurangi waktu tunggu di pendaftaran
		A	1. Follow up ke programmer 2. Monitoring dan evaluasi SIMRS
8.	Perubahan surat kontrol pasien tidak sesuai tanggal IU	P	Mengadakan rapat untuk alur perubahan surat kontrol
		D	Koordinasi dengan Karu IFSRS dan Karu Poli
		S	Untuk perawat poli lebih teliti kembali bila akan menginputkan surat kontrol pasien
		A	Bila terjadi perubahan surat kontrol maka farmasi menarik surat kontrol yang di bawa pasien untuk selanjutnya dan mengarahkan pasien ke CSO untuk ubah dan cetak surat kontrol terbaru

3.7.76 Permasalahan CSSD

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Kebutuhan mesin steam plasma belum terpenuhi.	P	Mengajukan kebutuhan mesin ke PT.
		D	Koordinasi dengan Vendor dan DPJP terkait kebutuhan mesin steam plasma.
		S	Instrument bedah saraf memerlukan perlakuan khusus terkait cara dekontaminasi dan sterilisasinya.
		A	1) Membuat telaah terkait mesin yang

			saat ini digunakan dan yang dianjurkan. 2) Koordinasi dengan DPJP (dr Fachri, Sp.BS) bahwa sterilisasi alat bedah saraf menggunakan autoclave dengan cara alat dikemas satu persatu.
--	--	--	--

3.7.77 Permasalahan Laundry

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Hasil pencucian membuat kain terkena bercak putih.	P	Memperbaiki alur pencucian.
		D	Menerapkan alur baru.
		S	Monitoring dan evaluasi alur baru, mencari penyebab kerusakan.
		A	1. Melakukan pemilahan baju dan linen dari unit menggunakan handscoon baru (tidak terkena zak kimia). 2. Melakukan pemisahan pencucian antara linen dan baju IKO.
2.	Pencatatan jumlah linen tidak valid.	P	Memperbaiki pencacatan menggunakan digital.
		D	Pencatatan jumlah linen menggunakan google spreadsheet.
		S	Pencatatan manual beresiko angka tidak terbaca dengan baik sehingga jumlah linen tidak valid.
		A	Pencatatan digital akan dimulai pada awal Bulan Januari 2025, sebelumnya akan dilakukan SO. Rencana dilakukan stok opname setiap bulan. Pencatatan real per lantai.

3.7.78 Permasalahan Radiologi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Respon Time Pelayanan Radiologi	P	Memperbaiki respon time pelayanan radiologi.
		D	Kolaborasi antara perawat dan radiographer dengan DS Radiologi.
		S	Pencatatan dapat diketahui respon time pelayanan radiologi dari selesai periksa sampai dengan selesai hasil.
		A	Melakukan pencatatan waktu permintaan dan selesai hasil di Google Spreadsheet.
2.	Menerima permintaan pemeriksaan pasien IGD tanpa ada inputan di SIMRS.	P	Perbaikan alur pelayanan pemeriksaan radiologi dari unit.
		D	Mendisiplinkan petugas menjalankan sesuai SPO.
		S	Petugas IGD sering kali meminta pemeriksaan sebelum dilakukan input untuk menegakan diagnosis. Perawat juga menghapus inputan tanpa konfirmasi petugas radiologi setelah selesai pemeriksaan dan hasil sudah dicetak.
		A	Pemeriksaan dilakukan jika sudah ada inputan di SIMRS. Pemeriksaan yang dihapus tanpa konfirmasi maka menjadi beban petugas yang menghapus.
3.	Pemeriksaan Cito Bed tidak sesuai dengan kriteria	P	1. Mengidentifikasi kriteria pemeriksaan cito bed yang sesuai. 2. Melakukan analisis akar masalah

			untuk mengetahui penyebab pemeriksaan cito bed tidak sesuai dengan kriteria. 3. Mengembangkan rencana untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan cito bed.
		D	1. Mengadakan pelatihan untuk tim medis dan tim keperawatan tentang kriteria pemeriksaan cito bed yang sesuai. 2. Mengembangkan checklist untuk memastikan pemeriksaan cito bed sesuai dengan kriteria. 3. Mengimplementasikan sistem pelaporan untuk memantau kualitas pemeriksaan cito bed.
		S	1. Peningkatan kualitas pemeriksaan cito bed sesuai dengan kriteria. 2. Identifikasi masalah yang masih ada dan perlu diperbaiki.
		A	1. Menyusun SPO pemeriksaan cito bed berdasarkan kriteria. 2. Mengimplementasikan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan cito bed. 3. Mengembangkan rencana untuk memantau dan mempertahankan kualitas pemeriksaan cito bed. 4. Mengadakan evaluasi berkala untuk memastikan kualitas pemeriksaan cito bed tetap sesuai dengan kriteria.

3.7.79 Permasalahan Instalasi Gizi dan Dapur

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Pendistribusian alat makan tidak tercatat dengan baik	P	Memperbaiki alur pengecekan fasilitas RS sebelum pasien KRS.
		D	Kolaborasi Ahli Gizi dengan Pendaftaran IGD, Perawat, CS Pantry, CS Ruangan dan Kasir.
		S	Fasilitas RS resiko hilang karena pasien jika tidak dibuatkan alur yang jelas. Petugas wajib memberikan edukasi untuk meminimalisir kehilangan/kerusakan.
		A	Membuat SPO "Pengecekan Fasilitas RS Sebelum Pasien KRS". Sosialisasi kepada Unit Terkait
2.	Selisih antara jumlah barang pada kartu stok dan jumlah fisik bahan makanan	P	Pendisiplinan pengisian kartu stok.
		D	Kolaborasi dengan tim pengolahan dan penyaji dalam pengisian kartu stok bahan makanan.
		S	Risiko kehabisan stok bahan makanan apabila tidak teratur mengisi kartu stok bahan makanan.
		A	Sosialisasi ulang kepada tim pengolahan dan tim penyaji dalam pengisian kartu stok bahan makanan.

3.8 Profil SDM

3.8.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	1	0	0
2	Kabid Pelayanan Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
3	Kabid Penunjang Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	1	1	0	1	0
5	Kabid Umum & Keuangan	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Satuan Pengawas Internal	SMK	1	1	1	0	0
7	Dokter IGD	Dokter Umum	8	8	0	8	0
8	Dokter Casemix	Dokter Umum	2	2	0	2	0
9	Farmasi	Profesi Apoteker	43	13	6	7	0
		S1 Farmasi		3	2	1	0
		D3 Analis Farmasi dan Makanan		1	1	0	0
		D3 Farmasi		11	2	7	0
		SMK		4	3	1	0
		SMA		1	1	0	0
10	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	10	1	1	0	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		8	7	1	0
		SMK		0	0	0	0
		SMA		1	1	0	0
11	CSSD	D3 Keperawatan	5	3	2	1	0
		SMA		1	1	1	0
		SMK		1	0	1	0
12	Fisioterapi	S1 Fisioterapi	5	1	0	1	0
		D3 Fisioterapi		3	2	1	0
		D3 Terapi Wicara		1	0	1	0
13	Gizi	S1 Ilmu Gizi	17	2	2	0	0
		D4 Gizi dan Dietetika		2	2	0	0
		D3 Ahli Gizi		2	2	0	0
		SMK		7	0	7	0
		SMA		1	0	1	0
		SMP		3	2	1	0
14	Humas & Marketng	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	2	1	0	1	0
		S1 Teknik Informatika		1	0	1	0
15	ICU dan HCU	Profesi Ners	12	6	6	0	0
		D3 Keperawatan		6	5	1	0
16	IGD	Profesi Ners	23	10	7	3	1
		D3 Keperawatan		8	6	2	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
17	IKO	Profesi Ners	12	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
18	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
19	IPSRS	S1 Tenik Elektro	6	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D3 Teknik		1	0	1	0

		Elektromedis					
		SMK		3	3	0	0
20	IRJA	Profesi Ners	27	8	7	1	1
		D3 Keperawatan		14	13	1	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
21	IRNA 2C	Profesi Ners	8	6	5	1	0
		D3 Keperawatan		2	2	0	0
22	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	18	5	4	1	0
		D3 Keperawatan		13	7	6	0
23	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	14	6	4	0	0
		D3 Keperawatan		7	7	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
24	IRNA 5C	Profesi Ners	8	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		5	4	1	0
25	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	22	10	4	6	3
		D3 Keperawatan		12	8	2	0
26	Maternitas	Profesi Kebidanan	11	1	0	1	0
		D4 Kebidanan		2	1	1	0
		D3 Kebidanan		8	8	0	0
27	Neonatologi	Profesi Ners	7	2	2	0	0
		D3 Keperawatan		5	4	0	1
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
28	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	10	2	2	0	0
		S1 Akuntansi		2	0	2	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
29	Laboratorium	D4 Analis Kesehatan	9	2	1	1	0
		D3 Analis Kesehatan		7	6	1	0
30	Laundry	SMK	4	1	0	1	0
		SMA		2	0	2	0
		SMP		1	0	1	0
31	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	9	9	9	0	0
32	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	16	1	4	0	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D4 Destinasi Wisata		2	0	1	0
		D3 Asuransi Kesehatan		2	0	2	1
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		5	3	2	1
		D1 Administrasi Perkantoran		1	1	0	0
		SMK		0	1	0	0
		SMA		2	2	0	0
33	PIPP & MPP	Profesi Ners	5	2	1	0	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1	1	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
34	PMKP	Profesi Ners	1	1	1	0	0
35	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	7	7	5	2	0

36	SDM	S1 Psikologi	2	1	0	1	0
		S1 Ilmu Sosial		1	1	0	0
37	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	1	0	0
38	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	3	0	0
39	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
40	Cleaning Service	SMK	39	11	2	6	1
		SMA		23	19	4	0
		SMP		5	5	0	0
41	Security	SMK	12	5	2	3	0
		SMA		7	6	1	0
42	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	5	1	1	0	0
		SMA		3	2	1	0
		SMP		1	1	0	0
43	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
44	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	5	4	1	4	0
45	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
46	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
47	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
48	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
49	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
50	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
51	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
52	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
53	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
54	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
55	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
56	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
59	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
60	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
61	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
62	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
65	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
Total			443	431	269	156	9

Keterangan :
Pada bulan Juli 2025 terdapat 6 staf resign

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

RS Prima Husada Malang yang selalu berbenah untuk meningkatkan pelayanan baik dari sisi Sumber Daya Manusia ataupun dari sisi sarana dan prasarannya. Dimana masih terdapat beberapa Sumber Daya manusia yang masih belum tertib baik dari kelompok tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang masih belum tertib secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimulai dengan penataan SDM yang disesuaikan dengan alur dan tata letak Gedung yang baru, maka dilakukan juga penambahan tenaga khususnya perawat untuk memenuhi kebutuhan setelah dilakukan evaluasi dan Analisa beban kerja. Proporsi antara karyawan kontrak/tidak tetap dengan karyawan tetap, dimana masih banyak karyawan kontrak/tidak tetap di RS Prima Husada Malang diperkirakan bisa mempengaruhi kualitas pelayanan di Rumah sakit

Kepatuhan DPJP dalam memvisite pasien dan melengkapi dokumen Rekam medis yang masih jauh dari standar juga mempengaruhi kualitas pelayanan di RS Prima Husada Malang dan menghambat proses klaim. Kinerja RS dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal Rumah Sakit. Jumlah kunjungan di RS Prima Husada Malang masih didominasi oleh kunjungan pasien lama dari BPJS Kesehatan. Pelayanan di beberapa unit yang belum optimal dikerenakan salah satu dampak kekurangan tenaga kerja membawa akibat pada pelayanan.

B. SARAN

1. Meningkatkan ketertiban administrasi di Unit SDM terutama ketertiban absensi dengan memanfaatkan SIM SDM yang baru
2. Membentuk dan mengoptimalkan kinerja dari komite – komite yang ada di RS Prima Husada Malang
3. Meningkatkan kepatuhan visite DPJP dengan mencatat dan melaporkan waktu visite DPJP serta mentertribkan DPJP dalm pengisian Dokumen Rekam Medis
4. Memperbaiki proses rekrutmen staf sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
5. Meningkatkan skill dan pengetahuan SDM dengan giat mengaktifkan diklat dan pelatihan internal serta mengikuti pelatihan secara eksternal
6. Meningkatkan marketing dan promosi untuk meningkatkan kunjungan ke RS Prima Husada Malang
7. Menjalin lebih banyak kerjasama dengan stakeholder dari luar RS Prima Husada Malang

BAB V
PENUTUP

Demikian laporan bulan Agustus 2025 ini kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit Prima Husada Malang pada Juli 2025, masih ada beberapa target yang belum tercapai sesuai standard namun upaya selalu kami lakukan secara terus menerus. Perbaikan dan pengembangan pelayanan akan terus kami lakukan seoptimal mungkin.

Malang, 07 Agustus 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN

NO	NAMA PKS	JENIS INSTANSI	MULAI BERLAKU	TANGGAL EXPIRED	KETERANGAN	NOMOR PKS RUMAH SAKIT	NOMOR PKS INSTANSI
1	ASURANSI DAYIN MITRA	ASURANSI	05 Februari 2015	05 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/269/XII/2014	003/MKT/HLT/PKS/I/2015
2	Batas Media 99	PERUSAHAAN	05 Juni 2024	05 Juni 2027	Pelayanan Kesehatan	158/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	-
3	BPJS KESEHATAN	ASURANSI	01 Januari 2025	31 Desember 2025	Pelayanan Kesehatan	2035/E-PKS/DIR/XII/2024	651/KTR/VII-05/1224
4	CV AUMERTA ANGGUN	PERUSAHAAN	28 Agustus 2023	28 Agustus 2026	PELAYANAN KESEHATAN	164.1/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2023	-
5	ESWEJE Aesthetic Center	INSTANSI KESEHATAN	01 Maret 2024	01 Maret 2027	Sterilisasi alat kesehatan	079/DPM/E-PKS/DIR/III/2024	9,1202E+12
6	Pelayanan Bimbingan Rohaniawan Agama Hindu	AKRE	05 Desember 2022	04 Desember 2025	Bimbingan Rohaniawan Agama Hindu	1754/E-PKS/DIR/XII/2022	-
7	Indonesia Smelting Technology	PERUSAHAAN	01 Juni 2024	01 Juni 2026	Rujukan Pelayanan	194/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	005/HRGA-IST/V/2024
8	Instruktur Zumba	AKRE	23 Februari 2024	23 Februari 2025	Instruktur Zumba	067/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	-
9	Klinik Mutiara Sehat (Karanglo, Lawang, Karangploso)	INSTANSI KESEHATAN	02 Agustus 2021	02 Agustus 2026	Pelayanan Laboratorium	429.77/I-PKS/DIR/VIII/2021	069/PKS/PDP/VIII/2021
10	Klinik Endisa Husada	INSTANSI KESEHATAN	01 Agustus 2023	01 Agustus 2026	Rujukan Pelayanan	148.3/DPM/E-PKS/DIR/VII/2023	PK/01/VII/2023-KEH
11	Klinik Losari Medika	INSTANSI KESEHATAN	06 Februari 2024	06 Februari 2027	Rujukan Pelayanan	-	021/DPM/E-PKS/DIR/II/2024
12	Klinik Pratama Beauty Medika Singosari	INSTANSI KESEHATAN	25 Mei 2024	25 Mei 2027	Rujukan Pelayanan	145/DPM.E-PKS/DIR/V/2024	001/PKS/12/2024
13	Klinik Rawat Jalan Mitra Prima Care	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2027	Pelayanan Kesehatan	346/DPM/E-PKS/DIR/XII/2024	025/MPC/E-PKS/KA/XII/2024
14	Klinik Utama Medika	INSTANSI	24	24 September	Rujukan Pasien	299/DPM/E-	-

		KESEHATAN	September 2024	2027		PKS/DIR/IX/2024	
14	Klinik Utama Rawat Jalan Akasia	INSTANSI KESEHATAN	25 April 2024	25 April 2027	Pelayanan Kesehatan	116/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	011/KUA/E-PKS/HMS/III/2024
15	Penerjemah Bahasa Isyarat untuk Difabel	AKRE	14 September 2022	13 September 2025	Penerjemah Bahasa Isyarat Untuk Difabel	1378/E- PKS/DIR/X/2022	-
16	Penerjemah Bahasa Madura	AKRE	01 Agustus 2022	02 Agustus 2025	Penerjemah Bahasa Madura	1305/E- PKS/DIR/IX/2022	-
17	Penerjemah Bahasa Asing	AKRE	01 Agustus 2022	01 Agustus 2025	Penerjemah Bahasa Inggris	1288/E- PKS/DIR/IX/2022	-
18	Persada Hospital	INSTANSI KESEHATAN	10 Oktober 2022	10 Oktober 2027	Pelayanan Kesehatan	152.45//DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	1083.b.HS/MOU/X/PH-2022
19	PMI Kabupaten Malang	INSTANSI KESEHATAN	19 Agustus 2024	19 Agustus 2026	Penyediaan Darah	246/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	0904/02.06.28/UTD/VIII/2024
20	PMI Kabupaten Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Juni 2023	30 Juni 2023	Rujukan Pelayanan	-	768/E-PKS/DIR/V/2023
21	PMI Kota Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Desember 2023	01 Desember 2025	Penyediaan Darah	1790/E- PKS/DIR/XI/2023	2214/02.06.27/UTD/XI/2023
22	PRAKTEK BIDAN MANDIRI NIA IRAWATI, S.TR.KEB	INSTANSI KESEHATAN	07 Februari 2024	26 Februari 2027	Rujukan dan Pelayanan Penunjang	081/DPM/E- PKS/DIR/III/2024	-
23	PT AA International Indonesia	ASURANSI	02 September 2019	02 September 2020	Pelayanan Kesehatan Grab	-	-
24	PT Administrasi Medika	ASURANSI	01 Juli 2024	01 Juli 2027	Asuransi		071/PKS/AdM/ManagedCare/VII2024
25	PT AIA Financial	ASURANSI	04 November 2020	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	No.069/DPM/E- PKS/DIR/X/2020	No. 639/AIA/-DPM/XI/2020
26	PT AJ Central Asia Raya	ASURANSI	02 Juni 2017	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	277/RSPH/E- IKS/DIR/VI/2017	DIR/PKS-RS/1455/VI/2017
27	PT AJINOMOTO SALES INDONESIA	PERUSAHAAN	01 Mei 2012	30 APRIL 2013 (selanjutnya)	PELAYANAN KESEHATAN		

				perpanjang otomatis)			
28	PT Alfiza Medika Utama	INSTANSI KESEHATAN	07 Maret 2024	07 Maret 2028	Pelayanan Kesehatan	090/DPM/E- PKS/DIR/III/2024	018/MOU/KAMU/07/III/2024
29	PT Aloita Prima (Harris Hotel Malang)	PERUSAHAAN	29 Juli 2024	29 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	221/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	-
30	PT ANTARMITRA SEMBADA CAB. MALANG	PERUSAHAAN	01 Desember 2024	01 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	304.1.DPM/E- PKS/DIR/X/2024	344/MLG/AMS/XII/2024
31	PT APLIKANUSA LINTASARTA	ASURANSI	25 Februari 2015	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/100/II/2015	095/LA/MOU/00300/2015
32	PT ASABRI	ASURANSI	13 Desember 2023	12 Desember 2026	PELAYANAN KESEHATAN	1902/E- PKS/DIR/XII/2023	PEFJ-182/HK.02.01/HBL.H/XII/2023
33	PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA	ASURANSI	12 Oktober 2023	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	PH/E- PKS/171/X/2013	499B/AAD-LEG-AGR/X/2013
34	PT Asuransi Allianz Life Indonesia	ASURANSI	12 Desember 2017	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	729/AZLI-LGL/AG/XII/2017
35	PT ASURANSI ALLIANZ LIFE SYARIAH INDONESIA	ASURANSI	18 November 2024	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	698.21/DPM/I- PKS/DIR/IX/2024	391/ALLISYA-LGL/AG/XI/2024
36	PT ASURANSI ASTRA BUANA	ASURANSI	01 September 2020	31 Agustus 2023	PELAYANAN KESEHATAN	1033/RSPHS/E- PKS/DIR/VIII/2020	26/HID-PM/ASURANSIASTRA/IX/2020
37	PT ASURANSI DAYIN MITRA	ASURANSI	05 Februari 2015	05 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/269/XII/2014	003/MKT/HLT/PKS/I/2015
38	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia	ASURANSI	01 Oktober 2023	01 Oktober 2028	Asuransi	183.3/DPM/E- PKS/DIR/X/2023	157/GI/OPS/Prov-PKS/X/2023
39	PT Asuransi Jiwa In Health Indonesia (Mandiri Inhealth)	ASURANSI	01 Februari 2023	31 Januari 2025	Asuransi	028.2/DPM/E- PKS/DIRR/11/2023	0.32/AJII.KOP-SBY/PKS/0123
40	PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA	ASURANSI	01 Desember 2024	01 Desember 2025	PELAYANAN KESEHATAN	361/DPM/E- PKS/DIR/XII/2024	331-11/EB-CONT/2024

41	PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK (ASURANSI MAG)	ASURANSI	28 Januari 2020	27 Januari 2024	RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN	015/DPM/E- PKS/DIR/XI/2019	PKS-0097/XI/2019/MAG-R2
42	PT Asuransi Reliance Indonesia	ASURANSI	06 November 2024	06 November 2027	Asuransi	338/DPM/E- PKS/DIR/XI/2024	024/LGL-ARI/PKS-RS-IB/XI/2024
43	PT ASURANSI RELIANCE INDONESIA	ASURANSI	07 September 2020	07 September 2025	PELAYANAN KESEHATAN	368/DPM/I- PKS/DIR/VIII/2020	163/LGL-ARI/PKS-RS-COB/IX/2020
44	PT ASURANSI SINARMAS	ASURANSI	01 September 2019	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	010/DPM/E- PKS/DIR/IX/2019	364/PKS-RS/PH.RI.ASM/IX/2019
45	PT ASURANSI SINARMAS MSIG	ASURANSI	10 September 2012	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		063/PKS-AJSMSIG-RS/IX/2012
46	PT ASURANSI TAFAKUL KELUARGA	ASURANSI	02 Januari 2017	01 Januari 2020	PELAYANAN KESEHATAN	508/RSPH/E- IKS/DIR/XI/2016	0642/PKS-RS-01/I/2017
47	PT ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA	ASURANSI	30 Oktober 2021	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	612/RSPHS/E- PKS/DIR/X/2019	300/PKS/DIR/TKP/X/2019
48	PT AXA SERVICES INDONESIA (ADMEDIKA)	ASURANSI	15 Agustus 2013	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		067/AGR-LEG/ASI/VIII/2013
49	PT Bestari Murni Anugrah	PERUSAHAAN	04 Juni 2024	04 Juni 2027	rujukan pelayanan	159/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	-
50	PT BNI LIFE INSURANCE	ASURANSI	25 Juli 2016	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	082/RSPH/E- IKS/DIR/II/2016	274.PKS.BL.DIR.0716
51	PT CAKRA SURYA HUSADA	PERUSAHAAN	02 Agustus 2022	02 Agustus 2025	ASUHAN PASIEN & PELAYANAN PENUNJANG	112.1/DPM/E- PKS/DIR/VII/2022	138/MOU/VIII/CSH/2022
52	PT Citra Karsa Dinamika	PERUSAHAAN	01 Juli 2024	01 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	196/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	-
53	PT Docdoc Healthcare Indonesia	ASURANSI	12 Desember 2024	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	-
54	PT Equity Life Indonesia	ASURANSI	14 Oktober 2019	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	-	091/ELI/LGL/X/19

55	PT EQUITY LIFE INDONESIA	ASURANSI	14 Oktober 2019	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		090/ELI/LGL/X/19
56	PT Fullerton Health Indonesia	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis		-	640/IP-OP/PKS/FHI/VIII/2019
57	PT Global Assistance & Healthcare	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	-	640/IP-OP/PKS/GAH/VIII/2019
58	PT Green Mountains Natural Food	PERUSAHAAN	07 Agustus 2024	07 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	225/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	01/GMN/KS/VI/2024
59	PT HANWA LIFE INSURANCE INDONESIA	ASURANSI	16 Maret 2015	15 Maret 2016	PELAYANAN KESEHATAN		0088/HLI-GH/PKS-RS/03-2015
60	PT Indo Aneka Atsiri	PERUSAHAAN	07 Agustus 2024	06 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	222/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	066/IAA/HRGA/VI/2024
61	PT INDOLAKTO PANDAAN	PERUSAHAAN	10 Januari 2014	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		
62	PT Indonesia Marine	PERUSAHAAN	10 September 2024	10 September 2027	Pelayanan Kesehatan	-	-
63	PT INTERNATIONAL SERVICES PASIFIC CROSS	VENDOR	03 Oktober 2022	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	150/DPM/E-PKS/DIR/X/2022	953/ISPC/PKS/X/2022
64	PT JASA RAHARJA	ASURANSI	04 Juli 2022	04 Juli 2027	PENAGANAN DAN PENYELESAIAN SATUAN KORBAN KECELAKAAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DAN LALU LINTAS JALAN	912.1/E-PKS/DIR/VII/2022	P/13/SP/2022
65	PT Java Smartindo	PERUSAHAAN	01 Agustus 2020	Perpanjangan Otomatis	Jasa Pengelolaan Administrasi Kesehatan	364/DPM/I-PKS/DIR/VIII/2020	PKS.TPA-JSMART.290/VIII/20/RS.SW.C
66	PT JAYA OBAYASI	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	360/DPM/I-PKS/DIR/VIII/2020	
67	PT Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza)	ASURANSI	17 Juli 2020	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	034/DPM/E-PKS/DIR/VII/2020	092/KBM-DPM/PKS/VII/2020
68	PT LABBIOGEN ARTHA MEGA	INSTANSI KESEHATAN	02 September 2024	01 September 2027		262/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2024	B-MKT 01/001/623/VII/2024

69	PT MALANG INTERMEDIA PERS	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	025/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	103.1/PKS/DIR/JPRM/VIII/2020
70	PT Medilink Digital Media	ASURANSI	22 Maret 2024	22 Maret 2027	Pelayanan Kesehatan	09/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	229/L/PKS/MDM-DPM/III/2024
71	PT MEDLINX ASIA TEKNOLOGI	ASURANSI	28 November 2016	Perpanjangan Otomatis	APLIKASI LAYANAN KESEHATAN	150/PKS- RSPRIMAHUSADA- MAT/DIR/XI/2016	
72	PT MOOR SUKSES INTERNASIONAL	ASURANSI	08 Juli 2024	08 Juli 2027	PELAYANAN KESEHATAN	200/DPM/E- PKS/DIR/2024	001/MSI/VI/2024
73	PT PAN PACIFIC INSURANCE	ASURANSI	31 Agustus 2020	31 Agustus 2023	PELAYANAN PERAWATAN DAN PENGOBATAN	017/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	0593-01/PKS/PRV-PANFIC/RS- PHMS/VIII/2020
74	PT PANCAMAS ELITE	PERUSAHAAN	12 Juni 2024	12 Juni 2027	Pelayanan Kesehatan	172/DPM/E- PKS/DIV/VI/2024	-
75	PT PANCAMAS ELITE	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	032/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	
76	PT PLN (Persero)	ASURANSI	02 Juli 2024	31 Desember 2025		261/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	0017.Add/HKM.02.01/F010800300/2022
77	PT Prima Sarana Jasa - Asuransi SOS	ASURANSI	17 September 2018	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	735/E- PKS/DIR/IX/2018	296/GAN/PT-6/HOSP/SEP/2018
78	PT Prudential Life Assurance	ASURANSI	28 Januari 2021	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	047/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2020	1578/PMN-PLA/XI/2020
79	PT Suprima Mitra Adihusada	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	640/IP-OP/PKS/TIRTA/VIII/2019
80	PT TASPEN (PERSERO)	ASURANSI	11 Juni 2024	10 Juni 2026	Program Jaminan Kecelakaan Kerja	110/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	JAN-09/C.5.1/2024
81	PT TASPEN (PERSERO)	ASURANSI	01 Januari 2023	31 Desember 2025	Program Jaminan Kecelakaan Kerja	008/E- PKS/DIR/II/2023	JAN-01/DIR/2023
82	PT TIRTA INVESTAMA	PERUSAHAAN	31 Agustus 2020	31 Agustus 2025	PELAYANAN KESEHATAN		
83	PT Tonggak Ampuh	PERUSAHAAN	31 Agustus 2024	31 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	263/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	-
84	PT TOYOTA BOSHOKU INDONESIA	PERUSAHAAN	01 Agustus	31 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	150.2/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2023	050/AK/2/VII/TBINA-Kenaf/2023

			2023				
85	PT TOYOTA BOSHOKU INDONESIA PASURUAN PLANT	PERUSAHAAN	27 Oktober 2020	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	1076/RSPHS/E-PKS/DIR/IX/2020	002/AK/10/V/TBINA-Kenaf/2020
86	PT Unggul Anugrah Sejahtera	PERUSAHAAN	04 Juni 2024	04 Juni 2027	Rujukan Pelayanan	160/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	-
87	PT Uniplastindo Interbuana	PERUSAHAAN	29 Juli 2024	29 Juli 2027	Pelayanan Kesehatan	224/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	-
88	PT YAMAHA ELECTRONICS MANUFACTURING INDONESIA	PERUSAHAAN	04 Januari 2021	04 Januari 2024	PELAYANAN KESEHATAN	303/DPM/I-PKS/DIR/VI/2021	002/PKS-COB/I/2021
89	PT YAMAHA ELECTRONICS MANUFACTURING INDONESIA	PERUSAHAAN	22 Maret 2024	22 Maret 2027	PELAYANAN KESEHATAN	183/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	014/PKS-COB/III/2024
90	PT YAMAHA MUSICAL PRODUCTS INDONESIA (YMPI)	PERUSAHAAN	01 Juni 2022	01 Juni 2025	PELAYANAN KESEHATAN	004/DPM/E-PKS/VI/2022	/YMPI/HI/PKS/VI/2022
91	PT Yanmar Diesel Indonesia	PERUSAHAAN	15 April 2024	15 April 2027	Pelayanan Kesehatan	108/DPM/E-PKS/DIR/IV/2024	107/YADIN/Pdn/Pga/IV/2024
92	PT Zurich Asuransi Indonesia TBK	ASURANSI	25 Juni 2024	24 Juni 2029	Asuransi	151/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	268/ZAI-LEG-AGR/VI/2024
93	RS Islam UNISMA Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Januari 2024	31 Desember 2026	Rujukan Pelayanan	222.11/DPM/E-PKS/DIR/XI/2023	08/PKS/RSI-4/I/2024
94	RS Lavalette	INSTANSI KESEHATAN	07 Agustus 2024	07 Agustus 2027		236/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2024	DA01-ADDNM-BB/P-B/24-07-16/138
95	RS Prima Husada Sukorejo	INSTANSI KESEHATAN	01 Oktober 2022	01 Oktober 2025	Pelayanan Kesehatan	1376/E-PKS/DIR/X/2022	1608/RSPJS/E-PKS/DIR/X/2022
96	RS Siti Miriam Lawang	INSTANSI KESEHATAN	31 Agustus 2024	31 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	264/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	566/HMS/RSSM/VIII/2024
97	RSIA Puri Bunda	INSTANSI KESEHATAN	06 Februari 2024	06 Februari 2026	Rujukan Pelayanan	020/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	001/PKS/PB/I/2024
98	RSUD Bangil	INSTANSI	22 Juli	22 Juli 2027	Rujukan Pelayanan	222/DPM/E-	400.7.5.2/1531.1/424.072.01/2024

		KESEHATAN	2024			PKS/DIR/VII/2024	
99	Yayasan Bhakti Luhur	AKRE	05 Desember 2022	04 Desember 2025	Pelayanan Rohaniawan Agama Kristen	1753/E- PKS/DIR/XII/2022	-
100	RS PANTI NIRMALA	INSTANSI KESEHATAN	07 Oktober 2022	06 Oktober 2025	PELAYANAN RUJUKAN	152.44/DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	3740/069/RSPN/X/2022
101	PKM SINGOSARI	INSTANSI KESEHATAN	12 April 2022	12 April 2027	TUBERKULOSIS DENGAN STRATEGI DOTS	593/I- PKS/DIR/IV/2022	440/894/35.07.103.135.2022
102	KLINIK IDAMAMUK	INSTANSI KESEHATAN	16 Juni 2021	PERPANJANG OTOMATIS	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG	347/DPM/I- PKS/DIR/VII/2021	/005/VI/2021
103	KLINIK RAWAT INAP MUSLIMAT SINGOSARI	INSTANSI KESEHATAN	15 April 2023	15 April 2026	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG	107.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	031.A/A.1/M/RSMS/02/IV/2023
104	KLINIK TIRTO HUSADA	INSTANSI KESEHATAN	18 September 2023	18 September 2026	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	176.3/DPM/E- PKS/DIR/IX/2023	015.004/KTH/IX/2023
105	KLINIK UTAMA JANTUNG HUSNA MEDIKA MALANG	INSTANSI KESEHATAN	01 Desember 2023	32/11/26	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	241.2/DPM/E- PKS/DIR/XII/2023	023/PKS/DIR-HMMMALANG/XII/2023
106	DOKTER PRAKTEK MANDIRI DR NIA ANITA	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2029	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	347/DPM/E- PKS/DIR/2024	
107	DOKTER PRAKTEK MANDIRI DR INDRAWAN DWANTORO	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2029	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	348/DPM/E- PKS/DIR/XII/2024	
108	RSJ DR RADJIMAN WEDIODONONGRAT LAWANG	INSTANSI KESEHATAN	30 Oktober 2023	30 Oktober 2026	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	220.1/DPM/E- PKS/DIR/X/2023	HK.03.01/D.XXXVII/12226A/2023
109	RSUD DR SAIFUL ANWAR	INSTANSI KESEHATAN	01 November 2024	01 November 2026	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	234/DPM/E- PKS/VIII/2024	400.14.5/7499.1/102.7/2024
110	KLINIK PRATAMA RAWAT JALAN MAWAR WASKITHA HUSADA	INSTANSI KESEHATAN	23 Januari 2024	22 Januari 2027	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	001.34/DPM/E- PKS/DIR/I/2024	
111	PRAKTEK BIDAN MANDIRI RIZA KHUTMI, S.S.T	INSTANSI KESEHATAN	05 Agustus 2024	05 Februari 2027	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	221/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	
112	RSU UNIVERSITAS	INSTANSI	05	22 Agustus	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	248/DPM/E-	081/SK_PKS/RSU-UMM/VIII/2024

	MUHAMMADIYAH MALANG	KESEHATAN	Agustus 2024	2027		PKS/DIR/VIII/2024	
113	IBAZZ AESTHETIC MEDICAL CENTER BY DR UMMAH	INSTANSI KESEHATAN	14 Juni 2024	14 Juni 2027	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	180/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	
114	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MALANG	INSTANSI KESEHATAN	02 Januari 2025	02 Januari 2026	PELAYANAN KELUARGA BERENCANA IUD & IMPLANT	2053/E- PKS/DIR/XII/2024	100-3-7/103/35-07-313/2025